

قضايا فقهية في مسائل طبية معاصرة

(الفرقة الأولى - شعبة الشريعة والقانون)

دكتور

أحمد محمد لطفي أحمد

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهننا الأشراف، وعضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية

توصيف مقرر القضايا الفقهية المعاصرة

للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م

بيانات المقرر	
القضايا الفقهية المعاصرة	اسم المقرر
الشريعة والقانون	البرنامج الذي يقدم من خلاله
الأولى	الفرقة
الشريعة والقانون	التخصص
نظري : ٤ ساعات الفصل الدراسي الأول	عدد الوحدات الدراسية
عملي (لا يوجد)	
(١) يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على :	

١	معرفة آراء العلماء المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية في الحكم الشرعي التجارب الطبية، وتأجير الأرحام، وموت الدماغ.
٢	توضيح الأدلة التي اعتمد عليها كل رأي من الآراء المختلفة في القضايا السابقة ونظائرها والمناقشات الواردة عليها، والرأي الراجح منها بدليله.
٣	توظيف الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي الصحيح فيما يعرض عليه من قضايا طبية.
٤	الوقوف على عظمة الفقه الإسلامي وبيان صلاحيته ومواكبته لكل عصر من خلال دراسة القضايا الجديدة.
(٢) المستهدف من تدريس المقرر : يجب أن يكون الطالب قادراً على أن .	
١/أ	يعرف القضايا الفقهية المعاصرة - والفرق بينها وبين الألفاظ ذات الصلة وحكم التصدي
١/أ	المعارف

للقضايا المعاصرة مثل التجارب الطبية، وموت الدماغ.		والمفاهيم
يبين آراء العلماء المعاصرين وأدلتهم في هذه القضايا مما يستجد.	٢/أ	
يحدد الحكم المختار والذي قويت أدلته في حكم القضايا الطبية المعاصرة.	٣/أ	
يذكر فتاوى دور الإفتاء وقرارات المجامع الفقهية، وأحكام القضاء وآراء الفقهاء فيما يعرض عليه من القضايا السابقة.	٤/أ	
يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :		
يستخدم المنهج العلمي في الربط بين القضايا الطبية المعاصرة وبين غيرها من القضايا التي يتناولها الفقهاء القدامى والتي قد تتشابه معها .	١/ب	١/ب المهارات الذهنية
يستدل لآراء العلماء المعاصرين في حكم استخدام الأجنة في البحث والعلاج بناء على ما درسه.	٢/ب	
يناقش آراء الفقهاء وقرارات المجامع الفقهية في حكم التجارب الطبية على الإنسان.	٣/ب	
يناقش الفتاوى والآراء المختلفة فيما يستجد من قضايا طبية كموت الدماغ وتأجير الأرحام.	٤/ب	
يقارن بين آراء العلماء وقرارات المجامع الفقهية والفتاوى الصادرة في شأن التجارب الطبية.	٥/ب	
يختار الرأي الذي قويت أدلته ويحقق	٦/ب	

المصلحة ولا يترتب عليه أية مفسدة في حكم تأجير الأرحام.		
يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :		ج/١
يقدم الحكم الفقهي الصحيح في استنباط الأحكام الشرعية لإجراء التجارب على الإنسان..	ج/١	المهارات المهنية
يظهر المسائل الفقهية التي تناولها الفقهاء القدامى والتي يمكن أن تُخرج عليها القضايا الطبية المعاصرة المتعلقة بموت الدماغ.	ج/٢	
يقيم التكييفات الفقهية المختلفة لموت الدماغ ومدى جواز التصرف في أعضاء المتوفى دماغياً.	ج/٣	
يظهر آراء العلماء والمجامع الفقهية المختلفة في حكم تأجير الأرحام.	ج/٤	
يبدي آراء الفقهاء في حكم التجارب الطبية وبناء ذلك على المصالح والمفاسد.	ج/٥	
يعطي رأياً فقهياً صحيحاً في آلية التعامل مع الأجنة المجمدة.	ج/٦	
يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :		
يبادر إلى الاطلاع على ما يستجد من قضايا طبية متعلقة بموت الدماغ وغيرها مما يستجد.	د/١	المهارات العامة
يتمسك بالقواعد العلمية في استنباط أحكام القضايا الطبية المتعلقة باستئجار الأرحام.	د/٢	
يحرص على تثقيف ذاته في مجال القضايا الطبية المعاصرة المتعلقة باستخدام الأجنة في	د/٣	

المقرر	التوقيت	
البحوث والعلاج.		
يشترك في الندوات والمؤتمرات التي تعقدتها المؤسسات العلمية في الداخل لمناقشة القضايا الطبية المعاصرة وإجراء التجارب على الإنسان.	٤/د	
ينظم ندوة فقهية عامة لمناقشة إحدى القضايا الطبية التي تبرز على الساحة المجتمعية.	٥/د	
يعاون في مكافحة العمليات الطبية التي يحرّمها الشرع والقانون والتي تضر بالفرد والمجتمع كاستئجار الأرحام والتصرف في جثة المتوفي دماغيا.	٦/د	
يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :		١/هـ
يقدر آراء الفقهاء المعاصرين واختلافاتهم في القضايا التي تناولها المنهج الدراسي.	١/هـ	الجوانب الوجدانية
يؤمن بأهمية اختلاف الفقهاء المعاصرين في الأحكام الفقهية المتعلقة بالتلقيح الصناعي وأنواعه.	٢/هـ	
يتمسك بقرارات المجامع الفقهية المختلفة وفتاوى العلماء المعاصرين فيما يتعلق بأحكام استئجار الأرحام.	٣هـ	
يعتز بثقافته الفقهية المعاصرة وتليتها لحاجات ومتطلبات الواقع الحياتي ، ومواكبتها للأحداث المستجدة غير المتناهية فيما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بموت الدماغ.	٤/هـ	

مقدمة في مفهوم القضايا المعاصرة، وأهمية دراستها، وضوابط التصدي لها.	الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول
مفهوم التجارب الطبية وأنواعها	الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول
حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان	الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول
حكم إجراء التجارب على البويضات الملقحة	الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول
القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر (القيود الخاصة بالتجربة).	الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول
القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر (القيود الخاصة بالخاضع للتجربة).	الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول
القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر (القيود الخاصة بالمجتمع).	الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول
المسؤولية المترتبة على إجراء التجارب الطبية	الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول
مفهوم تأجير الأرحام وحكمه.	الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول
الآثار المترتبة على عملية تأجير الأرحام.	الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول

مفهوم موت الدماغ، وشروطه.	الأسبوع الحادي عشر من الفصل الأول	
التكيف الشرعي لموت الدماغ	الأسبوع الثاني عشر من الفصل الأول	
حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ.	الأسبوع الثالث عشر من الفصل الأول	
مراجعة عامة	الأسبوع الرابع عشر من الفصل الأول	
المحاضرة.	١	٤ - أساليب التعليم والتعلم
الحوار والمناقشات مع الطلاب.	٢	
تكليف الطلاب بعمل أبحاث في بعض مفردات المقرر التي لا يسع الوقت لإنجازها.	٣	
حث الطلاب على قراءة موضوع المحاضرة قبل موعدها حتى يمكنهم المناقشة فيما يشكل عليهم من عناصر المحاضرة.	٤	
استقبال الطلاب ذوي القدرات المحدودة في أوقات الساعات المكتبية لتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء مذاكرة المقرر.	١	٥ - أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة
السماح لهم بتسجيل المحاضرة حتى يستفيدوا أكبر استفادة ممكنة.	٢	
تدريس الأقران.	٣	
(٦) تقويم الطلاب :		
- الاختبارات التحريرية.		أ - الأساليب

المستخدمة	
ب - التوقيت	نهاية الفصل الدراسي الثاني
ج - توزيع الدرجات	الاختبار التحريري: ١٠٠٪
(٧) قائمة الكتب الدراسية والمراجع:	
أ - مذكرات	لا يوجد
ب - كتب مُلزمة	القضايا الفقهية المعاصرة - المقرر على طلاب الفرقة الأولى شريعة وقانون. تأليف الأستاذ الدكتور / أحمد محمد لطفي
ج - كتب مقترحة	دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة : د/ عمر سليمان الأشقر - د/ محمد عثمان شبير - د/ عبد الناصر أبو البصل - د/ عارف علي عارف - د/ عباس أحمد الباز ، ط : دار النفائس.
	زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة : د/ أحمد محمود سعد - دار النهضة العربية .
	الطبيب أدبه وفقهه : د/ زهير السباعي - د/ محمد علي البار ، ط / دار القلم ، الدار الشامية .
د - دوريات علمية أو نشرات	١ مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهننا الأشراف .
	٢ مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة .
	٣ مجلة دار الإفتاء المصرية .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق فسوى، وَقَدَّرَ فهدى، علم الإنسان ما لم يعلم،
والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

وبعد

فمن خصائص الشريعة الغراء صلاحيتها لكل زمانٍ ومكان، ومسايرتها
لحاجات الناس ومتطلباتهم، أيًا كانت تلك المتطلبات، وقد اهتم الفقهاء
بوضع الضوابط التي تكفل الوصول إلى الحكم الشرعي فيما يستجد من
مسائل، فجاءت أحكام المستجدات مضبوطة بضوابط الشرع، لا شطط فيها
ولا مغالاة، لا إفراط فيها ولا تفريط.

والمجال الطبي مجال فسيح، يتطور بشكلٍ مذهل، حتى صرنا كل يوم
نسمع عن كشفٍ طبي جديد، وتقنية علاج جديدة، الأمر الذي يستدعي
البحث في الحكم الشرعي لكل ما يستجد في هذا المجال، لا سيما وأنه
يتعلق بحياة الإنسان.

وبات ضروريًا لطلاب العلم الشرعي عامةً وأبناء الأزهر المعمور
خاصةً أن يكونوا على درايةٍ بأحكام تلك المسائل، لينيروا للناس طريقهم،
وليُجلوا لهم حكم الشرع في تلك المسائل التي يصعب على العامي أو غير
المتخصص الوصول إلى حكمها.

لذا استخرت الله تعالى وسطرت بقلمي هذا السفر، وضممته بعض
القضايا الطبية المعاصرة التي يتوجب معرفتها للناس عامة، وطلاب العلم
خاصة.

وها أنا قد أعددت هذا المؤلف ليكون مادةً تدرس على أبنائنا وبناتنا

طلاب وطالبات كليات الشريعة والقانون، والشعب المناظرة لها في كليات الدراسات الإسلامية والعربية، وإني لأرجو الله تعالى أن يكون هذا الكتاب نبراسًا يضيء لهم الطريق، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الأستاذ الدكتور

أحمد محمد لطفي

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهما الأشراف دقهلية

التجارب الطبية على الإنسان بين ضرورة التقدم الطبي وحرمة الجسم البشري

رؤية فقهية طبية معاصرة

دكتور

أحمد محمد لطفي أحمد

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهننا الأشراف، وعضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية

المبحث الأول

مفهوم التجارب الطبية وأنواعها

يعتبر التحديد الدقيق لمفهوم التجارب الطبية وأنواعها من الأمور الرئيسة في بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من التجارب، فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره، لذا أعرض لمفهوم التجارب الطبية، وأنواعها وتاريخها فيما يلي:

أولاً: مفهوم التجارب الطبية:

التجربة في اللغة: مأخوذة من الفعل جَرَّبَ، يقال: جَرَّبَهُ تجربةً، اختبره، ورجلٌ مُجَرَّبٌ كمفطم على صيغة الفاعل، أي: محدث قد عرف الأمور وَجَرَّبَهَا، أي أن الأمور جَرَّبَتْهُ وأحكمتها، وفي التهذيب: المُجَرَّبُ هو الذي جَرَّبَ في الأمور وَعَرَفَ ما عنده^(١).

والجريب: الحصى الذي فيه التراب، يقال: رماه بالجريب، أي: بالحصى، والتجربة من المصادر المجموعة، ومنه قول النابغة: إلى اليوم قد جُرِّبَنَ كل التجارب، وقول الأعشى:

كم جَرَّبُوهُ فما زادت تجاربهم
أبا قدامة إلا المجد والقنعا^(٢).

(١) القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة - بيروت، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ٨٥/١، تاج العروس، لمحمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بالمرتضى الزبيدي، تحقيق. مجموعة من المحققين، دار الهداية - مصر، ١٥٤/٢.

(٢) جمهرة اللغة، لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيق. رمزي منير بعلبكي، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين - بيروت، ١٩٨٧ م، ١٠٧/١، المحكم والمحيط الأعظم، لعلي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق. عبد الحميد هندراوي، الطبعة الأولى، دار الكتب

والدراهم المُجَرَّبَة: هي الموزونة عن كراع، وقالت عجوزٌ في رجلٍ كان بينها وبينه خصومة عند موته:

سأجعل للموت الذي التف روحه وأصبح في لحدٍ بجدة ثاويًا
ثلاثين ديناراً أو ستين درهماً مجربة نقداً ثقالاً صوافياً^(١).

والتجربة: هي ما يحصل من المعرفة بالتكرار^(٢).

وعرفها المعجم الوسيط بأنها: اختبارٌ منظمٌ لظاهرةٍ أو ظواهرٍ يراد ملاحظتها ملاحظةً دقيقةً ومنهجيةً، للكشف عن نتيجةٍ ما، أو تحقيق غرضٍ معين^(٣).

وفي الاصطلاح: لا يختلف معناها الاصطلاحي كثيراً عن المعنى اللغوي:

فعرّفها الشاطبي في الموافقات بأنها: أمرٌ مُشاهدٌ في أي علمٍ كان^(٤).

وعرفها علماء النفس بأنها: وسيلةٌ لجمع دلائلٍ تُظهر تأثير متغيرٍ آخر،

العلمية - بيروت، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ٢٩٢/٣، لسان العرب، لابن منظور، الطبعة

الثالثة، دار صادر - بيروت، ١٤١٤هـ، ٢٥٩/١.

(١) لسان العرب، ٢٥٩/١.

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق. محمد الداية،

دار الفكر المعاصر - بيروت، دمشق، ص ١٦٠.

(٣) المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار

الدعوة، ١١٤/١.

(٤) الموافقات في أصول الشريعة، لإبراهيم بن موسى، المعروف بالشاطبي، تحقيق. مشهور

بن حسن آل سليمان، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، ١٤١٤هـ - ١٩٧٩م، ١٤٨/١.

وفي الظروف المثالية يتناول المُجَرَّبُ التغير المستقل، وَيُثَبِّتُ سائر العوامل الأخرى، ثم يلاحظ ما يطرأ بعد ذلك على المتغير المتابع^(١).

وقيل في تعريفها أيضاً أنها: إحدائ ظاهرة في ظروف صناعية معينة يُرَتِّبها الباحث قبل إجراء التجربة، بقصد جَمْع معلوماتٍ عن ظاهرة تعينه على التحقيق من صحة فرص افتراضية^(٢) أي أن التجربة في عمومها ليست إلا سلسلة من الخطوات التي يُخَطِّطُ لها بدقة وعناية، ويكون الغرض منها اختبار فرص، أو حل مشكلة، أو الحصول على معلومات جديدة^(٣).

وقد تعرض القانون الفرنسي رقم ٨٨/١١٣٨ الصادر في ١٢/٢٠/١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم ٩٠/٨٦ الصادر في ١/٢٣/١٩٩٠ لتعريف التجارب الطبية، فعرّفها بأنها: مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية^(٤).

وقد تعرض العلماء لتحديد مفهوم التجارب الطبية على نحو يتفق مع الواقع الحقيقي لهذا المصطلح:

ف قيل: هي الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي تعمل دون ضرورة تمليها حالة المرضى ذاتهم، لإشباع شهوة علمية، أو لخدمة الطب

(١) د. محمد عماد الدين إسماعيل: المنهج العلمي وتفسير السلوك، الطبعة الرابعة، دار القلم الكويت، ١٩٨٩م، ص ٢١٣.

(٢) د. مجدي أحمد عبد الله: علم النفس التجريبي بين النظرية والتطبيق، ص ٣٣، طبعة دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية، ١٩٩٦م.

(٣) د. أحمد رياض زكي: المعجم العلمي المصور، ص ٢٢٤، القاهرة.

(٤) د. جون بينو: حماية الأفراد الذين يوافقون على إجراء أبحاث طبية حيوية عليهم، بحث مقدم لمؤتمر الطب والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص ٥٧٥.

والإنسانية^(١).

وتعرف بأنها: التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم الطبيب بإجرائها على مريضه^(٢).

وقيل: هي استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض، بغرض البحث العلمي، وفقاً للأصول العلمية، دون أن يكون في حاجة إليها^(٣).

وبناءً على ذلك فإن التجارب الطبية تختلف عن التدخل العلاجي، حيث إن الأخير عملٌ يقوم عليه الطب، وهو مشروع بالاتفاق، فالتدخل العلاجي يتمثل في مجموعة من الأعمال الفنية والطبية التي يباشرها الطبيب لمصلحة المريض، والتي تكون لغرض تحسين حالته الصحية^(٤).

ثانياً: أنواع التجارب الطبية:

تتنوع التجارب الطبية إلى نوعين رئيسيين تبعاً للغرض من التجربة:

(١) د. عاطف علي عارف: مدى شرعية التصرف بالأعضاء البشرية، رسالة دكتوراة، جامعة

بغداد، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، ص ٣٣٤.

(٢) د. أسامة إبراهيم علي: مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار البيارق -

عمان - الأردن، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص ١٧٣.

(٣) د. شعلان سليمان محمد: نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية الحديثة في

الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراة - كلية الحقوق، جامعة المنصورة

٢٠٠٢م، ص ٦٠٦.

(٤) د. مأمون عبد الكريم: رضاء المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار

المطبوعات الجامعية - الإسكندرية ٢٠٠٦م، ص ٣٩٣.

النوع الأول: التجارب العلاجية:

هي التجارب التي تهدف إلى علاج الشخص الخاضع للتجربة من مَرَضٍ أَلَمَ به بطريقةً مبتكرةً جديدةً ومتطورة، حيث إن المعرفة العلمية القائمة وقت إجراء التجربة لا تكفي لعلاج هذا المريض، وبالتالي يتم اختيار الطريقة الجديدة على المريض لتسجيل النتائج^(١) وبمقتضاه يباشر الطبيب التجربة مستهدفًا علاج مريضه باستخدام وسائل حديثة، قد تحقق - من وجهة نظره - تقدمًا في العلاج^(٢).

وبتعبير أكثر دقة يمكن تعريف التجارب العلاجية بأنها: التجربة التي يباشرها الطبيب بقصد علاج المريض باستخدام وسائل حديثة في الحالات المرضية التي تفتقد إلى دواءٍ معروفٍ كفيلٍ بتحقيق الشفاء^(٣) والغرض الأساسي من تقرير هذا النوع هو محاولة إيجاد علاج للمريض عن طريق تجربة العديد من الأدوية والعلاجات التي يرى الطبيب أنها تُجدي نفعًا في علاج المريض، ومن أمثلة هذا النوع: التدخلات العلاجية المحضة من حيث الغرض، وهو علاج المريض، إلا أن لهذا النوع من التجارب ميزة أخرى تتمثل في إمكانية الاستفادة من المعارف المكتسبة منها^(٤).

(١) د. رضا عبد الحليم: النظام القانوني للإنجاب الصناعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية - القاهرة، ١٩٩٦م، ص ٦٢٤.

(٢) د. أسامة عبد الله قايد: المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠٣م، ص ٣١٨.

(٣) المرجع السابق.

(٤) أ. خالد بن النوى: ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون - المنصورة ٢٠١٠م، ص ٥٣.

النوع الثاني: التجارب العلمية:

ويطلق عليها التجارب غير العلاجية، وهي التجارب التي يخضع بمقتضاها الكائن البشري لطرق وأساليب دون ضرورة تملئها حالته^(١).

وقيل: هي كُلُّ بحثٍ منهجيٍّ يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم، أو المساهمة فيها^(٢).

وقيل في تعريفها: هي أعمال فنية وعلمية يباشرها الطبيب على جسم المريض بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من الأمراض، أو المعالجة الوقائية، أو العلاج^(٣).

ويرى البعض أن التفرقة بين التجارب العلاجية والتجارب العلمية تبدو غير واضحة المعالم؛ لأن العلاج عملٌ بمقتضاه يقوم الطبيب بالعمل على شفاء المريض، وهذا العمل قد يكون عقدًا، كما في حالة اتفاق المريض مع طبيبٍ خاص، سواءً أكان هذا الاتفاق صراحةً أم ضمناً، أما إذا كان العلاج في إحدى المستشفيات العامة فلا يمكن حينئذٍ القول بوجود عقد علاج بين المريض والطبيب، فالعلاج بذلك يكون من أعمال المساعدة^(٤).

(١) د. محمد عيد الغريب: التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي، طبعة ١٩٨٨م،

ص ١٠.

(٢) د. محمد سامي الشوا: الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراة، كلية

الحقوق، جامعة عين شمس، ١٩٨٦م، ص ٤٩٣.

(٣) د. مأمون عبد الكريم: رضاء المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات

الجامعية - الإسكندرية ٢٠٠٦م، ص ٦٩٤.

(٤) د. محمد المرسي زهرة: الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية،

مطبوعات جامعة الكويت ١٩٩٠م، ص ١١٨ وما بعدها.

أما التجارب العلمية فهي على العكس من ذلك، إذ إنها تسمح للباحث بالتحقق من صحة فرض معين، عن طريق خلق الظروف والمعطيات الملائمة لعلم الطب، وهو بذلك يعد عملاً من أعمال الإيثار، دافعاً مصلحة الطب ذاته بهدف تطوير العلم والمعرفة، وليس مصلحة من تُجرى عليه التجارب، وهو أيضاً عمل ليس له دافع شخصي من جانب الإنسان.

وبناءً على ما تقدم فالفارق بين النوعين يكمن في الهدف أو الغرض الذي يسعى إليه كل منهما، فالتجربة العلاجية هدفها الرئيس إيجاد أفضل طرق العلاج المتاحة للمريض وتعميم الفائدة إلى غيره من المرضى، أما التجربة العلمية أو غير العلاجية فتهدف إلى كشف طبي جديد، سواء أكان يتعلق بالتشخيص أم بالعلاج، ويتم تجربته على مجموعة من الأفراد، قد يكونوا أصحاء أو مرضى، مع الأخذ في الاعتبار أن من تُجرى عليهم التجارب ليست لهم مصلحة شخصية ومباشرة في إجراء التجربة.

ثالثاً: تاريخ التجارب الطبية:

لا تعتبر التجارب الطبية - كما يعتقد الكثيرون - من نوازل العصر الحديث، ولم يقتصر ظهورها عليه؛ فقد أوضح الأطباء القدماء لاسيما أطباء اليونان أن التجارب الطبية تعتبر من الركائز الأساسية في علم الطب، حتى صرّح الطبيب "أبقراط" عن ذلك بقوله: الطب قياس وتجربة^(١).

وقد وُجدَ من الأطباء المسلمين القدماء من أجرى التجارب بنفسه، فيذكر المؤرخون أن الطبيب أبو بكر الرازي أجرى نوعين من التجارب

(١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي،

المعروف بابن أبي أصيبعة، تحقيق د. نزار رضا، مكتبة الحياة - بيروت، ص ٤٩.

الطبية، إحداها على الإنسان، والأخرى على الحيوان: فبالنسبة للإنسان، يُذَكَّرُ أنه أُتِيَ له بعدد من المرضى، مصابين بمرض السرسام - وهو مرض يُقال له ورم في الدماغ - فقام بتقسيمهم إلى مجموعتين، وبدأ في علاج إحدى المجموعتين بالفصد، تاركًا علاج المجموعة الأخرى، وراقب النتائج وحلَّلها بدقة، ثم قرر بدء العلاج^(١).

أما التجارب على الحيوان: فقد قام الطبيب الرازي بتجربة تأثير الزئبق وأملاحه على القرد، وظل يراقبها، حيث أعطى الزئبق لقرد كان يسكن معه في بيته، فرأى القرد ملتويًا على نفسه، واضعًا يده على بطنه وهو يصك أسنانه^(٢).

ولم يقتصر أمر إجراء التجارب الطبية على الطبيب الرازي فقط؛ بل إن التاريخ حافل بالكثير من التجارب التي قام بها الأطباء على الإنسان، مما دعا الطبيب اليوناني الحاذق " جالينوس " إلى تصنيف كتاب خاص بالتجارب على الإنسان، ومن قام بها من الأطباء.

وقد وُجِدَ أيضًا الطبيب العربي البارع "ابن سينا" الذي كان له باع كبير في تلك المسألة، وحَقَّقَ من خلالها نتائج إيجابية، فقام بتجربة وضع الثلج على الرأس وتغطيته به لمنع مادةٍ تَصَوَّرَ أنها تريد النزول إلى حجاب الرأس، إذ إنه لا يأمن وربما يَنْزِلُ فيه، وذلك لصداعِ أَلَمَ به، فنجحت هذا

(١) د. علياء رشيد عزة: أبو بكر الرازي وأثره في الطب، مطبعة العمال - بغداد، ١٩٨٨م، ص

(٢) د. سمير عرابي: علوم الطب والجراحة والأدوية عند علماء العرب والمسلمين، دار

التجربة وَعُوفِي المريض على إثرها، كما أجرى ابن سينا أيضًا تجربةً على امرأةٍ مصابةٍ بداء السل، حيث أمرها ألا تتناول شيئًا سوى دواءٍ مُتَّخَذٍ من الورد والعسل يسمى "الجلنجبين السكري" فتناولت منه مائة، وَشُفِيَتْ، وعزم ابن سينا على إثبات تلك التجارب في كتابه "القانون في الطب" إلا أن هذه التجارب فُقدَتْ منه قبل إتمام كتابه ^(١).

وقد عقد ابن أصبغة في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" فصلًا تكلم فيه عن أهمية التجارب، مؤكدًا على أن الطب في الكثير من مسائله مبنيٌّ على الملاحظة والتجربة، وأن الإنسان يمكنه من خلال التجارب اكتشاف بعض الأدوية والعلاجات، وَرَدَّ على من ادعى أن الطب يُؤخَذُ من طريق الإلهام والوحي فقط، ولا دخل فيه للملاحظة والتجربة ^(٢).

وفي العصر الحديث: أيقن الأطباء أن التجارب على الحيوانات لم تعد وحدها كافيةً لإيجاد الحلول للكثير من المشكلات الطبية التي يعاني منها الإنسان؛ لأن تأثير الدواء في الكثير من الأحيان يختلف من الإنسان عنه في الحيوان، لذا بات ضروريًا اللجوء إلى إجراء تلك التجارب على الإنسان.

إلا أنه في بدايات إجراء تلك التجارب على الإنسان لم يكن يتوفر لها من الضوابط ما يكفل حماية الشخص الخاضع لها، وإنما كان جُلُّ اعتمادها على ضمير الباحث وإنسانيته، الأمر الذي أدى إلى وجود عواقب سيئة لهذه

(١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ٤٤٣، تاريخ يعقوبي، لأحمد بن إسحاق بن جعفر

بن وهب بن واضح يعقوبي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١١٥/١.

(٢) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ١٤.

التجارب، سواءً على الفرد أو على المجتمع^(١).

ومن أبرز الوقائع التي ظهرت في هذا الشأن: ما حدث عام ١٩٤٦م أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قام ثلاثة وعشرون طبيباً ألمانياً بإجراء تجارب طبية عنيفة على الآلاف من الأسرى والسجناء، مما كان سبباً في موت معظمهم، وإصابة العديد منهم بإعاقات جسدية مستديمة، وفي نهاية الحرب تمت محاكمة هؤلاء الأطباء من قِبَل دول التحالف.

لذلك اتجهت الأنظار عالمياً إلى ضرورة وضع الضوابط والنظم التي تكفل نجاح تلك التجارب، والحفاظ على حياة الأشخاص الخاضعين لها، وبالفعل كانت أولى الخطوات في هذا الشأن هو إعلان "هلسنكي الأول" نسبةً إلى المدينة التي وُضِعَ فيها هذا الإعلان، حيث تم فيه وُضْعُ مجموعة من القواعد التي يَسْتَرْشِدُ بها الأطباء في عملية إجراء التجارب الطبية على الإنسان.

ثم تمت مراجعة هذه الضوابط مرةً أخرى بعد قيام مجموعة من الأطباء بإجراء تجربة على ستمائة رجلٍ من أصلٍ إفريقي، كان منهم أربعمائة مصابون بمرض الزهري، وكان الهدف من هذه التجربة هو مراقبة تطور المرض دون تدخلٍ علاجي، ولم يتم إخبار هؤلاء المرضى بطبيعة المرض، وتم منع الأدوية التي صُرِفَتْ لعلاجهم، وَنَتَجَ عن هذه التجربة موت العديد

(١) أعمال مؤتمر الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، والذي عقد في القاهرة في الفترة من ٤ - ٧ جمادى الآخرة ١٤١٢هـ، أعده. المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية - جامعة الأزهر، ص ١٧٦.

من هؤلاء^(١).

وقد نصت اتفاقية جنيف الصادرة عام ١٩٤٦م والخاصة بالجرحى والمرضى من العسكريين على تحريم الأفعال التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تجاه المرضى والجرحى الذين يقعون في قبضتهم، ومن التصرفات التي نصت عليها:

- ١- القتل المتعمد، أو الإجهاز على المرضى والجرحى.
- ٢- التعذيب، أو المعاملة اللا إنسانية تجاه المرضى والجرحى من الطرف المعادي.
- ٣- إخضاع المرضى والجرحى إلى اختبارات بيولوجية، أو إجراء تجارب طبية أو علمية عليهم، أو التسبب المقصود في عدوانهم بأية أمراض أو بتر أي عضو من أجسامهم.

ومن الناحية التاريخية: فقد كان للقانون الدولي اليد الطولى في وضع الأسس القانونية للتجارب الطبية التي تجرى على الإنسان، وذلك عن طريق المبادئ التي أرسنها محكمة **urembing** سنة ١٩٤٩م عند محاكمة الأطباء النازيين عن الجرائم الحربية التي ارتكبوها أثناء الحرب العالمية الثانية باسم التجارب الطبية، حيث أدت المعاملات الغير إنسانية التي تعرض لها الكثير من البشر على أيدي هؤلاء الأطباء إبان هذه الحرب إلى صياغة العديد من المواثيق الدولية حول معاملة البشر في نطاق المجال

(١) د. محمد سليم محمد: جريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الثانية، مؤسسة شباب

الجامعة - الإسكندرية، ١٩٨٢م، ص ٤٦.

الطبي^(١).**الإسلام والطب:**

اتسم بأنه دين عام وشامل، ولا يقف حجر عثرة أمام التقدم في أي مجال من المجالات، بل يقف وبقوة خلف كل تطور يؤدي إلى تحقيق مصلحة الإنسان، بغض النظر عن دينه ومعتقد، ولعل المجال الطبي من أهم المجالات التي يعمل الإسلام على دفعها للأمام، نظرًا لتعلقه بحياة الإنسان، إذ من المقرر أن حفظ النفس وعدم تعريضها للخطر أو الاعتداء عليها من الكليات الخمس التي أولاهها الشارع العناية، واهتم بها اهتمامًا بالغًا.

وقد كان حرص الإسلام بالغًا في تكريس القوى للإبداع والتطوير في هذا المجال، لذا كان من المسلمين في العصور السابقة من لهم باع طويل في هذا المضمار، والتاريخ حافل بالنماذج التي تؤكد ذلك، وقد أمر النبي ﷺ بالتداوي، فقال: "تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ"^(٢) غاية ما في الأمر أن الإسلام اشترط في الدواء أن لا يكون محرّمًا، أو وسيلةً لمحرّم، وأن لا يكون في إجراء التجارب الطبية - مثلًا - اعتداء على ثوابت الشريعة ومخالفة نصوصها القاطعة، واعتداء على خصوصيات المرضى وهتك أسرارهم.

(١) د. مأمون عبد الكريم: السابق، ص ٦٨٨، ٦٨٩.

(٢) أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً، برقم (٣٤٣٦) ١١٣٧/٢، وابن حبان، كتاب الطب، باب ذكر الأمر بالتداوي، برقم (٦٠٦١) ٤٢٦/١٣، والحاكم في المستدرک، کتاب الطب، برقم (٨٢٠٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ٤٤١/٤.

لذا كان الأمر في بحبوحة وسعة من وجهة النظر الإسلامية، لاسيما إذا تمت مراعاة الضوابط والشروط التي سنذكرها لاحقاً.

المبحث الثاني

الحكم الشرعي للتجارب الطبية على الإنسان

تمهيد:

قررنا سابقاً أن التجارب الطبية تعتبر ضرورةً من الضرورات المفيدة في تحقيق التقدم العلمي في المجال الطبي، وإذا كانت التجارب الطبية ظاهرةً واقعةً منذ الزمن البعيد، إلا أنها تعرضت في فترةٍ من فترات التاريخ للنقد الشديد، مما أدى إلى رفضها كليةً، بسبب تلك الجرائم التي كانت تُرتكبُ باسم الطب ومصلحة المرضى، الأمر الذي أدى إلى تحوُّلٍ وحذرٍ شديدين قبل إبداء الحكم الشرعي فيها، سواءً من الوجهة الشرعية أو من الوجهة القانونية.

ومن ناحيةٍ أخرى فإن التجارب على البشر تختلف فيما بينها في مدى خطورة التجربة على الإنسان، ما بين تجاربٍ مميتةٍ تؤدي إلى هلاك الشخص الخاضع لها، وبين تجاربٍ تتسم بالخطورة، نظرًا لما تؤدي إليه من إصابة الشخص الخاضع لها بأضرارٍ جسدية.

والتجارب باعتبار خطورتها يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: التجارب المميتة: وهي تلك التجارب المؤدية حتمًا إلى هلاك الشخص الخاضع لها، أو غلبة الظن بهلاكه نتيجة إصابته بأمراض خطيرة، أي أننا لكي نكون أمام تجربةٍ مميتةٍ ينبغي توافر الشروط الآتية:

- ١- أن يكون الموت هو النتيجة الطبيعية في حال عدم نجاح التجربة.
- ٢- أن يؤدي إجراء التجربة إلى الإصابة بأمراضٍ تؤدي حتمًا للوفاة.
- ٣- أن يغلب على ظن القائم بالتجربة موت الخاضع لها.

وهذا النوع من التجارب في الغالب الأعم يتم دون علم من تُجرى

عليهم التجربة، بل وحتى دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إلحاق الضرر بهم، بل في الكثير الغالب تتم دون علم السلطات أو القائمين على حقوق الإنسان، حيث يؤدي عملهم إلى وقوع القائمين على التجربة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وعادةً ما يكون هؤلاء من المساجين وأسرى الحرب، أو الفقراء الذين يسهل إغراؤهم بالمال، نظرًا لضيق اليد وحاجتهم للأموال، حيث يجعلون أجسادهم محلًا للتجربة مقابل قدرٍ من المال، قد يكون من وجهة نظرهم كبيرًا، ومما يؤكد ذلك: الازدياد الملحوظ لتجارة الأعضاء في محيط الفقراء داخل الدول التي تسوء أحوالها الاقتصادية.

ومن أمثلة هذا النوع من التجارب:

- التجارب الحيوية: سواءً كانت فيروسية أو بكتيرية، إذ في هذه التجارب يتم حقن الشخص الخاضع للتجربة بفيروس معين يؤدي في الغالب إلى وفاته.
- التجارب الدوائية التي يكون الهدف منها معرفة التأثيرات الجانبية لدواء معين، سواءً من حيث النوع أو الكمية التي يجب إعطاؤها للمريض.
- التجارب التي تُجرى للوصول إلى معرفة الأضرار المحتملة والناجمة عن استخدام سلاح معين أو استخدام مواد خطيرة أثناء الحروب.

القسم الثاني: التجارب التي تؤدي إلى حدوث أضرارٍ بالخاضع لها: وهي

التجارب التي تُلحق أضراراً بمن تُجرى عليه، سواءً أكانت هذه الأضرار جسمية أم عقلية، وقد تكون معنوية.

والتاريخ الإنساني حافل بالعديد من التجارب التي اتسمت بالوحشية، والتي أدت إما إلى وفاة الخاضعين لها، أو إصابتهم بأضرارٍ بالغة الخطورة انتهت بوقاتهم، ومن هذه التجارب:

- ما قام به الطبيب الأمريكي "توسكيجي" والتي عُرفت في الوسط الأمريكي بتجارب توسكيجي، وذلك في عام ١٩٣٢م في ولاية "ألاباما الأمريكية" حيث أراد الأطباء اختبار أدوية جديدة أقل سُمِّية وأكثر فعاليةً لعلاج مرض الزهري، بعد ما ثبت فشل الزئبق في علاج هذا المرض الذي ينتقل بطريق الجنس، فبدأت تجارب هذا الطبيب بتمويلٍ من الحكومة الأمريكية، وقام الفريق الطبي بإجراء التجارب على قرابة ٣٩٩ مريض من المصابين بالزهري، كانوا كلهم من الزوج الفقراء، واستمرت التجارب مدة وصلت إلى أربعين عامًا، وعلى الرغم من ظهور علاجٍ فعالٍ لمرض الزهري، إلا أن الأطباء استمروا في تجاربهم، الأمر الذي أدى إلى قتل ثمانية وعشرين مريضًا منهم، ووفاة مائة آخرين نتيجة مضاعفات المرض، وإصابة قرابة الأربعين سيدة من زوجات المرضى، وولادة تسعة عشر طفلًا مصابًا بالزهري الحلقي^(١).

- وفي مواصلةٍ مستمرةٍ للتجارب الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية بتمويل تجارب جديدة حول مرض الزهري، والغريب في الأمر أن هذه التجارب تم اللجوء إليها بعد اكتشاف علاجٍ للمرض، أي أن التجارب آنذاك لم يكن هناك مبرر لإجرائها، ومع ذلك جرت التجارب في أمريكا الوسطى في ولاية "جواتيمالا" حيث تم إطلاق العاهرات المصابات

(١) يراجع موقع: <http://www.christian-dogma.com> على شبكة المعلومات.

بالمرض على المرضى العقليين والجنود في سجون "جواتيمالا" وتم نقل العدوى عنوةً إلى الحالات التي لم ينتقل إليها بالجنس، حتى وصل عدد المصابين إلى ألف وخمسمائة شخص، ترك ثلثهم تقريبًا بدون علاج، حتى يكشف الأطباء مضاعفات المرض عليهم، وانتهت تلك التجارب بوفاة عددٍ كبيرٍ من هؤلاء المرضى.

- وفي واقعة هي الأخطر من نوعها، وتحديدًا في عام ١٩٥٢م قامت الحكومة الأمريكية بإجراء تجارب على جزيرةٍ بأكملها، حيث أُجريت دراسةً طبيةً على سكان جزر مارشال، والذين تعرضوا للإشعاع إثر تجربة نووية أمريكية في "كاستيل برافو" القريبة منهم، وقامت الحكومة الأمريكية بمراقبة الضحايا في هدوءٍ دون إبلاغهم بتعرض جزيرتهم للخطر، وفي خلال عشر سنوات زادت حالات الإجهاض ووفيات الأجنة داخل الرحم، إضافةً إلى مشكلات النمو لدى الأطفال، وزيادة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وبحلول عام ١٩٧٤م أصيب ما يقرب من ثلث سكان الجزيرة بالأورام السرطانية^(١).

ونظرًا لخطورة التجارب التي تتم على البشر سواءً على الفرد أو على المجتمع، وبما أن الإنسان يمر بمرحلتين، مرحلة الحياة، ومرحلة الموت، ولكل مرحلةٍ منهما أحكامها الخاصة، قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

(١) يراجع موقع <http://www.akhbarak.net/news/> على شبكة المعلومات.

المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء.

المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأموات.

المطلب الثالث: حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات

الملقحة.

المطلب الأول

حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

يقصد بالأحياء هنا: الأشخاص الذين هم على قيد الحياة، سواء أكانوا من المرضى أم من الأصحاء، أي أنهم من المتطوعين لإجراء التجارب عليهم، وقد اختلف الرأي في مدى جواز إجراء التجارب على هؤلاء، على قولين:

القول الأول: يرى جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء^(١).

القول الثاني: يرى عدم جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء^(٢).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين:

١ - التعارض بين مصلحة البشرية في الوصول إلى علاج جديد لمرضى من الأمراض، أو تطوير علاج قائم، وبين الحق المقرر للإنسان على جسده،

(١) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، السابق،

ص ١٢٠، د. حمدي عبد الرحمن: معصومية الجسد، طبعة ١٩٨٧م، ص ٤٩، د. محمد

عيد الغريب: التجارب الطبية، السابق، ص ٢٥، د. محمد سامي الشوا: الحماية الجنائية

للحق في سلامة الجسم، ص ٤٩٠.

(٢) د. سهير منتصر: الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية - القاهرة، ص ٢١، د. محمود

نجيب حسني: الحق في سلامة الجسم، مجلة القانون والاقتصاد، السنة ٢٩، العدد ٣،

ص ٢١٧، د. محمود محمود مصطفى: مسؤولية الأطباء والجراحين، مجلة القانون

والاقتصاد، السنة ١٨، العدد الأول، ص ١١٥، د. رضا عبد الحليم: النظام القانوني

للإنجاب الصناعي، ص ٦٢٤.

وما له من حرمةٍ لا يجوز للغير ولا للشخص ذاته التعدي عليها.

٢- عدم وجود النص الصريح الذي يحسم المسألة، الأمر الذي كان سبباً في الخلاف، وإعمال قواعد المصالح والمفاسد، فمن رَجَّح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أجاز التجارب على الإنسان، ومن نظر إلى جانب الجسم البشري وحرمة الفرد، وأهمل جانب المجتمع، قال بعدم الجواز.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء بالكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾^(١).

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على جواز قتل النفس إذا كان ذلك القتل محققاً للمصلحة، والمصلحة التي أَرادها الخضر من قتل الغلام أشار إليها القرآن في قول الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾^(٢).

وهذه المصلحة مصلحة خاصة؛ لأنَّ نفعها مقتصر على الأبوين فقط، فمن باب أولى يجوز إذا كان محققاً لمصلحة عامة للمرضي، وبذلك تكون

(١) سورة الكهف: الآية ٧٤.

(٢) سورة الكهف: الآية ٨٠.

التجارب الطبية على الأحياء جائزة.

ونوقش الاستدلال بقتل الغلام على إجازة التجارب على الأحياء
بمناقشتين:

المنافشة الأولى: إن الخضر لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ لا علم له
بالمستقبل، وإنما فعل ذلك تنفيذاً لأمر الله، فقد جاء في الباب: "وما فعلته
عن أمري، أي: ما فعلته باختيارى ورأيت؛ بل فعلته بأمر الله وإلهامه بأن
الإقدام على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لا يجوز إلا بالوحي والنفي
القاطع" ^(١).

وقال ابن أبي حاتم: "كان عبداً مأموراً مضى لأمر الله" ^(٢).

المنافشة الثانية: إن الاستدلال بهذه الواقعة على جواز إجراء التجارب
الطبية على الأحياء استدلال لا يستقيم؛ لأن المصلحة التي ابتغاها الخضر
من وراء قتل الغلام مصلحة شرعية، إضافةً إلى كونها مؤكدة، بخلاف
المصلحة من إجراء التجارب الطبية، فهي مصلحة مظنونة، إضافةً إلى كونها
مصلحة غير مشروعة.

بقول ابن تيمية رحمه الله: "إن قصة الخضر ليس فيها مخالفةٌ للشريعة؛
بل الأمور التي فعلها إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر، ولهذا لما

(١) الباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي ابن عادل الدمشقي، تحقيق. عادل عبد الموجود،

علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ٥٤٩/١٢.

(٢) تفسير القرآن العظيم، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، تحقيق.

أسعد محمد الطيب، الطبعة الثالثة، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية ١٤١٩ هـ،

بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافق به حال..... وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائل، ولهذا قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما عَلِمَهُ الخضر من ذلك الغلام، فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم" ^(١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ^(٢).

وجه الدلالة من الآية:

أمر الله تبارك وتعالى بإحياء النفوس، وَمَدَحَ مَنْ كَانَ سَبِيًّا فِي ذَلِكَ، وإحياء النفوس يكون بإنقاذها من الهلاك، أو من الأسباب المؤدية إليه.

جاء في تفسير البحر المديد: "ومن أحياها، أي: تسبب في حياتها بعفو أو منع من القتل، أو استبقاء من بعض أسباب الهلكة" ^(٣).

ويتفق العقلاء على أن المرض أحد أسباب هلاك النفوس، والأدوية من الأمور التي تنقذ الحياة، ولا يتوصل إلى تلك الأدوية إلا بالتجارب، وبالتالي يكون إجراء التجارب على الإنسان من الأفعال التي امتدحها الله

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف - المدينة المنورة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، ٦٨/٤.

(٢) سورة المائدة: الآية ٣٢.

(٣) البحر المديد، لأحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية -

بيروت، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، ٢٣٧/٢.

عز وجل؛ لأنها تؤدي إلى إحياء النفوس^(١).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٢).

وجه الدلالة من الآية:

نهى الله عز وجل في الآية عن إلقاء النفس في مواطن الهلكة، فدل هذا النهى على استحباب التداوي من الأمراض، إذ إن كلمة التهلكة وردت عامة لم تخصص، مما يدل على شمولها لكل ما يؤدي إلى الهلاك، ومنه ترك التداوي، ولا شك أن في ترك التداوي هلاك للفرد والمجتمع، فإذا ترك المرضي بدون علاج أدى ذلك تضاعف الثروة البشرية والقضاء عليها، وهو مخالف لما جاء به الإسلام، وبما أن التجارب الطبية على الأحياء تسهم في التقليل من عدد المرضى، كان إجراؤها مشروعاً.

رابعاً: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ مرّ بقوم يلحقون النخل، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصاً، فمَرَّ بهم فقال: ما لنخلكم؟ فقالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم^(٣).

وجه الدلالة من الحديث:

دلّ الحديث على مشروعية التجارب، حيث إن النبي ﷺ رأى النخل على هيئة معينة، فاقترح أمراً ليتحسن به النخل ويثمر، فأشار على الصحابة بعدم التلقيح، فامثلوا لأمره، إلا أن النتائج جاءت على غير المتوقع، وعلى

(١) التجارب العلمية على جسم الإنسان، رسالة ماجستير، إعداد: ناريمان وفيق محمد أبو

مطر، الجامعة الإسلامية - غزة، كلية الشريعة والقانون، ٢٠١١م، ص ٩.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٥.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، برقم (٦٢٧٧) ٩٥/٧.

عكس ما أرادوا، فأوضح لهم النبي ﷺ أن هذا من الأمور التي تعتمد على الخبرة، فالحديث بذلك دليل على مشروعية التجارب وصولاً إلى النتائج الصحيحة^(١).

وبناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه خارج عن محل النزاع؛ حيث إن النزاع فيما يجري من تجارب على جسم الإنسان، والحديث وارد في التجارب على الثمار والنباتات، وهو أمر لم يقل أحدًا بمنعه، ولم يختلف أحد في مشروعيته.

خامساً: استدلووا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب التداوي، ومنها:

أ - ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"^(٢).

ب - ما رواه أسامه بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله ﷺ فقال: تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ"^(٣).

(١) التجارب العلمية على جسم الإنسان، الرسالة السابقة، ص ١٠.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، برقم (٣٨٧٤) ٧/٤ وهو مما سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود إما صحيح أو حسن، والطبراني في الكبير، برقم (٦٤٩) ٢٤/٢٥٤، والهيتمي في مجمع الزوائد، كتاب الطب، باب النهي عن التداوي بالحرام. ٨٦/٥ وقال: رجاله رجال الثقات.

(٣) أخرجه ابن حبان، كتاب الطب، باب ذكر الأمر بالتداوي، برقم (٦) ٤٢٦/١٣، وأبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، برقم (٣٨٥٥) ٤٣، والترمذي في سننه كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم (٢٠٣٨)، ٨٣/٤٠، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرک وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،

وجه الدلالة من الحديث:

تضمن هذا الحديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون الكلام على عمومه فيتناول سائر الأدوية والأدواء، إلا أَنَّهُ عَلَّقَ الشفاء على مصادفة الداء للدواء^(١).

والتجارب الطبية التي تتم على الأحياء أحد مقومات العلاج، ما لم تعتمد على محرم، إذ إن نتائجها تساهم في حد كبير في إيجاد العلاج الفعال والصحيح، لذا كان إجراؤها جائز ولا شيء فيه.

وفيه تصريح باشتراط حل الدواء؛ لأنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، حيث نهى النبي ﷺ في أحاديث كَثُرَ عن التداوي بالخمير والنجاسات، والأمر بالتداوي في الحديثين للوجوب، إذا لا صارف له عنه إلى غيره، فيكون إجراء التجارب على الأحياء وفقاً لذلك لا شيء فيه.

ويرى البعض أن قوله ﷺ " لكل داءٍ دواء " يحتمل معناه أمرين:

الأمر الأول: أن يكون على عمومه، فيتناول الأدوية القاتلة، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدويةً تُبرئُها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليها سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما عَلَّمَهُم الله.

ولهذا عَلَّقَ النبي ﷺ الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من

المخلوقات إلا له ضد، وكل داء له ضدٌ من الدواء يُعَالَجُ به، فعلق النبي ﷺ
البُرءَ بموافقة الداء للدواء.

الأمر الثاني: أن يكون من العام الذي أُريدَ به الخاص، لاسيما والداخل
في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كُلِّ لسان، ويكون
المراد أن الله عز وجل لم يجعل داءً يقبل الدواء إلا وَضَعَ له دواء، فلا
يدخل في ذلك الأدوية التي لا تقبل الدواء ^(١).

سادساً: ما روي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت عروة أصابه
هذا الداء - يعني الأكلة - فقطع رجله من الركبة ^(٢).

وجه الدلالة:

استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء بفعل عروة،
حيث إنه رضي الله عنه أُلْفَ عضوًا من أعضائه حفاظًا على باقي الأعضاء،
أي أن ذلك من باب إتلاف الجزء لاستبقاء الكل، والتجارب التي تجرى
على الإنسان الحي يتم فيها التضحية بعددٍ محدودٍ بهدف علاج باقي
المرضى ومن يصيبهم المرض مستقبلاً، فكان في ذلك إتلاف للبعض في
سبيل الحفاظ على الكل.

ونوقش الاستدلال بواقعة عروة بما يلي:

أولاً: إن هذه الواقعة خارجة عن محل النزاع؛ لأن قَطَعَ رجله كان
ضرورةً حتميةً يترتب على عدم فعلها تلف جسمه كليةً، وبالتالي كان قطعها

(١) زاد المعاد، لابن القيم، ١٣/٤.

(٢) المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد -

الرياض، ١٤٠٩هـ، ٤٥٣/٥.

واجب شرعاً، أما التجارب الطبية على الأحياء فليس فيها ضرورة محتمة؛ بل يمكن البحث عن بدائل أخرى في هذا الشأن.

ثانياً: على فرض التسليم بدخول واقعة عروة بن الزبير في المسألة، فإن عروة إنما فعل ذلك حفاظاً على نفسه هو، أما التجارب على الأحياء، فإنما تتم بهدف المحافظة على الغير من المرضى الآخرين، فكان الفارق بينهما كبير.

يقول الغزالي في المستصفى معقّباً على ذلك: "وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا قَطْعُ الْيَدِ لِلْأَكْلَةِ حِفْظًا لِلرُّوحِ فَإِنَّهُ تَنْقَدِحُ الرُّخْصَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَقَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ لِلْإِضْرَارِ بِشَخْصٍ فِي قَصْدِ صِلَاحِهِ كَالْفَضْدِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا قَطْعُ الْمُضْطَرِّ قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ الطَّعَامَ فَهُوَ كَقَطْعِ الْيَدِ. لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا ظَاهِرًا فِي الْهَلَاكِ فَيُمنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ يَقِينُ الْخَلَاصِ فَلَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً" (١).

سابعاً: إن التجارب الطبية على الأحياء تعتبر من الأمور الضرورية لتقدم العلوم الطبية، وبدونها يقف الطب عاجزاً عن إيجاد العلاجات الفعالة للكثير من الأمراض التي تهدد كيان البشرية، أو على الأقل يكون التقدم في العلاج بطيئاً، لذا كان ضرورياً القيام بها والسماح بإجرائها (٢).

ومما يدعم القول بالمشروعية أيضاً: أن هناك بعض الأمراض التي قد

(١) المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق. محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ١/١٧٦.

(٢) د. محمد عيد الغريب: التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي، السابق،

تصيب الإنسان ولا تصيب الحيوان، كما أن هناك أمراض تصيب الحيوان دون الإنسان، لاسيما وقد أثبت العلم الحديث مدى اختلاف تأثير الأدوية في الإنسان عنها في الحيوان^(١).

ولا يمكن القول بأن المخاطر التي تحيط بمسألة التجارب تؤدي إلى التقليل منها أو الحكم بعدم شرعيتها؛ لأن العمل الطبي طبيعته أن يتضمن مخاطر تهدد صحة من يُجرى عليه، إضافةً إلى أن العلم أثبت عدم دقة النتائج التي يحصل عليها نتيجة إجراء التجارب العلمية على الحيوانات بالنسبة للإنسان، وذلك مهما كانت درجة التشابه بين الحيوان والإنسان كبيرة؛ لأن فسيولوجية الإنسان تختلف عن الحيوان كثيرًا، وبالتالي لا يمكن معرفة انعكاسات العقاقير الطبية على الإنسان ومقاومتها لعوامل وأسباب المرض، لاسيما وأن تأثير الأدوية الحديثة نادرًا ما يكون واحدًا على الإنسان والحيوان^(٢).

ويناقش الدليل السابق بأننا نسلم لكم أن التجارب الطبية تحقق نفعًا للبشر، وتساهم في تقدم الطب، كما نسلم لكم أيضًا باختلاف التأثير الدوائي في الإنسان عنه في الحيوان، إضافةً إلى أن بعض الأمراض تقتصر على الحيوان دون الإنسان والعكس، إلا أننا لا نسلم لكم القول بمشروعية إجرائها على الإنسان الحي دون أن يكون في حاجة لذلك، فالقول بالمنع إنما يكون لعدم حاجة الخاضع للتجربة، وبالتالي يمكن تجربة الدواء على

(١) د. منذر الفضل: التجربة الطبية على الجسم البشري، بحث منشور مجلة الكوفة، العدد

٧، لسنة ٢٠١٣ ص ٩٤.

(٢) د. عبد الوهاب حومد: دراسات متعمقة في القانون الجنائي المقارن، ص ٢٩٢.

مرضى هم في حاجة للعلاج^(١).

ثامناً: إن الأصل العام المقرر في الشريعة الإسلامية أن التحريم يمتد إلى الكافة، فكما أنه لا يجوز للطبيب إجراء التجارب على الإنسان، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يتبرع بجسده لإجراء التجارب عليه، إلا أن الشارع خرج عن هذا الأصل، وأورد عليه بعض الاستثناءات، حالة توافر ظروف استثنائية معينة، أو كان هذا الاستثناء تقتضيه مصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد.

وهذه المصلحة أجازت إتيان بعض الأفعال المحرمة على الكافة، وإذا كان الفعل المحرم قد أُبِيحَ لتحقيق مصلحة معينة، فقد وجب منطقياً ألا يُؤْتَى الفعل المحرم إلا لتحقيق المصلحة التي أُبِيحَ من أجلها، فإن تَمَّ الإتيان بالفعل المحرم لغرض آخر اعتبر جريمة، ووجبت مساءلة الفاعل، فالطبيب الذي يجرح مريضاً بقصد علاجه يؤدي واجباً كُلِّفَ به، وبالتالي فما قام به يعد عملاً مباحاً، أما إذا كان الجرح بقصد القتل، ففعله جريمة تستوجب العقاب.

وبالتالي فالتجارب الطبية وإن كانت ممنوعة من حيث الأصل، لمساسها بجسد الإنسان، إلا أن هذا التحريم ارتفع لوجود الضرورة الطبية المجتمعية التي تقتضي ذلك.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على قولهم بتحريم التجارب الطبية على

(١) نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الإسلامية والقانون

الوضعي، د. شعلان سليمان محمد، الرسالة السابقة، ص ١١٢.

الأحياء بالأدلة الآتية:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(١).

وجه الدلالة من الآية:

نهى الله تبارك وتعالى صراحةً الإنسان أن يقدم على قتل نفسه؛ لأنه لم يباح للإنسان إتلاف نفسه أو شيءٍ منها، وقد جاء النهي عامًّا من غير تحديد لوسيلة القتل، لذا فإنه يَعُمُّ كل وسيلةٍ من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق النتيجة المنهي عنها، وهي قتل النفس، ومع أن مورد الآية في النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاً، إلا أنه أدخل فيها قتل الإنسان نفسه لِعَظَمِ خطره وشديد إثمهِ^(٢)، والآية وإن كانت دالةً على تحريم إزهاق الإنسان نفسه، فمن باب أولى تدل على حرمة إزهاق نفس الغير، وإخضاع الشخص نفسه للتجارب الطبية يعتبر من وسائل قتل النفس، فكان محرماً شرعاً.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٣).

وجه الدلالة من الآية:

مَنَّ الله تبارك وتعالى على الإنسان بتكريمه، والتكريم - كما قال المفسرون - يتمثل في أمور كثيرة، منها: خَلْقُهُ على صورةٍ حسنة، وهيئةٍ

(١) سورة النساء: من الآية ٢٩.

(٢) تفسير ابن عاشور المعروف بالتحريم والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، الطبعة الأولى مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، ٩٣/١، تفسير ابن أبي حاتم، ١٢٠/٤.

(٣) سورة الإسراء: الآية ٧٠.

كاملة^(١) ومن مقتضيات التكريم صيانة كله أو بعضه عن العبث، والتجارب الطبية تؤدي لا محالة إلى العبث بجسمه كله أو بعضه، لأنها إما أن تؤدي إلى موتٍ محققٍ، أو تؤدي إلى أضرارٍ تلحق بالشخص، وكلاهما ينافي الكرامة التي منحها الله إياها، لذا كان إجراء التجارب في هذه الحالة محرم شرعاً.

ثالثاً: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً^(٢).

وجه الدلالة:

يِنَّ النبي ﷺ عَظَّمَ عقوبة من قتل نفسه، لاجترائه على أحكام الله عز وجل، وجعل الجزاء من جنس العمل، على اختلاف بين شراح الحديث في المراد بالخلود، حيث إن منهم من قال هو الخلود الأبدي، ومنهم من قال هو المكث الطويل^(٣).

والتجارب الطبية منها ما هو خطيرٌ مميتٌ يؤدي بحياة الإنسان، لذا كان

(١) تفسير الرازي، المعروف بالتفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٢٠ هـ، ٢٠٥/٢.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، برقم (٥٧٧٨) ٤٣٩/١٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (٣١٣) ٧٢/١.

(٣) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ٤٣٨/١٠، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢٥/٢.

الإقدام عليها غير جائز، لدخوله في تعمد الإنسان قتل نفسه، ولو تبرع شخص لإجراء تجارب عليه، فليس للطبيب الحق في إجرائها؛ لأن تصرف الإنسان في جسده بما يؤدي إلى هلاكه يخرج عن نطاق التصرفات الجائزة له، لذا كان إجراء التجارب على الجسم البشري الحي محرم شرعاً.

رابعاً: استدلووا من المعقول بما يلي:

١- إن الإنسان لا يملك الحق في التصرف في جسده، وبالتالي لا يُقْبَلُ تطوعه بإجراء التجارب عليه؛ لأن جسده أمانة يسأله الله عنها يوم القيامة، فقد روى عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ^(١)، وفي رواية "وعن جسده فيما أبلاه" ^(٢) لذا لا يجوز للإنسان التصرف في جسده إلا بمقتضى التصرفات التي توافق مقتضى الشرع، وليس من التصرفات التي أباحها الشرع التبرع بالجسد لإجراء التجارب عليه، لذا كان إقدام الإنسان على هذا العمل لا يجوز.

ومما يؤكد ذلك: أن الفقهاء رتبوا الإثم والعقوبة على من يتلف عضوًا من أعضائه، ما قاله العز بن عبد السلام: "وَكَذَلِكَ جِنَايَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى

(١) المعجم الكبير، للطبراني، الطبعة الثانية، مكتبة العلوم والحكم - الموصل، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م، ٨/١٠، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي - بيروت، ١٤٠٧هـ، ١/١٤٤، شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٠هـ، ٣٠١/٥، مصنف ابن أبي شيبة، ١٨٥/٨.

(٢) المعجم الكبير، للطبراني، ٨/١٠.

أَعْضَاءُ نَفْسِهِ يَتَفَاوَتْ إِنْثَمَها بِتَفَاوُتِ مَنَافِعِ مَا جَنَى عَلَيْهِ، وَبِتَفَاوُتِ مَا فَوَّتَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ عَدْلِهِ وَإِقْصَاطِهِ وَبِرِّهِ وَإِنْصَافِهِ وَنُصْرَتِهِ لِلدِّينِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْلَفَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَلَيْسَ قَطْعُ الْعَالَمِ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُفْتِي أَوْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِسَانَ نَفْسِهِ كَقَطْعِ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِلِسَانِهِ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْبَطْلِ الشَّدِيدِ النِّكَايَةِ فِي الْجِهَادِ يَدَ نَفْسِهِ أَوْ رِجْلَ نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ قَطْعِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْجِهَادِ يَدَ نَفْسِهِ" (١).

٢- عدم وجود الضرورة في إخضاع إنسان سليم أو مريض لتجربة علمية لا تعود عليه بالفائدة؛ لأن مشروعية التجارب مرتبطة بالفائدة التي من الممكن أن تعود على الشخص الخاضع لها، ولا تكون للتجربة هذه الميزة إلا إذا تعلق بالبحث عن دواء أو طرق علاجية لمرضٍ أَخَفَقَتْ الوسائل الموجودة في علاجه، ومن ثم يجب أن يكون هناك مرضى مصابين بمرضٍ معينٍ لتجربة العلاج عليهم بسبب حاجتهم إليه، وبعد ذلك يمكن استخلاص النتائج المترتبة على استخدامه عليهم بدلاً من تجربته على إنسان سليم البدن، وعلة ذلك: أنه ليس هناك ضرورة للقيام بالتجربة على الإنسان إذا لم تُرَجَّ منها فائدة مباشرة له، أو كانت غير مأمونة العواقب (٢).

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، ١٣٠/١، ١٣١.

(٢) د. شعلان سليمان محمد السيد: نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراة - كلية الحقوق، جامعة المنصورة ٢٠٠٢م، ص ٦١٩.

القول الراجح:

بعد عرض قولي الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته منها،
يترجح عندي - والله أعلم - قول من قال بجواز إجراء التجارب الطبية على
الأحياء وفق ضوابط محددة، وذلك لما يلي:

أولاً: التجارب الطبية على الأحياء تؤدي إلى تحقيق مقصدٍ من مقاصد
الشريعة، وهو حفظ النفس، وحفظ النفس لا يتم إلا بالتداوي من الأمراض
عن طريق العلاجات النافعة المفيدة، وهو ما لا يتم إلا بإجراء التجارب.

يقول الغزالي: "مقصود الشرع من الخلق خمس، وهو أن يحفظ عليهم
دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يفوت هذه الأصول فهذه
مفسدة، وكل ما يحقق هذه الأصول فهذه مصلحة" ^(١).

ثانياً: إن التجارب الطبية على الأحياء إذا تمت وفق الضوابط التي
سنذكرها لاحقاً، فليس فيها أدنى اعتداء على حرمة الجسم البشري، لما
تؤدي إليه تلك الضوابط من التأمين الكامل لهذه العملية، وإزالة ما قد
يشوبها من عوائق، سواء تعلقت بالخاضع للتجربة، أو بالقائم بها، أو
بالمجتمع ككل.

الموقف القانوني من إجراء التجارب العلاجية على الأحياء:

يتفق الفقه والقضاء الغربيين على القول بمشروعية التجارب العلاجية
التي تتم على الإنسان، ويررون ذلك بما يلي:

١ - إن الغرض الرئيس من ممارسة الأعمال الطبية هو تحقيق الشفاء،

(١) المستصفى، ١/١٧٤.

والحكم يرتبط به على الدوام، فما دامت تلك التجارب تؤدي إلى تحقيق الشفاء كانت مشروعة، لتحقيقها مصلحة أكيدة للمرضى، غاية الأمر أن تؤدي هذه التجربة مُرادها والغرض المرجو منها، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كانت نتائجها مضمونة، أما إذا كانت نتائجها غير مؤكدة فإن ضررها يكون أكثر من نفعها مما يُرتَّبُ ضرراً محققاً للمريض الذي تجرى عليه.

٢- إن التجارب العلاجية على الإنسان في العصر الحاضر باتت ضرورة لا مناص منها، حتى ولو كانت الأصول العلمية تحتم ضرورة إجراء التجربة على الحيوان، إلا أنه لا بد من إجرائها على الإنسان في مرحلة من المراحل بسبب محدودية التجارب على الحيوان، والسبب في ذلك ان الاختلافات الفيزيولوجية بين الإنسان والحيوان توجب التجريب على الإنسان لمعرفة الأثر الفعلي للأدوية على جسمه، ومدى صلاحيتها للعلاج، وهذه الحقيقة العلمية دفعت البعض إلى القول بأن التجارب الطبية على الإنسان ليست فقط مشروعة أخلاقياً؛ وإنما مطلوبة^(١).

٣- عدم تعارض التجارب الطبية مع القواعد القانونية العامة التي تنظم الأعمال الطبية، حيث إن هناك اتفاق في الغرض الذي ترمي إليه القواعد القانونية والتجارب الطبية، فالطبيب يهدف إلى علاج المريض الخاضع للتجربة من خلال سعيه إلى تجربة الأدوية الجديدة التي يريد ملاحظة وتسجيل نتائجها، وكذلك ملاحظة آثارها الجانبية، والنظر في إمكانية تطبيق هذه العلاجات على المرضى الذين تماثل حالاتهم حالة المريض الخاضع للتجربة، ولا شك أن هذه أهداف نبيلة تحقق نفعاً عاماً لبني الإنسان، دون

(١) د. مأمون عبد الكريم: رضاء المريض عن الأعمال الطبية، السابق، ص ٦٩٩.

ما نظر إلى دينه ومعتقده.

وتعتبر فكرة العدالة من الأفكار التي أُسست عليها مشروعية التجارب الطبية لدى القانونيين، إلا أن التسليم بها لم يكن محل اتفاق:

فبعض الفقه يستند على هذه الفكرة، مقررًا أن من حق كل إنسان حي أن يتمتع ويستفيد من تجارب من سبقوه، ومن جملتها حقه في الاستفادة من التجارب الطبية التي تم إجراؤها في الماضي، ولعل مضمون تلك الحرية وفحوى هذه العدالة وتطبيقها على هذا النحو يخفف الكثير من الآلام التي يعاني منها بعض البشر، لاسيما في ظل انتشار الأمراض والأوبئة التي عمت البلاد والعباد.

ويرى البعض الآخر مؤيدًا الاستناد إلى فكرة العدالة أن منافع هذه التجارب لن تقتصر على فئة معينة من الناس، أو دولة من الدول؛ بل إن نفعها يمتد ليشمل الإنسانية ككل.

ويقرر البعض الآخر^(١) أنه ليس هناك إجماع بين الفقه بخصوص اعتبار فكرة العدالة أساسًا لمشروعية التجارب الطبية؛ حيث رفضها البعض بناءً على أن مشاركة الأطباء والمرضى في التجارب الطبية السابقة تمت بإرادتهم الحرة، وفي إطار أعمال التبرع أو الأعمال الخيرية.

واعتمد الاتجاه المؤيد لمشروعية التجارب الطبية على فكرة المصلحة، حيث تستهدف التجارب تحقيق مصلحة عامة تتمثل في الرغبة في إيجاد وسائل علاج جديدة يتم بموجبها التغلب على الأمراض المستعصية، ولا

(١) د. مأمون عبد الكريم: رضاء المريض عن الأعمال الطبية، السابق، ص ٧٠٢.

يُغَيَّرُ من مشروعية التجارب فشلها وعدم نجاحها في بعض الأحوال ما دام أنه تم إجراؤها وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليه.

ويرتبط هذا المبدأ بفكرة الحق في سلامة الجسم، فإذا كان الحق في سلامة الجسم يبيح للشخص حرية التصرف في جسده إلا أن ذلك مشروط بعدم التعارض مع مصلحة المجتمع؛ لأن مبدأ معصومية الجسد يرد عليه حقين: حق خاص للفرد في أن يُصَانَ جسده عن أي إيذاء، وحق عام للمجتمع في جواز المساس به متى تطلبت المصلحة العامة ذلك.

وبناءً على ذلك فإجراء التجارب الطبية بهدف كشف السبل الحديثة لعلاج الأمراض المستعصية عن طريق استجلاء الآثار المباشرة للعلاج المستحدث الذي سبق أن تمت تجربته على الحيوانات من خلال تجربته على الإنسان السليم خشية أن ينوء به الإنسان المريض، ولا يمثل ذلك اعتداءً على حق الفرد في صيانة جسده متى عُبِّرَ عن رضاه بذلك، وطالما لا يترتب عليه اعتداء جسيم يعيقه عن أداء وظيفته الاجتماعية، لاسيما وأن إباحة مثل هذه التجارب من شأنه تحقيق الدفاع الاجتماعي في أبرز مظاهره ليس ضد الجريمة فحسب؛ وإنما ضد المرض كذلك^(١).

وذهب البعض إلى تأسيس مشروعية التجارب الطبية على فكرة السبب، فما دام السبب مشروعاً كان الفعل مباحاً، أي أن الهدف من التجارب الطبية ما دام يحقق مصلحةً عليا للمجتمع، وكانت هذه المصلحة من المصالح التي يقرها القانون ولا تتعارض مع النظام العام، وكانت مصحوبة برضاء الشخص الخاضع للتجربة، وبرجحان المنافع المتوقعة منها على الأضرار

(١) د. محمد سامي الشوا: السابق، ص ٤٩٧..

المحتملة لها.

ويرى بعض الفقه الفرنسي حظر إجراء التجارب على الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام دون غيرهم، إذ قالوا: إن العدالة والإنسانية تنافيان أن يجازف الإنسان بمثل هذه التجارب على أناس أحرار، ولكنهما لا تأبيان أن يجري ذلك على مجرمٍ محكوم عليه بالإعدام^(١).

وقد أيدَ قلةً من الفقه المصري هذا الاتجاه، مستندين إلى إقرار الدستور المصري له، حيث نصت المادة ٤٣ من الدستور المصري على أنه: "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير رضائه الحر".

فأساس مشروعية التجارب في نظر هؤلاء هو رضاء الخاضع للتجربة، وهو الأمر الذي اشترطه الدستور المصري، وأضاف البعض إلى ذلك ضرورة أن يتأكد الطبيب من أن نسبة نجاح التجربة يفوق نسبة فشلها، وأن يكون الهدف من إجراء التجربة تحقيق تقدم علمي في المجال الطبي^(٢).

(١) د. فائق الجوهري: المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق -

جامع فؤاد الأول، دار الجوهري للطبع والنشر ١٩٥١م، ص ٣٠٩.

(٢) د. محمود أحمد طه: الأساليب الطبية المعاصرة وانعكاساتها على المسؤولية المدنية

للطبيب وتحديد لحظة الوفاة، دار الفكر والقانون - المنصورة، مصر ٢٠١٥م، ص

المطلب الثاني

حكم إجراء التجارب الطبية على الأموات

تبرز الفلسفة الإسلامية في أبهى صورها في التعامل مع الإنسان، سواءً في حياته أو بعد مماته، فاهتمام الإسلام بالإنسان في الحالتين أمرٌ لا ينكره عاقل، مع ملاحظة ما يملكه الإنسان الحي من قدرةٍ يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداءٍ قد يُوجَّهُ إليه.

وقد كان اهتمام الإسلام بالميت ذو طبيعةٍ خاصة؛ حيث إن الميت منعدم الإرادة، ولا قوة له يستطيع من خلالها القبول أو الرفض، أو بمعنى أوضح ليست لديه المقدرة على دفع الاعتداء الذي قد يُمارَسُ ضده، فهو جثةٌ هامدةٌ لا حراك فيها، لذا اعتبر الإسلام حالة الموت بالنسبة للميت نوعاً من الضعف، وَشَرَعَ له من الأحكام ما يتناسب معها، ومن هذه الأحكام:

أ - أمر الإسلام بتكريم الميت عن طريق تجهيزه ودفنه، وَمَسَّ الطيب جسده، حيث روى ابن عباس قال: بينما رجل واقفٌ بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأوقصته، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة ملبياً^(١) وعند تجهيز الميت أمر الإسلام القائمين على التجهيز بالرفق واللين، وعدم استعمال العنف والقسوة، حيث إن الميت لديه من الشعور ما يجعله يتأذى.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥)، ١٩٤/٣،
والحديث أورده البخاري في مواضع كثيرة، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم
إذا مات، برقم (٢٩٤٨)، ٢٣/٤.

ب - نهى الإسلام عن إيذاء الميت بأي وجه من وجوه الإيذاء، وقاسه على الحي بجامع الشعور في كُلِّ منهما، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: " كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا " ^(١).

وعلى الصعيد القانوني، فإن كافة المواثيق والاتفاقات الدولية أولت الميت حمايةً كاملة، واعتبرت حرمة الجسد أحد الركائز الأساسية التي لا يجوز من حيث الأصل المساس بها، ومن هذه المواثيق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨م، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس البشري الصادرة في ديسمبر ١٩٤٨م، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦م، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع هذا التكريم الذي أولاه الإسلام للميت، برزت على ساحة الواقع مسائل طبية عديدة تمس أجساد الموتى، مما ثار بشأنها جدلاً واسعاً، ومن تلك المسائل "مسألة التجارب الطبية على أجساد الموتى"، خاصةً بعد أن صار الاتجاه الغالب يميل إلى حَظَرِهَا على الأحياء، لما يترتب عليها من أضرارٍ قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت.

تاريخ التجارب الطبية على الأموات:

يعتبر إجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى من الأمور القديمة، وليست حديثة كما يعتقد البعض، وهي وإن ظهرت منذ القِدَم إلا أن

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في القابر يجد العظم، برقم (٣٢٠٩)، ٣/٢٠٤، وقال

الألباني: صحيح، مصنف عبد الرزاق، ٣/٤٤٤، السنن الكبرى، للبيهقي، ٤/٥٨.

أغراضها كانت تختلف من واقعةٍ لأخرى، ومن أبرز الوقائع التي ظهرت قديماً ما يلي:

١- **تحنيط الموتى:** ويقصد به حفظ جثث الموتى من التلف، حيث أراد المصريون القدماء الاحتفاظ بجثث الموتى حتى لا تبلى، إحياءً لذكراهم، فلجأوا إلى عملية التحنيط في أول الأمر من باب التجربة، فكانوا يزيلون أمعاء الموتى حتى لا يصيبها التعفن، مضيفين مواد أخرى تمنع الجثث من التلف^(١).

٢- **تشریح جثث الموتى:** مصطلح التشریح عبارة عن ترجمة حرفية للفظ اليوناني، والذي يعني في الأصل: تقطيع الشيء إلى أجزاء، وكان التشریح في بادئ الأمر يعني تشریح الجثث، ثم وضع بعد ذلك علماً على العلم الخاص بالتشریح، وهذا العلم يبحث عن الأجزاء التي تتألف منها الأجسام باعتبار بنائها ووضعها^(٢).

وقد قام الكثير من الأطباء قديماً - مسلمين وغير مسلمين - بتشریح جثث الموتى على سبيل التجربة، واشتهر منهم أبقرط، وجالينوس، ويعتبر المؤرخون أن "جالينوس" هو رائد علم التشریح، حيث لم يسبقه أحد إلى التأليف فيه.

يقول ابن جليجل: "وكان جالينوس هذا عالماً بطريق البرهان، خطيباً، وله كتاب ناقض فيه الشعراء وكتاب العامة، ولم يسبقه أحد إلى علم التشریح، فألف فيه سبع عشرة مقالة في تشریح الموتى، وألف في تشریح

(١) يراجع: د. حسن فرج زين الدين: التحنيط، دار الفكر العربي - القاهرة، ص ٣.

(٢) د. يوحنا ورتبات: التوضيح في أصول التشریح، بيروت ١٨٧١م، ص ٢.

الأحياء كتابًا، وشرح كتب أبقراط كلها وبسطها " (١).

وهناك ادِّعاءٌ أطلقه الغرب مفاده أن المسلمين لم يعرفوا التشريح ولم يمارسوه من حيث الأصل، وذلك للاحترام الذي يفرضه الإسلام لأجساد الموتى، إلا أن هذا الادِّعاءً مخالفٌ تمامًا للحقيقة الثابتة عبر التاريخ، فالأطباء المسلمون عرفوا التشريح ومارسوه على مستوى الإنسان والحيوان، ومارسوه كذلك بقصد التعليم، ومما يؤكد ذلك مقولة ابن رشد الخالدة " من اشتغل بالتشريح ازداد إيماناً بالله " (٢).

ويؤكد المؤرخون قديماً أن مصر كانت تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث يذكر صاحب كتاب التوضيح في أصول التشريح أن مدرسة الإسكندرية التي أنشأها بطليموس تعتبر أول مدارس العالم في ذلك الوقت التي كان يُدرَّس فيها علم التشريح، حيث كان يُدعى إليها المعلمون من كل مكان، وكانت الحكومة تدفع لهم بجثث المقتولين لسبب جرائمهم لأجل التشريح، ومن بين الذين اشتهروا في هذا الفن آنذاك "ابراسيسترموس" و "هيروفيلوس" حيث أظهروا أشياء كثيرة من مكونات هذا العلم، ووضع كثيراً من أولياته (٣).

الحكم الشرعي لإجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى:

لم يكن حكم التجارب على الموتى بمنأى عن الخلاف بين العلماء،

(١) طبقات الأطباء والحكماء، لأبي داود سليمان بن حسان، المعروف بابن جليجل، طبعة

المعهد العلمي الفرنسي، ١٩٥٥م، ص ٤٢.

(٢) د. محمد علي البار، د. زهير أحمد السباعي: الطبيب أدبه وفقهه، الطبعة الثانية، دار القلم

دمشق، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ص ١٦٢.

(٣) التوضيح في أصول التشريح، السابق، ص ٣.

أسوةً بحكم التجارب على الأحياء، بل إنه أولى منه؛ إذ للحي إرادة وقدرة يتمكن من خلالها التعبير عن إرادته، بخلاف الميت فلا قوة له ولا إرادة يتمكن من خلالها التعبير عن إرادته قبولاً أو رفضاً، لذا كان الاحتياط في تلك المسألة المتعلقة به أولى وأكد.

تحرير محل النزاع:

١- لا خلاف بين العلماء في جواز الأعمال الطبية التي تُجرى على أجساد الموتى إذا كانت تهدف إلى إثبات حق، أو نفي تهمة عن شخص معين، سواء كان حقاً لله أو حقاً للعبد، ومن ذلك: القيام بتشريح جثة الميت حالة الاشتباه في موته بسبب جنائية، حيث إن معرفة الحقيقة ترتب حقوقاً لذويه، وكذلك ترتب حقاً للمجتمع، وهو ما يسمى بالتشريح الجنائي.

٢- لا خلاف أيضاً في جواز التصرفات التي يُقصدُ منها دفع وباءٍ عن المجتمع، كما لو تمَّ الاشتباه في موت شخصٍ بمرضٍ من الأمراض الوبائية، ولا يتم إظهار الحقيقة إلا بإجراء تجربةٍ على جسد الميت لمعرفة نوع المرض ومدى خطورته، ففي هذه الحالة لا مانع من إجرائها، حفاظاً على المجتمع من انتشار هذا الوباء، حيث يقوم الطبيب بتبليغ ذوي الشأن ومن يعينهم الأمر، لاتخاذ ما يلزم للحد من انتشار هذا الوباء.

٣- مع اتفاق العلماء على جواز ما تقدم، إلا أن الخلاف وقع في التجارب الطبية التي تُجرى على الموتى بقصد التعليم، أو بقصد تحقيق نتائج، أو اكتشافات طبية يستفيد منها في علاج المرضى، وقد وقع الخلاف في مشروعيتها على قولين:

القول الأول: يرى أنصاره عدم جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى، وهذا القول هو ما ذهب إليه الحنابلة تخريجاً على قولهم في حكم

شق بطن المرأة لإخراج جنينها الحي، حيث قرر الحنابلة أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حي، فلا يجوز شق بطنها لإخراجه.

يقول ابن قدامة: "والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل" ^(١).

ومن المعاصرين الذين قالوا بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى: الشيخ. محمد بخيت المطيعي، والشيخ. محمد برهان الدين السنهلي ^(٢).

القول الثاني: يرى أنصاره جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى.

ويمكن نسبة هذا القول إلى الحنفية ^(٣) والشافعية ^(٤) والظاهرية ^(٥) بناءً على قولهم في حكم شق بطن الأم لإخراج الجنين الحي.

(١) المغني، لابن قدامة المقدسي، طبعة مكتبة القاهرة، ٤١٠/٢.

(٢) محمد بن المختار الشنقيطي: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الطبعة الثانية، مكتبة الصحابة - الإمارات، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ص ١٧٠، الشيخ. محمد برهان الدين السنهلي: قضايا فقهية معاصرة، الطبعة الأولى، مكتبة دار العلوم - بيروت، ١٩٨٨م، ص ٢٦٧.

(٣) قال ابن عابدين: "حامل ماتت وولدها حي يضطرب، يشق بطنها من الأيسر، ويخرج ولدها" رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ٢٣٨/٢.

(٤) قال النووي: " وإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها" المجموع شرح المذهب، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكر - بيروت، ٣٠١/٥.

(٥) قال ابن حزم: " ولو ماتت امرأة حامل، والولد حي يتحرك، قد تجاوز ستة أشهر، فإنه يشق بطنها طوالاً ويخرج الولد ". المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، طبعة دار الفكر - بيروت، ٣٩٥/٣.

وهذا القول هو ما ذهب إليه عامة المعاصرين، سواءً على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، فقال به من الأفراد الشيخ. حسنين مخلوف، والشيخ. إبراهيم اليعقوبي، والدكتور. محمد سعيد رمضان البوطي، وغيرهم، ومن الهيئات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ولجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية^(١).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في مسألة إجراء التجارب على الأموات إلى التعارض بين حق الميت في التكریم المقرر له من قِبَلِ الله عز وجل، وحق المجتمع في الحصول على المنفعة المتحصلة من التجربة، فمن نَظَرَ إلى تکریم الميت، مَنَعَ إجراء التجارب عليه، لما فيه من اعتداءٍ على الجثة، ومن نظر إلى حق المجتمع في الحصول على المنافع التي تنتج عن التجربة، أجاز إجراء التجارب على الموتى.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم جواز إجراء التجارب على الموتى بالأدلة الآتية:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٢).

(١) أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، السابق، ص ١٧٠، د. محمد علي البار، د. زهير

السباعي: الطبيب أدبه وفقهه، السابق، ص ١٦٥.

(٢) سورة الإسراء: الآية ٧٠.

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على تكريم الله للإنسان، وَخَلَقَهُ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْئَاتِ وَأَكْمَلَهَا، وهذا التكريم يقتضي تحريم إهانته، وفي إجراء التجارب على الموتى إهانة للإنسان بعد موته.

ويناقش هذا الاستدلال: بأن إجراء التجارب على الموتى لا يتنافى مع التكريم الذي أقره الإسلام للإنسان، لأن التصرفات التي تدل على عدم التكريم هي تلك التي يكون القصد منها التشفي والعبث بأجساد الموتى دون مصلحة مبتغاة، أما التجارب الطبية فإن هناك مصلحة لمجموع الناس من ورائها، فمن خلال نتائجها يتمكن الأطباء من علاج الكثير من المرضى ممن لا يُجدي معهم العلاج بالطرق القائمة، وبالتالي يمكن اعتبار هذا العمل من باب التعاون على البر والتقوى.

ثانياً: ما روي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا..... " (١).

وجه الدلالة من الحديث:

نهى النبي ﷺ في الحديث عن المثلة، والمثلة في اللغة هي: العقوبة والتنكيل، وتجمع على مثلات (٢)، وفي الاصطلاح: عرفها الزركشي بأنها

(١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآذَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا، برقم (١٧٣١)، ٣/١٣٥٧.

(٢) القاموس المحيط، ١/١٣٦٥، مختار الصحاح، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي،

تشويه خلقة القتل^(١)، ومن صور المثلة: تسميل عين، أو فقئها، أو بقر بطن، أو قطع عضو.

والتجارب الطبية التي تتم على الموتى يتم فيها ذلك، فكانت ممنوعة شرعاً لدخولها في نهى النبي ﷺ عن المثلة، أضف إلى ذلك: أن نهى النبي ﷺ إنما جاء في الحديث عن التمثيل بجثث الأعداء، وهم غير مسلمين، فكان التمثيل بجثة المسلم منهياً عنه من باب أولى، أيضاً فإن النهي ورد عن التمثيل بالجثث حالة الحرب، وبالتالي فالنهي عن التمثيل بالميت في حالة السلم أولى وأكد.

ويناقش الاستدلال بالحديث السابق بما يلي:

أولاً: لا نسلم أن في إجراء التجارب تمثيلاً بجثة الميت؛ لأن التمثيل هو ذلك الفعل الذي يكون غرضه غير مشروع، أو غير إنساني، كالتشفي والانتقام، وهو ما لا يوجد في التجارب التي يمكن أن تُجرى على الجثة.

ثانياً: إن التحارب الطبية على الميت وإن حدث فيها تسميل عين، أو فقئها، أو قطع عضو، أو نزع جلد وما إلى ذلك، فلا يمكن أن يطلق على ذلك أنه تمثيل بالجثة؛ لانتفاء الغرض من ناحية، ولوجود المبرر الداعي إلى ذلك من ناحية أخرى.

ثالثاً: على فرض التسليم أن التجارب تعتبر من باب التمثيل، فإن الأدلة

تحقيق. يوسف الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ١/١٤٢.

(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقى، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق. عبد المنعم

خليل، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ٩/١١٩.

التي تنهي عن التمثيل لا تشملها؛ إذ الأدلة عامةٌ وَرَدَ ما يخصها، فلكل واقعةٍ سبب، فالتمثيل بالعريين - مثلاً - إنما كان زجراً لغيرهم ممن قد تُسَوَّلُ لهم أنفسهم فعل ذلك، وكذلك ما يفعل بالمحاربين، وبالتالي فالنهي لا يشمل التجارب التي تتم على أجساد الموتى.

رابعاً: ما روي عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا" ^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

أثبت الحديث حرمة جسد الإنسان بعد الموت كاحترامه حال الحياة، والحديث دليلٌ صريح على بيان المثلية في الإثم المترتب على الاعتداء على كُلِّ منهما ^(٢) والتجارب الطبية قد تشتمل على كسر لعظم الميت، وكذلك تقطيع له، وبالتالي فكما لا يجوز إجراؤها على الأحياء، فكذلك لا يجوز على الموتى، للإثم الوارد في كُلِّ منهما، وَلَمَّا يتضمنه من إيذاء وهتكٍ لحرمتهم.

وبناقش هذا الاستدلال:

بأننا نسلم لكم أن للميت حرمة كحرمة الحي، فلا يُعْتَدَى عليه بكسرٍ أو شق، وأن حرمة باقية بعد موته، إلا أننا لا نسلم لكم الأخذ بعموم النص، فالاعتداء على الميت غير جائزٍ شرعاً، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) التيسير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية

- الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ٤٠٤/٢، سبل السلام شرح

بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث - القاهرة، ١٢٤/٣.

المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت؛ لأن قواعد الدين الحنيف مبنية على رعاية المصالح الراجعة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر^(١).

خامساً: إن الشريعة الإسلامية بالغت في احترام الموتى، حيث قررت حمايتهم من الإيذاء المعنوي، فنهت عن سب الأموات، وأمرت بذكر محاسنهم ومزاياهم، وتزك مسأوئهم وعيوبهم، فقال النبي ﷺ: "لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا"^(٢)، وقال أيضاً: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ"^(٣)، وإذا كان الإسلام نهى عن إيذاء الميت معنوياً مع عدم تأذيه، فإن النهي عن التجارب التي تطول جسده وأعضائه وفيها ألم جسدي يكون أولى وأكد.

سادساً: استدلوا بالعديد من القواعد الفقهية التي تفيد بمضمونها حرمة التجارب على الموتى، ومنها قاعدة "الضرر لا يُزال بالضرر" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"^(٤) حيث ثبت من خلال هاتين القاعدتين أن الضرر لا ينبغي أن يُزال بضررٍ مثله، وإذا كان المرضى يصيبهم ضرر من جرّاء

(١) المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه، لعلي بن نايف الشحوذ، الطبعة الثانية ٢٠٠٧م، ص ١١٦.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، برقم (١٣٢٩)، صحيح البخاري، ٤٧٠/١.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الموتى، برقم (٤٩٠٠)، ٢٩٦/٢، المعجم الكبير، للطبراني، ٤٣٨/١٢، وأخرجه الحاكم في المستدرک، برقم (١٤٢١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ٥٤٢/١.

(٤) الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص ٨٣.

مرضهم، فلا ينبغي أن نزيل هذا الضرر بتجارب على الموتى تُضَرَّ هي الأخرى بهم، فإزالة الضرر الذي ينادي به الأطباء لا يتم إلا بإلحاق ضررٍ بجسم الميت، وهو ما دَلَّتْ القواعد الفقهية على عدم جوازه.

ويناقش الاستدلال بالقواعد السابقة بمناقشتين:

المناقشة الأولى: سلمنا لكم بصحة ما تدل عليه القواعد السابقة، وأن الضرر لا ينبغي أن يُزَالَ بضررٍ مثله، إلا أن هذا التسليم مشروط بشرطين:

الأول: أن نكون في الظروف العادية.

الثاني: أن يكون الضرر الذي تتم به الإزالة مساوٍ أو أشد من الضرر المراد إزالته، أما إذا كان أخف فلا شيء في ذلك، والتجارب التي تقع على أجساد الموتى يكون ضررها أخف من تلك الأضرار التي يعاني منها المرضى.

المناقشة الثانية: إن القواعد التي تم الاستدلال بها مُعَارَضَةٌ بقواعد أخرى أوضح وأصرح في الدلالة على مسألتنا، وهي قاعدة "يَتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وقاعدة "يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد" ^(١)، وَلَمَّا كانت هذه القواعد صريحة في الموضوع، كان إجراء التجارب على الموتى جائز ولا شيء فيه.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى بما

(١) الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، طبعة عالم الكتب، ٢٤٦/١، الأشباه

والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي، الطبعة الأولى، دار

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، ص ٧٢.

يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١).

وجه الدلالة من الآية:

عَظَّمَ الله تعالى ثواب إحياء النفس، واعتبر إحياء نفس واحدة بمثابة الإحياء لجميع الناس، ولم يحدد رب العزة الطريقة التي يتم بها الإحياء لتكون عامة تشمل ما هو موجود، وما يفرزه التطور.

قال الحسن: "من إحيائها أن يُنَجِّيَهَا من القود، فيعفو عنها، أو يفاديها من العدوان، وينجيها من الغرق، ومن الحرق، ومن السبع، وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالها"^(٢).

وإجراء التجارب على الموتى فيه إحياء للآخرين، بل إن نتائج هذه التجارب يكون لها أثرها البالغ في وقاية الأفراد من برائن بعض الأمراض التي تفتك ببني الإنسان.

وقد جاء في تفسير معنى الإحياء في قوله تعالى "ومن أحياها" ما يؤيد ذلك: فقد ذكر ابن الجوزي في تفسيره أن المفسرين أوردوا في معنى الإحياء خمسة أقوال: أحدها: يعني: استنقاذها من هلكة^(٣).

ولا شك أن إجراء التجارب على الأموات فيه استنقاذ حياة الكثيرين، بعلاجهم من الأمراض المميتة وفقاً لنتائج تلك التجارب، فكان إجراؤها

(١) سورة المائدة: من الآية ٣٢.

(٢) تفسير القرآن، لابن أبي زمنين، ٢/٢٣، ٢٤، تفسير الماوردي، ٢/٣٢.

(٣) زاد المسير، ١/٤٠.

جائز شرعاً.

ثانياً: للتجارب الطبية فوائد عظيمة، سواءً على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، حيث يترتب عليها تحقيق النفع للبشرية، وإذا كان إجراؤها على الأحياء يثير بعض الإشكالات، نظراً للأضرار التي قد يُصابُ بها الشخص الخاضع للتجربة، لذا فإن إجراؤها على الموتى لا شيء فيه، فمن المسلم به شرعاً وعقلاً أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح العباد، وقرر الفقهاء أنه يُزَكَّبُ الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد، وإذا تعارضت مفسدتان قُدِّمَت أخفهما، لذا كان إجراء التجارب على الموتى جائزاً شرعاً.

ثالثاً: يُسْتَدَلُّ على جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى بالقياس على استخدام بعض أعضاء الميت في علاج الحي، حيث قرر العلماء جواز استخدام أعضاء الميت في حال الحاجة إليها من قبل الأحياء.

فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بحواز سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل، أما الأموات الذين لهم أهل، فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذنتهم وحدهم، فإذا أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنتهم وموافقتهم^(١).

كما أجازت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسانٍ مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها مالم يمنع أولياؤه ذلك، بناءً على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة

(١) فتوى دار الإفتاء المصرية الصادرة في ١٩٧٢/٢/٢م. يراجع: الفتاوى الإسلامية،

الحي على مصلحة الميت، فإنه يُزجى للحي الإبصار بعد عدمه، والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل^(١).

وبالتالي فإذا كان يجوز استخدام بعض أعضاء الميت لإحياء شخص آخر، فمن باب أولى يجوز إجراء التجارب عليه، لما في ذلك من إحياء أمة، أو مرضى كثيرين، وتخفيف آلامهم، لاسيما وأن الميت لا يلحقه ضرر من جراء تلك التجارب.

رابعاً: إن الفقهاء أجازوا الأكل من الميت في حالة الضرورة، استبقاء للحياة، وفي إجراء التجارب على الميت استبقاءً لأحياء بإتلاف أجزاء من الميت^(٢) فكان إجراء التجارب على الميت جائزاً ولا شيء فيه.

خامساً: إن في إجراء التجارب على الموتى بغرض التقدم الطبي يشتمل على مفسد، إلا أنه مع ذلك يحتوي على مصالح تترجح عليها، لأن المصلحة المترتبة على إجراء التجارب تعتبر من المصالح العامة التي تعود بالنفع على مجموع الأمة، حيث تؤدي إلى دفع الأضرار عن الأمة، كما تؤدي إلى التخفيف من آلام المرضى، ويقابل ذلك كله مفسدة عدم الحفاظ على كرامة الميت، وبالتالي فالمصالح التي تنتج من إجراء التجارب تؤدي إلى حفظ النفوس، لذا وجب تقديم مصلحة الأحياء على مصلحة الحفاظ

(١) قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم ٦٢، الصادر في ١٠/٢٥/١٣٩٨هـ.

(٢) المجموع، للنووي، ٣٠١/٥.

على الميت، نظرًا للمنافع التي تتحصل من وراثتها.

أضف إلى ذلك: أن مصلحة الميت خاصة، ومصلحة المرضى عامة، وعند التعارض يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما هو مقرر لدى العلماء^(١).

سادسًا: يُستدل على جواز إجراء التجارب على الموتى بالقاعدة الفقهية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"^(٢) وقد ذهب أغلب العلماء إلى وجوب التداوي من الأمراض، لورود الأحاديث الصريحة الموجبة للتداوي، ومنها قوله ﷺ "تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ"^(٣)، وإذا كان التداوي من الأمراض واجبًا، وكان التداوي لا يتم إلا بإيجاد الأدوية، كانت الوسائل التي تؤدي إلى اكتشافها جائزة شرعًا، والتجارب الطبية هي أحد العوامل الرئيسة التي تساعد على إيجاد العلاجات الناجحة الفعالة، لذا كان إجراؤها على الموتى جائز من الوجهة الشرعية، وبما أن تعلم الطب واجب على الكفاية، لما يحققه من منافع يستفيد منها مجموع الأمة، ولا يتم ذلك إلا بالتجارب، فتكون مشروعة من هذا الوجه.

سابعًا: القياس على شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وجنينها حي، حيث ذهب الجمهور إلى جواز شق بطنها لإخراج جنينها، فإذا كان ذلك

(١) أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، ص ١٧٣.

(٢) الموافقات، ٣٢٨/٢، المنشور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركشي، الطبعة الثانية،

وزارة الأوقاف الكويتية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ٢٣٥/١.

(٣) الحديث سبق تخريجه.

يباح لإحياء نفسٍ واحدة، فمن باب أولى يجوز إجراء التجارب الطبية على الموتى، لِمَا فيها من نفعٍ للإنسانية.

ثامناً: من المقرر في الشريعة الإسلامية أن حكم الوسائل متعلق بحكم المقاصد، وإذا كان الهدف من إجراء التجارب على الأموات هو تحقيق النفع للبشرية، فيكون الحكم هو الجواز، لاسيما وقد غابت النصوص الصريحة التي تحرم هذا الفعل.

يقول الغزالي رحمه الله: "وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ" ^(١).

القول الراجح:

بعد عرض القولين، وما اعتمدا عليه من أدلة، ومناقشة ما أمكن منها، يترجح عندي - والله أعلم - قول من قال بجوز إجراء التجارب الطبية على الموتى، وذلك لما يلي:

١ - قوة أدلة هذا الرأي وسلامتها من المناقشة.

٢ - الموازنة بين المصالح والمفاسد توجب ترجيح الجواز، حيث إن مصلحة الحي برعايته وإنقاذ حياته أعظم من مصلحة الحفاظ على حرمة جسد الميت وعدم امتهانه، لاسيما وأنه صار جسداً بلا روح، فتكون التجارب على الموتى من باب إحياء النفوس.

(١) المستصفى، ١/١٧٤.

المطلب الثالث

حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة

إذا كان الإنجاب الصناعي يستخدم في المقام الأول كعلاج لحالات العقم لدي الزوجين أو أحدهما، وبما أن الأطباء يتوقعون فشل المحاولة، فإنهم يعمدون إلى تنشيط المبيض لدى الزوجة حتى يتمكن من إفراز عدد من البويضات، ثم القيام بتلقيح هذه البويضات بالحيوانات المنوية المأخوذة من الزوج وحفظها، بحيث إذا فشلت تلك المحاولة يكون بإمكان الأطباء القيام بزرع إحدى البويضات الملقحة في رحم الزوجة دون إعادة الكرة مرة أخرى.

فيقوم الأطباء بتلقيح عدد من البويضات، والاحتفاظ بالبعض الآخر، فإذا ما كُتِبَ للعملية الفشل يقوم الأطباء بإعادة الكرة باستخدام البويضات الملقحة المحفوظة مرة أخرى دون عناء، أما إذا نجحت العملية وتم زرع الجنين في رحم الزوجة، وبدأت دورة الحمل الطبيعية، فإننا نكون أمام بويضات ملقحة قابلة للزرع في الرحم.

وهذه البويضات تمر بمراحل عدة، منها:

- مرحلة ما قبل الجنين، وهي مرحلة الأسبوع الأول من الحياة، وبعد الأسبوع الأول من الحياة، وبعد أن يصل عدد الخلايا داخل الجنين إلى ٣٢ خلية، تأخذ الكتلة البشرية في التشكيل، وتظهر داخله فراغات وتكتلات في الخلايا، ويصبح لتلك الخلايا خصائص وتخصصات، وتكرر هذه المرحلة في الأسبوع الثاني من الحياة، وفي هذه المرحلة يطلق على الناتج اسم الجنين، وهذه التسمية هي السائدة في العرف الطبي.

وبالتالي فالأجنة الفائضة إما أن تكون:

- مرحلة ما قبل الجنين، والتي هي عبارة عن مجموعة من الخلايا تصل إلى ٨ أو ١٦ خلية، ولكل خلية قدرة على مواصلة الحياة، وأن تكون شخصاً كاملاً.

- مرحلة الجنين: وبها حوالي ٣٢ خلية أو أكثر، وهذه المرحلة هي ما تسمى بالجنين^(١).

والسؤال: هل يجوز إجراء التجارب الطبية على هذه البويضات الفائضة؟

الإجابة عن ذلك تطرح تساؤلاتٍ عدة تدور حول مدى اعتبار البويضة الملقحة جنيناً أم لا، وما هو الوقت الذي تنفخ فيه الروح، ووفقاً لذلك يظهر حكم إجراء التجارب عليها.

مدى اعتبار البويضة الملقحة جنيناً:

الجنين في اللغة:

مأخوذ من الجن، وهو الستر، ومنه قوله تعالى ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ أي: ستره، ومنه سُمِّي الجنين، لاستتاره في بطن أمه، والجنين: المقبور والجنين: الولد في بطن أمه، لاستتاره فيه، وَيُجْمَعُ على أجنة، وَأَجْنُنُ^(٢).

جاء في المصباح المنير: "الجنين وصف له ما دام في بطن أمه، والجمع

(١) د. عبد الله باسلامة: الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة الأعضاء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ١٣٧٢/٦.

(٢) لسان العرب، لابن منظور، طبعة مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث

العربي - بيروت، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، ٣٨٥/٢، ٣٨٦.

أجنة، مثل: دليل وأدلة، قيل: سمي بذلك لاستتاره، فإذا وُلِدَ له وَلَدٌ فهو منفوس، والجن والجنة خلاف الإنسان " (١).

وفي الاصطلاح:

اختلف الفقهاء في تعريف الجنين تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليه:

فعره الحنفية بأنه: ما استبان من خَلْقِهِ شيء، فإن لم يَسْتَبِنْ شيء من خلقه فليس بجنين (٢).

وعرّه المالكية بأنه: كُلُّ ما حملته المرأة مما يُعْرَفُ أنه ولد (٣).

وعند الشافعية: يرى الغزالي أن الجنين هو النطفة إذا وقعت في رحم المرأة واختلطت بمائها (٤).

وزاد الغزالي أن المَعْوَل عليه في الحكم بكون ما في الرحم جنيناً من عدمه أن يستبين شيء من خلقه، وإلا فلا بد من شهادة أربع نسوة من القوابل الثقات، أو عالمين في الطب الشرعي، أو علم الأجنة أن المضغة التي سقطت فيها تخطيط لأدمي (٥).

ويرى الحنابلة أن الجنين: ما كان فيه صورة آدمي، وقبل ذلك لا يُعْلَمُ

(١) المصباح المنير، ص ١١١، ١١٢.

(٢) المبسوط، للسرخسي، طبعة دار المعرفة - بيروت، ٢٦/٦.

(٣) المنتقى شرح الموطأ، للباجي، طبعة دار الكتاب الإسلامي، ٨٠/٧.

(٤) إحياء علوم الدين، للغزالي، ٥٨/٢.

(٥) تكملة المجموع الثانية، لمحمد نجيب المطيعي، تحقيق. محمود مطرحي، الطبعة

الأولى، دار الفكر - بيروت ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ٤٧٠/٢٠.

يقيناً أنه جنين^(١).

ويرى ابن رجب الحنبلي وابن حزم الظاهري أن بدء اعتبار ما في الرحم جنيناً هو كونه علقة، فالعلقة بداية الجنين، وما قبل ذلك لا يعد جنيناً^(٢).

ويطلق بعض الأطباء لفظ الجنين على الولد في بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع الإنساني بتكون الأجهزة المعروفة للإنسان، ويكون ذلك فيما بين الشهر الثالث من الحمل إلى حين الولادة، ويُقصرُ بعضهم على الولد في بطن أمه إذا اكتملت بنيته، وكان بإمكانه أن يعيش إذا نزل حيّاً من بطن أمه، ويكون هذا في الفترة الواقعة بين بداية الشهر السابع إلى وقت الولادة^(٣).

ومن علماء الأجنة من يطلق الجنين على الفترة الواقعة بين انغراس البويضة الملقحة في جدار الرحم ونهاية الأسبوع الثامن، ثم يطلقون عليه بعد ذلك اسم "حميل" إلى أن يولد^(٤).

ويفرق أهل الطب بين الجنين في مراحل الأولى، والجنين في المراحل

(١) كشاف القناع للبهوتي، تحقيق. مصطفى هلال مصيلحي، دار الفكر - بيروت ١٤٠٢هـ، ٤١٣/٥.

(٢) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ٤٩/١، المحلى، لابن حزم، دار الفكر - بيروت، ٢٦٦/١٠، ٢٦٧.

(٣) د. محمد نعيم ياسين: حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء، ص ٦٦، نقلاً عن: تطور الجنين وصحة الحامل، للدكتور. محي الدين طابو.

(٤) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص ٣٧٦ وما بعدها.

التالية: فالجنين في مراحله الأولى يراد به: انقسامات البويضة خلال الشهور الأولى، وفي المراحل التالية يراد به: الطفل الذي لم يولد^(١).

وبمطالعة ما ورد عن الفقهاء يبدو للوهلة الأولى أنهم منقسمون بشأن هذا الأمر: فبعضهم يعتبرها جنيناً له مقومات الحياة، حيث إنهم اعتبروا البويضة من وقت تخصيبها بالحيوان المنوي تتمتع بالحماية الشرعية، ورتبوا على ذلك حكمهم بعدم جواز إجهاضها والاعتداء عليها.

والبعض الآخر لم يعطها المقومات التي يحيا بها الجنين، وأجاز صراحة الاعتداء عليها وإسقاطها في المراحل الأولى من الحمل.

فيرى الحنفية أن البويضة المخصبة قبل نفخ الروح لا حياة لها ولا تعتبر جنيناً، يقول ابن عابدين: "إنما يباح للمرأة استئزال الجنين قبل نفخ الروح؛ لأنه ليس بآدمي"^(٢).

وذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية، فقالوا: إنه لا يعتبر جنيناً قبل أربعة أشهر، ولذلك لا يغسل، ولا يصلى عليه، نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وقال بعده: "وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا"^(٣).

واعتبر ابن قدامة الجنين قبل نفخ الروح لا حياة فيه، بل هو الجماد والدم.

(١) د. عبد النبي محمد محمود في رسالته للدكتوراة بعنوان "الحماية الجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" كلية الحقوق - جامعة القاهرة - فرع بنى سويف، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ص ١٣.

(٢) حاشية ابن عابدين، ٢٠٢/١، ٢٠٣.

(٣) نيل الأوطار، للشوكاني، طبعة دار الجيل - بيروت ١٩٧٣م، ٥٧/٤.

ويرى ابن حزم أن الجنين قبل نفخ الروح فيه لا شيء ولا حياة له؛ حيث إن من مذهبه أن الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا غرة له ^(١).

ومن خلال ما سبق؛ يتضح أن الفقهاء لم يعتبروا البويضة المخصبة جنيناً قبل نفخ الروح لما يلي:

١- إن الحياة لم تدب فيه حقيقة، إذ الحي ما هو إلا جسد وروح، والجنين قبل الأربعة أشهر جسد بلا روح، فلا تتوافر فيه صفة الإنسانية.

٢- إن الجنين يتكون من الحيوان المنوي والبويضة، ويؤيد ذلك معنى كلمة جنين، حيث إنها في اللغة مأخوذة من الاستتار؛ لأنه مستور في بطن الأم داخل ظلمات ثلاث، ولذلك يقول القرطبي: "الجنين هو الولد ما دام في بطن أمه" ^(٢) ويمكن القول: إن حرمة البويضة الملقحة يرتبط بمكان وجودها، فقيمتها وحرمتها تكون إذا كانت في الرحم؛ لأنها عندئذ تسمى جنيناً، أما البويضة الملقحة خارج الرحم لا تعتبر جنيناً لعدم وجودها في بطن الأم ^(٣).

٣- إن القول بعدم اعتبار البويضة الملقحة جنيناً قول مؤيد بنظريات العلم الحديث؛ لأن البويضة لا تعتبر حملاً إلا إذا اندمجت في أنسجة الرحم، أما قبل ذلك لا تعد جنيناً ^(٤).

(١) المحلى، ١١/٢٣٤.

(٢) تفسير القرطبي، ٧/١١٠.

(٣) الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، طبعة ١٩٨٧م، ص ٧٣٢.

(٤) د. محمد المرسي زهرة: الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، ص

٤- إن خروج الروح من الجسد هو السبب الحقيقي الذي سببه الله تعالى لإنهاء حياة الإنسان، وإذا كان خروج الروح هو سبب خروج الإنسان من الدنيا، فإن وجود الروح هو سبب وجوده فيها، فالحياة الإنسانية لا تدب في الجنين إلا بعد نفخ الروح، أما قبل ذلك فهي حياة نباتية من أهم آثارها الحركة غير الإرادية والنمو^(١).

٥- إن الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا من وقت نفخ الروح في الجنين، إذ يصبح الجنين بعد نفخ الروح خَلْقًا آخر مباينًا عن الخلق الأول، وهو ما قبل نفخ الروح، وهذا الخلق بعد نفخ الروح فيه قوى الوعي والإدراك والتميز وغير ذلك من جميع الأجهزة المعوقة للإنسانية، وهذا بخلاف الأطوار السابقة على نفخ الروح^(٢).

وهذا القول هو ما انتهت إليه ندوة "رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية" حيث قررت: "إن الوضع الأمثل في موضوع مصير البويضات الملقحة هو ألا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قَصْدَ الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد، وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضًا، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية".

وقت نفخ الروح في الجنين:

تعتبر مسألة تحديد الوقت الذي تُنْفَخُ فيه الروح في الجنين من أدق

(١) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص ١٢.

(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٤١٦/١١، تفسير القرطبي، ٦/١٢.

المسائل التي يمكن بحثها في أحكام الجنين وما يتعلق به، إذ إن تحديدها يؤدي إلى بناء الأحكام الشرعية عليها.

وبمطالعة النصوص الواردة في هذه المسألة يمكن القول: إن هذه المسألة يتنازعها اتجاهات أربعة:

الاتجاه الأول: مؤداه أن الروح لا تنفخ إلا بعد الشهور الأربعة الأولى، أي: بعد مائة وعشرين يومًا.

واستند هذا الاتجاه إلى ما يلي:

ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق، قال: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيَقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدًا، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ " (١).

وجه الدلالة من الحديث:

في هذا الحديث تحديد صريح لا يقبل الجدل بأن الروح لا تُنفخ إلا بعد مائة وعشرين يومًا، بل نقل بعض العلماء ممن تعرض لشرح هذا الحديث الإجماع على ذلك:

قال القرطبي: "لم يختلف العلماء أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مائة وعشرين يومًا، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس - كما بيناه

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم (٣٠٣٦) ١١٧٤/٣،

ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق، برقم (٢٦٤٣) ٢٠٣٦/٤.

بالأحاديث - وعليه يُعوَّل فيما يحتاج إليه من الأحكام " (١).

وقال ابن عابدين: "نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، أي عقبها.... ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق" (٢).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: "واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر" (٣).

وقال ابن رجب: "فأما نفخ الروح فقد روي صريحاً عن الصحابة رضی الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود" (٤).

ونقل ابن حجر في الفتح القول باتفاق العلماء على ذلك، فنقل عن الفاضل على بن المذهب قوله: "اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يقع إلا بعد أربعة أشهر" (٥).

وقال ابن حجر: "وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار، كل طورٍ منها في أربعين، ثم

(١) تفسير القرطبي، ٨/١٢.

(٢) حاشية ابن عابدين، ٣٠٢/١.

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٣٩٢هـ، ١٩١/١٦.

(٤) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص ٤٩.

(٥) فتح الباري، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت ١٣٧٩هـ، ٤٢٠/١١.

بعد تكملتها ينفخ فيه الروح..... ثم يكون للملك فيه تصور آخر، وهو في وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة أشهر كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر^(١).

ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه قال: "اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع، ولم يختلف في أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك بعد تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس، وهذا موجود بالمشاهدة، وعليه يُعَوَّل فيما يحتاج إليه من الأحكام"^(٢).

الاتجاه الثاني: مؤداه أن الروح تنفخ في غضون خمسة أيام بعد الأربعين يوماً الأولى.

وسند هذا الاتجاه ما يلي:

ما رواه حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ"^(٣).

(١) فتح الباري، ١١/٤٢٢.

(٢) فتح الباري، ١١/٤٢٣.

(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم، كتاب القدر، باب خلق آدمي في بطن أمه، برقم

(٢٦٤٥) ٤/٢٠٣٧.

وقد جنح بعض المعاصرين إلى هذا الرأي ^(١) ودلَّ على ذلك بقوله:

إن صح حمل الحديث الأول - حديث ابن مسعود - على الأحاديث الأخرى، حيث إن هذا الحديث ليس فيه تصريح بأربعة أشهر، أو بأن مرحلة النطفة تكون أربعين يوماً وحدها؛ بل إن قوله: إن أحكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً يُفهم منه أن كل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة يتم في الأربعين يوماً، ولذلك لم ترد كلمة نطفة بعد هذه الجملة في أي من الروايات الصحيحة.

أما قوله: "ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" فليس صريحاً في أن المقصود المدة، وهي أربعون يوماً؛ بل يحتمل غيره، كأن تقول مثلاً: إن العلقة والمضغة مثل النطفة في كَوْنِ الجنين لا روح فيه، وكونه لم يكتب قدره يشير إلى ذلك قوله بعد ذلك: ثم يرسل إليه الملك.....".

ومما يؤكد أن المقصود في قوله "مثل ذلك" ليس الوقت رواية الإمام مسلم لحديث ابن مسعود، فلا شك أن قوله "في ذلك" أي: في ذلك الوقت، وهو الأربعون الأولى لا غير، فينبغي تفسير قوله "مثل ذلك" تفسيراً آخر غير الوقت، فيصبح معناه: ثم يكون في ذلك الوقت مثل الجمع، فهناك شبه بين العلقة والمضغة، وبين الجمع الأول وهو النطفة قد يكون عدم وجود الروح أو عدم كتابة قدر.

بل زعم البعض ^(٢) أن رواية مسلم تفيد ذلك، إذ إن الإشارة الأولى

(١) د. أشرف القضاة: متى تنفخ الروح في الجنين، دار الفرقان ١٩٩٠م، ص ٤٥.

(٢) د. محمد نعيم ياسين: حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء، بحث منشور

تعود إلى الأربعين يوماً الأولى، ولا تعود إلى بطن الأم فيكون علقاً ومضغةً في الأربعين الأولى، فرتب على ذلك أن يكون نفخ الروح بعد أربعين يوماً، وليس بعد مائة وعشرين يوماً.

تقييم هذا الاتجاه:

بالنظر إلى هذا الاتجاه نجد أن ما ذهب إليه من تأويل في الأحاديث الصحيحة - أي حديث ابن مسعود - فيه تكلف وتشدد لا مبرر له، ولعل تأويلهم هذا مردود بما يلي:

١- إن جميع الروايات التي ذُكر فيها نفخ الروح ليس فيها أي نوع من التعارض؛ بل إنها اتفقت على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وأما التعارض الذي يتوهمه البعض فقد جاء في الأحاديث التي لم تتعرض لذكر الروح، وإنما تعرضت لبيان القدر المكتوب على الإنسان، فاختلفت في وقت كتابة القدر، ولم تختلف في وقت نفخ الروح، لذلك وُجد من العلماء القدامى - كابن القيم - من تعرض للجمع بين الروايات المتعارضة في الظاهر من حيث وقت كتابة القدر دون المساس بما رُود في حديث ابن مسعود في وقت نفخ الروح^(١).

٢- إن كل من تعرض لشرح حديث ابن مسعود من العلماء والفقهاء لم يشكك في هذه المدة؛ بل نقل عنهم ما يشبه الإجماع على أن نفخ الروح لا

بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت، العدد ١٧ لسنة ١٤٠٧هـ، ص ٩٢.

(١) د. محمد نعيم ياسين: حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء، ص ٩٣،

شفاء العليل لابن القيم، ص ٢٢.

يكون إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وبالتالي فلا يجوز نقض هذا الإجماع بدعوى تعارض قد تكون موهومة لعدم ابتنائها على أساسٍ قويم، بل كل ما تبنى عليه مترادفات وأدوات لغوية لم تتعرض لهذه المسألة، وبالتالي تعتبر كل التأويلات التي وردت في حديث ابن مسعود خارجة عن محل النزاع.

٣- أكد الأطباء أن وقت نفخ الروح يكون بعد مائةٍ وعشرين يومًا، حيث ذكروا أنه إذا كانت مرحلة الأربعين تمثل مرحلة هامة، فإن مرحلة المائة وعشرين يومًا هي أشد أهمية؛ حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق العليا في المخ تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها في هذه الفترة، لذلك يقرر الأطباء أن للجنين مستويين في غاية الأهمية:

الأول: عند بلوغه الأربعين، وفيها يتم تكون الأعضاء التناسلية وجذع المخ.

الثاني: عند بلوغه أربعة أشهر، وفيها يتم تكون الدماغ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها، وبالتالي تبدأ في أداء مهام عملها^(١).

الاتجاه الثالث: مؤداه أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مائةٍ وثلاثين يومًا، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب^(٢) فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًا، ثم ينفخ فيه الروح"^(٣).

وأخرج الطبري عن ابن المسيب أنه سُئِلَ عن عدة الوفاة فقليل له: ما

(١) د. محمد على البار، د. زهير أحمد السباعي: الطيب أدبه وفقهه، ص ٢٧١.

(٢) حاشية ابن عابدين، ٣٠٢/١، تفسير القرطبي، ٧٠٦/١٢، فتح الباري، ٤٨٦/١١.

(٣) تفسير القرطبي، ٧٠٦/١٢.

بال عشرة بعد الأربعة أشهر؟ قال: تنفخ فيها الروح " (١).

تقييم هذا الاتجاه:

بالنظر إلى هذا الاتجاه نجد أنه اتجاه غير مقبول لما يلي:

١- إن هذا التحديد لم يقل به أحد مع كثرة ما نقل عن العلماء من أقوال في هذه المسألة، وبالتالي جاء مخالفاً لما عليه جماهير علماء المسلمين.

٢- من الأمور التي هي محل اتفاق بين العلماء أن قول النبي ﷺ مقدم على قول غيره من الصحابة والتابعين، وهنا تعارض قول النبي ﷺ في حديث ابن مسعود مع قول ابن عباس وابن المسيب، وقولهما لا يقوى على معارضة قول النبي، وبالتالي قُدِّمَ قول النبي ﷺ على قولهما ولا يُعَوَّلُ على ما ذهبوا إليه.

الاتجاه الرابع: يرى هذا الاتجاه أن حياة الجنين تبدأ من اللحظة التي تلتقي فيها النطفة بالبويضة ليصبحا خلية واحدة تسمى "الزيجوت" ومن هذه اللحظة هو كائن حي، يجب احترامه من أول التلقيح وحتى آخر أطواره (٢).

وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي، حيث قال: "أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإذا نفخ فيه

(١) فتح الباري، ١١/٤٨٦.

(٢) ممن ذهب إلى هذا الاتجاه الشيخ. بدر المتولي عبد الباسط، في ندوة الحياة الإنسانية،

الروح^(١).

ومفاد هذا الاتجاه: أن الحياة سابقة على نفخ الروح، وما استقبالها في الروح إلا حدثاً في حياة الجنين، وليس بداية له، فالحياة الإنسانية تبدأ بعد التلقيح، وما يتم بعد ذلك هو نمو وتطور، والنمو يكون جسمانياً وعقلياً وروحياً، ونفخ الروح سواءً أكان بعد أربعين يوماً، أم كان بعد مائة وعشرين يوماً ما هو إلا طَوْرٌ من أطوار النمو، فالحياة تبدأ بدايتها بالتلقيح، تمر بعد ذلك بأطوارٍ مختلفة منها نفخ الروح^(٢).

ال رأي الراجح:

بعد عرض الاتجاهات التي وردت في وقت نفخ الروح أرى أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، وذلك لوضوح دلالة حديث ابن مسعود على ذلك، ويمكن الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة على النحو التالي:

أولاً: إن التوفيق بين هذه الأحاديث يكون بحمل إرسال الملك على التعدد، أي أن إرساله لا يكون مرةً واحدة؛ بل مراتٍ متعددة، مرةً في بداية الأربعين الثانية، وأخرى في نهاية الأربعين الثالثة لنفخ الروح^(٣).

ثانياً: إن كلا التقديرين حق، لصدورهما عن النبي ﷺ فالأول: تقدير عند انتقال النطفة إلى أطوار التخليق التي هي أول مراتب الإنسان، والتقدير

(١) إحياء علوم الدين للغزالي، طبعة دار الحديث - القاهرة، ٥١/٢.

(٢) د. محمد المرسى زهرة: الطبيعة القانونية للجنين، مجلة المحامي الكويتية ١٩٩٠م، ص

(٣) فتح الباري، ٤٨١/١١.

الثاني: يكون عند كمال الخلق ونفخ الروح^(١).

ثالثاً: إن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى، والتصوير والنفخ يكون بعد الأربعين الثالثة، وقد يخلق في الأربعين الثانية بناءً على ما قيل من أن الجنين يخلق بعد الأربعين، وأن الذكر يخلق قبل الأنثى^(٢).

رابعاً: إن حديث ابن مسعود مُفسَّر للأحاديث الأخرى، فإن فيه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقه، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، فهذه أربعة أشهر، وفي العشر ينفخ الملك الروح، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها - كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب - ولم يختلف العلماء في أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً^(٣).

خامساً: إن معنى جمع الخلق الوارد في الحديث مختلف في تفسيره على معنيين:

أ - ما ورد عن ابن مسعود من تفسيره للحديث بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في جسد المرأة تحت كل ظفرٍ وشعر، ثم تمكث أربعين يوماً، ثم تنزل دمًا في الرحم فذلك جمعها.

إلا أن هذا التفسير مردود بأنه ليس لابن مسعود؛ وإنما هو لأحد رواة الحديث، نقله عنه بعضهم، وأدرجه في الحديث حتى وُهم أنه من كلام ابن

(١) طريق الهجرتين، لابن القيم، ص ٧٤، ٧٥.

(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق. عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي

الحلي، مكتبة ابن تيمية، ٢٤١/٤.

(٣) تفسير القرطبي، ٧/١٢.

مسعود^(١).

ب - المعنى الثاني هو تفسير ابن القيم، وهو أن المراد بالجمع: تخطيط أعضاء الجنين وتصويرها تصويرًا خفيفًا^(٢).

وَصَرَّحَ ابن القيم بأن الجمع إنما يحدث في الأربعين الأولى، ولم يدخل فيه مرحلة العلقة ومرحلة المضغة، وإنما يتم كل طور من هذين الطورين بمضي أربعين يومًا على نهاية المرحلة التي قبلها، ثم يكون نفخ الروح في بداية الأربعين الرابعة^(٣).

سادسًا: إن العلماء المسلمون قديمًا كانوا يدركون تمام الإدراك ويعرفون حق المعرفة أن الجنين يكتمل نموه وخلقه وتصويره قبل تمام الأربعة أشهر، وكان هذا أمرًا معروفًا لديهم في الشرع والطب:

ففي الشرع: ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

وفي الطب: فقد نقل عن أطباء مسلمون قديمًا بواسطة فقهاء عصرهم أن الجنين يستكمل أعضاؤه قبل تمام الأربعة أشهر، وأنه لا يوجد أدنى تعارض مع ما قرره الشرع من أن نفخ الروح لا يتم إلا بعد الأربعة أشهر^(٤) ولذلك يقول النووي: ".... لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته"^(٥).

(١) فتح الباري، ١١/٤١٩.

(٢) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص ٣٣٧.

(٣) السابق.

(٤) د. محمد نعيم ياسين: حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء، السابق، ص

٩٧.

(٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/١٩١.

حكم إجراء التجارب على البويضات الملقحة:

مما لا شك فيه أن إجراء التجارب والأبحاث على الأجنة الإنسانية أمر قديم عرفته البشرية منذ عهود طويلة، وقد فحص جالينوس وأبقراط مجموعة من الأجنة المجهضة، وقام ليوناردو دافنشي (الإيطالي الطبيب العالم الموسيقي الرسام الفلكي الرياضي) في القرن الخامس عشر بدراسة بعض الأجنة.

وكانت الدراسة تتمثل في معرفة تشريح الجنين، وكيفية بنيتها وتطورها مع تقدم الحمل، حتى تمكن العلماء من معرفة هذه المراحل المتطورة بدقة، وكانت هذه المعرفة نبراساً لمعرفة منشأ مختلف الشذوذات في التكوين التي يلاحظها الأطباء للأطفال عند الولادة وما بعدها، كما أن هذه الدراسات أدت إلى معرفة وثيقة لتشريح جسم الإنسان وكيفية تكون أنسجته وأعضائه مرحلة بعد مرحلة، وكيف يمكن أن تتوقف عملية النمو عند مرحلة معينة مؤديةً إلى عيوب خلقية خطيرة أو يسيرة^(١).

وعند بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة يقتضي التفريق بين أمرين:

الأمر الأول: تلقيح بويضات لغرض إجراء التجارب عليها:

إذا تم تلقيح بويضات لا بهدف التوالد والتكاثر، وإنما بهدف إجراء التجارب الطبية والحيوية عليها، فأرى أن هذا الأمر لا يجوز من الناحية الشرعية، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: إن التلقيح الصناعي في هذه الفرضية قد حادَ عن هدفه الذي أجاز

(١) د. محمد علي البار: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبطة، مجلة

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ١٣٣٣/٦.

من أجله، فمعلوم أن الهدف من التلقيح الصناعي معالجة العقم الذي قد يكون لدى الزوجين أو أحدهما، بهدف إشباع غريزة الأبوة والأمومة، وقد قرّر الفقهاء أن التلقيح الصناعي يكتسب صفة الجواز الشرعي مادام يسير وفق القواعد الموضوعية سلفاً من قِبَل الفقهاء مع التزام البعد عن الشبهات، مسترشدين في ذلك بقول النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ" ^(١).

ثانياً: إن تلقيح بويضات لغرض إجراء التجارب خاصة يتنافى مع التكريم الذي أولاه الله للإنسان، لاسيما وأن بعض الفقهاء يرى أن حرمة الجنين تتقرر من وقت التلقيح لا من وقت نفخ الروح، وقد ثبت هذا التكريم بقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ^(٢).

الأمر الثاني: البويضات الفائضة من عمليات الزرع:

هذا النوع من البويضات هو الذي يثير الإشكال، بمعنى هل هذا النوع من البويضات يجوز إجراء التجارب عليه أم لا؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل هناك تساؤل أكثر إفادة في بيان الحكم

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢) ٢٨/١،

ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩) ٣/ ١٢١٩.

(٢) سورة الإسراء: من الآية ٧٠.

في هذه النازلة، وهو: هل يمكن أن نعتبر هذه الأجنة أجنة مجهضة، وبالتالي تسري عليها حكمها؟

والإجهاض في أبسط صوره هو طرد الرحم للولد أو للجنين، يستوي في ذلك أن يكون هذا الإجهاض له ما يبرره أم لا، وقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الإجهاض إذا لم يكن له ما يبرره شرعاً فهو جريمة منكرة، أما إذا كان له مسوغ معتبر فقد اتفقت كلمتهم على جوازه، عملاً بحالة الضرورة.

وقد اتفقت اللجان المختلفة - كما ذكر الدكتور البار - على تقسيم الأجنة المجهضة إلى ثلاثة أقسام:

١- أجنة غير قابلة للحياة (Non-Viable) وهي ما قبل الأسبوع العشرين، وهذه الأجنة يُسَمَحُ باستخدامها للأبحاث ولنقل الأعضاء أو الأنسجة بشرط موافقة الأبوين على ذلك حتى لو كانت حية.

٢- أجنة قابلة للحياة: وهي الأجنة التي وصلت الأسبوع الرابع والعشرين وما بعد، ووزنها يتراوح ما بين ٤٠٠ - ٥٠٠ جم. وهذه الأجنة قابلة للحياة المستقلة خارج الرحم ويمكن إنقاذها..

وهذه الأجنة لا يُسَمَحُ باستخدامها، أو أخذ أنسجة منها إلا بعد وفاتها، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون الوفاة طبيعية، وينبغي أن تقدم لهذه الأجنة وسائل الإنعاش المتاحة.

٣- الأجنة التي تنزل حية ولكنها غير قابلة للحياة المستقلة خارج الرحم، والتي يتراوح عمرها ما بين عشرين أسبوعاً وأربعة وعشرين أسبوعاً، وهذه الأجنة معضلة بالنسبة لرجال القانون، وقد اتخذت اللجنة الأسترالية وبعض اللجان الأخرى قرارها بالسماح باستخدام الأجنة التي

تزن ٣٠٠ جرام فما دونها، وعدم السماح باستخدام الأجنة التي تزن أكثر من ثلاثمائة جرام حتى تتبين وفاتها^(١).

وأرى أنه لا يمكن اعتبار هذه الأجنة أجنة مجهضة؛ لأن الأجنة المجهضة تكون ميتة غير قابلة للحياة، أما البويضات الملقحة الفائضة فهي بويضات قابلة للحياة إذا ما تهيأت لها الظروف والأجواء المناسبة.

وينبغي التقرير أن الأجنة الميتة أو البويضات غير القابلة للحياة لا فائدة منها، وبالتالي فإجراء التجارب عليها أمر غير مجدٍ من الناحية العلمية، ومدار الكلام يدور حول البويضات الملقحة القابلة للحياة.

وفي بريطانيا: صدر قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشرية عام ١٩٩٠م، وكذلك قانون أخلاقيات العلوم الإحيائية الفرنسي تحت رقمي ٦٥٣، ٦٥٤ لسنة ١٩٩٤م قاما بوضع مجموعة من الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمليات المساس باللقاح والأمشاج الأدمية، ومنها:

- ضرورة الحصول على رخصة مزاولة النشاطات التي تمس الأمشاج الأدمية.

- احترام ضمانات حفظ واستخدام هذه الأمشاج، سواء للأغراض العلاجية، أو بهدف البحث والتجريب.

- يمنع منعاً باتاً استخدام هذه اللقاح والأغراض للبيع والشراء والاتجار غير الأخلاقي، أو القيام بممارسات الاستنساخ البشري

(١) د. محمد علي البار: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبطة، مجلة

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ١٣٤١/٦.

تحت طائلة المتابعات المدنية والجزائية^(١).

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تخرج البحوث العلمية التي تجرى على الجنين عن الحدود الشرعية والأخلاقية والقانونية والإنسانية التي تحكم التجارب الطبية على الإنسان، فلا يكون استخدامها بهدف الحصول على أعضاء تستخدم للنقل، أو أن يكون الغرض هو مجرد إشباع شهوة علمية أو العبث أو التجارب التي تتم لتغيير البنية الأساسية لها، كالأبحاث المتعلقة بتغيير الجنس البشري عن طريق التحكم في الكروموسومات، أو تجارب التحكم في جنس الجنين، أو التجارب التي يكون هدفها محاولة تحقيق حمل كامل في الأنبوب للتجريب عليه، وكذلك محاولات الإخصاب بين الإنسان والحيوان بما يتعارض مع النصوص الشرعية والمواثيق الدولية والقواعد التي تفرض الاحترام الكامل للجنس الإنساني، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون هدفها التلاعب بمقدرات الجنس البشري والنيل من قدره وكرامته^(٢).

(١) د. بلحاج العربي: موقف التشريعات الدولية من بحوث تجارب الخلايا الجذعية، ندوة

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - الرياض ١٤٢٣هـ، ص ٧٩.

(٢) د. بلحاج العربي: موقف الفقه الإسلامي من الأبحاث العلمية والتجارب الطبية على

الأجنة البشرية، بحث منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد ٤ لسنة

١٩٩٩م، ص ٥٦ وما بعدها.

المبحث الثالث

القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر

عرضنا فيما سبق للحكم الشرعي لإجراء التجارب الطبية على البشر، الأحياء منهم والأموات، وقررنا الجواز الشرعي، نظرًا للمصالح التي تحققها تلك التجارب.

وأرى أن القول بالجواز على إطلاقه دون ضوابط أو قيود قد يؤدي إلى التلاعب والحيدة عن الغرض التي أجازت من أجله، لذا فإن هناك جملة من القيود التي ينبغي توافرها للقول بالجواز، وبدونها يعتبر إجراء التجارب على البشر محرماً، وهذه القيود منها ما يتعلق بالتجربة ذاتها، ومنها ما يتعلق بالشخص الخاضع لها، ومنها ما يتعلق بحماية المجتمع.

المطلب الأول

القيود الخاصة بالتجربة

أولاً: أن يكون الهدف من التجربة هو العلاج:

من القيود التي ينبغي مراعاتها أن يكون الغرض من إجراء التجربة هو إيجاد العلاج الفعّال لمرضى من الأمراض التي تصيب الإنسان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الرُقّي بمستوى الطب، مما يعود بالنفع على البشرية جمعاء، فالتجارب العلاجية من المفترض أن تكون لها نتائج إيجابية ملموسة، يستوي في ذلك أن تكون هذه التجارب متعلقة بتصنيع الدواء، أو ابتكار وسائل جديدة يمكن العلاج على أساسها، أو رفع كفاءة وتحسين الطرق الموجودة بالفعل، ولعل هذا الأمر يجد ضرورته في العصر الحاضر مع ظهور الأمراض المعدية الفتاكة التي تحصد أرواح الآلاف، بل الملايين من البشر^(١).

وإذا حادت التجربة عن هذا الهدف، فإنها تكون غير مشروعة، ولا يجوز إجراؤها أو الإقدام عليها، كأن تتخذ وسيلةً لتحقيق شهرة للفريق الطبي، أو مجرد الحصول على كشفٍ علمي، مما يستتبع معه مكاسب مادية، أو إشباع الرغبة في الفضول العلمي فقط دون أن يكون لها تأثير في علاج المرضى، ففي هذه الحالات ومثيلاتها تكون التجربة قد حادت عن الهدف الذي وُضِعَتْ من أجله.

(١) الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة، ص ٢٦، ضمن أعمال المؤتمر العالمي

الثامن للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الكويت.

وهذا يفترض بالضرورة أن يكون الهدف من التجربة هو مصلحة المريض، وتطوير العلاج الخاص بمشكلة مرضية معينة، كما يجب الالتزام بالقواعد الأساسية من حيث التصميم الجيد للبحث، وحماية سرية المشاركين والعدل في معاملتهم، واعتبارات الأخطاء والمزايا، ومراقبة جميع المعلومات، مضافاً إلى ذلك الإقرار الحر^(١).

ولا يكفي مجرد استهداف العلاج؛ بل ينبغي أن يكون هذا الهدف حقيقياً وليس وهمياً، بمعنى أن يكون معتمداً على حقائق ثابتة، لا على أوهاام علمية لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها على أرض الواقع.

وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على تقرير مسؤولية الطبيب إذا لم يكن القصد من إجراء التجربة هو علاج المريض أو تحسين حالته، وإنما تحقيق أهداف أخرى، حتى ولو كان يُزجى منها تقدم العلوم الطبية، أو كشف علاجاتٍ لأمراضٍ أخرى خطيرة، ولو تم إجراؤها بناءً على الرضا، إذ الرضا في هذه الحالة لم يصادف محله^(٢).

ويقرر الفقيه الفرنسي "سافاتيه" أن إجراء التجارب على كائن بشري دون وجود ضرورة تبررها يعد خرقاً من الطبيب لواجب احترام سلامة جسم الإنسان، وهذا الواجب مستمد من النظام العام، ولا يستطيع الطبيب التحلل منه إلا لمصلحة المريض، لذا لا يباح له إجراء تجارب خطيرة لا

(١) د. أشرف فوزي يوسف: قواعد وآداب البحث العلمي في المجال الطبي، دار النهضة العربية - القاهرة ١٩٩٣م، ص ٢٧.

(٢) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ١٩٨٥م، ص ٢٩.

فائدة منها لصحة المريض بزعم أنها ترمي إلى بحثٍ علميٍّ يهدف إلى تطوير العلاج، وهو ما أقرته محكمة ليون الفرنسية في حكم لها صدر عام ١٩٣١ م^(١).

وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان وَضْعُ قاعدةٍ يمكن بمقتضاها تحقيق القدر المأمول من التوازن، حيث إن المسألة في غالب الأحوال مسألة فردية، فالأخطار المتوقعة من تجربةٍ علاجيةٍ معينة تختلف من شخصٍ لآخر، لاختلاف الظروف التي يتعرض لها كلٌّ منهما، وحالته الصحية، ومدى قدرته على تحمل أخطار التجربة^(٢) وخروجًا من هذا المأزق يمكن النظر لظروف كل حالةٍ على حده، حسبما يظهر من الفحوصات الأولية، وتقرير التوازن، والحكم عليها وفقّ الملبسات المحيطة بها.

وبمقتضى هذا القيد ينبغي أن لا يكون أمام الطبيب وسيلة أخرى لعلاج الأمراض التي يجري تجارب علمية لاكتشاف علاج آخر لها، وأن يحرص كل الحرص على التأني في إجراءاتها متى كان من المحتمل أن يترتب عليها أضرار جسيمة بمن يخضع لها، وبما أن الأضرار متوقعة للتجربة الطبية فإنه يتعين أن تكون النتائج الإيجابية المتوقعة الوصول إليها من خلالها أكثر بكثير من المخاطر المتوقعة حدوثها بسبب هذه التجربة^(٣).

(١) د. أحمد شرف الدين: عناصر الضرر الجسدي وانتقال الحق في التعويض إلى شخص آخر غير المضرور، بحث منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة - مصر، العدد ١ السنة ٤، ١٩٧٨ م، ص ٢٦٣.

(٢) د. محمد عيد الغريب: التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي، ص ٩٨.

(٣) د. محمد سامي الشوا: السابق، ص ٤٩١.

ثانياً: أن تتم التجربة وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها:

يشترط للاعتراف بشرعية التجارب الطبية والسماح بإجرائها على البشر أن تتم وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها في المجال الطبي، وأن تبعد كل البعد عن الأهواء الشخصية والخيالات العلمية ومحاولات الإبداع غير المنطقي.

ويرجع السبب في اشتراط ذلك: أن محل هذه التجارب هو الإنسان، وبالتالي فإن قيام هذه التجارب على أسس غير صحيحة يُعَرِّضُ حياته للخطر المحقق، الأمر الذي يُحوِّلُ هذه التجربة من عمل مشروع له هدفه النبيل إلى فعل يمثل تعدياً على الجسم، مما يُدرِّجُه في دائرة الحرمة، إضافةً إلى المسؤولية القانونية التي من الممكن ترتيبها بناءً على ذلك.

أضف إلى ذلك: أن التجربة الطبية تقوم على افتراض مبدئي هو مفترض البحث العلمي، فالتجربة بحث هادف علمياً يسعى إلى الكشف عن جديد في العلوم الطبية، لذلك كان منطقياً وبديهيّاً اشتراط هذا الشرط.

ويترب على ذلك أن يكون الطبيب القائم بالتجربة على قدرٍ وافرٍ من الكفاءة العلمية، بمعنى أن يكون على علمٍ بآخر ما توصل إليه العلم من بحوث في مجال التجربة التي يقوم بها، وهو ما يلتقي بالمبادئ العامة في المسؤولية الطبية^(١).

ويقصد بالأسس العلمية التي ينبغي أن تتم التجربة وفقاً لها: القواعد

(١) د. السيد محمد عمران: التزام الطبيب باحترام المعطيات الطبية، مؤسسة الثقافة الجامعية

– الإسكندرية ١٩٩٢م، ص ٨.

التي وضعها المختصون في المجال الطبي، والتي تحدد المسار الذي يتوجب على الباحثين سلوكه أثناء إجراء التجارب، حيث يُزاعى في هذه الأسس أسلم الطرق والمناهج للوصول إلى الهدف المنشود بأقل قدر ممكن من الأضرار، يستوي في ذلك الأضرار التي من الممكن أن تعود على القائم بالتجربة، أو تلك التي قد تعود على الشخص الخاضع لها^(١).

ويقرر البعض^(٢) أن من بين الأسس المتبعة في هذا الخصوص أن تُجرى التجارب أولاً على الحيوانات قبل إجرائها على الإنسان، حتى تكون الفحوص المخبرية جميعها قد تمت على الحيوان، وبالتالي معرفة آثارها، وظهور فرص الشفاء واحتمالاته.

إلا أن البعض عارض وبشدة اشتراط هذا الشرط، حيث قال: "قد يقال أن بإمكان الطبيب إجراء هذه التجارب الطبية على الحيوانات، وليس على الإنسان، ونقول إن هذا صحيح في جملته، غير صحيح على إطلاق؛ إذ ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن هناك بعض الأمراض التي تصيب الحيوان ولا تصيب الإنسان، كما أن هناك العديد من الأمراض تقتصر على الإنسان دون الحيوان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العلماء لاحظوا أن الدواء الواحد قد يُحدثُ على الحيوان آثاراً أو مضاعفات تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الآثار التي يُحدثُها في الإنسان"^(٣).

(١) يراجع: أخلاق مهنة الطب، دليل إرشادات للممارسين الصحيين، أعدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ، ص ٢٨.

(٢) د. مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية، طبعة مؤسسة نوفل ١٩٨٥م، ص ٥٠٩.

(٣) د. حسن الذنون: المسؤولية الطبية، محاضرات لطلبة الدراسات العليا غير منشورة ١٩٨٧م، ص ٤٧، ٤٨، مشار إليه في بحث "التجربة الطبية على الجسم البشري"

وقد أشار إعلان "هلسنكي" ضمن مبادئه الأساسية إلى ضرورة توافر هذا القيد، حيث نص في المبدأ الأول على أن: "التجارب الطبية التي تجري على البشر يجب أن تتفق مع المبادئ العلمية المقبولة بوجه عام، وينبغي أن تقوم على كفاءة أداء التجارب المختبرة على الحيوانات، وعلى معرفة وافية بالبحوث العلمية السابق تنفيذها".

ويقرر البعض ^(١) أن التجربة التي يتم إجراؤها على الإنسان لا بد وأن تمرّ بعدة مراحل، أو إجراءات أهمها:

١- إجراء التجربة على حيواناتٍ تتشابه مع الإنسان في صفاته البيولوجية.

٢- تسجيل جميع الملاحظات والآثار والنتائج.

٣- إخضاع النتائج للدراسات والمناقشات المستفيضة، لضمان سلامة المتطوعين من البشر، مع الأخذ في الاعتبار جميع الضمانات الكافية.

٤- وضع تقريرٍ مفصل قبل البدء في التجربة تبين فيه مراحل التجربة، وكذلك الخطوات المتعلقة بها.

٥- الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ على إجراء التجربة من قِبَلِ الهيئة الطبية والشرعية المختصة، وذلك منعاً لاستغلال التجارب في أغراضٍ

للدكتور. منذر الفضل: التجربة الطبية على الجسم البشري، السابق، ص ١٩.

(١) د. أحمد محمد كنعان: الموسوعة الطبية، تقديم د. محمد هيثم الخياط، دار النفائس -

بيروت، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٢م، ص ١٣٢.

مخالفة للشرع، ومنافية للأعراف العلمية المعتمدة^(١).

وقد تعرض الفقهاء صراحةً لهذا الأمر، حيث أوجبوا على الطبيب مراعاة القواعد المتعارف عليها في مهنة الطب، وأوجبوا عليه الضمان حالة مخالفته لتلك القواعد.

قال الشافعي: "وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَ غُلَامَهُ أَوْ يُبَيِّطَ دَابَّتَهُ فَتَلَفُوا مِنْ فِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مِمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتِلْكَ الصَّنَاعَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ وَكَانَ عَالِمًا بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ"^(٢).

ثالثاً: انعدام الخطر في التجربة:

مقتضى هذا القيد ألا يكون في إجراء التجربة تعريض حياة الخاضع لها للخطر، أو إصابته بضررٍ مستديم، وأن تكون الآلام التي يتعرض لها تتناسب مع ما قد ينتج عنها من علاج يخفف آلام المرضى.

ويقترح البعض^(٣) أن تتم هذه التجارب تحت إشراف نقابة الأطباء؛ إذ هي الجهة الوحيدة التي تملك المقدرة على اختيار الأطباء ذوي الكفاءة للقيام بمثل هذه التجارب.

(١) نصت المادة ٢٠٩ من قانون الصحة العامة الفرنسي على أن: "أية بحوث لا يجوز إجراؤها على الإنسان إلا إذا تأسست على أحدث المعارف العلمية، واستناداً إلى تجارب إكلينيكية كافية، ويتعين أن يتوفر هذا الشرط في جميع أفراد فريق البحث العلمي في حالة تعددهم، سواء أكانوا وطنيين أم أجانب".

(٢) الأم، للشافعي، ١٨٥/٦.

(٣) د. حسام الأهواني: مقدمة في القانون المدني، دار النهضة العربية - القاهرة، ١٩٧٢م، ص

ولعل السبب في اشتراط هذا الشرط هو أن الشريعة الإسلامية قررت أن إيقاع الضرر بالغير محرم شرعاً، حيث قرر الفقهاء تلك القاعدة الذهبية التي تقضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار"^(١)، وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة، وهي كذلك أصل في تحريم التجارب الطبية التي تؤدي إلى إلحاق أضرار، سواء وقعت هذه الأضرار على الخاضع للتجربة، أو على غيره، ومع تقرير الفقهاء لذلك إلا أنهم قرروا أنه يُغفَى عن الضرر اليسير غير المؤثر، حيث إن المفسد إذا تعارضت رُوْعِي أعظمها ضرراً بارتكاب أدناهما^(٢).

رابعاً: توافر الكفاءة العلمية في القائم بالتجربة:

ينبغي أن تتوافر في الشخص أو الفريق القائم بالتجربة الطبية الكفاءة العلمية، وإنما تم اشتراط هذا الشرط حتى يمكن التقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة.

والطبيب بالمفهوم العام: هو العارف بتركيب البدن وجراح الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها وعلاماتها، والأدوية النافعة لها، والاعتياض عمّا لم يوجد منها، والوجد في استخراجها، وطريق مداواتها، ومن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى، ولا يجوز له الإقدام على علاجٍ يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له فيه^(٣).

(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٨٣.

(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، ١/٣٦.

(٣) د. علاء علي حسين نصر: النظام القانوني للاستنساخ البشري، الطبعة الأولى، دار النهضة

العربية - القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ٩١.

وقد أشار الطبيب أبو بكر الرازي إلى هذا الأمر بقوله: "إن الطبيب يجب أن يرجع إلى الأصول الثابتة في علم الطب، وخواص الأشياء المستعملة في العلاج، ولا ينظر إلى ما يهذي به الجهال أن فلاناً قد وقعت له التجربة في غير علم يرجع إليه، فإن ذلك لا يكون ولو كان من أطول الناس عمراً، ونفع له من علاج موفق فهو من حسن الإتقان، وهؤلاء ليسوا يرجعون إلى علم أصول الصنعة، إنهم ينظرون في الكتب فيستعملون منها العلاجات، وليسوا يعلمون أن الأشياء الموجودة فيها ليست هي الأشياء التي تستعمل بأعيانها" ^(١).

والكفاءة العلمية والمهنية التي ينبغي توافرها تُوجِبُ على القائم بالتجربة متابعة المستجدات والتطورات على الساحة الطبية، نظراً لأن التجربة تستهدف تحقيق آمال البشرية في القضاء على العديد من الأمراض التي باتت عائقاً أمام التقدم والازدهار، الأمر الذي استتبع بدوره أن أصبح الطب علماً أكثر من كونه فناً تجريبياً، وليس مجرد ملاحظة، مما أدى في نهاية المطاف إلى ازدواج دور الطبيب ^(٢).

وقد جاء في كلام الفقهاء المسلمين صراحةً ما يدل على اشتراط كون الطبيب - عموماً - ذو كفاءة وخبرة، بل عبروا عن الطبيب الكفء بالطبيب الحاذق.

واشتراط الكفاءة العلمية في القائم بالتجربة من الأمور المنطقية المسلم

(١) أخلاق الطبيب، لأبي بكر الرازي، تحقيق. د. عبد اللطيف محمد، الطبعة الأولى، دار

التراث العربي - بيروت، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م، ص ٧٧.

(٢) د. محمد عيد الغريب التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي، ص ١٢٩.

بها؛ لأن إقدامه على ذلك مع عدم الكفاءة يُرَتَّبُ المسؤولية في حقه، وقد صرح الفقهاء بوجوب الضمان على الطبيب غير الكفاء، وسقوطه عن الكفاء.

قال ابن رشد: "وَأَمَّا الطَّبِيبُ وَمَا أَشْبَهَهُ إِذَا أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ، وَالِدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ وَفِي مَالِهِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ، وَالسَّجْنُ، وَالِدِّيَّةُ، قِيلَ: فِي مَالِهِ، وَقِيلَ: عَلَى الْعَاقِلَةِ" ^(١).

وقال ابن مفلح: "وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا خَتَّانٍ وَلَا طَبِيبٍ وَلَا بَيْطَارٍ عُرِفَ حَذُّهُمْ وَلَمْ تَجُنْ أَيْدِيهِمْ" ^(٢).

ولعل وضع هذا القيد يأتي من منطلق الطبيعة المهنية للطبيب، حيث يتوجب على الطبيب القائم بالتجربة أن يكون عالماً بجانبين من العلوم:

الجانب الأول: العلوم الطبية الثابتة، والتي أقرها علماء الطب قديماً وحديثاً، كالمواد العلمية المقررة في الجامعات والمعاهد الطبية، والتي تعتبر من المسلمات في مجال التجارب الطبية، كالقواعد الخاصة بالفحوصات التي تجرى قبل التجربة، والاحتياطات والتدابير التي يتوجب على الطبيب اتخاذها، حيث تعتبر هذه الأمور من الأمور الثابتة والتي لا تتغير بتغير

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الحديث - القاهرة، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ١٨/٤.

(٢) الفروع، لمحمد بن مفلح تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة - بيروت، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ١٧٦/٧.

الزمان.

الجانب الثاني: العلوم الطبية المستجدة: وهي العلوم والمعارف التي يطرأ اكتشافها، أي: القواعد التي يفرزها العلم الحديث والتطورات التي يفرزها الواقع الطبي.

وبناءً على ذلك لو كان الطبيب القائم بالتجربة غير كفء، ولا تتوافر فيه المقومات العلمية اللازمة، ومع ذلك باشر التجربة، وترتب عليها إضرار بالخاضع لها، كما لو أدى ذلك إلى فقد عضو من الأعضاء، أو التأثير على حاسة من الحواس، كحاسة الشم، أو السمع، أو البصر، أو غير ذلك، أو أصيب بضرر يؤثر على مباشرته لحياته، فإن الضمان يجب على القائم بالتجربة^(١).

وقد اعتبر القضاء الفرنسي الكفاءة العلمية للقائم على التجربة من الشروط المعتبرة عند إجراء التجربة، حيث قضت محكمة ليون الفرنسية بمسئولية طالب بكلية الطب، قام بإجراء تجربة طبية تحت إشراف أحد

(١) يراجع في ذلك: القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، المعروف بابن جزي، دار الكتب العلمية - بيروت، ص ٢٣٠، الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، ١٠١/٤، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد الرحيباني، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي - بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ١٢١/٦، بدائع الصنائع، للكاساني، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ٣١١/٧، التاج والإكليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن يوسف أبي عبد الله المواق المالكي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٦هـ - ١٩٩٤م، ٢٦٠/٦.

الأطباء لصبي في العاشرة من عمره كان مصاباً بقراع، وأدى ذلك إلى حدوث أضرارٍ للصبي، فقامت المحكمة بمعاقبته لافتقاره إلى الكفاءة العلمية^(١).

والكفاءة المطلوبة في الطبيب الذي يجري التجربة تتطلب توافر أمرين:

الأول: أن يكون من الأشخاص المصرح لهم بمزاولة المهنة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

الثاني: أن يكون متمتعاً باللياقة والنزاهة في تعامله مع مرضاه الذين يخضعون لإجراء التجارب عليهم، ومن المظاهر الأساسية في هذا الخصوص: التسوية بين المرضى في الرعاية وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز التمييز - مثلاً - بسبب المركز الأدبي أو الاجتماعي أو المالي؛ بل يجب عليه أن يقدم المساعدة في كل الظروف، وأن يلتزم موقفاً لائقاً واعياً تجاه أي شخص يقوم بإجراء التجربة عليه^(٢).

خامساً: ازدياد احتمالات نجاح التجربة:

من القيود التي يمكن إيرادها على مشروعية التجارب الطبية على البشر أن تكون احتمالات نجاح التجربة متزايدة وفقاً للقوانين العلمية المعترف

(١) حكم محكمة ليون الفرنسية الصادر في ١٥ ديسمبر ١٨٥٩م، د. خالد بن النوى: ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على المسؤولية المدنية، طبعة دار الفكر والقانون - المنصورة ٢٠١٠م، ص ١٥٨.

(٢) د. جابر محجوب علي: قواعد أخلاقيات المهنة، مفهومها، أساس إلزامها، نطاقها، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية - القاهرة، ٢٠٠١م، ص ٣٨.

بها، وهو ما يعني أن تكون الأخطار التي من الممكن أن يتعرض لها الخاضع للتجربة مقبولة إذا ما قورنت بالمنفعة المتوخاة منها، وهذا الأمر يعني بدوره تحقيق قدرٍ معقولٍ من التوازن بين نتائج التجربة وأعراض المرض وعواقبه، بحيث لا يُقدّم الطبيب على إجرائها إذا كانت احتمالات فشلها تزيد على احتمالات نجاحها^(١).

ولعل أبرز تطبيق لهذا القيد ما ورد في الفقه الإسلامي متعلقًا بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وارتكاب أخف الضررين، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر هذه التجارب دون أن تشتمل على مخاطر محتملة، ومنها ما قد يقع بالفعل، وفي الوقت ذاته هناك مصالح يُزجى تحقيقها عند نجاح هذه التجربة، لذا كان لا بد من تحقيق الموازنة بين المصالح والمفاسد.

يقول العز بن عبد السلام: "لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْعِ أَنَّ تَحْصِيلَ الْمَصَالِحِ الْمُخْضَةِ، وَدَرْءَ الْمَفَاسِدِ الْمُخْضَةِ عَنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَعَنْ غَيْرِهِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ أَرْجَحِ الْمَصَالِحِ فَأَرْجَحِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ دَرْءَ أَفْسَدِ الْمَفَاسِدِ فَأَفْسَدِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ أَرْجَحِ الْمَصَالِحِ فَأَرْجَحِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ دَرْءَ أَفْسَدِ الْمَفَاسِدِ فَأَفْسَدِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَصَالِحِ الرَّاجِحَةِ عَلَى الْمَرْجُوحَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ الرَّاجِحَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَرْجُوحَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَاتَّفَقَ الْحُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَمْوَالِ

(١) د. خالد جمال حسن: إرادة المريض في العمل الطبي بين الإطلاق والتقييد، مجلة

الحقوق - جامعة البحرين، العدد الثاني، السنة العاشرة ٢٠٠٨م، ص ٢٤٨.

وَالْأَعْرَاضِ، وَعَلَى تَحْصِيلِ الْأَفْضَلِ فَأَلْفَظِلِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ" (١).

وقد تضمن ميثاق "هلسنكي" الصادر سنة ١٩٦٤م والمعدل سنة ١٩٧٥ ثم في سنة ٢٠٠٠م، والذي ينظم كيفية إجراء التجارب الطبية والدوائية على الإنسان هذا القيد، حيث أعطى للطبيب الحرية أثناء علاج المريض الحق في استعمال الطرق المستحدثة في التشخيص والعلاج، والموازنة بينها في سياق العلاج الطبي الناجح، وفقاً للفوائد المرجوة والمخاطر المحتملة الكامنة في هذه الطرق العلاجية المستجدة.

وبناءً على ذلك: ففي التجارب الطبية ينبغي المقارنة بين الخطر الذي تتضمنه التجربة وبين الفوائد المتوقعة منها، ويدخل في المقارنة كذلك الموازنة بين هذه الفائدة وبين عجز الطرق التقليدية عن تقديم العلاج، الأمر الذي يسمح بقبول درجة أكبر من المخاطر.

وهذه القاعدة تعتبر جوهرية وأساسية عند البحث عن حكم التجارب الطبية، إلا أنها تتسم بالصعوبة نوعاً ما، حيث إن الالتزام به يحتاج إلى اتخاذ القرار السليم، وهو ما يختلف في كل حالة عن الأخرى، أي أنه قرار يتعلق بحالة فردية، والمألوف في نطاق التجارب الطبية قبول خطر قد يكون كبيراً في بعض الحالات، لكن يتعين في جميع الأحوال أن يظل متناسباً مع الفائدة المرجوة على وجه صحيح للشخص الخاضع للتجربة، وتبقى المصلحة العامة التي يحققها البحث العلمي من هذا الفرض غير ذات وزن كبير في المقارنة، لأن الغرض هو تحقيق المصلحة الفردية أولاً (٢).

(١) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، ١/٥، ٦.

(٢) د. جابر محجوب علي: دور الإرادة في العمل الطبي، دار النهضة العربية - القاهرة

سادساً: إجراء التجربة على الحيوانات مسبقاً:

يشترط البعض لإجراء التجارب الطبية على الإنسان أن يكون قد تمَّ إجراؤها مسبقاً على الحيوانات القريبة من الإنسان من حيث التكوين، وأن تكون نتائجها إيجابية، بحيث تشجع لإجرائها على الإنسان، والهدف من هذا الشرط هو الحد من الأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة، فمما لا شك فيه أن إجراء التجربة أولاً على الحيوان بعد اختبارها معملياً من شأنه تجنب المضار التي ظهرت على الحيوان عند تجريبيها عليه^(١).

٢٠٠٤م، ص ٤٠٥، د. خالد حمدي عبد الرحمن: التجارب الطبية، الالتزام بالتبصير،

الضوابط القانونية، دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠٠م، ص ٩٩.

(١) د. محمود أحمد طه: الأساليب الطبية المعاصرة، السابق، ص ٢٩٥.

المطلب الثاني

القيود الخاصة بالأشخاص الخاضعين للتجارب

أولاً: الرضا بإجراء التجربة:

تثير مسألة الرضا بإجراء التجارب الطبية على الإنسان إشكالية وقوع الاعتداء على جسم الإنسان وتعرضه للخطر، وفي المقابل هناك ضرورة طبية ومجتمعية لإجرائها، وخروجاً من هذا المأزق اشترط القائلون بالجواز الرضا من قِبَل الشخص الخاضع للتجربة.

وقد جاء اشتراط الرضا في التجارب الطبية ليتوافق مع طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض أدبياً وأخلاقياً، وتعارضها مع ضرورة إيجاد علاج فعّال، وقد اشترط الفقهاء الرضا في عقد العلاج الطبي وهو عمل مألوف، فمن باب أولى ينبغي اشتراطه عند إجراء التجارب، الذي يعد عملاً غير مألوف.

وقد اشترط الفقهاء فيمن يصدر منه الرضا المؤثر في إجراء التجارب جملة شروط، منها:

١ - التكليف: فالمكلف هو المحكوم عليه، وهو الشخص الذي تعلق خطاب الله بفعله، ولا يكون الشخص مكلفاً إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة، وقد قرر العلماء أن أهلية الشخص تتحقق بتوافر البلوغ والعقل.

وبناءً على ذلك، فالصبي ومن لا عقل له، كالمجنون والنائم لا يمكن تحصيل الموافقة منهما على إجراء التجارب الطبية، حيث إن كلاهما لا يفهم ما يوافق عليه، ولا يُدرِك مدى الخطورة التي من الممكن أن يتعرض لها، وقد رفع الإسلام القلم عنهم، فقد روت عائشة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ

الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْقِلَ" ^(١).

يقول الأمدى: "المجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيضاً إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يُطَاقُ، لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله، وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، غير أنه أيضاً غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل" ^(٢).

٢- أن يصدر الرضا عن إرادة حرة، غير متأثر بمؤثراتٍ أخرى، فيجب أن تكون إرادة الشخص خالية من عيوب الإرادة، فلا ينعقد الرضا صحيحاً إذا وقع تحت إكراه أو غش أو تدليس أو أي سببٍ آخر من شأنه أن يعيب الإرادة.

ويمكن اعتبار الرضا بمثابة الإذن، فالرضا يعني في جوهره إذن المريض للطبيب قي القيام بإجراء التجربة عليه.

والإذن في التجارب الطبية يتخذ إحدى صورتين:

الأولى: الإذن المطلق: وهو أن يأذن المريض للطبيب بإجراء التجربة المتفق عليها، مع السماح له بالقيام بأي عملٍ طبي آخر قد يرى الطبيب أنه مفيد للمريض، وفي هذه الحالة يكون للطبيب الحق في القيام بأي عملٍ يستدعي الأمر القيام به.

(١) السنن الكبرى، للبيهقي، ٢٦٩/٤، سنن النسائي، ١٥٦/٦، والحاكم في المستدرک وقال

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرک، ٣٨٩/١.

(٢) الإحكام، للأمدى، ١٩٩/١.

الثانية: الإذن المقيد: وهو تقييد المريض الطبيب في القيام بالتجربة فقط دون ما سواها من الأعمال، وحتى يكون هذا الإذن منتجاً لأثاره ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١- أن يصدر ممن يملك الحق في إصداره مع توافر الأهلية اللازمة للإصدار، ويتمثل ذلك في الشخص الخاضع للتجربة نفسه، أو من يقوم مقامه، سواء كان ولياً خاصاً أو ولياً عاماً كالحاكم.

٢- أن تكون صيغة الإذن دالةً على إجازة مباشرة الطبيب للتجربة صراحةً، وفي تقديره أن الإذن الضمني لا يعتد به في مسألة التجارب الطبية نظراً لخطورة المسألة وتعلقها بحياة الإنسان.

٣- أن تكون التجربة محل الإذن مشروعة، فإذا كان الفعل محل التجربة محرماً كان الإذن غير معتبر ولا قيمة له، لأن الأعمال الطبية - ومنها التجارب - ما أبيحت إلا لغرض جلب المصالح ودرء المفاسد.

وقد أكد ابن القيم ذلك بقوله: "لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه، ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن"^(١).

٤- أن يتم الحصول على الإذن قبل مباشرة العلاج، إذ القاعدة أنه لا يجوز لإنسان أن يتصرف في جسم إنسان آخر إلا بإذنه منه.

واشترط الرضا يوجب على الطبيب التزاماً رئيساً يتمثل في تبصير المريض، إذ يجب على الطبيب تبصير المريض بطبيعة التجربة ونوعية

(١) تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص ١٦٧.

العلاج المقترح، والمخاطر التي من الممكن أن تتحقق، وبناءً على ذلك فإن أي كذبٍ أو إخفاء أي معلومات تتعلق بالتجربة يعد من باب الخطأ الذي يستوجب المسؤولية، حيث إن المريض لا يستطيع أن يقبل أو يرفض تحمل المخاطر الناجمة عن إجراء التجربة إلا إذا تم تبصيره حتى يصدر الرضا عن بيئة وعلمٍ كاملٍ بحقيقة الأمر^(١).

ومع ضرورة هذا الالتزام إلا أنه وجد اتجاه في الفقه القانوني يرى أنه يجوز للطبيب أن يكذب على مريضه في حدودٍ معينة.

ولكن أنصار هذا الاتجاه وإن كان يرون أنه يجوز للطبيب الكذب على المريض في حدودٍ معينة، إلا أن هذا الكذب يجب أن لا يصل إلى جعل الرضا بالتجربة في حد ذاته معيَّباً، لذا ميَّز أنصار هذا الاتجاه بين نوعين من الكذب في هذا الخصوص:

الكذب الممنوع: ويعبر عنه بالكذب المتشائم، وهو الكذب الذي ينطوي على إخفاء العلامات، أو النتائج الحسنة عن المريض، وحمله على الاعتقاد بأن هناك علامات أو عواقب أكثر خطورة مما أظهرته الفحوص والتحاليل الطبية، وهذا الكذب لا يوجد ما يبرره؛ لأنه ليس في مصلحة المريض^(٢).

الكذب المتفائل: ويعبر عنه بالكذب المسموح، ويعني قيام الطبيب بإخفاء حقيقة المرض وعواقبه الوخيمة على المريض، ما دام ذكر الحقيقة

(١) د. عبد الرحمن هاشم: المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ١٩٩٤م، ص ٢٩.

(٢) د. عيد حومد: المسؤولية الطبية الجزائية، بحث منشور، مجلة الحقوق والشرعية - جامعة الكويت ١٩٨١م، ص ١٩٤.

لن يكون له إلا أثرًا سلبيا على حالته النفسية، ولن يفيد في علاجه.

ووفقاً لهذا الاتجاه فإنه يجب النظر إلى الهدف من وراء هذا الكذب، فالكذب لا يكون من قبيل الخطأ إلا إذا لم يكن في مصلحة المريض^(١).

وأرى أن ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه وإن كان مقبولاً في العلاج الطبي بشكل عام إلا أنه يصعب قبوله في مجال التجارب الطبية ففي تقديري أن الكذب بكل أنواعه ممنوع في نطاق التجارب الطبية، فيجب أن يتم تبصير المريض بالتجربة واحتمالاتها، والأخطار التي من الممكن تحقيقها بصدقٍ وشفافية، ولا يجوز الكذب على المريض بحجة استدراجه للموافقة على خضوعه للتجربة، وإن حدث ذلك فإنه يستوجب المسؤولية القانونية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: في أي مرحلة من المراحل ينبغي توافر الرضا؟

في هذا الصدد ينبغي التمييز بين نوعين من الفحوصات:

النوع الأول: الفحوصات التشخيصية: وهي الفحوصات المبدئية التي يجريها الطبيب على المرض محل التجربة بقصد تحديد مدى صلاحيته لإجراء التجربة عليه، ويطلق على هذه الفحوصات اسم الفحوصات النظرية، ويراد بها: إصغاء الطبيب لأقوال المريض فيما يتعلق ببياناته الشخصية، كالسن والجنس وتاريخ المراجعات السابقة، والمرض الذي

(١) د. منصور مصطفى منصور: حقوق المريض على الطبيب، بحث منشور بمجلة الحقوق

والشريعة - جامعة الكويت، العدد الثاني ١٩٨١م، ص ٢١.

يعاني منه وأعراضه.

النوع الثاني: الفحوصات التطبيقية: وهي الإجراءات الفنية التي يجريها الطبيب على جسد المريض بقصد التشخيص، كالكشف عليه بالوسائل الطبية وما إلى ذلك.

وهذا التشخيص التطبيقي يعتمد غالبًا على التشخيص النظري لتحديد مدى حاجة المريض إلى معرفة حقيقة مرضه عن طريق الفحوصات، وذلك لتحديد مدى صلاحيته لإجراء التجربة عليه.

إشكاليات الرضا في إجراء التجارب الطبية:

لا خلاف في سهولة التعرف على الرضا من الشخص المكلف الذي يستطيع التعبير عن إرادته، إلا أن الصعوبة تكمن في الأشخاص الخاضعين للتجربة، والذين يصعب التعرف على إرادتهم، إما لعجزهم الجزئي كالقاصر، والأسير والمحكوم عليهم بالإعدام، أو لعجزهم الكلي كالموتى.

أ- الرضا من القاصر:

القاصر خلاف المكلف، أي: الشخص الذي يرفع عنه حكم التكليف، ويطلق على الصغير دون البلوغ

حكم رضاء القاصر بالتجربة:

اتفق الفقهاء على أن الأعمال الطبية لا يجوز ممارستها على جسد القاصر؛ لأن إذن القاصر كعدمه، ولا يعتد به شرعًا، ويضمن الطبيب الأضرار التي يحدثها في جسد القاصر.

جاء في المغني: "وَإِنْ خَتَنَ صَبِيًّا بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ قَطَعَ سِلْعَةً مِنْ إِنْسَانٍ بغيرِ إِذْنِهِ، أَوْ مِنْ صَبِيٍّ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَسَرَتْ جَنَائِثُهُ، ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ غَيْرَ مَاؤُودٍ فِيهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ، أَوْ مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ فَعَلَهُ مَنْ أَذْنَا لَهُ،

لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا" (١).

وقال الشافعي: "وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبِيٍّ لَيْسَ بِإِنِّهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَوْلِي إِلَى خَتَّانٍ أَوْ طَبِيبٍ فَقَالَ: اخْتَنَ هَذَا أَوْ بَطَّ هَذَا الْجُرْحَ لَهُ أَوْ أَقْطَعَ هَذَا الطَّرْفَ لَهُ مِنْ قُرْحَةٍ بِهِ فَتَلَفَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ وَالْخَتَّانِ دِيَّتُهُ وَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَلَا يَزْجَعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى الْأَمْرِ بِشَيْءٍ وَهُوَ كَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ" (٢).

ومضمون ما سبق أن الأعمال الطبية التي تجري على جسد القاصر يلزم فيها إذن الولي، إلا أن الولي فيما يتعلق بالإذن في هذه الحالة مقيد بما فيه مصلحة القاصر.

وفي تقديري أنه يمكن تقسيم الأعمال الطبية التي من الممكن إجراؤها على جسد القاصر إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الأعمال الطبية العاجلة: وهي التي تتطلب تدخلاً سريعاً، حفاظاً على حياة القاصر، والتي يؤدي التأخر في التدخل فيها إلى إصابة القاصر بأضرارٍ بالغة، كما في حالات الحوادث والأمراض المفاجئة، ففي هذه الحالات لا يتوجب الانتظار لحين إذن الولي، وعلى الطبيب التدخل السريع، شريطة أن يكون تدخله وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، فإن لم يكن كذلك، كان ضامناً لما أتلفه من جسد القاصر.

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هذه الحالة، حيث قال عند ذكره لأقسام الأطباء: "طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعةً من رجلٍ أو صبيٍّ أو مجنونٍ بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبياً بغير إذن وليه فتلف،

(١) المغني، ٣٩٨/٥.

(٢) الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، الطبعة الأولى، دار الفكر، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، ٦/٦٥.

فقال أصحابنا: يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن، ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل" ^(١).

القسم الثاني: الأعمال الطبية غير العاجلة: وهي الأعمال التي لا تتطلب سرعةً في إجرائها ويمكن تأخيرها، كالعلاقات التي تتم على جسد القاصر من غير أن تتطلب سرعة، ولا يضر تأخيرها، فهذه الأعمال لا يجوز الإقدام عليها إلا بإذن الولي، وإن قام بها الطبيب من غير إذنه، وتلف منه شيء كان ضامناً.

القسم الثالث: الأعمال الطبية الخطيرة: والتي لا حاجة للقاصر بها، ويمثل لها بالتجارب الطبية على جسد القاصر، فإنه يجب التفريق بين نوعين من التجارب في هذا القسم:

التجارب الخطيرة: وهي التجارب التي تؤدي إلى آثار خطيرة على القاصر، كأن يحتمل فيها هلاكه، أو يصاب بأضرار خطيرة، كالعاهات والتشوهات، أو احتمال فقدان أحد أعضائه، أو أحد مقومات جسده، وهذا النوع من التجارب يحرم الإقدام عليه شرعاً، ولا عبرة بالموافقة الصادرة من الولي؛ لأن الإذن في مثل هذه الحالات خارج عن حدود الولاية، ولا يملكه الولي، وإن أذن الولي بذلك صار ضامناً.

التجارب العادية: وهي التجارب التي لا تحمل خطراً على القاصر من أي وجه كان، وهذه التجارب إن كان فيها مصلحة للقاصر، كأن تساهم في علاجه من مرض أصيب به، أو غير ذلك مما يحقق له فائدة، فلا حاجة إلى

إذن الولي في القيام بها، لأن فيها النفع للقاصر، أما إذا لم تكن للقاصر فيها مصلحة، وكان الغرض هو إيجاد علاجٍ لمرضى، أو غير ذلك مما يحقق تقدماً في الطب، فأرى أنه لا يجوز في هذه الحالة إجراء التجارب على جسد القاصر، حتى ولو أذن الولي، لأن هذه التجارب تنطوي على بعض التصرفات التي تؤدي إلى آثارٍ نفسيةٍ سيئة على القاصر.

والقول بضرورة الرضا الصريح والمستنير هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ٦٧ (٥/٧) حيث نص على أنه: "لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية، بصورة خالية من الإكراه - كالمساجين - أو لأغراض مادية - كالمساكين - ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر، ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقضها ولو بموافقة الأولياء".

ب- الرضا من الأسرى والمُسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام:

تعتبر مشكلة الرضا الصادر من الأسرى والمُسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام من المشاكل بالغة الأهمية في هذا الخصوص، لاسيما وأن الأسرى وكذلك المحكوم عليهم يفقدون جزءاً من إرادتهم نوعاً ما، ويكون ذلك في بعض الأحيان سبباً لإجراء التجارب عليهم، دون اعتبار لرضاهم.

فعلى سبيل المثال يستخدم بعض السجناء في التبرع بالدم قسراً في بعض الأحيان، أو يتبرعون مقابل تخفيف قيود السجن، وفي بعض البلدان يُسْتَحْدَمُ السجناء لإجراء التجارب الطبية عليهم رغماً عنهم، ويتم كذلك تجريب العقاقير عليهم قبل نزولها للأسواق^(١).

(١) د. محمد علي البار: إذن المريض وعلاج الحالات الميؤوس منها، مجلة مجمع الفقه

فهذه الفئة لا تتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رضاها، فتقييد حريتهم من شأنه أن يدفعهم للخضوع والموافقة من أجل الحصول على مكافأة أو خفض من العقوبة المقررة عليهم، وفي أحيان كثيرة قد يُنتزَع الرضا تحت الضغط أو الإكراه^(١).

وذهب البعض^(٢) إلى وجوب حظر التجارب الطبية التي تُجرى على السجناء، حتى ولو صدر منهم الرضا بإجرائها على أجسادهم؛ لأنهم يجدون أنفسهم في حالة تبعية أو ارتباط يرجع إلى حالتهم ذاتها، ولعل المناداة بذلك ليست إلا نتيجة لما حدث في العديد من الولايات الأمريكية من إخضاع المسجونين لإجراء التجارب عليهم قسراً.

إلا أن هذه الأمر كان محل نقدٍ من قبل الكثيرين، على أساس أن مشاركة المسجونين في التجارب الطبية والعلمية يُضفي عليهم قيمة، وليس من العدل استبعادهم منذ البداية، ففي ذلك تفرقة لا مبرر لها، ولكن كل ما يحتاجه الأمر مجرد تدابير خاصة تؤدي إلى حمايتهم دون اللجوء إلى الحظر العام^(٣).

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي إجراء التجارب على المساجين والمحكوم عليهم بالإعدام، شريطة توافر الرضا التام الخالي من العيوب التي من الممكن أن تشوب الإرادة، حيث ورد في قراره رقم ٦٧ (٥/٧) أن:

الإسلامي، ١٧٤/٧٢.

(١) د. حبيبة سالم راشد: النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، رسالة دكتوراة، كلية

الحقوق، جامعة عين شمس ٢٠٠٥م، ص ٤٣٣.

(٢) د. محمد عيد الغريب: التجارب الطبية والعلمية، السابق، ص ٧٩.

(٣) المرجع السابق، ص ٨٠.

"لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية شائبة من الإكراه - كالمساجين - أو لأغراض مادية - كالمساكين -، ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر".

وقد منع الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١م في المادة ٤٣ إجراء التجارب على المساجين، فنصت على أنه: "تحظر إساءة معاملة المسجونين المعتقلين بدنياً ومعنوياً"، فهذا النص - كما يرى فقهاء القانون - يجرم إجراء التجارب على المساجين، حيث يعتبر ذلك من باب الإساءة.

وفي تقديري أن هذا الأمر مخالف للواقع تماماً، فالنص يمنع فقط التجارب التي تتضمن إساءة، وبإعمال مفهوم المخالفة فإن التجارب التي لا تشمل على إيذاء أو إساءة للمسجون جائزة ومشروعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالتجارب التي تُجرى على المسجونين بموافقتهم الصريحة ورضاهم المستنير مع توفير كافة الضمانات لهم لا تعتبر من قبيل الإساءة، قياساً على غيرهم من الأحياء، أي أن جواز إجراء التجارب عليهم هو الأصل باعتبارهم أشخاصاً عاديين، ويستثنى من ذلك ما إذا وافق المسجون على ذلك بإرادته الحرة.

أما بالنسبة للأسرى، وهم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم واعتقالهم^(١).

والأسير لا يمكن الحكم عليه بأنه ذو إرادة حرة، نظراً للمؤثرات التي تقع عليه، وهي بلا شك مؤثرة على رضاه، والحكم في الأسرى هو عين

(١) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، تحقيق. محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، دار

الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، ص ١٤١.

الحكم في المساجين، غاية ما في الأمر أن تصرف الإمام في الأسرى منوطٌ بما يحقق مصلحة الجماعة، حيث قرر الفقهاء أن الإمام مخيرٌ في الأسرى بين خمسة أمور: إما القتل، وإما المن، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما عقد الذمة، ولكنه مُقَيَّدٌ في اختياره هذا بما يحقق مصلحة جماعة المسلمين^(١).

ومع تحقيق الإمام لمصلحة الجماعة، إلا أنه لا يغفل أيضاً مصلحة الأسرى، وبالتالي فيجوز إجراء التجارب على الأسرى شريطة ألا تكون مضرّةً بهم، ولا تؤثر على أجسادهم، مع ضرورة توافر الرضا التام المستنير، وصدوره عن إرادة لا تشوبها شوائب، أو يعيها عبٌّ من عيوب الإرادة، وفي حال رفض الأسير إجراء التجارب عليه، فليس من الجائز شرعاً إجباره على ذلك، لعدم إدراج هذا الأمر ضمن الأمور التي وضع الإسلام فيها الخيار في التعامل مع الأسرى.

ج- الرضا في التجارب على الموتى:

مبدأ الرضا في التجارب الطبية كما يسري على الأحياء يسري أيضاً على الأموات، فينبغي أن يكون الرضا بقبول إجراء التجربة الطبية صريحاً، وهذا الرضا يصدر من الميت قبل وفاته، شريطة توافر الشروط السابقة، أي

(١) يراجع تفصيلاً في توضيح هذه المسألة: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، مطبعة الحلبي - القاهرة، ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م، ١٢٥/٤، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، المعروف بالحطاب، طبعة دار الفكر ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ٣/٣٥٨، المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، ٢٨٠/٣، مطالب أولي النهى، ٥٢٠/٢.

لا يقع تحت ضغطٍ أو إكراهٍ، وإذا لم يصدر منه قبل وفاته ما يدل على الرضا، فيجوز لذوي الشأن أي الأقارب الموافقة على ذلك، شريطة أن تكون هناك حاجة ماسة لهذه التجربة، أما إذا وُجِدَتْ طرق أخرى يمكن الاستعاضة بها عن إجراء التجربة على الميت، فالأمر والحالة هذه أنه لا يجوز إجراء التجربة على الميت^(١).

وأجاز المشرع المصري استخدام الجثة لأغراضٍ علمية، شريطة موافقة ذوي الشأن، حيث نصت المادة ٢٦ من القانون رقم ١٣٠ الصادر عام ١٩٤١م على أنه "يجوز لمفتش الصحة أن يأذن بعدم دفن الجثة بناءً على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية، للاحتفاظ بها لأغراضٍ علمية، وذلك بعد موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفى".

ثانياً: التبصير بطبيعة التجربة ومدى خطورتها:

إذا كان الفقهاء وكذلك القانونيون اشترطوا في إجراء التجارب الطبية على البشر ضرورة الحصول على رضا الشخص الخاضع للتجربة، إلا أنهم لم يكتفوا بمجرد الرضا فقط؛ بل أوجبوا أن يكون الرضا صادراً عن إرادة مستنيرة، بحيث يتم فيها تبصير الشخص الخاضع للتجربة بكل الأمور المحيطة بها، فيجب أن يُبَصَّرَ بجوانب التجربة الطبية التي يخضع لها، لأن الطبيب بالنسبة للمريض، وفي أغلب الأحيان عالم يواجه جاهلاً في شأن العلوم الطبية، ومن هنا يتميز الطبيب بحيازته لكم هائل من المعلومات الطبية والإمكانات التي تجعل الشخص الخاضع للتجربة معه في مركز غير

(١) د. عبد المطلب عبد الرازق حمدان: مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الأدمي حيًا وميتًا في

الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية ٢٠٠٥م، ص ٤٣.

متعادل^(١).

وإذا كان إعلام الخاضع للتجربة وتبصيره ضرورياً لإجراء التجربة، فإن ما أثار الجدل هو طريقة الإعلام، لاسيما ما يتعلق بالضمانة التي يحققها الإعلام المباشر للشخص من قبل الطبيب، إلا أن طريقة الإعلام تعتمد في غالب الأحيان على إطلاع المعالج أو المتطوع بكل ما يتعلق بالعلاج الذي يجب أن يخضع له، أو بالتجربة التي يُقدّم على التطوع من أجلها، وعادةً ما تبدو مثل هذه المستندات في الواقع كما لو كانت محررة حمايةً للطبيب، وتفادياً للمنازعات التي قد تثور فيما بعد^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن أي تجربة لا تخلو من مخاطر تحيط بها، إلا أن الفقه القانوني قسم المخاطر إلى مخاطر مقبولة يمكن مع وجودها إجراء التجربة، ومخاطر غير مقبولة لا يمكن عقلاً أن تتم التجارب معها، وبناءً على ذلك اشترطوا في التجربة أن تكون المخاطر المترتبة عليها مقبولة، واشترط ذلك إنما كان لمصلحة الشخص الخاضع للتجربة، حتى تتوافر الجدية العلمية والالتزام الأخلاقي للبحث العلمي قبل الالتزام القانوني.

وإضافةً إلى ذلك يشترط وجود التناسب بين المخاطر المتوقعة من التجربة، وبين النتائج التي من الممكن تحصيلها من وراء إجراءاتها، حيث نصت المادة ٢/٢٠٩ من قانون الصحة العامة الفرنسي على أنه "لا يجوز إجراء التجربة إذا تجاوزت المخاطر المتوقعة بالنسبة للخاضع للتجربة حد

(١) د. سهير منتصر: الالتزام بالتبصير، السابق ص ١٦٩.

(٢) د. محمد عبد الغريب: التجارب الطبية والعلمية، السابق، ص ١٨٤.

التناسب مع الفوائد التي تعود عليه، أو المصلحة من وراء البحث".

وقد نصت مبادئ القانون الطبي الأمريكي على الضوابط المتعلقة بإجراء التجارب العلمية والفنية المحضة على الإنسان، ومنها:

- الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص الخاضع للتجربة العلمية.
- حماية الحياة الخاصة للأشخاص الخاضعين للتجارب العلمية.
- الحرص على حياة وصحة الشخص الخاضع للتجربة العلمية.
- العمل على تقليل الأخطار والمخاطر المرتبطة بالتجارب العلمية^(١).

كما وضعت الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة في فرنسا سنة ١٩٩٧م مجموعة من الشروط في هذا الخصوص، هي:

- ١- الرضا المستنير للشخص الذي سيخضع للتجارب الطبية.
- ٢- أن لا تتضمن التجربة أي خطر على حياة وصحة الخاضع لها؟
- ٣- لا يجوز إخضاع الأشخاص إلى تجارب متعددة في نفس الوقت.
- ٤- لا يجوز مباشرة التجارب الطبية إلا تحت إشراف أطباء ذوي كفاءات ومؤهلات علمية عالية يتولون الإشراف على إجراء التجارب العلمية، والتحقق من إجراءاتها وفقاً للأصول العلمية.
- ٥- أن لا توجد بدائل أخرى التحقيق نفس النتائج المتوقعة من هذه التجربة إلا بإجرائها على الإنسان.
- ٦- لا يجوز مباشرة التجارب الطبية العلمية إلا بعد الحصول على

(١) د. بلجاج العربي: أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - الأردن،

موافقة الجهة الإدارية المختصة، وبأن تجرى في المراكز التي تتوافر فيها الإمكانيات المادية والنفسية اللازمة.

٧- التزام الشخص أو الأشخاص القائمين بالتجربة الطبية بالتأمين من المسؤولية^(١).

(١) يراجع: الموافقة المتنورة، وثيقة من إعداد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض - المملكة العربية السعودية، ص ٤.

المطلب الثالث

القيود الخاصة بحماية المجتمع

أولاً: اتفاق التجارب الطبية مع قواعد النظام العام:

ينبغي حتى توصف التجارب الطبية على البشر بالمشروعية ألا تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، وهذا الأمر يتطلب أن تكون تلك التجارب متفقة مع النظام العام، وبالتالي يجب من حيث المبدأ تحريم التجارب التي تؤدي إلى العبث، أو تؤدي إلى نتائج مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية، ومن ذلك تحريم التجارب التي تتم بغرض تغيير الجنس، لمخالفة ذلك لأمر الله تعالى واعتباره من فعل الشيطان، قال تعالى ﴿وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ﴾^(١) كذلك تحريم التجارب التي يكون هدفها تحقيق نتائج علمية ليس لها تأثير من الناحية العملية.

واتفاق التجربة مع النظام العام يعني الجواز الشرعي، فالتجارب المحرمة لا أثر لها، ولا يعتد بالموافقة الصادرة بموجبها.

يقول ابن القيم: "..... كَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُ فِي قَطْعِ أُذُنِهِ أَوْ إصْبَعِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَسْقُطُ الْإِثْمُ عَنْهُ بِالْإِذْنِ"^(٢).

ثانياً: الالتزام بالأحكام الشرعية:

ينبغي على الطبيب الالتزام بالأحكام الشرعية المقررة في هذا

(١) النساء: ١١٩.

(٢) تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص ١٣.

الخصوص، ومنها:

١- تجنب النظر للعورات والاطلاع عليها: معلوم أن إجراء التجارب يعد من باب المداواة، وقد قرر الفقهاء أن النظر إلى العورات لا يجوز من حيث الأصل، أما إذا كان النظر أمراً محتوماً لا بد منه، فقد أوجب الفقهاء أن يكون النظر إلى موضع الحاجة فقط؛ لأن النظر في هذه الحالة من قبيل الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر عند الفقهاء.

يقول الكاساني: "الْقَابِلَةُ، وَالطَّبِيبُ يَنْظُرَانِ إِلَى الْفَرْجِ، وَيَمَسُّ الطَّبِيبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ" ^(١).

وقال الأزهري في الثمر الداني: " فيجوز للطبيب والجراح في النظر إلى موضع العلة وإن كانت في العورة" ^(٢).

وقال الشرييني: "الضرب الخامس: النظر للمداواة، كفصد، وحجامة، وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط" ^(٣).

وقال ابن مفلح: "وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى نَظَرِهِ، وَلَمَسِهِ حَتَّى دَاخِلِ الْفَرْجِ" ^(٤).

وقد ورد في السنة ما يدل على جواز النظر إلى العورة عند الحاجة، وهو ما حدث مع بني قريظة، فقد روي عن عطية القرظي قال: كُنْتُ مِنْ

(١) بدائع الصنائع، ١٨٢/٣.

(٢) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، طبعة المكتبة الثقافية - بيروت، ص ٦٦٠.

(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشرييني الخطيب، ٤٠٦/٢.

(٤) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، ٨٧/٦.

سَبَى بَنَى قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَتَبَتِ الشَّعْرَ قَتَلَ، وَمَنْ لَمْ يُنَبِّثْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنَبِّثْ^(١).

ويقول ابن القيم رحمه الله: "وَقَدْ كَانَ الْأَسْرَى مِنْ قُرَيْظَةَ يَدْعُونَ عَدَمَ الْبُلُوغِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْشِفُونَ عَنْ مَا زَرَهُمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَعْلَمُونَ بِذَلِكَ الْبَالِغَ مِنْ غَيْرِهِ"^(٢).

٢- عدم إفشاء الأسرار الخاصة بالخاضع للتجربة: أقرَّ الإسلام المحافظة على الأسرار على سبيل العموم، حيث قال ﷺ فيما رواه أبو سعيد الخدري: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضَى إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"^(٣).

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: "وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه"^(٤).

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية، وكذلك القوانين الوضعية المحافظة على أسرار المرضى، وهو التزام أخلاقي تمليه قواعد الشرف وعادات وأعراف المهنة، ولم يقتصر هذا الالتزام على العصر الحديث فقط؛ بل

(١) الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، برقم (٤٤٠٤)

٢٤٥/٤، صحيح ابن حبان، ١٠٤/١١، السنن الكبرى، للبيهقي، ٥٨/٦.

(٢) الطرق الحكمية، لابن القيم، طبعة مكتبة دار البيان، ص ٩.

(٣) الحديث أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، برقم (٣٦١٥)،

١٥٧/٤.

(٤) شرح النووي لصحيح مسلم، ٨/١٠.

عُرِفَ هذا الالتزام في العصور الفرعونية، وفي الهند عُرِفَ في الكتابين القديمين "الرجفية - الأجيرفيدا" وعرفه الإغريق، وكان يمثل هذا الالتزام الضمير المهني للأطباء، واهتمت الامبراطورية الرومانية بموضوع الأسرار الطبية هي الأخرى اهتماماً بالغاً^(١).

ووفقاً لمضمون هذا الالتزام يجب على الطبيب أو الفريق القائم بالتجربة المحافظة على أسرار الشخص الخاضع للتجربة، ولعل هذا الالتزام يستمد أساسه من العقد الذي يعد أساساً لمسئولية الطبيب في مواجهة مريضه^(٢).

فعلى الطبيب وفقاً لذلك الحفاظ على كل ما يتعلق بالتجربة مما يخص الخاضع لها، وليس للطبيب أو الفريق القائم على التجربة إفشاء أية أسرار أو معلومات متعلقة بها، وقد ورد في التراث الطبي الإسلامي ما يؤكد التزام الطبيب بذلك.

قال ابن الحاج: "ينبغي أن يكون - يعني الطبيب - أميناً على أسرار المريض، فلا يُطْلَعُ أحداً على ما ذكره المريض، إذ إنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك"^(٣).

ومع التزام الطبيب بالمحافظة على عدم إفشاء ما يتعلق بالتجربة، إلا أنه

(١) د. عبد الحميد الشواربي: شرح قانون العقوبات، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، طبعة منشأة المعارف - الإسكندرية، ص ٣٨٥.

(٢) د. علي حسين نجيدة: التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية، ١٩٩٢م، ص ٢٥٥.

(٣) المدخل إلى تحسين الأعمال بتحسين النيات، لابن الحاج، دار البيان، ١٩٨٤م، ٤/١٤٣.

يجوز له على سبيل الاستثناء إفشاء هذه الأسرار إذا كان له ما يبرره، كأن يجد هذا الشخص مصاباً بمرضٍ خطير يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، وذلك تطبيقاً لقاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

المبحث الرابع

المسؤولية عن إجراء التجارب الطبية

يجمع العلماء من أهل القانون على أن المسؤولية إما مدنية وإما جنائية، لذا فإن التجارب الطبية من الممكن أن تحقق فيها المسؤوليتين، وهو ما أتناوله في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية

المسؤولية المدنية في عمومها نظام يهدف إلى جبر الضرر الذي يحدث للشخص نتيجة فعل ارتكبه شخص آخر، وينحصر هدفها في إزالة آثار الفعل الضار عن طريق التعويض دون التعرض لشخص المتسبب في إحداث الضرر، فهدفها جبر الضرر وليس عقاب من ارتكبه.

والمتمفق عليه فقهاً وقضاءً أن المسؤولية المدنية إما عقدية أو تقصيرية:

فالمسؤولية العقدية: هي المسؤولية التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام عقدي، أي أنها تفترض وجود عقد يقوم أحد أطرافه بالإخلال بالالتزامات المفروضة عليه.

أما التقصيرية فلا تترتب على الإخلال بالتزام عقدي؛ بل مدارها الإخلال بالتزام قانوني هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير^(١).

(١) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية الالتزام بوجه عام - مصادر الالتزام، منشأة دار المعارف - الإسكندرية ٢٠٠٤م، ص ٦١٨، د. علي نجيده: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية، ص ٣٣٨.

وَيُجْمَعُ شرح القانون المدني على عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، بمعنى أنه إذا توافرت في الفعل الواحد شروط كل منهما فلا يجوز الجمع بين المسؤوليتين، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية، ويستحق التعويض، ثم بعد ذلك يتقاضى تعويضاً آخر بموجب المسؤولية التقصيرية، حيث لا يجوز استحقاق تعويضين عن ضررٍ واحد.

ولكن لا يوجد مثل هذا الإجماع الفقهي على جواز أو عدم جواز التمييز بين المسؤوليتين، فيذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا توافرت شروط كل من المسؤوليتين كان للمضروب أن يختار أحدهما، ويرفع المسؤولية استناداً لهما، بينما يذهب رأي ثانٍ إلى أنه إذا توافرت شروطهما فللمضروب أو الدائن أن يرجع على أساس دعوى المسؤولية العقدية وليس التقصيرية، لأن العلاقة الأصلية التي تربط بينه وبين المدين المسؤول هي علاقة تعاقدية أساسها العقد^(١).

والمستقرى للأحكام التي أوردها الفقهاء سواء فقهاء الشريعة أو فقهاء القانون يلحظ أن المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية قد تكون عقدية، وقد تكون تقصيرية، وهو ما أعرض له تفصيلاً في الفرعين الآتين:

(١) د. نزيه المهدي: النظرية العامة للالتزام - الجزء الأول - مصادر الالتزام، طبعة ٢٠٠٨م،

ص ٣٠٢، د. سليمان مرقس: أصول الالتزامات - مصادر الالتزام، طبعة دار النشر

للجامعات المصرية ١٩٦٠م، ص ٤٦٩.

الفرع الأول

المسؤولية العقدية عن إجراء التجارب الطبية

المسؤولية العقدية قوامها العقد، حيث إنها تتقرر بناءً على مخالفة أحد أطراف العقد للالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد.

والقاعدة العامة في الأعمال الطبية أن المريض يرتبط مع الطبيب بعقد، غاية ما في الأمر هي تحديد الطريقة التي يظهر بها العقد، وقد يكون هذا العقد مكتوباً، إلا أن أغلب تلك العقود تكون شفوية، أي تعقد بطريقة ضمنية، لذلك ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن مجرد فتح الطبيب عيادته وتعليقه لافتةً تدل على ذلك، فإنه بذلك يضع نفسه في موضع الشخص الذي يعرض الإيجاب، ويعد توجه المريض قبولاً يلاقي هذا الإيجاب، وبهذا يتم توافق القبول مع الإيجاب، وينعقد العقد صحيحاً فيما بين الطبيب والمريض^(١).

إلا أن الوضع في عمليات التجارب الطبية يختلف عن ذلك تماماً، فإذا كانت القاعدة العامة في العقود الاكتفاء بالرضا لانعقادها، فإن عقود التجارب الطبية يشترط فيها أن تكون مكتوبة، حيث إن ذلك هو المستفاد من نص المادة رقم ٣ من إعلان "هلسنكي" إذ ورد فيها ضرورة أن يكون عقد التجربة الطبية مكتوباً، وهو ما تطلبه الفقه الفرنسي الذي يرى أن الكتابة تعد أمراً ضرورياً، وأن وجود الشهود يمكن أن يكون مفيداً أيضاً،

(١) د. شيرين محمد القاعد: خصوصيات المسؤولية المدنية لجراح التجميل، رسالة

ماجستير - معهد البحوث والدراسات العربية ٢٠٠٩م، ص ٤٨.

وهو ما يتماشى مع ما تبناه المشرع الفرنسي، حيث نص في المادة ٩ - ٢٠٩ L من قانون الصحة العامة الفرنسي، حيث نصت على أن: "يصدر رضاء الشخص الخاضع للتجربة في الشكل المكتوب".

شروط تحقق المسؤولية العقدية في التجارب الطبية:

إذا كانت المسؤولية العقدية هي الأصل في المسؤولية المدنية، فإنه يشترط لتحقيقها في التجارب الطبية توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: وجود عقد بين الطبيب والمريض الخاضع للتجربة:

من الشروط البديهية لوجود المسؤولية العقدية في مسألة التجارب الطبية وجود عقد بين الطبيب القائم بالتجربة والشخص الخاضع لها.

وتجدر الإشارة إلى أن العقد المبرم بينهما في المقام الأول هو عقد رضائي، أي يكفي لانعقاده توافر الرضا، وهذا الرضا لا يقلل منه أن يشترط القانون شكلاً معيناً لإثبات العقد، حيث يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته، وبالتالي يظل العقد رضائياً حتى ولو اشترط القانون شروطاً شكلية لإثباته^(١).

الشرط الثاني: استيفاء العقد للأركان والشروط:

يجب أن يكون العقد مستوفياً للأركان والشروط حتى يكون محققاً للأثر الذي يترتب عليه، وإذا تخلف أحد هذه الأركان فإن العقد يكون باطلاً، وتتحول المسؤولية من عقدية إلى تقصيرية.

وبناءً على ذلك فكل عمل يخرج عن إطار العقد أو إطار الأعمال التي

(١) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، السابق، ص ٦٢٠.

تم الاتفاق عليها تكون مسؤولية المجرب عنها مسؤولية تقصيرية حتى ولو كان لهذه الأعمال الجديدة علاقة أو اتصال بينها وبين الأعمال الأولى التي تَمَّ الاتفاق عليها.

ويمثل لذلك باستعمال الطبيب المجرب النطف الفائضة عن عملية التلقيح الصناعي، أو العلاج الطبي في أغراض علمية مثل: الأبحاث الخاصة بالاستنساخ البشري دون علم أو موافقة صاحب النطف^(١).

(١) د. نسرین سلیمان منصور: مشكلات المسؤولية المدنية الناجمة عن إجراء الاستنساخ

على البشر، رسالة دكتوراة - كلية الحقوق - جامعة القاهرة ٢٠٠٨م، ص ٨٤.

الفرع الثاني

المسؤولية التقصيرية عن التجارب الطبية

تعرف المسؤولية التقصيرية في نطاق الأعمال الطبية بأنها: الجزء المترتب على عمل الطبيب نتيجة إخلاله بالتزام قانوني، وهو التزام يفرض عليه عدم الإضرار بالآخرين، ويعبر عنه بالخطأ غير المشروع، ومعياره: انحراف الطبيب في سلوكه وتصرفاته عن جانب الحيطة والحذر والتبصر، وعن بذل العناية اللازمة للمريض^(١).

والقاعدة العامة في مسؤولية الطبيب كما أقرتها محكمة النقض المصرية: أن الطبيب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة، ومسؤوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية، فقاضي الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه^(٢).

والأطباء من حيث تحملهم للضمان من عدمه إلى خمسة أقسام^(٣):

أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَادِثٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطْبُهُ تَلَفُ الْعُضْوِ أَوْ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

(١) د. محمد شفقة: المسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب، مجلة

المحامون السورية، العدد ٣ السنة الرابعة ١٩٧٩م، ص ١٣٩.

(٢) نقض مدني مصري في ٢٢/٦/١٨٣٦م، مجموعة القواعد القانونية برقم ١١٥٦.

(٣) زاد المعاد، لابن القيم، ١٢٨/٤ وما بعدها.

القسم الثاني: مُطِيبٌ جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِيبُهُ، فَتَلَفَ بِهِ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ الْمَجْنُونُ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طَبِّهِ لَمْ يَضْمَنْ.

القسم الثالث: طِيبٌ حَادِقٌ، أَذِنَ لَهُ وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَتْ يَدُهُ، وَتَعَدَّتْ إِلَى غُضْوٍ صَحِيحٍ فَأَتْلَفَهُ، مِثْلُ أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الْخَاتِنِ إِلَى الْكَمَرَةِ، فَهَذَا يَضْمَنْ.

القسم الرابع: الطَّيِّبُ الْحَادِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ، اجْتَهِدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضِ دَوَاءً فَأَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ، فَقَتَلَهُ، فَهَذَا يُخْرَجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

القسم الخامس: طِيبٌ حَادِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَقَطَعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ بغيرِ إِذْنِهِ، أَوْ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ حَتَنَ صَبِيًّا بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَتَلَفَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَضْمَنْ، لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ.

ويجمع الفقه الشرعي والقانوني على أن المسؤولية التقصيرية لها ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية.

الركن الأول: الخطأ الطبي في عمليات التجارب الطبية:

يعد الخطأ أول أركان المسؤولية التقصيرية في عمليات التجارب الطبية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهذا الخطأ يندرج تحت المفهوم العام الخطأ الطبي.

والخطأ الطبي هو: تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وُجِدَ في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول^(١).

(١) د. أحمد شوقي عبد الرحمن: مضمون الالتزام العقدي، طبعة المطبعة العربية الحديثة

وعرف أيضًا بأنه: إخلال الطبيب بواجبه، سواء القانوني أو العقدي، حيث يرتب كل خطأ طبي مسؤولية الطبيب، كما في حالة الخطأ عند عدم اتخاذ جانب الحذر والحيلة اللازمة^(١).

وينتج الخطأ الطبي عند إخلال الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه أصول مهنته، وليس عن إخلاله بالالتزامات التي يفرضها الواجب القانوني العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير، وبالتالي فقياس مسلك الطبيب عند تحديد الخطأ يقاس بمسلك الطبيب المعتاد الذي يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول^(٢).

ويمكن تعريف الخطأ الطبي في مجال التجارب الطبية بأنه: كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليه نظريًا وعلميًا وقت تنفيذ التجربة، أو إخلاله بواجبات الحيلة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله أضرارًا جسيمة، وكان بإمكانه تفاديها.

وهذا الخطأ لا يوصف بأنه تقصيري إلا إذا توافر فيه اثنان من العناصر:

العنصر الأول: عنصر التعدي: حيث يعتبر الطبيب متعديًا وفقًا لمعيارين،

(١) د. رمزي رشاد الشيخ: المسؤولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء، دراسة مقارنة في ضوء القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية ٢٠١٥م، ص ١٢٧.

(٢) د. محمد نصر محمد: المسؤولية المدنية والجناية للطبيب، الطبعة الأولى، مطبعة القانون والاقتصاد - الرياض، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، ص ١٩، د. أحمد محمود سعد: مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، دراسة تحليلية لاتجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين، طبعة ٢٠٠٣م، ص ٣٧١.

أحدهما شخصي، ويبنى على أساس حرص الطبيب وفطنته ومدى صلاحيته للقيام بالتجربة الطبية، والآخر موضوعي، حيث يُنظر فيه إلى الانحراف الذي صدر من الطبيب دون ما نظر إلى الأمور الشخصية الخاصة بالطبيب القائم بالتجربة ^(١) ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب فيها قواعد المهنة من الطبيب التدخل السريع دون حاجة إلى إذن أو موافقة، كما في حالات الحوادث التي لا تحتمل التأخير.

الثاني: العنصر المعنوي: ويعني في مجال التجارب الطبية: إدراك الطبيب لما وقع منه، إذ لا يكفي الانحراف عن السلوك؛ بل يجب إدراكه له، وعلمه بأن فعله يشكل جريمة أو فعل لا تجيزه قواعد المهنة.

والخطأ في مجال التجارب الطبية هو في المقام الأول خطأ مهني بالدرجة الأولى؛ لأنه يتعلق بمهنة الطب.

ويمكن القول: إن الخطأ في مجال التجارب الطبية يكتنفه شيء من الغموض، نظرًا لتعدد الصور التي يمكن أن يتوافر بها، ومن صوره:

- خطأ الطبيب في إجراء فحوصات ما قبل التجربة، مما أدى إلى خطأ في إجراءاتها.

- خطأ الطبيب في عدم مسايرة التطورات العلمية في المجال الذي يجري فيه التجربة، إذ يقع على عاتقه الالتزام باتباع الأصول العلمية والمستجدات المهنية في المجال الذي ينوي إجراء التجربة فيه، وبالتالي يسأل الطبيب عن الخطأ في إجراء التجربة إذا كانت القواعد التي استخدمها

(١) د. السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني - النظرية العامة للالتزام، ص ٨٨١.

قواعد قديمة؛ لأن من الواجبات الأساسية للطبيب أن يستخدم وسائل علمية حديثة حتى يكون ما عنده من العلم مسائرًا للعلوم الحديثة وقت إجراء التجربة.

- عدم كفاءة الطبيب للقيام بالتجربة، وذلك يقتضي توافر الخبرة التي تؤهله لأداء مثل هذه التجربة، إذ الأصل أن يكون الطبيب القائم بالتجربة مؤهلًا تأهيلًا كافيًا، فشهادة الطب لا تكفي لجعل الطبيب أهلاً للقيام بالتجربة؛ لأنها تتطلب دقة وعناية خاصة، لذا فإن الممارس العام لا يجوز له إجراء تجربة طبية على جسم إنسان حتى ولو كان الهدف منها العلاج.

- تقصير الطبيب في بذل العناية المطلوبة، لاسيما إذا كانت التجربة من قبيل التجارب العلاجية، حيث يلتزم الطبيب بفحص المريض فحصًا دقيقًا دون تسرع أو إهمال، وهذا يفرض عليه أن يقدم للمريض كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق استفادة المريض من التجربة، ويقع عليه أيضًا التزام بأن يسمع شكوى المريض، وأن يحصل منه على كافة المعلومات المتعلقة بالمرض، سواءً منه شخصيًا أو من أهله.

معييار الخطأ الطبي في الفقه الإسلامي:

اعتبر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الخطأ في التجربة سببًا من أسباب وجوب الضمان على الطبيب، إلا أن الخلاف وقع بينهم في المعايير التي يتم على أساسها الخطأ للطبيب، أو المعيار الذي يمكن بناءً عليه وصف فعل الطبيب بأنه خطأ يستوجب الضمان.

ف عند الحنفية: لا يضمن الطبيب الفعل الذي وقع منه إلا في حالتين:

الأولى: حالة كون الطبيب غير حاذق، أي غير متقن لمهنة الطب، أو على أقل تقدير ليس بارعًا في الفرع الطبي الذي تؤدي فيه التجربة، كأن

تكون التجربة مثلاً في مجال أمراض القلب، واختصاص الطبيب هو مجال أمراض العظام، أو أمراض الجهاز الهضمي، أي ليس بين التخصصين ارتباط، ومَرَدُّ ذلك أن التجربة غالباً ما تتسم بالدقة، وبالتالي يتوجب أن يكون الطبيب له اختصاص أصيل فيه حتى لا يؤدي إلى إهلاك النفوس.

الثاني: أن يكون الفعل الذي وقع فيه الطبيب والذي كان سبباً مباشراً غير معتاد، بمعنى لا يفعل مثله في هذا الظرف ^(١).

أما الملكية فقد فرقوا بين عدم المعرفة وبين الخطأ:

فإذا أعطى الطبيب المريض دواءً، فمات بعدما شربه، أو قطع منه شيئاً فمات من القطع، فلا ضمان عليه ما لم يثبت وقوع الخطأ.

أما إذا أخطأ الطبيب بأن أعطاه دواءً لا يصلح لمرضه فمات، أو تجاوز في العلاج فقطع ما لا ينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقاً ولم يعتمد، فالضمان على العاقلة، وإن كان غير حاذقٍ فعليه العقوبة ^(٢).

والمعيار عند الشافعية: أن يؤدي الطبيب عمله بدقة، وهو كذلك ما ذهب إليه الحنابلة ^(٣).

يقول الشافعي في الأم: "وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتَنَ غُلَامَهُ أَوْ يَبْطِشَ دَابَّةً فَتَلَفُوا مِنْ فِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مِمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتِلْكَ الصَّنَاعَةِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا

(١) رد المحتار، ٣٣٥/٢٤.

(٢) التاج والإكليل، ١٣١/١٠.

(٣) المغني، ٥٨/١٢.

لَا يَفْعَلُ مِثْلَهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ، وَكَانَ عَالِمًا بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ" ^(١).

وبناءً على ذلك فالطبيب القائم بالتجربة يكون ضامناً في الأحوال الآتية:

- إذا كان غير ماهرٍ في المجال الذي يُجْرِي فيه التجربة.
- إذا لم يتبع الأصول المهنية والقواعد التي يتوجب مراعاتها عند القيام بمثل هذه التجارب.
- إذا اتبع قواعد عادية في إجراء التجربة في الوقت الذي توجد فيه قواعد جديدة أفرزها التطور العلمي الحديث.

كيفية إثبات الخطأ في التجارب الطبية:

القاعدة العامة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وهو ما أقرّه النبي ﷺ بقوله: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ^(٢).

وفي مجال التجارب الطبية: فإن الخطأ الذي يقع من الطبيب القائم بالتجربة يقع عبء إثباته على المريض، فيقع عليه عبء إثبات أن الطبيب أخطأ خطأً مهنيًا عند قيامه بالتجربة، وأنه لم يراعِ الأصول المهنية، ولم يقم باتباع المستجدات في المجال الطبي فيما يتعلق بموضوع التجربة، أو أنه قصر في اتخاذ إجراءات السلامة والأمان التي كان يتوجب عليه اتباعها،

(١) الأم، ٤٢٨/٧.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم

ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم، برقم (٤٥٥٢) ٣٥/٦، ومسلم، كتاب الأفضية، باب

اليمين على المدعى عليه، برقم (١٧١١) ٣/١٣٣٦.

وهذا كله أمور إيجابية يمكن للمريض إثباتها.

ومع أن عبء إثبات الخطأ في مجال التجربة يقع على عاتق المريض، إلا أن هناك العديد من الإشكالات التي تقف عائقاً أمام الإثبات، ومنها:

١ - الحالة التي يكلف فيها المريض بإثبات واقعة سلبية، وذلك كما إذا طوّل المريض بإثبات انحراف الطبيب عن اتباع الأصول المستقرة في الفن الطبي.

٢ - صعوبة إثبات عدم قيام الطبيب ببذل العناية باعتباره واقعة سلبية لا يمكن إنكارها، وهنا يلجأ القاضي إلى الخبرة لاستظهار الحقيقة كما هو الحال في كل واقعة سلبية يمكن توصل المريض إلى ذلك من خلال إثبات أنه غير مباشر لها، أي من خلال إثبات واقعة إيجابية عكسية، ويكتفي القضاء هنا بالأدلة المقدمة من المريض على حصول الطبيب على موافقته من العمل الطبي^(١).

الركن الثاني: الضرر:

الضرر في اللغة: ضد النفع، والضرر: المصدر، والضرر: الاسم، وقيل: هما لغتان، فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضمنت الضاد إذا لم تجعله مصدرًا، كقولك: ضررت ضرًا^(٢).

والضرر على سبيل العموم هو: ما يستوجب التعويض، أو هو مساس بحق من حقوق الإنسان أو مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو

(١) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ٦٤.

(٢) مختار الصحاح، لسان العرب، مادة "ضر".

تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسده وحقه في الحياة، أو في ماله أو عاطفته أو شرفه أو غير ذلك ^(١).

وقيل: الضرر هو الأذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه ^(٢).

ويعتبر الضرر أحد الأركان الرئيسة للمسؤولية التقصيرية في التجارب الطبية، ويمكن تعريف الضرر الطبي الناشئ عن التجربة الطبية بأنه: أذى ألحقه الطبيب القائم بالتجربة بالمريض محل التجربة أدى إلى أضرار مادية أو معنوية.

وبناءً على ذلك فوجود الضرر شرط في تحقق المسؤولية التقصيرية، يستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديًا أو معنويًا.

صور الضرر في مجال التجارب الطبية:

إذا كان الضرر الطبي عبارة عن أذى يلحق بالشخص، وهذا الأذى قد يكون ماديًا وقد يكون معنويًا:

الضرر المادي في مجال التجربة الطبية:

يتمثل الضرر المادي في الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية، فالأذى الذي يلحق بالشخص من جراء التجربة الطبية قد يؤدي إلى عدم قدرته على الكسب، أو يكبده نفقات علاج عالية تفوق قدراته، مما يعد ضررًا ماديًا

(١) وائل تيسير محمد عساف: المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،

جامعة النجاح الوطنية - نابلس - فلسطين ٢٠٠٨م، ص ٩٣.

(٢) د. جلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب،

٢٠٠٤م، ص ٣٦٤.

كبيراً.

والضرر المادي في المجال الطبي يراد به: الخسارة التي تصيب الذمة المالية للمضرور، ويشمل هذا الضرر ما لحق المريض من خسارة، كمصاريف العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى، ونفقات إصلاح الخطأ^(١).

ويدخل في الضرر المادي كذلك الأضرار الجسدية، وهي الأضرار التي تصيب الإنسان في جسمه نتيجة الاعتداء عليه من الغير، سواء اقتصرَت هذه الأضرار على مجرد المساس بحق الإنسان في سلامة جسمه أو حياته، أو تعدت ذلك وترتبت عليها أضرار أخرى^(٢).

الضرر المعنوي في التجارب الطبية:

هو ما يصيب الشخص خارج نطاق المال، أي يصيبه في كرامته أو شعوره، والضرر المعنوي في التجارب الطبية يتمثل في عدة صور، منها: الخطأ في التجربة الذي يترتب عليه إصابة الشخص محل التجربة بعجز دائم، أو تعطيل منفعة عضو من أعضاء الجسد، بحيث تتولد لدى الإنسان مشاعر الأسى والحزن، أو إصابة المريض محل التجربة بتشوهاتٍ من غير الممكن علاجها، مما يُشعره بأنه إنسان غير سوي داخل المجتمع.

(١) أ/ بركات عماد الدين: التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية الأطباء المدنية،

دار الفكر الجامعي - الإسكندرية ٢٠١٧م، ص ٢٥.

(٢) د. طه عبد المولى: مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء

الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون - المنصورة - مصر ٢٠٠٠م، ص ٧٥.

وإذا كان الأصل أن الضرر في التجارب الطبية ينبغي أن يلحق الشخص محل التجربة مباشرة، فإن التساؤل الذي يثور، هل يجوز لغيره كالورثة مثلاً المطالبة بالتعويض؟ الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى:

موت الشخص الخاضع للتجربة: إذا قام الطبيب بإجراء التجربة، وترتب على ذلك موت الشخص محل التجربة، فالأمر والحالة هذه أنه يجوز للورثة المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية العقدية.

ولعل إخضاع هذه الحالة لقواعد المسؤولية العقدية يرجع إلى أن الخطأ الذي وقع من الطبيب هنا يستند إلى تقصيره في التزامه الذي أوجبه العقد، والذي تم إبرامه بين الطبيب ومورثهم^(١).

الحالة الثانية:

مطالبة غير الورثة بالتعويض: يجوز لغير الورثة المطالبة بالتعويض في حالة وفاة الشخص الخاضع للتجربة، كأن يكون الميت هو الذي يعولهم ويتكفل بهم، ولا عائل لهم سواه، فيحق لهؤلاء الرجوع شخصياً على الطبيب الذي قام بالتجربة؛ لأنه أخلّ بالتزامه العقدي إذا كان هذا التقصير هو الذي أدى إلى وفاة الشخص محل التجربة، مما ألحق بهم أضراراً مادية تتمثل في فقد من يعولهم، وأضراراً معنوية تتمثل في الحزن والأسى على فقد عزيز وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية، لأن من قام برفع الدعوى يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الذي أبرمه الخاضع للتجربة مع الطبيب

(١) د. خالد بن النوى: ضوابط مشروعية التجارب الطبية، ص ١٧٨.

المجرب^(١).

الركن الثالث: علاقة السببية:

علاقة السببية الركن الثالث، ويعني: ضرورة أن يكون الخطأ الذي وقع من الطبيب المجرب والضرر الذي أصاب الشخص محل التجربة علاقة سببية، أي أن الخطأ هو السبب في حدوث الضرر الذي لحق الشخص محل التجربة.

والأصل أن تحديد رابطة السببية في المجال الطبي من الأمور العسيرة نوعاً ما بسبب تعقد الجسم الإنساني وتغير حالاته، فقد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل خفية مردها طبيعة تركيب جسم الخاضع للتجربة واستعداداته، مما يصعب معه تبيينها^(٢).

إلا أن هذا لا يعني عدم البحث في مسؤولية الطبيب المجرب وخطئه، لذلك يقع على عاتق الطبيب المجرب التزاماً بالتأكد من حالة المريض واستعداداته وما لديه من حساسية خاصة قبل التدخل، ولا يعفي الطبيب المجرب من المسؤولية إلا إذا أثبت أن نتائج تدخله تعد غير متوقعة وضعيفة الاحتمال طبقاً للمجرى العادي للأمور^(٣) وإذا أثبت المضرور، الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادةً مثل هذا الضرر، فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور،

(١) د. حسين زكي الإبراشي: مسؤولية الأطباء والجراحين، رسالة دكتوراة - كلية الحقوق -

جامعة القاهرة ١٩٥٧م، ص ٨٢.

(٢) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، ص ١٧٠.

(٣) د. حسين زكي الإبراشي: السابق، ص ١٩١.

وللمسؤول نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سببٍ أجنبي لا يد له فيه، وهو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير^(١).

أما إذا صدر خطأ من المريض، وكان لهذا الخطأ أثره في إحداث الضرر، فإن مسؤولية الطبيب المجرب تنتفي ولا يمكن مساءلته، ومن أمثلة تلك الحالات: انتحار المريض أو تناوله لأشياء حرمها الطبيب صراحة، لِمَا لها من تأثير ضارٍ على المريض خلال فترة إجراء التجربة، إذ الضرر هنا يكون مرده خطأ المريض وليس الطبيب.

ويمثل لها أيضًا: بكذب المريض على الطبيب بإعطائه معلومات خاطئة لها تأثيرها على نجاح التجربة، كتعاطيه أدويةً معينة لم يصرح بها للطبيب، وكذلك بالنسبة للأضرار التي لا يمكن للطبيب توقعها^(٢).

(١) د. خالد بن النوى: ضوابط مشروعية التجارب الطبية، ص ٢٣٣.

(٢) د. حسين زكي الإبراشي: السابق، ص ٢٠٦، د. خالد بن النوى: السابق، ص ٢٣٤.

تدريبات على الوحدة الأولى

- ١- تناول تعريف التجارب الطبية موضعاً أهميتها.
- ٢- قسم العلماء التجارب الطبية إلى نوعين، اذكرهما، مبيناً خصائص كل منها
- ٣- من الضوابط التي وضعها المجيزون لإجراء التجارب الطبية ألا يكون فيها خطر، اشرح ذلك.
- ٤- بين حكم إجراء التجارب الطبية على الأجنة.
- ٥- صارت التجارب الطبية في الواقع المعاصر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، اشرح ذلك.
- ٦- بين صور الضرر في مجال التجارب الطبية.

حكم تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي

دكتور

أحمد محمد لطفي أحمد

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهننا الأشراف، وعضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قَدَّرَ الأرزاق لعباده تقديراً، وأفاض عليهم من بحر جوده وكرمه، وأرسل إليهم رسوله ﷺ مبشراً ونذيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ المبعوث للعالمين بكتاب ربه معلماً ولطريقهم منيراً.

وبعد

ففي ظل الثورات الهائلة التي يشهدها العالم اليوم في شتى مناحي الحياة، صار العقل البشري في مأزقٍ شديد، إذ إن بعض هذه التطورات فاقت إدراكه، ومن هذه الاكتشافات ما جاء لتحقيق الرفاهية، ومنها ما جاء علاجاً لمشكلاتٍ قائمة بالفعل منذ بدء الخليقة.

ومن قديم الزمان وُجِدَ العقم، وهو عدم القدرة على الإنجاب، ونظر الإسلام إلى الولد على أنه هبة من الله فقال سبحانه وتعالى ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ * وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّهُ لِلَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾^(١).

إلا أن نظرة الإسلام للعقم لم تكن تلك النظرة المستبعدة العاجزة المستسلمة، فمع اعتبار العقم وعدم الإنجاب رزق من الله إلا أنه اعتبره من قبيل الأمراض التي تستوجب العلاج، بل دعا الإسلام إلى التداوي، فقال

(١) الشورى: ٤٩، ٥٠.

ﷺ: "تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم" ^(١).

وفى الماضي لم يكن علاج العقم أمراً ميسوراً نظراً لضعف الخبرات وقلة الإمكانيات، فكانت الوسائل بدائيةً إلى حدٍ ما، وجاء العصر الحديث حاملاً معه أحدث الاكتشافات في علاج العقم، وهو التلقيح الصناعي، والتلقيح الصناعي ليس نوعاً واحداً؛ بل هو نوعان تلقيح داخلي وتلقيح خارجي، ويعتمد استخدام كل نوعٍ منهما على درجة العقم وأسبابه، فالتلقيح الداخلي يستعمل في الحالات البسيطة والممكنة العلاج بسهولة ويسر، أما التلقيح الخارجي فلا يُلجأ إليه إلا عند وجود أسباب قوية، مضافاً إليها فشل عمليات التلقيح الداخلي.

والتلقيح الخارجي قد يتم في إطار العلاقة الزوجية، وقد يمتد خارجها عن طريق دخول طرفٍ ثالث، أو أطراف آخرين لا علاقة لهم بالعلاقة الزوجية القائمة.

ومن بين صور التلقيح الخارجي تلك الصورة التي نحن بصدددها وهي مسألة "تأجير الأرحام" والتي تعتمد في أساسها على وجود طرفٍ ثالث مع الزوج والزوجة في تلك العملية مع اختلاف دور هذا الطرف في كل حالةٍ

(١) الحديث أخرجه ابن حبان، كتاب الطب، باب ذكر الأمر بالتداوي، برقم (٦) ٤٢٦/١٣، وأبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، برقم (٣٨٥٥) ٣/٤، والترمذي في سننه، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم (٢٠٣٨) سنن الترمذي ٨٣/٤٠، وقال: حديث حسن صحيح، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق. أحمد شاكر، وأخرجه الحاكم في المستدرک وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرک للحاكم ٢٠٨/١٠ تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.

على حدة، فقد يكون هذا الطرف امرأةً تؤجر رحمها لوضع اللقيحة المأخوذة من مني الزوج وبيضة الزوجة أيًا كانت علاقتها بالزوجين، أي سواءً أكانت أجنبية عنهما أم كانت من أقاربهما، أم كانت زوجة ثانية للرجل، وقد يتمثل دورها في أخذ البيضة منها، وتلقيحها بمنى الزوج ثم وضعها في رحم الزوجة، وذلك في حالة عدم صلاحية مبيض الزوجة لإفراز بويضات.

وفكرة تأجير الأرحام فكرة غريبة الأصل، وفَدَتْ إلى بلاد المسلمين بعد ذيوها وانتشارها في الغرب، إلا أنها وَجَدَتْ معارضةً شديدةً في بلاد المسلمين، وتجاوزها العلماء بين مجيزٍ ومانعٍ، وأدلى كُلُّ بدلوهِ فيها، مسترشداً بأدلته التي توصل إليها وما تقتضيه ظروف الواقع من وجهة نظره.

وقد استخرت الله تعالى محاولاً جمع شتات هذا الموضوع، ونظمت الحديث فيه في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة:

التمهيد: في أهمية البحث.

المبحث الأول: التعريف بتأجير الأرحام.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي لتأجير الأرحام.

المبحث الثالث: نسب طفل تأجير الأرحام.

الخاتمة: أهم نتائج البحث.

تمهيد

بظهور أول مولود بطريقة طفل الأنبوب في ١٠ نوفمبر ١٩٧٧م في بريطانيا على يد الطبيين - "استيتوا وإدوارد"، حيث قاما بتلقيح بويضة زوجة بمني زوجها، واشتهرت هذه الطفلة وتحديث عنها جميع وسائل الإعلام وراقبتها أنظار العالم ناعته إياها "بطفلة الأنبوب" تولدت بناءً على ذلك قضايا جديدة وأساليب تلقيح جديدة، ومن هذه القضايا:

بنوك المني، تجميد الأجنة، زرع الخصية، زرع الرحم، زرع المبيض، مواليد الكتالوج، الحمل بعد الوفاة للزوج^(١).

ولقد انتشرت قضية استئجار الأرحام بعد أن رفضت "ماري وايتهد" وهي "أم مستعارة" تسليم الطفلة المولودة التي حملتها بالنيابة إلى الزوجين "اليزابيث ووليام شيرن" اللذين كانا قد تعاقدوا معها^(٢).

فقام الوالدان بالتوجه إلى محكمة الأسرة في نيوجرسي وأقاما دعوى مطالبين ماري وايتهد - الأم المستعارة - بتسليم الطفلة إليهما، إلا أن القاضي حكم بأحقية "ماري وايتهد" في استعادة الوصاية المؤقتة على الطفلة، والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك خمسة شهور، أما "وليام" والد الطفلة فكان سعيداً إزاء هذا الحكم، ووعد بأن يسمح للسيدة "وايتهد"

(١) فقه النوازل، للدكتور. بكر بن عبد الله أبوزيد، ص ٢٥٩-٢٦٠، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

(٢) المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص ٣١٠، طبعة دار الحكمة -

بزيارة الطفلة مرتين في الأسبوع^(٣)

وحكم القاضي بصحة التعاقد، الذي أجراه الزوجان لدى المحامي "نويل كوين" صاحب الوكالة التي أشرفت على توقيع العقد، وقد أعلن كوين أن "ماري وايتهد" لم تكن أول أم بالوكالة في الولايات المتحدة؛ فقد رفضت قبلها أربع أمهات بالوكالة تسليم أطفالهن، إلا أن "ماري" كانت الأولى التي تصل قضيتها إلى المحكمة، وأضاف أن خمسة وستين طفلاً أمريكياً وُلِدُوا في ذلك العام وفق عقود تأجير الأرحام، وأن في أمريكا إثني عشر مركزاً لخدمة هذا النوع من الإنجاب^(١).

وفي مصر:

بدأت جذور هذه القضية عندما ذهب زوجان، الزوج يدعى يسري، والزوجة تدعى سماح، وهما من مدينة الإسكندرية في مصر، إذ توجها إلى الدكتور. عبد المعطى بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر آنذاك، لمعرفة رأي الدين في إمكانية استئجار رحمٍ بديلٍ لرحم الزوجة التي كانت حاملاً بالفعل، إلا أنها في الشهر التاسع من الحمل أصيبت بنزيفٍ حادٍ ترتب عليه فقد الجنين والرحم معاً، وكان رأى الدكتور. عبد المعطى بيومي بالجواز، معللاً ذلك بأن الإسلام يلبي حاجات البشر.

وكان الطبيب الذي أقنعهما بإجراء مثل هذه العملية هو الدكتور

(٣) إيمان عكور: هل الرحم قابل للتأجير قضية عاطفية في المحكمة تتعلق بإمكانية الولادة بالنيابة، جريدة الرأي الأردنية، عدد رقم ١٩٨٧، ٢٣، عن مجلة التايم، جامعة اليرموك: عمان، ص ١٢.

(١) المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص ٣١٠.

إسماعيل برادة طبيب النساء والتوليد، وأخبرهما أن هذه العملية والتي يجريها في مصر لأول مرة تُجرى منذ سنواتٍ طويلةٍ في أمريكا، وتكلفتها تصل إلى ما يربو على خمسة وعشرين ألف جنيه مصري، بخلاف أجر الأم البديلة.

وكانت الأم البديلة اسمها نجلاء، من أقارب الزوجة وهي مطلقة، وسبق لها الإنجاب، وتريد أن تقف بجانب الزوجة التعيسة من وجهة نظرها، وحفظاً للحقوق قام أطراف هذا العمل بكتابة تعاقدٍ قانوني لدى أحد المحامين.

لكن الزوجين أرادا التأكد من رأي الدين، فقاما بالتوجه إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر آنذاك، الذي أحال الأمر بدوره إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأي، وتم عرض الأمر على مجمع البحوث الإسلامية الذي أفتى بتحريم هذه العملية استناداً إلى رأى الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق وعضو المجمع، الذي أكد أن الجنين يتأثر بالوسط المحيط في الرحم الذي قد يكون سلبياً، ويؤدي إلى جعل الطفل مشوهاً، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الوالدين صاحبة البويضة، والأم المستأجرة، ومن وقتها وحتى الآن وما زالت الآراء متضاربة.

ورغم أن هذا الاستئجار مباح في الغرب فإن مشاكله لا حدود لها ووصلت إلى ساحات المحاكم قضايا كثيرة ومتنوعة متعلقة بهذا الأمر رغم وجود العقود المكتوبة بين الأطراف؛ لأن عملية الاستئجار هذه تتنافى مع الفطرة السوية، وفيها اعتراض على مشيئة الله وقدره باللجوء إلى الوسائل المحرمة شرعاً من خلال قرارات المجمع الفقهية في العالم الإسلامي التي استندت إلى آراء المنظمات الطبية الموثوق بها في عالمنا الإسلامي.

المبحث الأول التعريف بتأجير الأرحام

أولاً: تعريف الإجارة:

في اللغة:

الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته، وأجره الله أجرًا من باب قتل، ومن باب ضرب لُغَةً بني كعب، وأجره بالمد إذا أثابه، وأجرت الدار، قال الزمخشري: "وأجرت الدار على أفعلت فأنا مؤجر، ولا يقال: مؤاجر، فهو خطأ، ويقال: أجرته مؤاجرة، مثل عاملته معاملة وعاقدته معاقدة، ولأن ما كان من فاعلٍ في معنى المعاملة كالشاركة والمزارعة إنما يتعدى لمفعولٍ واحد، ومؤاجرة الأجير من ذلك، فأجرت الدار والعبد من أفعل لا من فاعل، ومنهم من يقول: أجرت الدار على فاعل فيقول: أجرته مؤاجرة"^(١).

وتستعمل الإجارة في اللغة ويراد بها الأجرة على العمل، كما تستعمل في العقد الذي يَرُدُّ على المنافع بعوض.

يقول القرافي: "إنه قد غلب على وضع الفعالة بالكسر للصنائع، نحو الصناعة والخياطة، والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجليلة نحو السماحة والشجاعة، وبالضم للمحتقرات كالكناسة والنخالة"^(٢).

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ص ٥.

(٢) الذخيرة، للقرافي، ٣٧١/٥، تحقيق. محمد حجي، طبعة دار الغرب - بيروت، ١٩٩٤م

المعجم الوسيط، مادة "أجر".

كما تطلق ويراد بها العوض، ومنه قوله تعالى ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾^(١)، ويطلق الأجر أيضًا بمعنى الجبر، قال ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت اليد، فهذان الأصلان، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله^(٢).

والإيجار مصدر أجره يؤجره مؤجرة وإيجارًا، أي اكتراه منه، وأصله من أجر الشيء أي أكراه، وأجر فلانًا على كذا أي: أعطاه أجرًا، والمضارع منه يأجر، ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ﴾^(٣) أي تكون أجيرًا لي، يقال: أجر الله عبده أي أثابه، واستأجره أي اتخذه أجيرًا، واثتجر أي طلب الثواب بصدقة ونحوها.

يقول الرافعي: "الإجارة وإن اشتهرت في العقد فهي في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير"^(٤).

وفى الاصطلاح:

اختلف الفقهاء في تعريف الإجارة، وجاءت تعاريفهم على النحو التالي:

(١) الكهف: ٧٧.

(٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ٦٢/١.

(٣) القصص: ٢٧.

(٤) لسان العرب، مادة "أجر"، فتح العزيز بهامش المجموع، ١٧٦/١٢، تحقيق. محمود

مسطر جي، طبعة دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦م.

- عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوضٍ هو مال ^(١)، وقيل: هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلوم ^(٢).
- وقال المالكية: هي تمليك منافع شيءٍ مباحةٍ مدّةً معلومةً بعوض ^(٣)
- وعند الشافعية: هي عقد على منفعةٍ مقصودةٍ معلومةٍ قابلةٍ للبدل والإباحة بعوضٍ معلوم ^(٤).
- وقيل: هي تمليك منفعة بعوض بشروط ^(٥)
- وقال الحنابلة: الإجارة عقد على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ تؤخذ شيئاً فشيئاً ^(٦)

ثانياً: تعريف الرحم في الإسلام: -

اهتم الإسلام برحم المرأة اهتماماً بالغاً، فوضع له من الأحكام ما يؤدي في النهاية إلى تقديسه وعدم امتهانه بعد أن كان الرحم ممتهاً في الجاهلية لا قيمة له ولا حرمة، فالثابت أن الأنكحة في الجاهلية كانت متعددة ومتنوعة، فمنها ما يسمى بنكاح الرهط، ونكاح الاستبضاع، وغيرهما وكلها أنكحة تجعل رحم المرأة سلعة مباحة أمام الرجال.

(١) المبسوط، للسرخسي، ٧٤/١٥، طبعة دار المعرفة - بيروت.

(٢) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، ١٠٥/٥، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

(٣) حاشية الدسوقي، ٢/٤، طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري، ٤٠٣/٢، طبعة دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.

(٥) حاشية الجمل، ٥٣١/٣، طبعة دار الفكر - بيروت.

(٦) كشاف القناع على متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٥٤٦/٣، تحقيق.

هلال مصيلحي مصطفى هلال، طبعة دار الفكر - بيروت ١٤٠٢هـ.

وهذه الأهمية البالغة للرحم إنما تقررّت لأنه يعدّ عضواً أساسياً وهاماً، ففيه ينبت الإنسان وتمر به أطوار التخليق المختلفة وهو بداخله، فهو يعتبر منبثاً للبذرة الإنسانية التي تتغذى بدم الرحم، ويعمل الرحم على صيانتها من الأخطار إلى أن يحين الموعد المقدر لخروجها، كما أن هذا العضو له من اسمه نصيب، حيث إنه يرحم الجنين بالمحافظة عليه، ويقوم كذلك بتوفير الظروف الملائمة له، فهو قرار مكين ومسكن قوى راسخ متين^(١).

والرحم في اللغة: هو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن^(٢).

واصطلاحاً: هو عبارة عن حويصلة صغيرة الحجم في أسفل التجويف البطني للمرأة يتسع ويكبر تبعاً لنمو الجنين بداخله إلى أن يصل إلى قمة تمدده في نهاية فترة الحمل، ثم يعود إلى حالته الأولى تدريجياً بعد خروج الجنين طفلاً^(٣).

وقد ورد ذكر الرحم في القرآن في أكثر من موضع، ومن هذه المواضع يفهم أن للرحم معنيين:

المعنى الأول: العضو التناسلي للمرأة، وهو المهد والفراش، والمحضن للنطفة الإنسانية يحيطها ويغذيها ويرعاها حتى تبلغ أوج نموها وكمالها، فيخرجها الله بشراً سوياً.

(١) د. مها الأبرش: الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ٤٦/١، طبعة

جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١٩٩٦م.

(٢) المعجم الوجيز، ص ٢٥٩.

(٣) د. عبد الحميد عثمان محمد: أحكام الأم البديلة " الرحم الظئر "، ص ٣٥، طبعة دار

النهضة العربية ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

ومن الآيات التي تحدثت عن هذا المعنى:

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^(٢)، وقوله تعالى: وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾^(٤).

المعنى الثاني: هو صلة القرب الناتجة عن الرحم وما يحمله، وهو الصلات الناتجة عن التزاوج، فالآباء والأبناء والأخوال والأعمام ومجموعة الأقارب وإن بعدوا يطلق عليهم لفظ الرحم^(٥).

ومن الآيات التي وردت دالة على هذا المعنى:

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^(٧)، وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾^(٨)، وقوله تعالى:

(١) آل عمران: ٦.

(٢) الرعد: ٨.

(٣) الحج: ٥.

(٤) البقرة: ٢٢٨.

(٥) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٣٨، طبعة الدار السعودية

للنشر والتوزيع، جدة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.

(٦) النساء: ١.

(٧) الأنفال: ٧٥.

(٨) محمد: ٢٢.

﴿فَارَدْنَا أَنْ يُدِلَّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾^(١).

وفى السنة: ورد ذكر الرحم في أحاديث كثيرة منها:

أ - ما روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته " ^(٢).

ب - ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، فقال: لك ذلك، ثم قال رسول الله ﷺ: اقرءوا إن شئتم " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم " ^(٣).

ومما سبق يتبين أن الله عز وجل شَرَفَ الرحم عن غيره من سائر أعضاء الجسم، وذلك لأن الرحم هو منبت البذرة الإنسانية، فيها تنمو وترعرع، يغذيها بدمه، ويحفظها من كل سوء حتى إذا آن موعد خروجها إلى الدنيا انقبض الرحم انقباضات متتالية حتى يخرجها إلى الدنيا سليمة دون أن يمسه بأذى، مع أن هذه الانقباضات الشديدة من الممكن أن تؤدي بحياة

(١) الكهف: ٨١.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، ٣١٥/٤، والبيهقي في السنن، كتاب قسم الصدقات، باب الرجل يقسم صدقته، ٢٦/٧.

(٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، ٢٢٣٢/٥، ومسلم،

كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ١٩٨٠/٤.

الجنين ولكن الله يجعل له سبيلاً ليخرج، ويجعل هذه الانقباضات متقطعة ولا تؤثر على حياة الجنين، لأنها تتجه إلى أسفل لتوسيع عنق الرحم بدلاً من الضغط المباشر على الجنين.

والرحم موضوع في وسط حوض المرأة، ويكون محمياً ومصوناً من كل أذى، وهو عضو عضلي أجوف ذو جدار ثخين ومتين، وهو كمثري الشكل، ويبلغ طوله ثلاث بوصات، وعرضه بوصتين، وسمكه بوصة واحدة في الأنثى البالغة، فإذا حملت المرأة فإن الرحم ينمو ويكبر حتى يملأ البطن من القص إلى العانة، أما حجم تجويف الرحم في الأنثى البالغة فلا يزيد عن مئيلترين، وفي نهاية الحمل فإن حجم الرحم يتسع لسبعة آلاف مئيلتر، أي أن حجمه يتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة، ووزن الرحم في غير أوقات الحمل لا يزيد عن خمسين جراماً، فإذا كان في نهاية الحمل فإن وزن الرحم يبلغ ألف جرام أو يزيد، أما محتويات الرحم فإنها تزن خمسة آلاف جرام، أي أن وزنه بمحتوياته يزيد أكثر من مائة مرة.

والرحم هو الجزء الوحيد في جسم المرأة الذي له هذه القابلية للتغير السريع من حالٍ إلى حال، وهو بذلك أسرع نمو يعرفه الجسم، حتى قيل إن أخطر السرطانات لا تنمو بسرعة نمو الرحم^(١).

تركيب الرحم:

يتكون الرحم من جسم وعنق، وكلاهما مكون من ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: طبقة البريتون التي تغطي جسم الرحم، وشيئاً من عنقه من الخلف.

(١) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٤ وما بعدها.

الطبقة الثانية: الطبقة العضلية، وهي عضلات سميكة غير إرادية، وتشتمل هذه الطبقة في ذاتها على ثلاث طبقات من الألياف، وهي: الطبقة السطحية، وأكثر أليافها طويلة.

الطبقة المتوسطة، وأليافها مختلفة الاتجاهات، وبعضها على شكل رقم ثمانية باللغة الإنجليزية.

الطبقة الداخلية، ومعظم أليافها دائرية، وترتكز حول عنق الرحم لتكون عاصرة للعنق.

وللعضلات وظائف عديدة أهمها: حماية غشاء الرحم الذي تنغرز فيه البويضة الملقحة لتصبح جنيناً، كما أن وظيفة العضلات قفل الأوعية الدموية العديدة عند الطمث وعقب الولادة ولولا ذلك لنزفت المرأة حتى الموت.

الطبقة الثالثة: الطبقة المخاطية، وهي الغشاء المبطن للرحم، وغشاء الرحم هي الغراس الوثير للنطفة الأمشاج التي تتعلق به وعن طريقه تتغذى وتنمو، وهذا الغشاء مكون من طبقات تتخللها الأوعية الدموية الكثيرة، والغدد الرحمية العديدة، وتقع هذه الطبقة بالذات تحت تأثير الهرمونات، ولها دورة شهرية كاملة تبدأ من سن البلوغ وتنتهي في سن اليأس.

قناة الرحم:

توجد للرحم قناتان على كل جانب واحدة، وتنتهي القناة بانتفاخ يعرف باسم البوق الذي يحيط بالمبيض بمجموعة من الأهداب، فإذا أفرز المبيض البويضة تلقفتها أهداب البوق وحملتة حاملاً رقيقاً ودفعته مجموعة من الشعيرات الدقيقة المبطنة لغشائه حتى تصل إلى الثلث الأخير منه، وهناك تبقى البويضة حتى تأتيها الحيوانات المنوية في رحلتها الطويلة المحفوفة

بالمخاطر، فإذا ما نجح حيوان منوى في تلقيح البويضة أصبحت البويضة الملقحة "النطفة الأمشاج" أي المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، عندئذ تبدأ هذه البويضة المخصبة في الانقسام حتى تصبح مثل الكرة، وتسير الأمور في قناة الرحم تدفعها شعيرات دقيقة في غشاء قناة الرحم حتى تصل إلى الرحم في ستة أيام، فإذا ما وصلت إلى الرحم فقد أدت قناة الرحم واجبها، وأسلمت أمانتها إلى الرحم، وهناك يستقبل الرحم البويضة الملقحة بعد أن مهد لها الفرش والبطائن وتنغرز فيه وتعلق بجداره، وتحاط بالدم الغليظ من كل جهة من جهاتها، فهي علقه عالقة بجدار الرحم، محاطة بالدم الغليظ من كل جهة، وبما أن العلقه لا تكاد تبين، ولا يظهر منها إلا هذا الدم الغليظ فقد أجمع المفسرون القدامى على أن العلقه هي دم غليظ، وأصابوا من جهة وأخطأوا من أخرى، فهي محاطة بالدم الغليظ ولكنها ليست هي ذاتها الدم الغليظ، وتدعى قناة الرحم أيضاً القناة المبيضية، كما تدعى قناة فالوب، نسبة إلى الطبيب الذي وصفها أول مرة^(١).

ومن خلال ما سبق فقد عرف البعض إجارة الرحم بأنه: موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة لا تنسب إليها لحساب امرأة أخرى وتسلم المولود لها بعد ولادته^(٢).

وانتقد البعض هذا التعريف من وجوه:

أولها: إنه تعريف غير مانع من دخول غير المعروف فيه، حيث اقتصر في

(١) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٤٢ وما بعدها.

(٢) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، ص

١٦٠، مطبوعات جامعة الكويت ١٩٩١م.

تعريفه على موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة دون ذكر العوض، وهذا لا يمنع من دخول الإعارة فيه.

الثاني: إنه تعريف غير جامع؛ لأنه عرفه بأنه حمل بويضة ملقحة لامرأة أخرى على أن يسلم المولود إليها بعد ولادته، وهذا غير جامع لأفراد المعرفة، لأن المولود قد يسلم إلى امرأة أخرى غير صاحبة البويضة كما في بعض صور استئجار الرحم.

الثالث: التعريف فيه تكرار، حيث كرر لفظ المرأة، ومن شرط التعريف الإيجاز في الحد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً^(١).

وعرفه البعض الآخر بأنه: عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعياً لزوجين استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجة^(٢).

وقيل في تعريفه أيضاً: هو عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على ألا ينسب المولود إليها^(٣).

ثالثاً: دواعي اللجوء لاستئجار الأرحام:

هناك عدة مبررات تؤدي إلى اللجوء لاستئجار الأرحام أهمها:

١- الدواعي الطبية، كأن يكون هناك مانع طبي يمنع المرأة من استخدام

(١) د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، ٣٤٦/١، ٣٤٧، طبعة كنوز

اشيلىا - السعودية - الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م.

(٢) د. حسان حتحوت: أطفال الأنابيب، ضمن بحوث مجلد الإسلام والمشكلات الطبية

المعاصرة، ص ١٨٩، القاهرة ١٩٩٨ م.

(٣) أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ٣٤٧/١.

رحمها وقيامه بالوظيفة التي أنيطت به، كأن تولد المرأة بدون أعضاء تناسلية أو بدون رحم، أو تكون مصابة بتشوهات أو مرض يجعل الحمل بالنسبة لها مستحيلاً.

٢- ألا تكون لدى المرأة القدرة على استكمال مدة الحمل حتى نهايته، أو تخشى حدوث مضاعفات شديدة تهدد حياتها كالإصابة بتسمم الحمل وغيره.

٣- الدواعي الاجتماعية، كأن تكون المرأة في مركز مرموق لا تستطيع مع الحمل القيام بواجباتها الوظيفية، وفي بعض الأحيان تريد المرأة الحصول على مولود بعيداً عن آلام الحمل والولادة والأوجاع المصاحبة لهما^(١).

(١) د. محمد علي البار: أخلاقيات التلقيح الصناعي، ص ٧٠ وما بعدها، طبعة الدار

السعودية للنشر والتوزيع - جدة ١٩٩٠م. د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي،

السابق، ص ١٦٢

المبحث الثاني الحكم الشرعي في تأجير الأرحام

إن بيان الحكم الشرعي في مسألة تأجير الأرحام ليس بالأمر اليسير، فهو يقتضي بيان الصور التي قد يتم بها، وإعطاء الحكم الشرعي في كل حالة على حدة، وأبين ذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: صور تأجير الأرحام.

المطلب الثاني: الزرع في رحم الزوجة الأخرى للزوج صاحب النطفة.

المطلب الثالث: استئجار رحم امرأة أجنبية.

المطلب الأول صور استئجار الأرحام

لم يقف التطور العلمي عند حدٍ معين، ولم يجد من الضوابط ما يمكن أن يوقفه، خاصة إذا كان في الأمر مصلحة على الأقل من وجهة نظر العلماء، وقد وُجِدَ التلقيح الصناعي وخاصة ما يتعلق منه بتأجير الأرحام تطوراً ملحوظاً، وأعمل الأطباء عقولهم في ابتكار طرق جديدة وصور متعددة يتم بها الوصول إلى نتائج أفضل ونسب أعلى، والمتتبع للتطور الطبي في هذا المضمار يجد أن هناك عدة صور لتأجير الأرحام، وهي:

الصورة الأولى: الزرع في رحم امرأة أجنبية عن العلاقة الزوجية، وذلك بعد أخذ الحيوان المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة وتلقيحهما في الخارج، ثم يعاد زرعها في رحم تلك المرأة الأجنبية^(١).

(١) د. عيسى نضال: الطب الوقائي بين العلم والدين، ص ٢٥٣، طبعة دار المكتبي - سوريا،

وتعد هذه الصور هي الأكثر شهرة في عالم تأجير الأرحام.

الصورة الثانية: الزرع في رحم الزوجة الثانية للرجل، حيث تكون له زوجتان إحداهما سليمة المبيض معتلة الرحم، والأخرى عكسها، أو تكون الزوجة الثانية سليمة من الناحيتين، فتؤخذ البويضة من الزوجة معتلة الرحم، والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية^(١).

الصورة الثالثة: التبrec بالبويضة من قبل امرأة أجنبية، وهذه الصورة يلجأ إليها إذا كانت الزوجة عاقراً بحيث لا يفرز مبيضها بويضات، إذ يتم أخذ البويضة من امرأة متبرعة والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة.

الصورة الرابعة: في هذه الصورة تنعدم العلاقات بين أطراف العملية، إذ إن كلاهما أجنبي عن الآخر، وفي هذه الصورة تؤخذ البويضة من امرأة أجنبية، والحيوان المنوي من رجل أجنبي، وتوضع بعد تلقيحها في رحم امرأة أجنبية، وبعد تمام الوضع يعطى الجنين لامرأة أخرى هي التي أنفقت على العملية، وهذه الصورة يلجأ إليها في حالة عدم قدرة الزوجين كلية عن الإنجاب^(٢).

الصورة الخامسة: تؤخذ البويضة من الزوجة ويؤخذ الحيوان المنوي من

(١) د. محمد علي البار: طفل الأنبوب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثانية، العدد

الثاني، الجزء الأول، جدة: منظمة المؤتمر الإسلامي، ١٤٠٧هـ، ص ٢٨٢.

(٢) في نفس المعنى: د. علي عارف: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ٨١٣/٢، طبعة

دار النفائس - الأردن، ٢٠٠١م.

الزوج، ويتم تلقيحها خارجياً في طبق في المعمل، وبعد تلقيحها تُنقل اللقيحة إلى جسم متبرعة بالرحم، على أن يكون هذا الأمر بعد وفاة الزوجين.

الصورة السادسة: تلقح بويضة الزوجة بماء رجل غريب ليس زوجها، ثم تُزرع اللقيحة أو الجنين المجمد في رحم امرأة أجنبية، وتستعمل هذه الصورة في حال كون الزوج عقيماً، والزوجة عندها خلل في رحمها ولكن مبيضها سليم^(١).

الصورة السابعة: تؤخذ بويضة من الزوجة وحيوان منوي من الزوج، ويتم تلقيح البويضة خارجياً، ثم توضع اللقيحة في رحم أنثى حيوان يصلح لاحتضان البويضة الملقحة، فيحل رحمه محل رحم المرأة لفترة من الزمن، ثم يعاد الجنين بعدها إلى رحم الزوجة^(٢).

وباستقراء الصور المستخدمة في الواقع العملي يتضح أن الصورتين الأولى والثانية هما الأكثر استعمالاً، لذا أفصل القول في حكمهما الشرعي، أما باقي الصور فقد وقع الاتفاق على تحريمها.

(١) المرجع السابق، ص ٨١٦.

(٢) د. محمد عقلة: نظام الأسرة في الإسلام، ١/١٥٦، طبعة مكتبة الرسالة الحديثة - عمان،

المطلب الثاني

الزرع في رحم الزوجة الأخرى للزوج (الضرة)

تعد هذه الصورة إحدى صور التلقيح الصناعي الخارجي، وفيه يكون للرجل زوجتان أو أكثر فتؤخذ البويضة من إحداهن، والحيوان المنوي من الرجل ثم تزرع في رحم الزوجة الأخرى.

وقد عرضت هذه الصورة لأول مرة عام ١٤٠٤هـ في الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، وأصدر المجلس قراراً بجواز هذه العملية، إلا أنه مع الاستنكار الشديد من العلماء اضطر المجمع لنظر القضية مرة أخرى على المجمع في الدورة الثامنة في عام ١٤٠٥هـ، وأصدر المجلس قراره بالتحريم القاطع لهذه الصورة.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يرى أنصاره أن الإخصاب مع استخدام رحم الزوجة الثانية للرجل أمر محرم ولا يجوز فعله، وهو ما ذهب إليه أغلب العلماء المعاصرين والمجامع والندوات الفقهية التي عقدت لبحث هذا الموضوع^(١)

(١) يراجع: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٤) د ٨٦/٥٠/٣، د. محمد علي البار: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي، السابق، ص ١٢١، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ٣٥٠، د. عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، ٣٩٠/٩ وما بعدها، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م. د. محمد عباس: حول طفل الأنبوب، مقال منشور بمجلة الأزهر، محرم ١٤٠٥ هـ، ص ٢٠٣ وما بعدها، آراء في التلقيح الصناعي، للشيخ بدر المتولي عبد الباسط موجود على الموقع الإلكتروني:

القول الثاني: يرى جواز زرع اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل، وهو قول بعض المعاصرين كالدكتور عمر الأشقر، والشيخ محمد علي التسخيري^(١).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بتحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية بما يلي:

أولاً: استدلوا بآيات عديدة من القرآن الكريم، منها: قوله تعالى ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ﴾^(٢) وقوله تعالى ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾^(٣) وقوله تعالى ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾^(٤) وقوله عز وجل ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾^(٥).

حيث بَيَّنَّتْ هذه الآيات أوصاف الأمومة التي أُتِطَّتْ بها الأحكام

http://www.islamsat.com/arabic/abioothics/engab.htm، ندوة جمعية العلوم

الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية بعنوان "قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية" عام ١٩٩٢ م، ص ١٣٤.

(١) د. عمر سليمان الأشقر وآخرون: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ٢ / ٨٢١، طبعة

دار النفائس - الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، مناقشات مجمع الفقه

الإسلامي في دورته السابعة ١٤٠٤ هـ، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ضمن مجلد

الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ص ٨٣ وما بعدها، مطابع الطوبجي - القاهرة.

(٢) لقمان: ١٤.

(٣) الأحقاف: ١٥.

(٤) الزمر: ٦.

(٥) المؤمنون: ١١، ١٢.

الشرعية، ومفادها أن الأمومة لها وصفان: وصف التكوين، ووصف الحمل والولادة، فأصل التكوين هي البويضة، وأصل الحمل والولادة هو الرحم، وفي مسألتنا وُجِدَت الأولى يقيناً، وانعدمت الثانية قطعاً، الأمر الذي يجعل هذا الفعل محرماً^(١).

ثانياً: إن مثل هذا الفعل يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم، إذ قد تحمل الزوجة صاحبة الرحم من زوجها في ذات الوقت، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على هذه الحالة فقال: "احتمال حمل الزوجة التي زرعت فيها اللقيحة قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين، ولا يُعْلَم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، أو قد تموت علقة أحد الحملين، ولا يعلم أمه الحقيقية مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب من جهة الأم"^(٢).

المناقشة:

نوقش الاستدلال السابق بمناقشتين:

الأولى: إن احتمال حمل صاحب الرحم قبل انسداد الرحم وإن كان وارداً من الناحية النظرية إلا أنه مستبعد من الناحية العملية؛ لأن صاحبة الرحم هذه تحتاج إلى فترة إعداد، وغالباً ما يمنع الاتصال الجنسي مع زوجها في هذه المرحلة، إذ إنها لا تخرج غالباً من المستشفى إلا بعد أن

(١) في نفس المعنى د. بكر أبو زيد: فقه النوازل، ٢٤٧/١، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت،

الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن أطفال الأنابيب رقم (٤) د ٨٦/٠٧/٣.

توضع اللقيحة فيها^(١).

الثانية: من المعلوم بديهيًا أن نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية - الضرة - لا يكون إلا بعد التأكد من خلو رحمها من الحمل، وامتناع الجماع بينها وبين زوجها لحين التأكد من حصول الحمل، وبالتالي لا يترتب على ذلك أي اختلاط للأنساب، فيكون هذا النوع من التلقيح بناءً على ذلك مباحًا^(٢).

الجواب: يجب عن هذه المناقشة بأن هذه الصورة مؤدية إلى اختلاط الأنساب حتى مع منع هذا الاحتمال؛ لأن هذه الطريقة في الإنجاب تؤدي إلى الاشتباه في تحديد الأم الحقيقية للمولود، وهل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم^(٣).

ثالثًا: استدلوا بقياس على السحاق بجامع أن كلاً منهما وُضِعَ لماء امرأة أجنبية في رحم أخرى، وَلَمَّا كان السحاق محرماً كان التلقيح بهذه الصورة هو الآخر محرماً^(٤).

المناقشة:

نوقش قياس وضع النطفة في رحم الزوجة الأخرى للرجل على السحاق بأنه قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:

أ - اختلاف القصد والهدف في كل منهما، فالقصد من السحاق هو

(١) مناقشات مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢٣٣.

(٢) د. سعيد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ٣٦٥/١.

(٣) المرجع السابق، ٣٦٥/١.

(٤) د. عمر الأشقر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، السابق، ٨١٩ / ٢.

الحصول على المتعة واللذة وقضاء الشهوة، بخلاف التلقيح، إذ الهدف منه الاستيلاد والحصول على الولد.

ب- إن السحاق لا ينتج عنه نقل بويضات من طرف إلى الطرف الآخر، أما في التلقيح فيتم نقل بيضة عن طريق عملية جراحية.

ج - إن السحاق هو إتيان المرأة المرأة من أجل الحصول على اللذة، وهذا الفعل لا يتضمن الإنزال داخل الفرج، أما غرس اللقيحة فيتضمن نقل ماء المرأة إلى رحم امرأة أخرى^(١).

وابتعا: استدلوا على التحريم بالقاعدة الفقهية التي تقضى "أن الأصل في الفروج التحريم" حيث أوضحت القاعدة أن كل أمر يتعلق بالفروج حرام إلا ما ورد الدليل بجوازه في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾^(٢) وبناءً على ذلك فإن المني إذا كان من الزوج جاز استدخاله في رحم زوجته؛ لأنه لم يخرج عن نطاق الحياة الزوجية، فهو مما ورد الدليل بجوازه، أما اللقيحة التي تُزرع في رحم غير رحم المرأة المأخوذ منها فهي غير جائزة حتى ولو تم تلقيحها بماء الزوج، لأن الجائز والمباح هو ماء الزوج فقط، واللقيحة ليست من ماء الزوج فقط، بل هي خليط من ماء الزوج وماء الزوجة، فاللقيحة في هذه الحالة اجتمع فيها المحظور والمأذون فيه، والقاعدة أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قُدِّم جانب الحظر فيه

(١) المرجع السابق، ص ٣٨١.

(٢) المؤمنون: ٥ - ٧.

على جانب الإباحة خاصةً إذا كان يتعلق بالفروج^(١).

خامساً: قرر الفقهاء أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح، وفي التبرع بحمل اللقيحة مفسد تفوق ما فيه من مصالح، إذ تؤدي إلى نزاعات وخلافات، وكل ما أدى إلى النزاع والشقاق كان حراماً.

المناقشة:

يناقش هذا الدليل بأن هذه الخلافات والنزاعات يمكن التغلب عليها عن طريق العقد الذي يتم بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم والذي توضح فيه كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها والواجب اتباعها.

الجواب:

نسلم لكم أن هذا العقد قد يحسم الخلافات والنزاعات، ولكن هذا من الناحية النظرية، أما من ناحية الواقع العملي فالأمر يخالف ذلك تماماً؛ لأن غريزة الأمومة التي وضعها الله في المرأة كفيلة بجعل المرأة تضحي بكل شيء في سبيل الحصول عليها، وشعور المرأتين أن كل واحدةٍ منهما شاركت في تكوين الطفل يجعلها تشعر أنها هي الأم الحقيقية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى النزاع والخلاف^(٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على قولهم بإباحة وضع اللقيحة في رحم

(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٦١، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى

١٤٠٣هـ، د. سعيد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ١/٣٦٦.

(٢) في نفس المعنى: د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق،

١/٣٦٧.

الزوجة الأخرى للزوج بما يلي:

أولاً: إن هذه العملية ليس فيها اختلاط للأنساب، ولا توجد فيها مفسدة من مفسد الزنا.

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بمناقشات ثلاث:

المناقشة الأولى: إن تعليل الجواز بعدم اختلاط الأنساب وعدم وجود مفسدة من مفسد الزنا لا يكفي كدليل لإباحة هذه الحالة، بل لا بد من إقامة الدليل على الحل؛ لأن الزنا ليس هو الوحيد المحرم من بين الأشياء المتعلقة بالفروج، وإنما يوجد غيره، فهو ليس إلا أحد الأفراد التي شملها أصل التحريم.

المناقشة الثانية: دعوى عدم اختلاط الأنساب في هذه الطريقة مردودة؛ لأن فيها اختلاط للأنساب من جهة عدم معرفة الأم الحقيقية للمولود هل هي صاحبة البيضة أو صاحبة الرحم.

المناقشة الثالثة: إن الفقهاء اتفقوا على تحريم أشياء تتعلق بالفروج كالسحاق مع أنه لا يعد زنا مما يدل على أن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما ورد الدليل بحله، ونقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى لم يرد دليل بجوازه ^(١)

ثانياً: إن القرآن الكريم حدد موضع الحرث في المرأة، وفي مسألتنا كلتا الزوجتين حرث لصاحب النطفة، وبالتالي فلا مانع من حمل إحداهن

(١) المرجع السابق، ٣٦٨/١.

لقيحة الأخرى.

المناقشة:

نوقش الاستدلال السابق بمناقشتين:

الأولى: ما سبق وأن أوضحناه من أن ذلك عرضة لاختلاط الأنساب.

الثانية: إنه في حالة تعدد الزوجات يتم كل زواج بعقد مستقل بين رجل وامرأة، أي أنه عقد خالٍ عن التثليث، وبالتالي يجب أن يكون كل حمل هو ثمرة اثنين مزوجة لا مثالثة، وتظل كلتا الزوجتين خارج نطاق عقد زواج الزوجة الأخرى، مع أن زوجهما واحد، فلا بد من اشتراك الزوجين يقينا في صلة التكوين والوراثة، ولا بد أيضًا أن يكون الحمل والولادة من الزوجة صاحبة البيضة؛ لأن الأبوة والأمومة هي مجموع الهيئة الحاصلة لمولود وقع لقاحه وتكوينه بماء أبويه على فراش الزوجية فحملته أمه في بطنها ^(١).

الرأي الراجح:

من خلال ما سبق عرضه من قولي الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها يظهر لي أن الراجح والأولى بالقبول هو القول بتحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج، وذلك لما يلي:

١- إن الصورة التي نحن بصددھا لا تنطبق عليها شروط حالة الضرورة أو الحاجة؛ لأن الزوجة صاحبة الرحم إذا كانت سليمة المبيض فإن الزوج

(١) د. بكر بن عبد الله أبو زيد: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي، مجلة

مجمع الفقه، العدد الثالث، ٤٣٧/١، د. السيد محمود مهران: الأحكام الشرعية والقانونية

للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، السابق، ص ٥٩٣.

يمكنه الإنجاب منها مباشرة دون حاجة لبيضة زوجته الأخرى صاحبة الرحم المعطل، أما لو كانت صاحبة الرحم معتلة المبيض، وكلتاهما لا يمكنهما الإنجاب، فإن من البدائل المشروعة في هذه الحالة هو الزواج بأخرى.

٢- إنه لا يجوز التذرع بتحقيق رغبة المرأة المعتلة المبيض في الإنجاب، لأن الرغبة الجديرة بالاعتبار الشرعي هي رغبة من يصلح لأداء دوره الإنجابي ولو بالعلاج أو التلقيح الصناعي دون حاجة لتدخل غيره لمساعدته أو القيام مقامه في هذا الدور، مع ملاحظة أن الرغبة إذا تعارضت مع محظور شرعي فإن اتباع الشرع أولى وأكد^(١).

٣- إن حفظ النسل وما يترتب عليه من صيانة للأنساب يعد أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وفي سبيل تحقيق هذه المصلحة حرمت الشريعة كل ما يمكن أن يؤدي من قريب أو بعيد لحفظها.

٤- إن القول بجواز هذه الصورة من صور التلقيح - كما سبق أن أوضحناه - يؤدي إلى نزاعات كثيرة، وهذه النزاعات تكون بين أفراد تربطهم علاقات أسرية، مما يؤدي إلى قطع أواصر الروابط فيما بينهم وإذا تم حسم الخلاف بالقضاء - مثلاً - فإن الآثار النفسية لن تزول، بل تبقى إلى مدى لا يعلمه إلا الله.

(١) يراجع قريب من هذا المعنى: د. السيد محمود مهران: الأحكام الشرعية والقانونية

للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، ص ٥٩٤، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م - ١٤٢٣هـ.

المطلب الثالث استئجار رحم امرأة أجنبية

اختلف العلماء في حكم إجارة الأرحام، أو ما يعرف بالرحم البديل، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إجارة الرحم لا تجوز مطلقاً، لا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا ^(١).

القول الثاني: إجارة الرحم جائزة على الإطلاق سواء أكانت صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل أم لا ^(٢).

القول الثالث: التفريق بينما إذا كانت المرأة صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أو لا: فإذا كانت زوجة أخرى

(١) د. محمد رأفت عثمان: جريدة اللواء الإسلامي، العدد رقم ٩١٩، وممن ذهب إلى القول بالتحريم مجمع الفقه الإسلامي والذي انعقد بمكة عام ١٩٨٤ م، حيث تراجع عن قوله بالجواز، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر، والدكتور. يوسف عبد الرحمن الفرت في كتابه قضايا طبية معاصرة، ص ٣٥، طبعة دار الفكر العربي - القاهرة ٢٠٠٤، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، والمستشار أحمد الجندي، في كتابه النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص ١١٠، طبعة دار الفكر ٢٠٠١ م، والدكتور. بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل، ١/١٣٤، والشيخ محمود شلتوت، في كتابه الفتاوى ص ٣٢٥.

(٢) د. محمد نعيم ياسين: الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ١٣٠، وممن ذهب إلى الجواز أيضاً: مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة والمنعقدة في عمان في شهر صفر ١٤٠٧ هـ، والدكتور عبد المعطى بيومي في مقاله بعنوان " الأم الأصلية والأم الحاضنة، تأجير الأرحام شرعي وليس بزنا " والمنشور بمجلة المصور المصرية الصادرة في ٢٨/٣/٢٠٠١ م، والدكتور عبد الصبور شاهين، في مقال بعنوان " الحمل في رحم الغير " والمنشور بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠١ م.

جازت إجارة رحمها وإلا فلا^(١).

الأدلة^(٢)

أولاً: أدلة القائلين بحرمة تأجير الأرحام:

استدل القائلون بحرمة تأجير الأرحام بالأدلة الآتية:

أولاً: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾^(٣).

وجه الدلالة:

حث الله عز وجل في الآيات السابقة على حفظ الفروج، وبين أن الحفظ لا يكون إلا بقصرها على الزوجة وملك اليمين، وفي الآية استثناء في قوله تعالى "إلا على أزواجهم" وهو يعني أنه لا يجوز وضع أو إيصال أي شيء إلى امرأة إلا إذا كانت زوجة شرعية

ومن المعلوم أن نقل البويضة الملقحة إلى امرأة أخرى من متعلقات

(١) د. عمر الأشقر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، السابق، ٨٢١/٢، ندوة الإنجاب

في ضوء الإسلام، ص ٤٨٣.

(٢) بما أن القول الثالث جمع بين القولين الأول والثاني، فإنني لن أتعرض لذكر أدلة له

اكْتِفَاءً بِأَدْلَةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي.

(٣) المعارج: ٢٩ - ٣١.

الجماع الذي حرمه الله على غير الأزواج، فكأن الرجل بذلك اتصل بغير زوجته.

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن وضع البويضة المخصبة من منى الزوج في رحم زوجة ثانية لنفس الشخص محرم شرعاً، فمن باب أولى يحرم هذا مع امرأة أجنبية^(١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾^(٢).

وجه الدلالة:

بين الله عز وجل أنه جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم أوضح أن الولد إنما يكون من الزوج والزوجة، بدليل قوله " من أزواجكم "، فهذا نص صريح في عدم جواز تأجير الأرحام، لأن الولد وفقاً للنص القرآني لا يكون إلا من زوجة شاركت في إعداده، وصاحبة الرحم البديل ليست كذلك، فبطل القول بجواز تأجير الأرحام.

أضف إلى ذلك: أن الزوجية متتفية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة والمرأة المستأجرة، إذ يشترط في جواز الإنجاب بين رجل وامرأة أن يتم ذلك في ظل عقد زواج مستجمع للأركان والشروط التي بينها الشرع، وفي إجارة الأرحام لا توجد صلة بين الرجل والمرأة، وبالتالي

(١) د. رشدي شحاته: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، ص ٢٤٨، بحث منشور بمجلة

كلية الحقوق بجامعة حلوان - العدد السابع ٢٠٠٢م.

(٢) صدر الآية رقم ٧٢ من سورة النحل.

يكون حملها غير مشروع^(١).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ * أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرًاوَأُنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَليمٌ قَدِيرٌ﴾^(٢).

وجه الدلالة: أخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين أنه يهب بمشيئته الإناث لمن يريد والذكور لمن يريد، ويمنع الإنجاب عموماً ممن أراد، فدل ذلك على أن هناك طائفة من الناس سيصابون بالعقم، فليس هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا العمل للمرأة العاقر أو العقيم أو من تعاني عجزاً، وبالتالي فليست هناك مصلحة في مخالفة شرع الله وسننه في كونه، فالمؤمن يرضى بأمر الله، ويصبر على ما قدره الله له، لأن الله هو الحكيم الخبير، ولا يجوز لنا أن نخالف أحكامه، كما لا يجوز أن نأتي بطرق ملتوية تكون مثاراً للشك في الأنساب.

وهنا يثور التساؤل: هل بهذا الرحم البديل سنقضي على العقم، أم أننا نبيح هذه الوسيلة متوهمين أننا نقضي على العقم، بل أكثر من ذلك يمكن أن نختار جنس الطفل ونوعه^(٣).

رابعاً: إن المرأة ليس لها الحق ولا تملك الصلاحية في أن تقوم بتأجير

(١) د. حسني محمود عبد الدايم: عقد إجارة الأرحام بين الحظر والإباحة، ص ٣٢٠، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة القانون بتفهننا الأشراف - ذقهلية، العدد السادس مايو ٢٠٠٥م.

(٢) الشورى: ٤٩، ٥٠.

(٣) د. رشدي شحاته: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، السابق، ص ٢٥٠.

رحمها، لأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب محكومة بنصوص محكمة من قبل الشارع، كما أن استئجار الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾^(١) كما أن هذه العملية تحتوي على استقرار ماء الرجل وزوجته في رحم غريب، وهو غير جائز، لأن رحم الأجنبية محرم، فكانت منفعتها هي الأخرى محرمة^(٢).

يقول ابن رشد: "فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيءٍ محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النواحي والمغنيات"^(٣).

خامساً: إن تأجير الأرحام يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم البديلة إذا كانت متزوجة، كما أنه يشتمل على صورٍ من الزنا.

ولعل تأجير الأرحام مرفوض للأسباب الآتية:

١- إن الجنين إذا انفصل عن الأم المستأجرة وُولِدَ، فإنه يعيش في هذه الحياة في حيرةٍ من أمره، فإذا كان نسبه ثابتاً قطعاً من جهة الأب، إذ هو صاحب النطفة، فالحيرة واقعة من ناحية الأم.

٢- إن الجنين الناشئ بهذه الطريقة لا يوجد علمياً ما يقطع بأنه تم تكوينه من الماء والبويضة اللتين تم إدخالهما في الرحم البديل، أو

(١) المعارج: ٢٩ - ٣١.

(٢) د. عمر سليمان الأشقر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، السابق، ٢ / ٨١٢.

(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، ١٦٦/٢، طبعة دار الفكر - بيروت.

من ماء الرجل وبويضة أنجبته المرأة نفسها، فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فجاء تحريمه من هذه الناحية، وهو محرم في جميع الملل.

لذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي في بادئ الأمر عام ١٩٨٦م أباح عملية تأجير الرحم إذا كان الزوج متزوجاً من امرأتين، وتقوم إحداها باستضافة لقيحة الأخرى، ثم عاد وحرّم ذلك لأنه يؤدي إلى مفسد كثيرة، وقد رجع عن رأيه قائلاً: "إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة الزوجة الأولى قد تحمّل ثانياً قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة بسبب معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقه أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر الذي لا يُعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، أو التباس ما يترتب على ذلك من أحكام" ^(١).

٣- إن النسب نظام اجتماعي وضعه الشارع الحكيم، وحدد طريقه وهو الزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه، وفي النسب الصحيح توجد أسس القاعدة التي يركز عليها التشريع ذو الصلة القوية في هذا الجانب من جوانب الإنسان الذي يوصف بأنه كائن اجتماعي، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي طبيعة علاقة الولد بأطراف العلاقة الثلاثة، الزوجين، والمتطوعة بالحمل، وماذا عن

(١) يراجع: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تأجير الأرحام.

البيانات الرسمية^(١).

٤- إن مسألة تأجير الأرحام إذا أبحاث فما الذي يضمن أن تقتصر على ذوات الحاجة لها فقط، أي تقتصر على النساء اللواتي برحمهن علة، فقد تلجأ إليه كل من تريد أن تحافظ على جمالها ورشاقتها، فما أسهل عليها أن تستأجر من تحمل عنها كما تستأجر من ترضع عنها، ومعنى هذا أن تكون المرأة الغنية تستطيع أن تكون أمًا لستة وتسعين ولدًا في كل سنة، ما دامت الأمومة هينةً لينة لا تكلف أكثر من إنتاج البويضات، والباقي على الحاضنات أو المضيفات الفقيرات اللاتي يقمن بدور الأمومة ومتاعبها لقاء دريهمات معدودة، ويستطيع الرجل الثرى أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج من النساء مثني وثلاث ورباع، حيث يمكن لكل واحدةٍ منهن أن تنجب بعدد البويضات التي خلقها الله لها والتي تبلغ حوالى أربعمائة بيضة من البنين والبنات.

سادسًا: إن المولود الجديد يولد معه جدل لا يموت إلا بموت صاحبه، فهذه الوسيلة تؤدي ٩٠٪ من حالاتها إلى مشاكل كثيرة، وبالتالي حدوث نزاعات وخلافات بين الناس، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق بين الناس.

فاستخدام هذه الوسيلة سيلقي بنا في بحار من الظلمات لن نستطيع أن نخرج منها ولا بشق الأنفس، ولَمَّا كان هناك من المفاسد ما لا تحمد عقباه فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن هنا فمن الممكن أن يتفق

(١) د. رشدي شحاته: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، السابق، ص ٢٥٣.

الطرفان الأب والأم المؤجرين، وذات الرحم المؤجر، وقد يختلفان، وقد يوافق الاتفاق الشرع الإسلامي الحنيف، وقد يخالفه، وعند الخلاف قد تعرض الحلول الشعبية، وفي هذه الحالة يكون المال كفيلاً بإسكات ذوي الحاجات.

أيضاً: فإن إباحة هذه الطريقة أو هذه الوسيلة يتعارض مع الناحية الأخلاقية والاجتماعية، إذ إن العلم مسخر للارتفاع بقيمته الإنسانية وليس العكس، وهناك العديد من الأسئلة تطرح نفسها، ومنها:

- هل يمكن أن تكون امرأة مطلقة أو أرملة توفي عنها زوجها؟ والجواب بالنفي؛ إذ كيف يمكن أن تعيش تلك المرأة بالحمل في بطنها وعليها كل مظاهر الحمل وهي بدون زوج، هل تعلق على صدرها لافتة تبين فيها أنها صاحبة رحم مؤجر، وأن الجنين الذي في بطنها ليس ابنها.

- هل يمكن أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة تعيش مع زوجها؟ والجواب أيضاً بالنفي، حتى ولو وافق الزوج كتابياً على تأجير رحم زوجته، فهنا تظهر مشاكل دينية وأخرى طبية تمنع مثل هذا التأجير، فالمشكلة الدينية هي أن الإسلام يمنع مخالطة السائل المنوي للرجل لجنين في بطن أمه من رجل آخر، وبالتالي شرع الدين الإسلامي شهور العدة للزوجة المطلقة قبل أن تتزوج من رجل آخر حتى يمنع هذا الاختلاط في حالة وجود جنين في رحمها من الزوج الأول^(١).

سابعاً: إن تأجير الأرحام يؤدي إلى مشاكل مالية، إذ إن كلمة التأجير لا يأتي من ورائها سوى الربح، وهو ما يؤدي بدوره إلى جعل ساقطات

(١) د. رشدي شحاتة: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، السابق، ص ٢٧٥ وما بعدها.

المجتمع وعاهراته أعلام هذه العملية، أو أعلام لهذه التجارة، وهو أمر يدعو للاشمئزاز، فإذا كان من الممكن إجراء الحمل في رحم امرأة أخرى، إلا أن نسبة نجاح هذه العملية بخطواتها قليلة، وتحتاج إلى إعادته أكثر من مرة حتى يحدث الحمل، أضف إلى ذلك: أن هناك آلاف الجنيهاً مطلوبة لإجراء الأبحاث والتحليل الطبية اللازمة، إضافة إلى أجر الأطباء الذين سيقومون بهذه العملية، بالإضافة إلى أجر المستشفى والعلاج، مضافاً إلى ذلك كله ما تحتاجه المرأة الحاضنة من مرتب مرتفع شهرياً، فالعملية مكلفة وليست مضمونة^(١).

إضافةً إلى ذلك: فإن هذه العمليات تؤدي إلى الكثير من المشكلات والنزاعات بين أطرافها^(٢)، ومن أهم المشكلات التي تترتب على هذا الفعل:

- استغلال المرأة من قبل الشركات المتخصصة، كما حدث في الغرب الأمر الذي دفع لجنة الأخلاقيات الطبية في بريطانيا إلى اعتبار هذه العمليات نوعاً من الاستغلال، وتحريم دخول طرف ثالث في عمليات الإخصاب الخارجي.

- استغلال المرأة لهذا الفعل، فتقوم بتأجير رحمها، حيث إنها تجد فيه مخرجاً وطريقاً للحصول على الأموال الكثيرة تحت وطأة الحاجة

(١) د. أنور عبد الخالق، مقال بجريدة الأهرام، بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠١م، عدد ١٨٠٧، ص ١١.

(٢) الأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، رسالة ماجستير - كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية - غزة، للباحثة. لبنى محمد جبر، سنة ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧، ص ٣٤.

(٣) د. رشدي شحاتة، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، السابق، ص ٢٨٢، ٢٨٣.

الاقتصادية، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى فإنه يفتح الباب أمام النساء الأثرياء للحصول على الأطفال دون شعور بآلام الحمل ومعاناته، الأمر الذي يفقدن الشعور الكامل بعاطفة الأمومة.

- المشكلات التي تحدث بين صاحبة الرحم وصاحبة البويضة، إذ قد ترفض صاحبة الرحم تسليم الطفل، لأن مشاعرها تتغير بالحمل والولادة، لأن الرحم عضو بشري له علاقة وثيقة الصلة بالمشاعر والعواطف، بخلاف أي عضو آخر ^(١).

وقد حدثت بالفعل بعض المنازعات التي وصلت إلى ساحات المحاكم ومنها ^(٢):

عندما وافقت امرأة تدعى " ريتا باركر " على أن تكون أماً بديلة تحمل طفلاً لزوجين هما " بولين، هاري تيلر " وذلك في مقابل أجر، وتم الحمل بالفعل من اللقيحة المكونة من بيضة بولين تيلر والمخصبة بحيوان منوى من زوجها هاري تيلر، وبدأ هاري تيلر يتردد على المرأة التي حملت له ولده، وبدأت المشاكل تظهر، فالأم البديلة وقعت في حبه وغرامه وزنا بها، والزوجة الأصلية شعرت بالغيرة من عملية الحمل التي تكون طرفها من الناحية البيولوجية فقط، وبدأ الشقاق في الأسرة التي كانت تتمتع بقدر من السعادة والاستقرار حتى ذلك الوقت، والأم البديلة رفضت تسليم الطفل بعد ولادته بحجة أن مشاعرها تغيرت بالحمل والولادة، وصارت تشعر بأنها أم الطفل، ولا تستطيع التفريط فيه، وبالتالي امتنعت عن تسليمه إلى أمه، وتم رفع الأمر إلى القضاء الذي كان في حيرة من أمره.

(٢) د/ محمد على البار: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي، السابق، ص ٩٢.

وقد حدث عكس ذلك في أمريكا : حيث استأجر زوجان امرأة متزوجة لكي تقوم بدور البديلة مقابل مبلغ معين، وتم شتل النطفة الأمشاج والمكونة من الزوجين في رحمها، وبعد الولادة تبين أن الطفل معاق ومصاب بنقص بالغ في حجم دماغه بحيث سيظل طيلة حياته متأخرًا عقلياً، فرفض الزوج الاعتراف بالطفل، كما رفض دفع الأجر المتفق عليه للأم البديلة بدعوى أنه ليس هو الأب لذلك الطفل، وحكمت المحكمة بإلحاق الولد بالزوج المكثري بناءً على التحاليل الطبية، ولكن بالفعل رفض الزوجان أن يعيش الولد معهما وبقي في دار للحضانة تحملت مصاريفها شركة تأمين.

وقد نشرت صحيفة "الجارديان" في لندن أحدث فضائح تأجير الأرحام، حول السيدة "أنجيلا" التي أجزت رحمها للأسرة غير القادرة على الإنجاب، ولكن الغريب الذي حدث هو قيام الطبيب المختص قام بزرع جنين ثانٍ إضافةً إلى الجنين المتفق عليه لصالح أسرة أخرى وكان ذلك في سبتمبر ١٩٩٦م، وكان الجنينان ينموان نموًا طبيعيًا في رحم المرأة رغم إنكار الأوساط الدينية لهذا السلوك الغريب، وقامت صاحبة الرحم المؤجر بالدفاع عن نفسها بأنها تقوم بإدخال السرور على الأسر العاجزة عن الإنجاب، ولكن الأكثر غرابة هو ما سيحدث عند الولادة فلمن يُعطى المولود الأول، ولمن يُعطى المولود الثاني، وهما المولودان اللذان سيولدان في لحظة واحدة، وأجاب الطبيب المختص بأن فصيلة دم المولود هي التي ستحدد أبويه الحقيقيين، وبالتالي فلا حيرة إذاً ولا لبس في تحديد هوية

المولودين بعد ولادتهما^(١).

أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام:

استدل القائلون بجواز تأجير الأرحام بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٢).

وجه الدلالة: يرى المجيزون لإجارة الرحم أن هذه الآيات ما هي إلا دليل واضح وصريح على أن الجنين إنما هو نتاج عملية التقاء الحيوان المنوي - ماء الرجل - بالبويضة، ولا دخل للرحم في تكوينه، فالرحم هو الوعاء، وشبهوا دور الرحم بالنسبة للجنين بدور الأرض بالنسبة للنبات، فدوره يقتصر على الحمل فقط دون أدنى تأثير في التركيب البيولوجي بدلالة اختلاف أنواع الزروع وطعمها مع أن الماء الذي تسقى به واحد^(٣).

المنافسة: يناقش هذا الدليل بأنه وإن كان الرحم - كما تقولون - هو الوعاء والقرار الذي يستقر فيه الجنين، فإن ذلك لا يعني انعدام تأثر الجنين ببعض الصفات الوراثية من المرأة الحامل، وذلك لما يلي:

- إن هذا التأثير مقبول من الناحية الطبية، فالدم وما يقدمه من الغذاء، وما يحمله من الإفرازات، وما يسبح فيه من هرمونات أو سموم، وهو يحيط دائماً بخلايا الجسم والخلايا الجرثومية الأصلية لا بد أن يكون له أثره الكبير في هذه الخلايا، أضف إلى ذلك: أن التغيير

(١) د. عطا السنباطي: بنوك النطف والأجنة، ص ٢٦٨.

(٢) المرسلات: ٢٠ - ٢٢.

(٣) د. عبد الحميد عثمان: المرجع السابق، ص ٢٧.

الذي يصيب الخلايا الجرثومية الأصلية لا يزال مثار جدل في الحقل الطبي، والاختبارات التي أجريت حول هذا الموضوع تميل إلى الاعتقاد بأن صفات بلازما الخلايا الجرثومية قد تتغير طبقاً للتأثيرات الخارجية^(١)

- إن الجنين ليس فقط نتاج الكروموزومات الوراثية؛ بل أصبح من المسلمات في المجال الطبي أن الإنسان هو نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة والظروف المحيطة بمراحل نشأته، وأشد هذه الظروف هي تلك التي يتعرض لها أثناء وجوده في الرحم، وبالتالي فمع التسليم الكامل بأن الكروموزومات هي التي تحمل الشفرة الوراثية، فإن ذلك لا يمنع على الإطلاق تأثر الإنسان بظروف أخرى^(٢).

وقد أكد ابن رشد هذه الحقيقة بقوله: "متى صادف المني الهواء فسد مزاجه، فعلى هذا ينبغي أن يفهم أن في الرحم قوة مغيرة.... ليس لقائل أن يقول إن مني الرجل ومني المرأة ليس لواحدٍ منهما هذا الفعل على الانفراد حتى يمتزجا ويختلطا ويصير لهما لون آخر.... لكن إن وضح هذا أيضاً فالمازج إذاً لهذين المنين والمعطى لهما هذه الصورة هو ضرورة المكون بالحقيقة.... وليس هاهنا شيء يفعل هذا الفعل، ويلزم أن يكون العضو

(١) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٤٣٧، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلامية التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت سنة ١٩٨٣م، ص ٢٣٢.

(٢) د. عبد الفتاح محمد دويدار: الأساس البيولوجي والفيزيولوجي للشخصية، ص ٥٠، طبعة دار العلم للملايين - بيروت.

الفاعل لذلك هو العضو الذي فيه القدرة المولدة بالحقيقة، فتكون على هذه القوة المولدة إنما هي في الرحم" ^(١).

الدليل الثاني: إنه لا تعارض بين قوله تعالى ﴿إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ وقوله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ وقوله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعْتَهُ كَرْهًا﴾ حيث إن هذه الآيات لا تعارض بينها وبين إباحة عملية تأجير الأرحام؛ لأن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، أما الأم صاحبة الرحم فهي كالأم من الرضاعة ^(٢).

الدليل الثالث: إن إجارة الأرحام تجوز إذا كانت هي الطريق الوحيد للإنجاب وتحقيق رغبة الزوجين، حيث لا يوجد غيرها شريطة أن لا تكون المرأة متزوجة ولا في حكم المتزوجة، وثبوت القدرة الصحية على إتمام الحمل، وإخطار وليها بذلك، وهو متوافر في مسألتنا، فيكون بذلك تأجير الأرحام جائزاً ^(٣).

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بمناقشتين:

الأولى: إن القول بضرورة أن يكون التأجير للرحم هو الطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجين لا يصح؛ لأن هناك من البدائل الأخرى ما يحقق

(١) الكليات في الطب، لابن رشد، ص ٧٠، طبعة ١٩٨٧ م.

(٢) د. رشدي شحاتة: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، ص ٢٨٦.

(٣) د. السيد مهران: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر،

السابق، ص ٥٨٩، د/ عبد الحميد عثمان: السابق، ص ١٣٩.

الرغبة لكل منهما، وهي الزواج من شخص آخر، كما أن اللجوء إلى المحرمات لتحقيق رغبات مباحة ليس إلا نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل.

الثانية: إن تقييد الإباحة بشروط محددة - كما ذكرها المجيزون - من وجهة نظري ليست إلا مرغبات تُرغَّب في القيام بهذه العملية، أو محاولات لإضفاء الصفة الشرعية عليها وإقناع الأفراد بجوازها، ومعلوم أن للشروط في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة، فهي مضبوطة بضوابط الشرع، فليست كل الشروط مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو شرطاً حرم حلالاً " ^(١).

أضف إلى ذلك: أن الشروط التي وضعها المجيزون من المسلمات، فاشتراط عدم كون المرأة متزوجة شرط بديهي، إذ لا يعقل أن تفعل هذا متزوجة، أو أن يوافق مسلم على استخدام رحم زوجته، كما أن القدرة الصحية على الحمل أمر طبيعي، لأن الزوجين الراغبين في التأجير لا يستأجران إلا من تتوافر لديها تلك القدرة، أما شرط إخطار ولي المرأة المستأجرة فهو شرط منتقد؛ إذ لا علاقة للولي بتلك المسألة، فقد قرر الفقهاء أن الشيب أحق بنفسها، فإذا كان هذا في الزواج فيكون هنا من باب أولى، وذلك على فرض التسليم بصحة هذا الشرط.

الدليل الرابع: إذا كان من مبررات تحريم هذا الفعل ما يؤدي إليه من منازعات بين أطرافه، فإنه يمكن التغلب على هذه النزاعات عن طريق كتابة

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم (٤٨٥٦)، فتح

عقدٍ تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف^(١).

الدليل الخامس: استدلووا بالقياس من وجوه:

الأول: قياس الأم صاحبة الرحم على الأم من الرضاع، ووجه القياس: أن الله جَمَعَ بين الحمل والرضاع في المدة اللازمة لهما في قوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^(٢).

الثاني: إن كلاً منهما يتغذى منه الطفل، والأصل المشترك بينهما الرحم والثدي؛ لأن التغذية تتم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء

(١) وبالفعل قام الدكتور المحامي. عبد الله البلتاجي بإعداد نموذج لهذا العقد، وجاء هذا

العقد في المواد الآتية:

المادة الأولى: أن تجري الأم البديلة الفحوصات الطبية اللازمة، وأن يتم كتابة إقرار يوقع عليه مجموعة من الأطباء بأنهم أجروا عليها البحوث الكافية، وأنها خالية من أية أمراض يمكن أن تنتقل إلى الجنين.

المادة الثانية: أن توضع الأم البديلة تحت ملاحظة مستمرة وكاملة طوال فترة الحمل، وأن تبقى تحت تصرف الطبيب المعالج طوال الوقت.

المادة الثالثة: أن تكون الأم البديلة غير متزوجة، وفي سن مناسبة للإنجاب، وأن تُقَرَّ بألا تتزوج أثناء فترة الحمل، حتى تنتهي من الحمل وتضع المولود.

المادة الرابعة: أن تحتضن الأم البديلة البيضة طوال فترة الحمل، وأن تراعي عدم القيام بأي مجهود يعرض سلامة هذا الحمل المستكن للخطر.

المادة الخامسة: تقر الأم البديلة بأن من تضعه سيكون ابناً لكل من "....." و "....." وأنه ليس لها الحق في المطالبة بأي شيء خاص به، حيث تنقطع صلتها بالمولود منذ ولادته، ولا ترتبط به بأية حقوق مادية أو معنوية، وأنه ليس لها سوى الجعل المادي أو المبلغ الذي ستحصل عليه نتيجة تطوعها للقيام بالعملية. يراجع: د. يوسف الفرت:

قضايا فقهية معاصرة، السابق، ص ٢٣٤.

(٢) الأحقاف: ١٥.

الأم، وهذه المواد في أصلها غير مستساغة المذاق، فتغذية الجنين بها عن طريق الحبل السري لا يحتاج إلى تغيير في الطعم، أما تغذية الطفل عن طريق الفم فإنها تتطلب تغييراً في المذاق حتى يمكن أن تستساغ، لأنها تلامس مركز التذوق في الإنسان ألا وهو اللسان.

الثالث: وجود العلاقة الطردية بين نمو الثدي للحامل وبين نمو الجنين، فنمو الثدي مرتبط بنمو الجنين حتى يكون مستعداً لكي يحل محل الرحم في التغذية عندما يخرج الجنين طفلاً، وعليه فإذا كان الإثم ينتفي في حنو المرأة على غير ولدها بإرضاعه، وقد يسند إليها أيضاً أمر تربيته عندما ينتقل الطفل من حجر أمه إلى حجر أسرة مرضعته خلال فترة الرضاعة دون ما سبب أو علة تمنع الأم الوالدة من القيام بأمر الرضاع والتربية، فإنه يصبح من الممكن حلول رحم امرأة محل صاحبة الرحم المعطوب في حمل جنين لها، وإذا كان في انتقال الطفل من أسرته إلى أسرة مرضعته في سن مبكرة خطر ما نظراً للدور الذي يلعبه العامل البشري في تنشئة الطفل، فإن في الحمل لحساب الغير لا يوجد الأثر المباشر لهذا العامل على الجنين؛ لأن الدور الغالب في فترة الحمل يكون للعوامل الطبيعية التي لا تخضع في عملها لإرادة الإنسان ومشيتته^(١).

المناقشة:

نوقش قياس الأم البديلة على الأم من الرضاع بجامع قَصْر دور كل واحدةٍ منهما على التغذية بأنه قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:

(١) د. عبد الحميد عثمان: الأم البديلة، السابق، ص ١٤٠، الإنجاب في ضوء الإسلام، ص

٢١٩، د. عطا السنباطي: بنوك النطف والأجنة، ص ٢٥٩.

أ - إن إباحة الاستئجار للرضاع إنما شرعت للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حياة الطفل، والضرورات التي تبيح المحظورات هي التي تتعلق بهلاك النفس أو إتلاف جزء منها، وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره، وبالتالي لا يجوز قياس الأم البديلة على الأم من الرضاع^(١).

ب - إن تعليل القياس بالجمع بين الحمل والإرضاع في آية واحدة غير مسلم؛ لأن العطف في اللغة يقتضي المغايرة، فالحمل غير الإرضاع، ومن ثم فالجمع بينهما غير سديد^(٢).

ج - إن هناك فرقاً كبيراً يثبت العقل ويؤكد العمل بين تغذية طفل اكتمل خلقه وانفصل عن أمه، وصار له كيانه الخاص، وبين التغذية التي يحصل عليها جنين لم يكتمل خلقه بعد، بل هو ما زال يتدرج في أطوار الخلق ومراحله، فتغذية الطفل الذي انفصل عن أمه تكون بالرضاع أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي يتغذى بها الطفل في تلك الفترة، أما الجنين الذي ما زال حبيس رحم أمه فتغذيته تكون عن طريق الدم وما يحمله من خلايا تعمل على تكوين الأعضاء^(٣).

وقد أوضح هذه الحقيقة أحد أطباء المسلمين في القرن الرابع الهجري حيث قال: "السبب في قوام الجنين آلات أمه، وغذاؤه من غذائها، وهو يتغذى بسرته، فإذا ولد فليس غذاؤه مثل الذي كان يتغذى من قبل أن يولد،

(١) د. عبد السلام السكري: نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، ص ٢٢٤، طبعة دار المنار - القاهرة.

(٢) د. عطا السنباطي: بنوك النطف والأجنة، السابق، ص ٢٦١.

(٣) د. ماهر حتوت: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، السابق، ص ٢٣٢.

لكنه يتغذى باللبن، ثم بالأطعمة، ويشرب الأشربة بفيه، فأما قبل أن يولد فيتغذى بسرته من غذاء أمه، فإذا ولد واغتذى فإنما يغتذي بطبيعته التي توزع غذاؤه في بدنه، وهي التي تبعثه على الاغتذاء ^(١).

د - إن هناك فارقاً مؤثراً بين أهلية الطفل بعد الولادة، وأهليته قبل أن يولد، حيث إن الأحكام الشرعية تختلف لكلا الشخصين؛ لأن الأهلية موضع تقدير الشارع في كثير من الأحكام، واختلاف نظرة الشارع للأهليتين مرجعه تقديره لاختلاف الطبيعة في الحالين، وهو فارق لا يصح معه قياس ^(٢).

هـ - قياس استئجار الرحم على الإرضاع مرفوض لاختلاف تكييف الفعل في الحالتين، فالإرضاع عقد إجارة أباحه الشارع ودل عليه القرآن وأقرته السنة، أما استئجار الرحم فهو فعل لم يُبح نص، بل إن مفهوم النصوص يحرمه، لأن التعاقد على محرم لا يجوز، كما أن المرأة لا يجوز لها من حيث الأصل الإقدام على هذا الفعل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فهذا الفعل وإن كان في ظاهره استئجار لمنفعة الرحم إلا أن حقيقته بيع لطفل مولود، وبيع الحر حرام ^(٣).

الدليل السادس: إنه قد ثبت من الناحية الطبية عدم تحقق الاختلاط بين الأنساب، حيث إن حق الطفل محفوظ عن طريق حمله للصفات الجينية

(١) كتاب تدبير الحبالى، للبلدي، ص ٧٨، تحقيق. محمود الحاج قاسم محمد، طبعة دار الفكر.

(٢) د. السيد مهراڤ: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، السابق،

ص ٥٨٧

(٣) د. عمر الأشقر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ٢ / ٨١٥.

والوراثية للأب والأم.

فيقول علماء الطب: "إن البويضة من الزوجة إذا خُصِبَتْ بماء زوجها ووضعت مخصبةً في رحم امرأة أجنبية لا تتضمن اختلاطاً للأنساب؛ لأنه في اللحظة التي يتم فيها التلقيح وتتحد كروموزومات البويضة والنطفة تغرز البويضة الملقحة حاجزاً حولها يمنع المساهمة بأية مواد وراثية أخرى حتى تحتفظ الخلية بتكوينها الجيني الذي يحتوي على كل الإرشادات اللازمة لتكوين مخلوق كامل، ولا يمكن تغييرها إطلاقاً، والحياة مليئة بأمثال عديدة تؤيد كل هذه المفاهيم" ^(١).

الدليل السابع: اعتمد المجيزون لتأجير الأرحام في تبريرهم جواز هذه العملية على أن التأجير في هذه الحالة يكون من باب التداوي، والتداوي مشروع، كما أن عدم قدرة الزوجين على الإنجاب يعد من باب الضرورة التي أقرها الشرع ^(٢).

المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الدليل بما يلي:

أولاً: سلّمنا لكم أن عدم قدرة الزوجين على الإنجاب تعد من قبيل الداء الذي يستوجب الدواء، كما نسلم أيضاً لكم أن التداوي أمر مشروع دعا إليه القرآن ورغب فيه الرسول ﷺ إلا أن مشروعية التداوي ليست على إطلاقها؛ بل هي مشروطة بكون الدواء المستخدم في العلاج مباحاً لا حرمة

(١) د. رشدي شحاتة: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، ص ٢٨٨.

(٢) الحديث سبق تخريجه.

فيه، فقد قال النبي ﷺ : "تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام" ^(١) وبالتالي فإن الأمر والحالة هذه خارج عن محل النزاع.

ثانياً: إن الاعتماد على قاعدة الضرورة على إطلاقها محل نظر؛ لأن لقاعدة الضرورة شروطها وضوابطها التي تكفل الوصول إلى تطبيق أمثل.

ثالثاً: سَلَّمْنَا لكم القول بأن تأجير الأرحام يحقق رغبةً أكيدةً للزوجين في أن يكون لهما طفل، إلا أنه بالنظر الدقيق لهذه المسألة نجد أن هناك تعارضاً بين المصالح، حيث إن مصلحة الزوجين التي هي الرغبة في الإنجاب تتعارض مع مصلحة شرعية هي حرمة التعدي على الأبضاع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اختلاط الأنساب، والمصلحة الأولى خاصة، والثانية عامة، وعند التعارض يجب إهمال المصلحة الخاصة، أي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

الراي الراجح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها أرى أن تأجير الأرحام لا يجوز شرعاً، وذلك لما يلي:

١- إن هذه الوسيلة فضلاً عن كونها ذريعةً إلى اختلاط الأنساب نتيجة الازدواج في التكوين والنشأة والخلقة ؛ فإنها وسيلة أيضاً إلى الشر والفساد، وكل ما يؤدي إلى الضرر أو الحرام فهو حرام ؛ فعادة الشارع ألا يترك المفسدة حتى تقع ثم يعالجها؛ بل يحتاط في منع الوسائل المؤدية إليها، ولا يقال: إن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ لأن ضابط الضرورة خوف الهلاك أو الضرر

(١) الحديث سبق تخريجه.

الشديد على إحدى الضروريات للنفس أو للغير يقيناً أو ظناً إن لم يوجد ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد، ومن ضوابطها كذلك: أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع، ومستندة إلى قواعد شرعية، وألا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير، لأن الضرر لا يُزال بالضرر، وأن تقدر بقدرها، والأهم في هذا الخصوص ألا يخالف المضطر مبادئ الإسلام في تحريمه للزنا، وحرصه على ثبوت النسب، وعدم اختلاط الأنساب، والأصل في الإسلام أن: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

٢- إن القول بجواز تأجير الأرحام يحول الأمومة من مشاعر مغمورة بالحب والحنان إلى مهنة تصطبغ بالصبغة التجارية، ولقد عانى الغرب من ذلك أسوأ معاناة، فبعد أن انتشرت المراكز التجارية التي تقوم بهذه العملية صارت المرأة تستأجر، وتحولت الأرحام إلى سوقٍ تجاريٍّ للربح المادي^(١).

٣- إننا نعيش في بيئة إسلامية للمرأة فيها وضع خاص يمنع المساس به، وتستمد المرأة هذا الوضع من أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإذا أبيع هذا النوع من الحمل فإنها إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة: فإن كانت متزوجة فمشاكل اختلاط الأنساب لا تنتهي، وإن لم تكن متزوجة فالسنة السوء ستفوه على المرأة التي حملت من غير زواج، ففي كل الحالات يتم الإضرار بالمرأة (٢)

(١) د. محمد على البار: التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،

ص ٢٩٢.

(٢) د. عطا السنباطي: بنوك النطف والأجنة، السابق، ص ٢٦٣.

هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى فإن التطور العلمي لا بد أن يَخدِمَ الإنسان ويدلّل له الصعاب، واستتجار الأرحام كشف يؤدي إلى فتح باب الانحلال الخلقي والزنا والفواحش، كما أنه يخالف الفطرة السوية في المجتمعات الإسلامية، وبالتالي كان هذا العمل غير مقبول عقلاً وممنوع شرعاً.

المبحث الثالث نسب طفل تأجير الأرحام

أولاً: نسب الطفل من جهة الأم:

تعد مشكلة نسب طفل استئجار الأرحام من جهة الأم من المشاكل المعقدة التي ثار بشأنها جدلٌ كبير في الأوساط الفقهية، فبعضهم نظر إلى أصل التكوين، واعتبر الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، والبعض الآخر نظر إلى الغذاء والحمل والولادة، فاعتبر صاحبة الرحم هي الأم، وبعضهم اعتبر أن للطفل أمين، وبالتالي فالمسألة يتنازعها ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب أنصاره إلى أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، وهذا القول هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي برأي أكثرية أعضائه، وأغلب العلماء المعاصرين^(١).

القول الثاني:

يرى أن الطفل ينسب إلى صاحبة الرحم المؤجر التي حملت وولدت، فهي أمه الحقيقية، وهو قول بعض العلماء المعاصرين^(٢).

(١) د. محمد نعيم ياسين: الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ١٣٠، د. مصطفى الزرقا: طفل

الأنبوب، ص ٦٣، د. عبد السلام السكري: التلقيح الاصطناعي بين الحل والحرمة، ص

١٤٣، د. محمد علي البار، طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي، ص ٦٨

(٢) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ٢١٨، د. أحمد شوقي أبو خطوة: القانون الجنائي

والطب الحديث، ص ١٥٢، طبعة دار النهضة العربية - القاهرة، د. عبد العزيز الخياط:

حكم العقم في الإسلام، ص ٤٥، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الأردن

١٤٠١ هـ، د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي، ص ٢٨٦، د. زياد سلامة: أطفال

القول الثالث:

يرى د. جابر مهران رأياً مختلفاً في هذه المسألة، فيقول: "إني والله سبحانه وتعالى أعلم أرى أن للطفل أمين: الأولى: التي حملته، والثانية: صاحبة البيضة.

أما أمومة الأولى:

فدليلها ما ذكره القائلون بأن أمه هي من حملته، وإن كانت أدلتهم لا تصلح إلا لإثبات الأمومة الناقصة للولد على أساس فقدان وصفٍ ضروري آخر للأمومة الكاملة، وهو أن تكون بيضتها سبباً في تكوينه، ولَمَّا لم تكن كذلك فلا محل للقول بأن كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، والأم بالنسبة لولدها، فهي أم بالوكالة فقط، وتنطبق عليها كما زعم أصحاب هذا القول لأن هذه الأم لم تعطه أيّاً من جيناتها الوراثية.

وأما الثانية:

صاحبة البيضة، فهي أمه أيضاً، لكنها ليست كالأم المرضعة بل إنها أمه التي أعطته جيناتها الوراثية، وإن كانت لم تحمله في رحمها، وعليه فليست أمومتها كاملة، لأن وصفاً من أوصاف الأمومة الكاملة وهو الولادة لم يتحقق^(١).

وبما أن هذا القول لا دليل له إلا ما ذكره قائله، فسأكتفي بعرض أدلة القولين الأول والثاني فقط.

الأنابيب بين العلم والشرعية، ص ١٣٩، طبعة ذات السلاسل - الكويت.

(١) د. جابر مهران: حكم الاستنساخ والتلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،

ص ١٩٩، ٢٠٠.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أن الطفل ينسب إلى صاحبة البويضة بالأدلة الآتية:

أولاً: استدلو بقول النبي ﷺ : الولد للفراش ^(١).

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ جعل الفراش علة للحكم بالولد، إذ لا معنى للفراش إلا الزوجية الصحيحة، فالولد في الحديث لا يعني إلا التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، وترتيباً على ذلك فإذا كان للرجل زوجة صارت فراشاً له، فإذا أتت بولدٍ لمدة الحمل صار ولده، وتجري بينهما الأحكام المترتبة عليه ^(٢).

المناقشة:

يناقش الاستدلال بهذا الحديث بمناقشتين:

المناقشة الأولى: إن هذا الحديث خارج عن محل النزاع، فهو واردٌ في النسب من جهة الأب، فليس في الحديث دليل لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ على أحقية صاحبة البويضة بالنسب.

المناقشة الثانية: إن الاستدلال مبني على وجود فراشٍ بين الزوج وصاحبة البويضة، وبالتالي ينسب الطفل إلى صاحبة البويضة وزوجها ^(٣).

ثانياً : استدلو بقولهم: إن القرآن الكريم اهتم بالعوامل البيولوجية

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٧/١٠، نيل الأوطار، ٧٩/٦، الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ٢٢٧.

(٣) د. سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ٣٨٤/١.

والوراثية كأساسٍ لثبوت النسب، حيث ورد في القرآن في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة، وهى المسماة بالنطفة الأمشاج، حيث تبدأ بالانشطار منذ لحظة التخصيب، أي أن الخلية تصبح خليتين، والخليتين أربع، وهكذا حتى يتم تكوين مئات الخلايا التي تشبه ثمرة التوت، ثم تتطور هذه النطفة إلى علقة، وتنمو العلقة عن طريق امتصاص الغذاء من البرك الدموية الرحمية، وفى تلك الفترة يكون الاتصال بين دم الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالاً مباشراً، وتتغذى الكرة الجرثومية من هذه الدماء، كما أنها تتغذى بإفرازاتها الغدد الرحمية التي يبلغ عددها ١٥٠٠٠ غدة رحمية تفرز جميعها ما يسمى بلبن الرحم الذى تتغذى عليه العلقة، وتتطور العلقة بعد ذلك إلى نطفة، وقد جاءت آيات القرآن مؤكدة تلك التطورات^(١).

وعلى ذلك فالجنين إنما يتكون من الخلايا التي تحمل الصفات الوراثية للأم والأب، يقول د. عبد المحسن الصالح : "إذا حملت السيدة غير المتزوجة جنيناً غريباً عنها ووضعتة، وأرضعته وحضنته وأنشأته، فإن الشعور السائد قد ينسب الطفل إليها على أنها أمه، لكن ذلك ليس صحيحاً من وجهة النظر البيولوجية أو الوراثية، فمثل السيدة التي تلد جنيناً مزروعاً كمثل المرضعة التي ترضع وليداً غير وليدها، فالطفل الرضيع يستخلص من الدم غذاءه، وكذلك بفعل الجنين المزروع، فهو يحصل من دمها الحاضنة على مقوماته الغذائية عن طريق اتصال دورتها الدموية بدورته مع ما ينساب في تلك الدورة من هرمونات لها أثر على الجنين..... إن السجل

(١) د. محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ١٩٨، ١٩٩، د. عطا

السباطي: بنوك النطف والأجنة، ص ٢٧١.

الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء أساسًا من الخلايا الجنسية للأبوين، فكل خلية بمثابة ميكرو فيلم للمخلوق الذي منه قد جاءت، فإذا كان الأبوان شقراوين وطويلين وحدث التلقيح بين خلاياهما الجنسية في الأنبوب، ثم زرع الجنين الناتج في زنجية فإنه لا يحمل أي صفة من صفاتها؛ بل يخرج إلى الحياة كوليد أشقر تمامًا كصفات والديه" (١).

المنافسة:

نوقش الاستدلال السابق بالمناقشات الآتية:

المنافسة الأولى: إن الاستدلال السابق محل نظر؛ لأن الإسلام في مسألة النسب لا يعتمد فقط على الحقائق العلمية؛ بل للقواعد الشرعية دور أساسي، وقد علق النبي ﷺ ثبوت النسب على الفراش مع وجود بعض الصفات الوراثية في الولد.

فقد روى البخاري أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد عهد به إلي، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد به إلي، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله ﷺ: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج

(١) مجلة العربي الكويتية، العدد ٢٤٢، ص ٣٠، مشار إليه في أحكام التلقيح الطبيعي،

النبي ﷺ، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله ^(١).

ويرى ابن القيم أن حكم النبي ﷺ في هذه القضية مراعاة للشيين وإعمالاً للدليلين؛ لأن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحب الفراش دليل نفي النسب، وأعمل الرسول ﷺ أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوة الفراش، فأعمل الشبه الظاهر بعتبة بن أبي وقاص بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة بنت زمعة ^(٢).

يقول ابن القيم: "وهذا من أحسن الأحكام وأثبتها وأصحها، ولا يمتنع ثبوت النسب من وجهٍ دون وجهٍ، فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها، وقد تتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة مثل القتل والردة فإنهما يمتنعان من الميراث مع ثبوت النسب، فلا ينكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا محض الفقه" ^(٣).

الجواب: يجب عن ذلك بأن الشارع لم يعتمد الشبه لوجود معارض أقوى وهو الفراش، وبالتالي إذا لم يوجد الفراش فإن الشبه يعتد به، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قذف هلال بن

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) د. رأفت عثمان سعيد: استتجار الأرحام، موجود على شبكة المعلومات موقع

http://www.bab.com/persons/٨٨/show_particle.cfm?article_id=١٢

(٣) زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم، ٤١٤/٥، تحقيق: د. حمزة النشرتي، الشيخ.

أمية امرأته قيل له والله ليجلدك رسول ﷺ ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين جلدة وقد علم أنني رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استثبت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعة فدعا بهما رسول الله ﷺ حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحكما كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال والله إني لصادق فقال احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنني لصادق يقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله ﷺ قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلفت ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين وإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله ﷺ قفوها عند الخامسة فإنها موجبة، فرددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفصح قومي، فقال رسول الله ﷺ إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر قصفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على الصفة ^(١)

المنافسة الثانية: إن الطب قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجنين نتاج العوامل الوراثية، فهو يتأثر بها، ويتعامل مع البيئة المحيطة به، وأشد تلك البيئات هو الرحم، وقد جاءت عبارات الأطباء دالة على هذه الحقيقة، ومن عباراتهم:

- يقول دكتور. جمال أبو السرور: "إن عدم تغير الصفات الوراثية للجنين بانتقاله إلى رحم جديد ليس القول الفصل في المسألة؛ لأن الجنين يتغذى ويتأثر بالرحم، وأن المعروف أن نمو الجنين وتكوينه لا يعتمد فقط على "الكروموزومات" من أمه وأبيه؛ بل يتأثر بالبيئة المحيطة، وربما يؤدي

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ٢٢٠/٢.

تناول عقاقير معينة أو سلوك عادات ضارة - كشرب الكحول أو التدخين - إلى تشوه الجنين؛ لأن الأم الحاضنة تتفاعل مع جنينها، ولا بد أن تؤثر بالسلب أو بالإيجاب، وبالتالي لا نوافق على موضوع الأم الحاضنة أو تأجير الأرحام طبيًا^(١)

- ويقول دكتور. محمد عبد السلام: "إن الرحم ليس مجرد وعاء، بل هو غذاء ومناعة، ومشاعر ودفع، وبه أجسام مضادة للأمراض، وهناك جدل كبير حول هذه العمليات في الغرب، فلماذا نفتح هذا الباب هنا، بالتأكيد الأم الحاضنة أسهمت في إنتاج المولود، فلمن ينسب؟ وكيف نقول لها: ليس لك حق فيه، وماذا لو حدث تلاعب بالأجنة؟"^(٢).

- وتقول الدكتورة. إكرام عبد السلام: "تغذية الجنين في الرحم ليست فقط بإمداده بالغذاء والأكسجين، ولكن دم الأم الحاضنة الذي يصل إلى الجنين يحمل كل مكوناته الوراثية، وعلى سبيل المثال: إذا زاد هرمون الغدة الدرقية في دم الأم الحاضنة أثناء الحمل أدى إلى اختلاط نشاط الغدة الدرقية للجنين، كذلك إصابة الأم الحامل بمرض السكر يتأثر به الجنين، وإذا كانت الأم الحاضنة حاملة لجين أحد الأمراض الوراثية مثل بعض أمراض سوء التمثيل الغذائي الوراثية، فإن ذلك يؤثر على الجنين ويستمر تأثيره إلى فترات متفاوتة بعد الولادة، لذلك فإن الأم الحاضنة لا يقف تأثيرها على حمل الجنين، بل يتعدى إلى التأثير المباشر في مكونات الدم

(١) مجلة المصور القاهرية الصادرة بتاريخ ٢٠٠١/٤/٦.

(٢) مجلة المصور القاهرية الصادرة بتاريخ ٢٠٠١/٤/٦.

الوراثية، وبالتالي على الجهاز العصبي، والغدد الصماء للجنين" (١).

وغير ذلك من أقوال الأطباء التي لا يتسع المجال لذكرها.

الجواب: يجب عن ذلك بأن الصفات الوراثية تُؤخذ من الأب صاحب الحيوان المنوي، والأم صاحبة البيضة بصفة أساسية، والتأثير الذي تقولون به مهما بلغ مداه فلن يرقى إلى التغيير في الصفات الوراثية، سواءً من ناحية الأصل أو الطبع، لأن أصول كل إنسان ترجع إلى الوالدين صاحب النطفة والبيضة (٢).

المناقشة الثالثة (٣): القول بأن أساس ثبوت النسب هو العوامل البيولوجية فقط قول غير مسلم؛ لأن الإسلام عند إقراره أن الطفل من ماء الزوج والزوجة اشترط في هذين المائين أن يكونا محترمين، وإلا فيعتبران هدرًا لا قيمة لهما، وبالتالي فالأم البديلة أو صاحبة الرحم التي ليست بفراش للزوج صاحب النطفة لا يثبت منها نسب المولود؛ لأن هذا التصرف لا يجوز شرعًا، لأنه تم في غير الإطار الذي رسمه الشرع، إذ إنها لم تحمل بطريق صحيح أو فاسد بشبهة، ولكن بإدخال حيوان منوي وبيضة أجنبية عنها مخصبة بهذا الحيوان المنوي مما يعد في معنى الزنا والسحاق الموجبين للعقوبة، وعدم اعتبار النسب منها لغيرها مطلقًا، إلا أنه ليس بأب شرعي، وبالتالي فالمدار في ذلك كله اعتبار الشرع وعدمه، والشرع وإن تشوف لثبوت النسب وأثبته بمجرد الإمكان إلا أنه اشترط أن يكون ذلك في

(١) جريدة الأهرام المصرية الصادرة في ١٧/٤/٢٠٠١.

(٢) يراجع بتصرف: د. سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ١/٣٨٧.

(٣) د. عطا السنباطي: بنوك النطف والأجنة، السابق، السابق، ص ٢٧٣، ٢٧٤.

إطار علاقة من العلاقات التي رتب عليها الشارع هذا الأثر، والأم البديلة لا تدخل تحت أي علاقة من تلك العلاقات، بل إنها وإن لم يصدق عليها وصف الزنا ظاهراً، إلا أنه يصدق عليها معناه، فظاهر الزنا أو صورته المادية تتمثل في الإيلاج، أما حقيقته ومعناه وهو إنزال المني لما يترتب عليه من اختلاط للأنساب، فإنزال المني في الفرج عن طريق الجماع يسمى جماعاً بصورة ومعنى، أما إنزاله فقط يسمى جماعاً معنى.

ثالثاً: استدلووا من القياس بدليلين:

الأول: قياس نسب الأم على نسب الأب، إذ إن الأب الذي هو صاحب النطفة نسب إليه الطفل، فكذلك الأم قياساً عليه.

الثاني: قياس الرحم المؤجر على أنبوب الاختبار، فالأنبوب الذي ينمو فيه الطفل ليس له تأثير في النسب، فكذلك الرحم المؤجر باعتبار أن كلاً منهما وعاء.

المناقشة:

نوقش الاستدلال السابق من وجهين:

أحدهما: إن القياس على نسب الأب قياس مع الفارق؛ لأن النسب الثابت للأب ليس لأن الطفل تخلق من مائه، بل يثبت له النسب لأنه صاحب الفراش الذي ولد عليه المولود، والغالب في صور التأجير للرحم أن يكون صاحب الماء أجنبياً عن صاحبة الرحم، وبالتالي فالفراش لا وجود له هنا، وبالتالي فالقياس غير صحيح^(١).

(١) د. زياد صبحي ذياب: أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص ١٠٥، طبعة ذات

الجواب: يجاب عن ذلك بأن المولود من جهة الأب ينسب إلى صاحب النطفة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فإذا وُجِدَ مانع وهو الزنا انتفى الأصل، إلا أنه لا يلزم من انتفاء النسب عن صاحب النطفة انتفاؤه عن صاحب البويضة، لأن الشارع أثبت نسب المولود من جهة الأم المزني بها، وهو اتفاق بين العلماء مع نفيه عن الزاني صاحب النطفة ^(١).

الثاني: قياس رحم المرأة على أنبوب الاختبار مرفوض لثلاثة أسباب:

١- إن استخدام الأنبوب لا يؤدي إلى الشك في الأنساب بخلاف رحم المرأة.

٢- إن الأنبوب ليس إنساناً يمكن مطالبته بحق أو متطلعاً لذلك الحق.

٣- إنه يوجد ترابط وتلاحم كاملين بين الجنين وصاحبة الرحم مع إيجاد عاطفة بينهما عكس الأنبوب ^(٢).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن الأم هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت بالأدلة الآتية.

أولاً: من القرآن استدلو بما يلي:

أ - قوله تعالى ﴿إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ ^(٣) وقوله تعالى

السلاسل - الكويت.

(١) د. سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، ٣٨٩/١.

(٢) المرجع السابق، ٣٩٠/١، الإنجاب في ضوء الإسلام، ص ٢٢٧.

(٣) المجادلة: ٢.

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾^(١).

وجه الدلالة:

دلت الآيتان دلالة لا خفاء فيها على أن الأم الحقيقية لطفل تأجير الأرحام هي التي حملت وولدت، حيث صرحت الآية الأولى أن الولادة هي سبب الأمومة، والآية الثانية أسندت أمومة الولد إلى المرأة القائمة بالإرضاع، ومفهوم المخالفة يقتضي انتفاء صفة الأمومة عن التي لم تلد ولم ترضع.

ب - قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾^(٢) وقوله تعالى ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾^(٣).

وجه الدلالة: بيّن القرآن الكريم أن للخلق أطوارًا، وهذه الأطوار تحدث للجنين في رحم الأم، وبالتالي فإن الأمومة تعتمد على تخلق الجنين في بطن الأم، لذا وجب الحكم بأنها الأم الحقيقية، أما صاحبة الببيضة فهذا الوصف بذلك غير متحقق فيها، وبالتالي تنتفي عنها صفة الأمومة^(٤).

المناقشة^(٥): نوقش الاستدلال بالآيات السابقة بمناقشات ثلاث:

(١) البقرة: ٢٣٣.

(٢) النجم: ٣٢.

(٣) الزمر: ٦.

(٤) يراجع قريب من هذا المعنى، د. سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق،

٣٩٦/١.

(٥) د. بكر أبو زيد: فقه النوازل، ٢٤٥/١ وما بعدها، أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق،

الأولى: إن مفهوم الأمومة الوارد في هذه الآيات يقتضي أن الأم هي التي تحمل المولود في رحمها بعد اختلاط مائها بماء زوجها، فهي بذلك تشارك في تكوين المولود، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تقوم بحمله في رحمها مدة الحمل حتى تضعه، وعلى هذا المفهوم تنزل جميع الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام، أما إذا كانت البويضة من امرأة والحمل والولادة من امرأة غيرها فلا تدخل في مفهوم هذه النصوص الشرعية، فالأم الواردة في هذه الآيات هي الأم التي تخلق الجنين في رحمها ابتداءً وانتهاءً، فالتكوين والحمل لا يبدأ إلا عند تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل، وصاحبة الرحم ما كان لها أن تحمل ثم تلد لولا زرع اللقيحة في رحمها.

الثانية: إن حصر الأم في المرأة التي تحمل وتلد يتعارض مع قوله تعالى ﴿وَأُمّهْتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾^(١) لأن الله تعالى سماها أمًا.

الثالث: إن حصر الأم في التي تحمل وتلد ليس مقصودًا هنا، لأن للآية سبب خاص، حيث نزلت ردًا على الذين يشبهون زوجاتهم بأمهاتهم - الظهار -.

الجواب: يجاب عن هذه المناقشات بجوابين^(٢):

الأول: سَلَّمْنَا أن الآية نزلت في بيان أمر الظهار، إلا أن ذلك لا يعتبر دليلاً على نفي حصر الأمومة في الولادة، لأن الآية وإن كانت قد نزلت في

شأن الأم والزوجة إلا أنها تفيد تحديد المعنى الحقيقي للأمومة وحصرها في الولادة، وأن أي امرأة أخرى سواء الزوجة التي ظوهر منها أو غيرها ليست أمًا بالمعنى الحقيقي للأمومة.

الثاني: لا نسلم لكم القول بأن حصر الأمومة في الولادة يخرج الأم من الرضاعة لوجود الفارق الكبير بينهما، لأن الأم المرضعة وإن سميت أمًا إلا أنها ليست أمًا بالمعنى الحقيقي للأمومة، فتسميتها أمًا لترتب بعض الأحكام الشرعية على الرضاعة ^(١).

ثانيًا: استدلو بقولهم: إن الغذاء الذي نما به الطفل وترعرع في بطن الأم إنما كان من دم المرأة صاحبة الرحم، كما أنها هي التي تحملت آلام الحمل والولادة وأوجاعهما، فكان منطقيًا أن تكون هي الأم على عكس صاحبة البيضة التي لم تذق أيًا من هذه الآلام ^(٢).

ثالثًا: استدلو بقياس صاحبة البويضة على الدجاجة التي تبيض البيض ولا تحضنه، فالفرخ الناتج عن هذه البويضة ينسب إلى الحاضنة لا إلى صاحبة البيضة ^(٣).

المناقشة:

يناقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: إن القياس منقوض بما لو كان البيض الذي تحضنه الدجاجة

(١) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي، ص ٣٧٣، ٣٧٤ بتصرف.

(٢) آراء في التلقيح الصناعي، للشيخ بدر المتولي عبد الباسط، ص ٤٨٥.

(٣) الشيخ بدر المتولي عبد الباسط: آراء في التلقيح الصناعي، ص ٤٨٥.

بيضاء لطيور أخرى كالبط والحمام، فقطعاً أن البطة أو الحمامة لا تنسب إلى الدجاجة

الثاني: إن الشارع لم يرتب على أنساب الحيوانات أحكاماً شرعية، ولذا لم يشترط شروطاً للإنجاب بين الحيوانات بخلاف الإنسان، وحينئذٍ فهو قياس مع الفارق^(١).

الرأي الرابع:

من خلال ما تقدم عرضه من أقوال في هذه المسألة يترجح عندي قول من قال بأن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، وذلك لما يلي:

أولاً: إن هذا القول هو ما تطمئن إليه النفوس نظراً لاتفاقه مع قواعد الفطرة السوية.

ثانياً: إن الأدلة التي استدل بها أنصار هذا القول قوية في الدلالة على أن صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية للطفل.

ثالثاً: إن المعتبر في نظر الشرع هو لحظة تلقيح البويضة، فما دام التلقيح تم بين بيضة الزوج والحيوان المنوي من الزوج فإن صفة الاحترام وجدت في المائين، وبالتالي يثبت النسب لهما، أي أن نسب الطفل قد ثبت لصاحبة البويضة قبل أن تدخل اللقيحة في الرحم الآخر، واستمر هذا النسب ثابتاً طيلة وجود اللقيحة في الرحم.

ثانياً: النسب من جهة الأب:

اختلف العلماء في نسب الطفل من ناحية الأب، فبعض الفقهاء اعتبر

(١) أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، ٤٠٧/١.

أن الأب هو صاحب النطفة، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن النسب لصاحب الفراش أي زوج المرأة التي غرست اللقيحة في رحمها، وإذا كانت ليست بذات زوج أخذ هذا الولد حكم ابن الزنا.

ولكن بعيداً عن الخلاف السابق أرى أنه في ظل التطورات العلمية والتقدم الطبي، فإن النسب يثبت لصاحب الحيوان المنوي حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تكفل اتخاذ الحيطة والحذر لضمان سلامة هذه العملية من أية شوائب، إذ يمنع الاتصال الجنسي بين صاحبة الرحم وزوجها طيلة الفترة الأولية المخصصة لإجراء العملية، لذا فإن الطفل ينسب إلى الرجل صاحب الحيوان المنوي.

تدريبات على الوحدة الثانية

- ١- بين المفهوم العلمي والشرعي لعملية تأجير الأرحام.
- ٢- تأجير الأرحام يأخذ صوراً عديدة، اذكرها على سبيل الإجمال.
- ٣- اذكر دليلين من أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام، ثم قم بمناقشتها، والرد عليها.
- ٤- لمن ينس طفل تأجير الأرحام من جهة الأم؟
- ٥- متى يكون تأجير الأرحام جائزاً؟

موت الدماغ وأثره في عمليات نقل الأعضاء

دراسة فقهية طبية مقارنة

دكتور

أحمد محمد لطفي أحمد

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهننا الأشراف، وعضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، ليبلو العباد أيهم أحسن عملاً، وجعل الأمراض والعلل أسباباً ومقدمات للاتعاظ والاستعداد للخطب الجلل، والصلاة والسلام على البدر المنير، صاحب الوجه الأنور، الشفيع المشفع في المحشر، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد

فلا تزال التحديات الإلهية تتوالى في الظهور، لتثبت للعقل البشري في خضم هذه المدنية المخيفة، وهذا المعترك الهائل من التقدم المهيّب في شتى مناحي الحياة، أن الله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون، والعقل البشري أمام هذه التطورات يتخذ أحد موقفين: إما أن يكون هذا التقدم وتلك المدنية وما فيها من أهوال، دليلاً جديداً يضاف إلى الأدلة التي تثبت عظمة الخالق وقدرته، وذلك برد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن ينبهر الإنسان بهذا التقدم، وتشغله النعمة عن المنعم، فيعتقد أن هذا التقدم ما هو فقط إلا نتاج فكرٍ بشري، وبذل جهدٍ خارق، وبذلك يكون قد وضع قدميه على أولى خطوات الضلال.

وبما أن الإنسان دائماً يحن إلى أصله، قصد ذلك أم لم يقصد، فإن فلسفة وجوده وبقائه ونهايته لا تزال مسيطرة عليه وعلى فكره، فقضية الحياة والموت تشغل بال الفرد ليل نهار، بل إن فلسفة الموت تأخذ حيزاً من التفكير أكبر من تلك التي تأخذها فلسفة الحياة؛ لأن الإنسان إذا ولد وبلغ وترعرع، فإن الموت يكون في انتظاره، أما قبل ذلك فلا يفكر في حياةٍ ولا ينتظرها، لأنه لا وجود له من حيث الأساس، لذلك فإن مفهوم الموت أمر لا يحتاجه الفرد ليسيّط على مشاعره؛ بل ليؤثر في سلوكه وتخطيطه

لحياته، فهو المؤثر على حاضره ومستقبله.

ولقد كثرت المفاهيم التي تنازعت معنى الموت، وكشف الأطباء عن صور حديثة للموت، كموت الدماغ، وصرح أغلبهم بأنه موت بالمعنى الحقيقي، ويجب بناء الأحكام عليه، إلا أن هذا الاتجاه وجد معارضة من بعض الأطباء وأغلب علماء الشريعة؛ نظراً لأن للموت عندهم علامات لا بد من تحققها.

من خلال الاطلاع على أغلب ما كتب في هذا الموضوع، من الناحيتين الشرعية والطبية، بات واضحاً أن المشكلة تكمن في عدم الوصول إلى عناصر أساسية في التحديد الدقيق لمفهوم الموت، حتى نستطيع من خلالها الحكم على الشخص بالموت أو عدمه، فبينما ينظر الفقهاء إلى الموت باعتباره انقطاع تعلق الروح بالجسد، وعدم صلاحية هذا الجسد لخدمة الروح؛ نجد الأطباء ينظرون إلى المآلات، وما توافر عندهم من القواعد العلمية المعروفة في المجال الطبي.

فالفقهاء يقصدون بالموت، الموت الكلي لكافة أعضاء الجسم مجتمعة، بحيث إن بقاء أحد الأعضاء أو بعضها قائماً بوظيفته يخرج هذا المريض عن وصف الميت، ويثبت له صفة الحياة، أما الأطباء فينظرون إلى المخ باعتباره المحرك الرئيس لسائر الأعضاء، وأن تلفه أو موته هو النهاية التي لا مفر منها، وأنه لا أمل في إصلاح هذا التلف.

وبما أن باقي الأعضاء تموت تدريجياً واحداً تلو الآخر، فليس هناك ما يمنع عندهم من إعلان الوفاة، تحقيقاً لمنافع اقتصادية، كرفع أجهزة الإنعاش، وتوفير التكاليف، أو منافع معنوية كإنهاء معاناة أهل المريض بمجرد إعلان الوفاة، وتقليل فترة حزنهم، أو تحقيق منافع إنسانية - على حد قولهم -، كالحصول على الأعضاء في حالة جيدة لزرعها في أجساد مرضى

آخرين في حاجة ماسة إليها.

وبالتالي بات واضحاً أن المشكلة هي عدم التوافق بين المفهوم الشرعي والمفهوم الطبي في هذه المسألة، مما أثار تساؤلاً مؤداه، هل الخلاف بين الفقهاء والأطباء يمكن رأب صدّعه، عن طريق إمكانية الوصول إلى مفهوم توافقي فيما بينهما ينهي هذه المسألة.

أضف إلى ذلك: أن الخلاف الذي شب بين الفقهاء والأطباء يأخذنا إلى خلاف أكثر خطورة، وهو تحديد لحظة الوفاة، إذ يترتب على تحديد تلك اللحظة الكثير من الأحكام، فهل يتم إعلان الوفاة رسمياً بمجرد موت الدماغ؟ أم أن الإعلان يتم بعد توقف سائر الأعضاء؟ وهذه النقطة أكثر خطورة؛ لأننا بحاجة ماسة إلى معرفتها، حتى يمكن ترتيب أحكام الموت عليها، إذ إننا نريد معرفة الوقت الذي تبدأ فيه عدة الزوجة، ومسألة توافر شروط الإرث من عدمها، وهل يرث لو مات له وارث، وهل يرث منه الغير إذا حكمنا بموته، وهل يجوز شرعاً الحصول على أعضائه أم لا؟ كل هذه إشكالات لا بد من إيجاد حلول جذرية لها حتى تستقيم أحكامها الشرعية.

لكل ذلك حاولت الوصول إلى القول الفصل في هذه المسألة من خلال هذا البحث الذي أسميته " التكييف الشرعي لموت الدماغ وأثره في عمليات نقل الأعضاء - دراسة فقهية طبية مقارنة ".

وقد نظمت الحديث في هذه المسألة في مقدمة وثلاثة مباحث:

المقدمة: في أهمية الموضوع.

المبحث الأول: مفهوم موت الدماغ.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لموت الدماغ.

المبحث الثالث: حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ.

المبحث الأول

مفهوم موت الدماغ

يعد تحديد مفهوم موت الدماغ نقطة البدء في هذا الموضوع، إذ بتوضيح مفهومه تظهر أوصافه، ويسهل بيان حكمه، وكما قال العلماء حقيقة الشيء فرعٌ عن تصوّره، لذا أقوم في مطلبٍ أولٍ بتعريف الموت بصفةٍ عامة، وأتبعه بتعريف الموت الدماغى، وطرق تشخيصه في مطلبٍ ثانٍ.

المطلب الأول

تعريف الموت

لا يتخذ القرآن الكريم عند حديثه عن الموت موقفاً فلسفياً؛ بل يعمل على بيان حقيقته مضمناً عليه الناحية التربوية، أي أن القرآن الكريم لا يهتم ببيان حقيقته، ولا بالكيفية التي يتم بها، بل يهتم بالسبب الداعي إليه، وما يأتي بعده من أمورٍ تتعلق بالسؤال والحساب وغير ذلك.

وتقرر معظم الأديان والفلسفات الأدبية، أن الموت هو خروج الروح من بدن الإنسان، ومغادرتها إلى حيث لا يعلم، وهذا المفهوم هو الذى ساد لدى الأمم القديمة، كقدماء المصريين والبابليين والآشوريين والهنود والإغريق، ويعتقد البوذيون أن الروح تظل حبيسة الجسد، وبالتحديد في الجمجمة، ولا تنطلق إلا بعد حرق الجثة وانفجار الجمجمة، أما الهنود فيعتقدون بتناسخ الأرواح، وأن الروح الشريرة تعاد في كل جسدٍ حقير، كالكلب والخنزير، وتظل في تلك الدورات حتى تتطهر، وأن الروح الصالحة الحَيِّرة تظل تنتقل في الأجساد الخيرة، حتى تصل إلى مرحلة

السعادة الأبدية المطلقة في الروح الطليقة المتصلة بالأزل والأبد^(١).

أ- الموت في اللغة: الموت والحياة في لغة العرب متناقضان، لذا فإن معاجم اللغة العربية تُعرِّف كل واحدٍ منهما بأنه نقيض الآخر وضده، فعند تعريف الحياة يقال: الحياة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الموت، والجمع أحياء، وعند تعريف الموت يقال: الموت والموتان ضد الحياة، وهو خلقٌ من خلق الله تعالى، وأصل الموت في لغة العرب السكون، وكل ما سكن فقد مات، ولذلك تقول العرب: ماتت النار موتاً إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء، وماتت الريح إذا ركدت وسكنت، وماتت الخمر أي سكن غليانها، والموت مالا روح فيه^(٢).

قال ابن فارس: " الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، ومنه الموت خلاف الحياة "^(٣).

وقد ورد الموت في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة، منها:

- إزالة القوة الحية النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى ﴿لَنَحْيِيَّ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾^(٤).

(١) د. محمد علي البار: الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي، مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، مجلد الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة ندوة " التعريف الطبي للموت "، ص ٦٢٨، ٦٢٩، طبعة ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠ م.

(٢) لسان العرب، لابن منظور، ٩٠/٢، مختار الصحاح، للرازي، ص ٣٠١.

(٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ٢٨٣/٥.

(٤) الفرقان: ٤٩.

- زوال القوة الحساسة، ومنه قوله تعالى ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾^(١).

- النوم الأبدي، ومنه قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾^(٢).

- الموت الفكري، وقد ورد بهذا المعنى قوله تعالى ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾^(٣).

- المصيبة الكبرى والأمر الجلل الذي ينغص نعم الحياة الدنيا، ومنه قوله تعالى ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾^(٤).

ب - الموت في الاصطلاح: الموت عند جمهور أهل السنة، صفة وجودية مضادة للحياة، وقالت المعتزلة: هو عدم الحياة عما من شأنه، ويرون أن المراد بالخلق في قوله تعالى " الذي خلق الموت والحياة " هو التقدير^(٥).

يقول الغزالي مبيناً ظنون الناس في فهم الموت: " اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنونا كاذبة قد أخطأوا فيها، فظن بعضهم أن الموت هو العدم، وأنه لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشر، وأن موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النبات، وهذا رأى الملحدين وكل من لا يؤمن

(١) مريم: ٦٦.

(٢) الزمر: ٤٢.

(٣) الأنعام: ١٢٢.

(٤) المائدة: ١٠٦.

(٥) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، ١٨٩/٢.

بالله واليوم الآخر، وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولا يتألم بضار، ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر، وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد، وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلاً، وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق، بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة ^(١).

وقد تعرض الفقهاء لتعريف الموت، فقال الحنفية: هو صفة وجودية مضادة للحياة ^(٢)، وقيل هو عدم الحياة ^(٣).

وقال المالكية: الوفاة هي مفارقة الروح للجسد ^(٤).

وعرفه الشافعية بقولهم: الموت مفارقة الروح للجسد ^(٥).

أما الحنابلة فلم يعرفوا الموت اكتفاءً بذكر علاماته ^(٦).

وبناءً على ما سبق، فإن الموت الذي يصيب الإنسان هو موت نسبي، أي موت بالنسبة لعلم البشر في حدود تكليفهم، فهو موت جزئي يقتصر

(١) إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ٢/٢١٥.

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ١/١١٦.

(٣) رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين ٢/١٨٩.

(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٥/٢٨٣.

(٥) المجموع شرح المذهب، للنووي، ٥/١٠٥، أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ

زكريا الأنصاري، ١/٢٩٤.

(٦) المغني، لابن قدامة، ٢/٣٣٧.

على مفارقة الحياة الدنيا، ولا يمتد إلى حياة البرزخ، فالموت انتقال من دارٍ معروفٍ حقيقتها إلى دارٍ وحياةٍ أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى^(١).

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً " وهذا حُصّ على الجهاد، وإعلام أن الموت لا بد منه، وأن كل إنسانٍ مقتولٌ أو غير مقتولٍ ميتٌ إذا بلغ أجله، وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومة سبحانه أن روح الحي تفارق جسده^(٢).

وقد ذكر الأطباء للموت عدة تعريفات، أهمها:

قيل: هو التوقف النهائي لكل مظاهر الحياة، أو التفاعلات الحيوية بالجسم مع وجود بعض مظاهر الحياة عقب الموت العام، ولكن بالأنسجة والخلايا^(٣).

وعُرف الموت عند الأطباء بأنه: انقطاع الحياة - سواء في الإنسان أو الحيوان - نتيجة توقف واحدٍ أو أكثر من أجهزته الحيوية عن العمل^(٤).

ومن خلال ما سبق يمكن بيان ما يلي:

أولاً: إن الموت مخلوق كالحياة، فليس فناً محضاً، لذلك يجب على

(١) د. عقيل بن أحمد العقيلي: حكم نقل الأعضاء، ص ١٥٥.

(٢) تفسير القرطبي، ٢٢٦/٤.

(٣) د. عبد الحميد عامر، د. سيدني سميث: الطب الشرعي في مصر، ص ٣٧، طبعة المقتطف - المقطم - القاهرة.

(٤) د. محمود مرسي، د. سحر كامل: الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم، ص ٤٨، طبعة مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية ١٩٧٥ م.

الإنسان ألا يخاف منه بالصورة التي تعكر عليه صفو حياته.

ثانياً: إن الله ذكر الموت أولاً قبل الحياة، فقال سبحانه ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١) وهذا الترتيب الوارد في الآية وإن كان لفظياً، إلا أنه ينبىء عن الترتيب الطبيعي بين الموت والحياة، وهو ما يدعو إلى فهم جديد للآية، بمعنى أن ذكر الموت أولاً ومن بعده الحياة، يعد دليلاً على التغير والتطور، فالتغير عبارة عن موت مرحلة وبداية مرحلة أخرى.

ثالثاً: إن الحكمة من خلق الموت والحياة كما جاءت في القرآن الكريم هي الابتلاء والاختبار، فالموت والحياة في منطق القرآن ما خُلِقَا إلا لأجل الاختبار، وهذا الاختبار يجب أن يُحوّل خوف الفرد من الموت كفناء إلى خوف تربوي له أثره في السلوك، كما ينبغي أن يخلق عنده روح المنافسة، فتتحول كل الطاقات إلى البناء لا إلى الهدم، كما أنه يجعل حياة الإنسان حقلاً للسعي والإنتاج.

رابعاً: إن تعريفات الفقهاء اقتصرَت على الإشارة إلى العلاقة الكائنة بين الروح والجسد، حيث انتهت إلى أن الموت هو مفارقة الروح للجسد، دون الإشارة إلى أية تفصيلاتٍ أو أمورٍ أخرى، وهذه التفصيلات وإن كانت أمراً عادياً فيما مضى، إلا أنه صار لها أهمية كبيرة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال الطبي.

ج- صعوبة وضع تعريف جامع للموت:

يعد الموت هو نهاية الحياة الإنسانية، وهو أمر لا يشك فيه عاقل

(١) الملك: ٢.

مستقرء للأحداث والوقائع، فما من حي إلا ويموت إلا الله عز وجل، وقد أخبر القرآن الكريم بهذه الحقيقة فقال تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ * وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(١)، إلا أن هذه المسألة ليست هي محل الجدل والنقاش، بل المسألة التي أثارت انتباه العلماء والباحثين هي تحديد اللحظة التي يحكم فيها بموت الإنسان.

ففي الماضي كان هذا الأمر سهلاً ميسوراً، إذ بمجرد خروج الروح وظهور علامات الموت المعروفة يحكم بالموت، ومن هذه اللحظة يصبح الشخص في عداد الأموات، أما في العصر الحاضر وفي ظل التقدم في مجال العلوم الطبية وانتشار أجهزة الإنعاش الصناعي، وظهور المصطلحات الطبية الجديدة كالموت الإكلينيكي، وموت الدماغ وما إلى ذلك، صار من الصعب تحديد لحظة الوفاة، وبمعنى أدق تحديد اللحظة التي يحكم فيها بموت الشخص وجريان أحكام الموت عليه، ومما يزيد من صعوبة هذه المسألة خلوها من النص الذي يبين حكمها، وهو على العكس تماماً من مسألة بداية الحياة، حيث وردت فيها الأحاديث الصحيحة التي تبين بدايتها بطريق اليقين.

ويرى البعض^(٢) أنه في ظل غياب النص الذي يحدد نهاية الحياة الإنسانية، فإنه ينبغي عند تحديد هذا الوقت الانطلاق من قاعدتين

(١) الرحمن: ٢٦، ٢٧.

(٢) د. محمد نعيم ياسين: بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة الثانية ربيع أول ١٤٠٦ هـ - ديسمبر ١٩٨٥ م، ص ١٦٨ وما بعدها.

أساسيتين:

الأولى: إن الأمر بين تحديد البدء وتحديد الانتهاء ينبغي أن يكون عكسياً أو متناقضاً، بمعنى أن حياة الإنسان تنتهي عكس ما بدأت به، فإذا كانت البداية هي تعلق الروح بالبدن، فالمنطق أن تنتهي الحياة بانقطاع هذا التعلق.

الثانية: إن الروح خلق من خلق الله عز وجل يمكن للإنسان البحث فيه من حيث خصائصه وصفاته وأنشطته وآثاره في البداية وتأثره فيه، ووقت تعلقه به ومفارقه له.

فالقاعدة الأولى هي نتيجة منطقية تنطلق من قاعدة السببية التي تحكم هذا الوجود، والتي تقضي بأن كل شيء جعله الله متوقفاً على سبب لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يقوم أو يحيا في حالة مفارقة هذا السبب، وبما أن الله عز وجل جعل لبداية الحياة سبباً، هو تعلق الروح بالجسد، فإن النهاية حتماً تكون بالافتراق، وإذا كان علماء الإسلام لم يحددوا اللحظة التي تتم فيها تلك المفارقة، فإنهم أكدوا أن ملازمة الروح للجسد مرهونةً بصلاحية هذا الجسد لخدمة الروح، وتنفيذ أوامرها، وبالتالي إذا صار الجسد عاجزاً عن خدمة الروح والقيام بالوظائف المنوطة به، كان ذلك سبباً داعياً للافتراق.

المطلب الثاني

تعريف موت الدماغ وطرق تشخيصه

تجدر الإشارة إلى أن هناك تناقضاً واضحاً في تحديد المفهوم العلمي لموت الدماغ، حيث يختلف تعريفه من بلدٍ لآخر في البلدان التي تعترف به وتقره، فيختلف التعريف على سبيل المثال بين أمريكا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، بل إن هناك العديد من البلدان لا تعترف من حيث الأصل بفكرة الموت الدماغية كاليابان والدانمارك، بل الأغرب من ذلك، أن التعريف قد يختلف في البلد الواحد، نظراً لاختلاف المعايير المتبعة والتي يتم الأخذ بها، ففي أمريكا - مثلاً - توجد تشريعات مختلفة في ولاياتها، وبالتالي من الطبيعي أن يختلف التعريف وبناءً عليه تختلف طرق التشخيص^(١).

ويقرر الأطباء المختصون أن المريض في غرفة الإنعاش لا يخلو حاله من إحدى ثلاث صور:

الأولى: عودة أجهزة المريض من التنفس، وانتظام ضربات القلب وإعادةتها إلى حالتها الطبيعية، وفي هذه الحالة يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش، لتحقيق السلامة وزوال الخطر.

الثانية: التوقف التام للقلب والتنفس، وعدم القابلية لآلة الطبيب، وحينئذ يقرر الطبيب موت المريض تماماً بموت أجهزته من الدماغ

(١) د. صفوت لطفي: تحديد المفهوم الحديث لموت الدماغ، منشور ضمن بحوث ندوة

التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في

الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ١٩٠.

والقلب، ومفارقة الحياة لهما، الأمر الذي يستتبع رفع الأجهزة لثبوت تحقق الوفاة لديه.

الثالثة: قيام علامات موت الدماغ من الإغماء وعدم الحركة، وعدم أي نشاط كهربائي في رسم المنخ بآلة الطبيب، لكن بواسطة العناية المركزة وقيام أجهزتها عليه كجهاز التنفس وجهاز ذبذبات القلب، ولا يزال القلب ينبض، والتنفس مستمر.

وفي هذه الحالة يقرر الطبيب موت المريض بموت جذع الدماغ الذي هو مركز الإمداد للقلب، وقرر أنه بمجرد رفع الآلة عن المريض بتوقف القلب والتنفس تماماً^(١).

أولاً: مفهوم موت الدماغ:

تباينت الرؤى واختلفت الاتجاهات في تحديد مفهوم موت الدماغ، وانبثقت كل رؤية من المنهج الذي ينتهجه أصحابها، وقد عُرِفَ موت الدماغ بتعريفات متعددة، أهمها:

عُرِفَ بأنه: " تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه، بما فيها وظائف جذع الدماغ^(٢)."

قيل في تعريفه: إنه غياب الأداء السريري للدماغ غياباً لا يقبل الانعكاس، بما في ذلك جذع الدماغ، وينتج موت الدماغ من الأمراض

(١) د. بكر بن عبد الله أبو زيد: أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، مجلة

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، ص ١٥٢.

(٢) أ. ندى محمد نعيم الدقر: موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص ٥٦، طبعة دار الفكر -

دمشق، دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

العصبية الأساسية بسبب جرحٍ حادٍ في الرأس، أو نزيفٍ فيما تحت الغشاء العنكبوتي نتيجة تمدد الأوعية الدموية، لكن في وحدات العناية المركزة العلاجية والجراحية يمكن لإصابات الدماغ بسبب نقص الأكسجين وفقر الدم، أو الفشل المفاجئ أن تؤدي إلى غياب أداء المخ غياباً لا يقبل الانعكاس^(١).

ويقرر الطب الشرعي أن جميع حالات الموت تحدث فيها ثلاثة عوامل تتمثل في: توقف الدورة الدموية، توقف التنفس، توقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ^(٢).

ومع التسليم بهذه الحقيقة، إلا أن هناك مجموعة من المتغيرات تحدث تدريجياً بالموت وهي: التلون الموتى، برودة الجسم، التيبس الموتى، التحلل الموتى.

والتيبس الموتى هو تصلب العضلات الإرادية واللا إرادية بعد الموت

(١) يراجع: ملخص تقرير اللجنة الفرعية للمقاييس النوعية التابعة للأكاديمية الأمريكية للأعصاب، مشار إليه لدى د. محمود كريدية: التحديد الطبي الإسلامي في مفهوم الدماغ، منشور ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي عقدت في الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ٤٩٠، د/ مختار المهدي: مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العملية ومقارنتها بالمفهوم الشرعي، منشور ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي عقدت في الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ٢٨٧، ٢٨٨.

(٢) د. إبراهيم محمود وجيه: الطب الشرعي والسموميات، ص ١٩، الكتاب الطبي الجامعي الصادر عن منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط عام ١٩٩٣ م.

بفترة وجيزة، ويبدأ هذا التيسر تدريجياً في العضلات الصغيرة حول الفك السفلي والرقبة، ثم عضلات الوجه وجفون العين، ثم يمتد تدريجياً إلى عضلات الصدر والبطن والعضدين والفخذين، ثم عضلات الساعدين والساقين، ثم عضلات الكفين والقدمين، ويحدث التيسر في العادة في فترة تتراوح بين ساعتين إلى ثنتي عشرة ساعة، ويحدث التحلل خلال أربع وعشرين ساعة، ومن الطبيعي أنه إذا لم تحدث تغيرات ما بعد الموت في الجسد، فإن هذا الجسد ما يزال حياً، ولذلك فإن الرأي الطبي السليم يقرر أنه إذا لم نستطع أن نقطع بزوال علامات الحياة، فإننا لا نحكم بالموت إلا بعد ظهور تغيرات ما بعد الموت على الجسد، بل إن هذه التغيرات على درجة من الثبات والتدرج الزمني المعروف، حتى أنها تستخدم لتحديد الفترة الزمنية التي مضت بعد حدوث الموت، أي أنها تستخدم لتحديد ساعات الموت^(١).

ثانياً: أسباب موت الدماغ:

يلخص الدكتور محمد على البار الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث ما يسمى بموت الدماغ فيما يلي:

- ١- إصابات الدماغ بسبب الحوادث، وأهمها حوادث المرور، وهذه الحوادث تمثل ٥٠٪ من جميع حالات موت الدماغ، وفي المملكة العربية السعودية تمثل حوادث المرور نسبة ٦٠٪ من جميع وفيات الدماغ، وعموماً تعتبر حوادث المرور في منطقة الخليج العربي

(١) د. رؤوف محمود سلام: التعريف العلمي الطبي للموت، منشور ضمن بحوث ندوة

التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في

الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ٤٤٢، ٤٤٣.

صاحبة الرقم الأعلى في العالم، حيث تبلغ النسبة عشرة أضعاف ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالنسبة لكل مائة ألف من السكان، وفي عام ١٩٩٤ م توفي في السعودية ما يزيد على ٣٧٠٠ شخص، منهم ٧٥٪ لم تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً، كما أصيب في حوادث المرور إصابات بالغة أدت إلى دخول المستشفى أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص كل عام.

٢- نزف داخلي بالدماغ بمختلف أسبابه، ويمثل حوالي ٢٠٪ من جميع حالات موت الدماغ.

٣- أورام الدماغ والتهابات الدماغ وخراج الدماغ، والسحايا، وتمثل حوالي ٢٠٪ من حالات موت الدماغ^(١).

ثالثاً: أهمية التشخيص المبكر لموت الدماغ وطرقه:

يعتبر التشخيص المبكر لموت الدماغ - عند القائلين به - من المسائل الهامة والشديدة الخطورة، ويلجأ الأطباء في تشخيص الموت عموماً إلى إحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: تتمثل في البحث عن مظاهر الحياة للتأكد من زوالها، ويمكن أن نسمي هذه الطريقة بالتشخيص السلبي للموت.

الطريقة الثانية: هي البحث عن علامات التغيرات، أي التي تصيب الجسد بعد الموت للتأكد من ظهورها، ويمكن أن تسمى هذه الطريقة بالتشخيص الإيجابي للموت، والطريقة الأولى تثبت فور حدوث الموت،

(١) د. محمد علي البار: الفرق بين الموت الشرعي والموت الإكلينيكي، السابق، ص ٤٥٨،

أما الطريقة الثانية فإنها لا تثبت إلا بعد مرور ساعات من حدوثه، ولا اعتبارات كثيرة يكون من الأفضل إثبات الموت فور حدوثه، فيلجأ الأطباء إلى الطريقة الأولى والتي تعتمد على زوال مظاهر الحياة، وينبغي على الطبيب قبل الحكم بالموت التأكد من زوال جميع علامات الحياة، وإذا التبس عليه الأمر في التشخيص السلبي للموت وجب عليه انتظار التشخيص الإيجابي بظهور التغيرات المعروفة حدوثها بعد الموت، ولكن هذا الالتباس يعد من الأمور النادرة الحدوث^(١).

ويتم تشخيص موت الدماغ وفق ما يلي:

١ - غيبوبة عميقة مع انعدام الإدراك والاستجابة.

٢ - العلامات السريرية (الإكلينيكية) لتوقف وظائف جذع الدماغ، وتشتمل على غياب منعكسات الحدقة والقرنية، واختلاف المنعكس الرأسي العيني، والمنعكس العيني الدهليزي البلعومي، ومنعكس السعال والتقيؤ

٣ - انعدام قدرة المصاب على التنفس التلقائي، بالاختبار المتعمد أثناء توقف مضخة التنفس لفترة محدودة، وهي عدم التنفس لمدة ثلاث أو أربع دقائق، أو عشر دقائق حسب المدارس المختلفة بعد إبعاد المنفسة، ويشترط لإيقاف المنفسة أن يتنفس المصاب أو كسجين ٩٥٪ مع ٥٪ ثاني أكسيد الكربون لمدة عشر دقائق بواسطة قسطرة يتم إدخالها إلى القصبة الهوائية، ويتم التنفس بواسطة المنفسة؛ وذلك يؤدي إلى رفع ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى ٤٠ مم زئبق أو فوقها، وهو مسؤول عن تنبيه مركز

(١) د. رؤوف محمود سلام: التعريف العلمي للطبي للموت، السابق، ص ٤٤٤.

التنفس في جذع المخ.

٤ - عدم وجود حركة الدمية عند تحريك الرأس، وإعادة فحص وظائف الدماغ من فريق آخر بعد مرور عدة ساعات.

٥ - لا يعتبر رسم الدماغ أساسياً في تشخيص موت الدماغ، إلا أنه قد يكون دليلاً إضافياً مفيداً من الناحية القانونية^(١).

وعموماً فإن الغالب أن تشخيص موت الدماغ يعد عملاً سريرياً بالدرجة الأولى، إلا أن الطبيب في سبيل التأكد من هذا التشخيص يلجأ إلى إجراء مجموعة من الاختبارات المساعدة، وذلك بعد التأكد من وجود الترابط بين الغيبوبة المصحوبة بانقطاع التنفس وانعدام الانعكاس العصبي، وتكون أمامه أربع خيارات:

الأول: أن يقوم بالانتظار لمدة اثنتي عشرة ساعة.

الثاني: سكون في كهرباء قشرة الدماغ كما يظهر في رسم المخ.

الثالث: خطوة نحو إلغاء إمكانات جذع الدماغ السمعية الماثرة في سلسلة اختبارات متتابعة.

الرابع: إظهار مؤقت دورة الدم داخل المخ عن طريق رسم للأوعية، أو

(١) د. محمد على البار، د. زهير أحمد السباعي: الطبيب أدبه وفقهه، ص ١٩٧، طبعة دار القلم، الدار الشامية - بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، د. محمد على البار: موت الدماغ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، ص ١٥٩، د. السيد الجميلي: نقل الأعضاء وزراعتها، دراسة طبية دينية، ص ٢٤، ٢٥، طبعة دار الأمين - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

رسم صوتي^(١).

وقد وُضِعَت العديد من المعايير في بعض دول العالم لمحاولة وضع قواعد يتم الاستهداء بها عند تشخيص موت الدماغ، ومن أهم المعايير التي وضعت في هذا الشأن، معايير هارفارد، ومعايير مينيسوتا، ومعايير الجمعية الطبية الكندية^(٢).

-
- (١) د. عدنان خريط: موت الدماغ، التعريفات والمفاهيم، منشور ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ٣٦٤.
- (٢) د. سميرة عايد الديات: عمليات نقل وزرع الأعضاء، ص ٢٥٢، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ٢٠٠٤ م، د/ عدنان خريط، موت الدماغ التعريفات والمفاهيم، السابق، ص ٣٦١، ٣٦١، د. محمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، ص ٣٢.

المبحث الثاني

التكليف الشرعي لموت الدماغ

تعد مسألة موت الدماغ من نوازل العصر التي تتطلب حكماً شرعياً يقطع الخلاف الدائر حولها، والتكليف الشرعي لهذه المسألة ينبني على أحد أمرين، إما القول بأنه يعتبر موتاً، وبالتالي تترتب عليه جميع آثار الموت المقررة في الفقه الإسلامي، وإما القول بعكس ذلك وعدم اعتباره موتاً، وبالتالي لا يتم إعلان الوفاة ولا إدخال المريض في عداد الأموات، والوصول إلى تكليف محدد في هذه النازلة ليس بالأمر اليسير؛ بل يتطلب بحثاً دقيقاً في أحكام الموت وعلاماته وأحواله من الناحية الشرعية، وكذلك مقارنة هذه الأمور بما قرره الأطباء، مع مراعاة القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، ومحاولة التوفيق قدر الإمكان بين أقوال الفقهاء وما قرره الأطباء.

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء وكذلك الأطباء على أن الموت في الأحوال العادية، يتحقق وتترتب أحكامه بمجرد مفارقة الروح للجسد، وتوقف القلب والنبض والتنفس، ويترتب على ذلك دخوله في عداد الأموات، وخروجه من دائرة الأحياء، مع ترتيب الأحكام المقررة على الموت، وهذا هو الغالب في الموتى.

ثانياً: اتفق الفقهاء والأطباء أيضاً على أن الغيبوبة وتوقف الدماغ لا يحكم بالموت بناءً عليهما، وبالتالي فحالات الغيبوبة المؤقتة وإن طال مدتها، وكذلك السكتة الدماغية، لا يعتبر كل منهما موتاً، إذ إن معظم هذه

الحالات يمكن علاجها طبياً، خاصةً في ظل التقدم الطبي في العصر الحديث^(١).

ثالثاً: مع الاتفاق على ما تقدم إلا أنهم اختلفوا فيما إذا تم تشخيص حالة المريض على أنه ميت دماغياً وفق الأصول العلمية والطبية المتعارف عليها، إلا أن قلبه لا يزال ينبض، ويقوم بالتنفس عن طريق أجهزة التنفس الصناعي، فهل بموت دماغه فقط يعتبر ميتاً، تجري عليه أحكام الموتى، أم لا بد من توقف التنفس والنبض والقلب؟ وبمعنى أدق هل موت الدماغ يعتبر موتاً بالمعنى المعروف أم لا؟

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول: يرى أنصاره أن موت الدماغ لا يعتبر موتاً حقيقياً، ولا بد من توقف عمل جميع أعضاء الجسم، وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الحياة.

وهذا الرأي هو ما ذهب إليه بعض الأطباء وكثير من الفقهاء المعاصرين منهم: د. بكر أبو زيد، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد سعيد البوطي، والدكتور محمد الشنقيطي، وهو ما أخذ به المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، والدكتور محمد رأفت عثمان وغيرهم^(٢).

(١) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور. محمد مختار الشنقيطي، ص

٣٤٥، طبعة مكتبة الصحابة - جدة، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

(٢) د. بكر بن عبد الله أبو زيد: فقه النوازل، ص ٢٣٣، طبعة مطابع الفرزدق - الرياض،

الرأي الثاني: يرى أنصاره أن موت الدماغ يعتبر موتاً حقيقياً، وتترتب عليه أحكام الموت.

وهذا الرأي هو رأي أغلب الأطباء، وبعض الفقهاء المعاصرين وبعض القانونيين^(١)، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث الذي عقد في عمان بالأردن عام ١٤٠٧هـ.

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ، الشيخ. جاد الحق علي جاد الحق: بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ٤٩١/٢، طبعة الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، د. محمد سعيد البوطي: قضايا فقهية معاصرة، ص ١٢٧، طبعة مكتبة الفارابي - دمشق، الطبعة الأولى ١٩٩٢ م، د. عقيل العقيلي: حكم نقل الأعضاء، ص ١٥٠، طبعة مكتبة الصحابة - جدة، د/ محمد الشنقيطي: أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، ص ٢٣٥، فتوى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية الصادرة في ١٤/١٢/١٩٨١ م، جريدة الأخبار المصرية الصادرة في ٢٨/٥/١٩٩٧ م، جريدة الأهرام المصرية الصادرة في ٤/١٠/١٩٩٧ م، د. محمد رأفت عثمان: نقل وزرع الأعضاء، بحث مقدم لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر بعنوان " زراعة ونقل الأعضاء " والذي عقد في ١٣ ربيع أول ١٤٣٠ هـ الموافق ١٠ مارس ٢٠٠٩ م، ص ١٠.

(١) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ١٦٠، تصدير د. محمد سيد طنطاوي، د. حسان حنحو، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، د. أحمد شوقي أبو خطوة: القانون الجنائي والطب الحديث، ص ٧٣، طبعة دار النهضة العربية - القاهرة ١٩٩٥ م، د. محمد نعيم ياسين: نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبية، بحث منشور ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي، ضمن ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والتي عقدت في ٢٤ ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ الموافق ١٥ يناير ١٩٨٥، ص ٤٠٣.

حقيقياً بالكتاب، والسنة، والقواعد الفقهية، والمعقول:

أولاً: من الكتاب: استدلوا بما ورد من آيات في حق أصحاب الكهف، حيث قال تعالى ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا* إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا* فَضَرْبَنَا عَلَى ءِذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا* ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا﴾^(١).

وجه الدلالة:

تعد قصة أصحاب الكهف من أعجب القصص في القرآن الكريم، وقد اختلف في سبب إيواء الفتية إلى الكهف على قولين:

الأول: قيل إنهم هربوا بدينهم إلى الكهف، وهو ما يفسره قوله تعالى " فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

الثاني: أنهم كانوا أبناء عظماء وأشراف، خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد، فقال أسنهم: أجد في نفسي شيئاً ما أظن أن أحداً يجده، إن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً، ثم دخلوا الكهف ليختبئوا فيه، وظلوا فيه ثلاثمائة سنة وتسعاً^(٢).

وقد استدل بهذه الآية القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، حيث إن أصحاب الكهف طيلة هذه المدة الطويلة لم يكونوا في عداد الأموات؛ بدليل أن الله تعالى لم يصفهم بالموت، بل إنه أفقدهم القدرة

(١) الكهف: ٩ - ١٢.

(٢) تفسير الماوردي المسمى "النكت والعيون"، ٣/٢٨٧، ٢٨٨.

فقط، بدلالة قوله تعالى "فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا" والضرب على الأذن هو المنع من الاستماع، فكان دليلاً - كما قال المفسرون - على أنهم لم يموتوا^(١).

يقول الدكتور: توفيق الواعي: "أجمع الفقهاء والمفسرون على أن كلمة "بعثناهم" معناها أيقظناهم، لأن أجسامهم كانت حية، وفيها الحياة ولم تفقدها، بدليل قول الله تعالى بعد ذلك ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾"^(٢).

وبالتالي ففقد المريض الإحساس بالشعور، لا يُدْخِلُهُ في عداد الأموات، ما دامت الأعضاء الأساسية لا زالت تعمل، ويترتب على ذلك، أن موت الدماغ لا يعد موتاً بالمعنى الحقيقي لكلمة موت، إذ إن أعضاءه لا زالت تعمل، كما هو الحال في قصة أصحاب الكهف، وإذا كان الله عز وجل لم يحكم بموتهم ولم يصفهم بالموت، فكذلك موتى الدماغ.

المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال بأنه مبني على أن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس؛ وهو أمر لم يقل به أحد؛ بل هو تعطيل لمركز الأوامر الحياتية في الإنسان، بما لا يبقى معه حياة بعد رفع أجهزة الإنعاش، فإن الأطباء

(١) تفسير البغوي، ٣/١٨٢.

(٢) د. توفيق الواعي: حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية، بحث منشور ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي، ضمن ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والتي عقدت في ٢٤ ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ الموافق ١٥ يناير ١٩٨٥، ص ٤٧٢.

مجمعون على أنه لا أمل في إعادة حياة من ثبت تشخيص موت دماغه لا اعتبار ارتباط أسباب الحياة فيه، أضف إلى ذلك أن ما حدث مع أصحاب الكهف ليس موتاً بل نوم عادي طالت مدته، ولا شيء فيه من الموت أو الإغماء^(١).

الجواب:

يجاب عن هذه المناقشة، بأننا لم نقل إن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس، ولم يكن هذا هو الفارق بين موت الدماغ وبين الحالة التي كان عليها أصحاب الكهف، بل إن وجه الشبه بينهما هو بقاء الأعضاء حية، وما دام أصحاب الكهف أحياء لبقاء صفة الحياة في الأعضاء، فكذاك الميت دماغياً، لوجود ذات العلة فيه.

ثانياً: من السنة استدلو بما يلي:

- ما رواه الطبراني عن عمرو بن تميم بن عويم، عن أبيه عن جده، قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل، فقتلتها وما في بطنها، ف قضى رسول الله ﷺ فيها بالدية، وفي جنينها بغرة عبدٍ أو وليدة، فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نظر ولا استهل؟ فمثل هذا يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الجاهلية^(٢).

(١) د. فهد الرشيدى: أثر الموت في التصرفات الشرعية - دراسة فقهية مقارنة، ص ٢٤،

رسالة دكتوراة - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

(٢) المعجم الكبير، للطبراني، ١٧/١٤١

- ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاخصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان^(١).

وجه الدلالة:

استدل القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً بهذين الحديثين من وجهين:

الأول: إن النبي ﷺ قضى بالدية على الجاني، والجاني الذي في بطن الأم لم تكتمل له كل مظاهر الحياة وعلاماتها، بل منها ما ظهر، ومنها ما كان في طور الظهور، أي أنه جعل مناط الحكم مطلق العدوان على كل ما يسمى جنيناً، وقد حدد الفقهاء أقل ما يكون به ما في البطن جنيناً، فقال المزني: "أقل ما يكون به جنيناً، أن يفارق المضغة والعلقة، حتى يتبين شيء من خلق آدمي من أصبع أو ظفر أو عين وما أشبه ذلك" ^(٢).

الثاني: إن قضاء النبي ﷺ بذلك يدل بمفهوم المخالفة على اشتراط موت جميع الأعضاء للحكم بالموت؛ حيث أثبت الحياة له لثبوت حياة بعض الأعضاء دون البعض الآخر، والميت دماغياً باتفاق الجميع ما زالت

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، ١٣٥/٧

(٢) مختصر المزني، لإسماعيل بن يحيى المزني، ٣٥٦/٨.

الحياة سارية في بعض أعضائه، بل إن هناك تشابهاً واضحاً بين الجنين والميت دماغياً في أمارات الحياة الظاهرة على كل منهما، وهي التنفس والنبض واستمرار النمو، فكان الميت دماغياً بناءً على ذلك حياً، ولا يجوز الاعتداء عليه.

ثالثاً: إن الفقهاء عند بيانهم لحقيقة الموت حددوا جملةً من العلامات، لإصدار الحكم على الشخص بالموت، وهذه العلامات هي:

- استرخاء القدمين، حيث تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل.
- اعوجاج منخره أو ميل أنفه، لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة بالإنسان، فإذا مات ارتخى ولان ومال.
- انخساف صدغيه، لأن اللحيين ينطلقان، فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفاً.
- امتداد جلدة الوجه.
- تدلي جلدة الخصية^(١).

وقد اعتبر النبي ﷺ هذه العلامات، وحكم بقرب حدوث الموت بناءً عليها، فقد أخرج أبو داود، عن الحصين بن حوح، أن طلحة بن البراء مرّض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: إني لأرى طلحة إلا قد حدث فيه

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ٥٥٨/١، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، حاشية ابن عابدين، ١٨٩/٢، أسنى المطالب، ٢٩٩/١، نهاية المحتاج، لشمس الدين الرملي، ٤٤١/٢، طبعة دار الفكر - بيروت، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، المغني، ٣٣٧/٢، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ٣٤٣/١، طبعة عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

الموت، فأذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرائي أهله^(١).

والعلامات التي ذكرها الفقهاء تعني موت جميع الأعضاء، وعدم بقاء الحياة فيها كلية، لذا فإن موت الدماغ الذي يقول به الأطباء لا يعتبر موتاً بالمعنى المعروف لدى الفقهاء، لبقاء أجزاء الحياة في الجسد، ولعدم ظهور علامات الموت المؤكدة، وبالتالي يجب الاعتبار بتلك العلامات، وليس هناك ما يمنع من اعتبار كلام الأطباء والأخذ به، فهم أهل الخبرة والاختصاص، شريطة ألا يكون مخالفاً لما قاله الفقهاء، وما اعتبروه عندهم.

رابعاً: استدلو على قولهم بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً بقاعدة سد الذرائع، والتي تعني حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها^(٢) وقيل: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور^(٣) فهي بناءً على ذلك سد جميع الطرق الموصلة للمحرّمات، وإعمال قاعدة سد الذرائع في مسألتنا يتحقق من عدة وجوه:

أحدها: إن الاعتراف بهذا المفهوم يتيح أجساداً للبحث العلمي، أقرب ما تكون إلى الحياة، وبالتالي تكون نتائج البحوث أكثر دلالة، ويستفيد منها آخرون، وهذا يعني أن هذه الأجساد ليست ميتة، الأمر الذي يكون عائقاً أمام التقدم في وسائل علاجهم، إذ من المعروف أن كل داءٍ لا بد له من

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنّازة وكراهة حبسها، ٢٠٠/٣

(٢) الفروق، للقرافي، ٣٢/٢.

(٣) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٩٠/٨.

دواء، غاية الأمر أن الدواء لم يتم اكتشافه بعد، واحتمال إيجاد دواءٍ لمرضى موت الدماغ أمرٌ ليس بالمستحيل.

ووفقاً لما قاله الأطباء، فإنه في حالات إصابة الرأس التي تعتبر سبباً رئيساً لموت الدماغ يتضرر المخ، فيؤدي إلى إعاقة جزئية لإمدادات الدم للمخ، ونتيجةً لذلك فإن الخلايا العصبية لمركز التنفس تصبح خامدة، ثم تموت بعد ذلك، كما أن مرحلة التغيرات الوظيفية قابلة للعلاج، وقد قال أحد الأطباء مؤكداً ذلك: "إن التغيرات الوظيفية تخضع لمحاولات العلاج حتى في الوقت الحالي، وأن العلاج الدوائي في المستقبل قد يظهر أن جذع المخ الذي انعدمت وظائفه لم يدمر بطريقة لا يمكن إصلاحها؛ ولكن فقط تعطل تعطلاً مؤقتاً" ^(١).

ثانيها: إن قبول التعريف الجديد للموت قد يكون عاملاً أساسياً في فقدان الجمهور الثقة في الأطباء؛ لأن المعلوم لدى الجميع أن الأطباء رحمة من الله، وسبب من أسباب جلب الشفاء، فإذا تغير المفهوم المتأصل لدى الناس، حيث بتحول الرحمة إلى مجرد المتاجرة بالأجساد، فإن ذلك تكون له أضراره الكبيرة، وبالتالي فضرر قبول هذا المفهوم للموت على الأطباء أكثر من غيرهم.

ثالثها: إن تعريف الموت بناءً على مفهوم غامض، أدى إلى ظهور معايير مختلفة للتشخيص من بلدٍ لآخر، بل من مستشفى لآخر في نفس البلد، فيصبح المرء ميتاً في إحدى المستشفيات، فإذا انتقل إلى مستشفى آخر صار حياً، وهذا الأمر يعكس عدم مصداقية المفهوم، والتعجل في

(١) د. رؤوف سلام: التعريف العلمي للموت، السابق، ص ٤٦٢.

التطبيق الذي لا يستفيد منه المريض، كما أنه يتعارض مع مبدأ مسؤولية الطبيب عن مريضه^(١).

خامساً: استدلو بالاستصحاب باعتباره دليلاً من الأدلة الشرعية^(٢) ومعناه: بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل^(٣).

وجه الاستصحاب في مسألتنا: أننا أمام أمرين، أحدهما ثابت لا خفاء فيه، والآخر مدعى، فالحياة ثابتة، والموت مُخْتَلَفٌ في حدوثه ومشكوك فيه، وإعمالاً لهذه القاعدة، ينبغي الحكم بالحياة للمريض، حتى يقوم الدليل على انتهاء حياته ودخوله في عداد الأموات.

المناقشة: يناقش هذا الاستدلال بأن الحياة وإن كانت ثابتةً باعتبارها الأصل، فإن الموت قد طرأ، وقد قامت عليه الأدلة مما ذكره الأطباء بعد الفحص، وكذلك استخدام أجهزة رسم المخ، وما توصلوا إليه من خلال دراساتهم وبحوثهم.

الجواب: يجاب عن ذلك بأن الأدلة التي ذكرها المجيزون لاعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، لا تنهض من حيث قوتها على إثبات العكس، حيث إن هذه الأدلة تبناها المجيزون من الأطباء، في حين رفضها البعض الآخر، وأقاموا الأدلة على عدم القطع بصحة ما تؤدي إليه، وبالتالي فالدليل الطارئ ليس في قوة الدليل الأصلي، وبذلك تنعدم المخالفة.

(١) د. رؤوف سلام: التعريف العلمي الطبي للموت، السابق، ص ٤٦٣.

(٢) د. عقيل العقيلي: حكم نقل الأعضاء، السابق، ص ١٥٤.

(٣) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ١٣/٨، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٥١،

الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ٤٩/١.

سادساً: إن الأطباء قرروا أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم على أنهم موتى دماغ، تتوافر فيهم علامات الحياة، وهذه العلامات هي:

- استمرار الأفعال المنعكسة من سعال وقئ، وهذا أمر يحدث كثيراً لدرجة أن اثنين من الأطباء المتحمسين لموت الدماغ وهما د. بيتس PITS ود. كارونا CARONNA أكدا أن وجود هذه الأفعال يجب ألا يلغي تشخيص موت الدماغ.
- النشاط العصبي العضلي، والارتعاشات العضلية، والحركات المعقدة للأعضاء والجذوع، كثني الذراعين عند المرفقين، وإبعادهما عن مكانهما الأصلي، ورفعهما عن الطاولة، وتحريك اليدين إلى الصدر.
- الاستجابة المنعكسة في النشاط الدموي على شكل ارتفاع في معدل النبض وفي ضغط الدم، وهذه الأعراض تحدث عادةً استجابة للتحدي في حالة الاختناق، والاستجابة للمثير الجراحي خلال حصد الأعضاء.
- المحافظة على حرارة الجسم، حيث إن الشخص المتوفى دماغياً يمكن أن يظل جسمه محتفظاً بحرارته خلال المدى المعتاد، مما يشير بوضوح إلى وجود نشاط، كذلك يمكن أن يرتفع ضغط الدم، وتتكاثر كريات الدم البيضاء.
- يظل الشخص الميت دماغياً محتفظاً بما يسمى بالحياة الخاملة، بمعنى أن أظافره وشعره يستمران في النمو، وجهازه المعوي يمكن

أن يهضم الطعام ويمتصه^(١).

يقول الدكتور. أحمد الشواربي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة عين شمس مؤكداً هذه الحقيقة: " إنه من الثابت في كل المراجع الطبية، أن حالات موت المخ يكون أصحابها أحياء، تظهر فيهم مظاهر الحياة المختلفة، رغم توقف بعض وظائف المخ، حيث ينبض القلب نبضاً عادياً، ويحتفظ الجسم بحرارته الطبيعية، وتظل إفرازات معظم أجهزة الجسم على طبيعتها، ويستمر التمثيل الغذائي للكبد، وعمل الكليتين، ويحتفظ الجسم بالكثير من الأفعال الانعكاسية الإرادية، كما يستمر شعره وأظافره في النمو، وأن الحمل في حالة السيدات الحوامل اللاتي تم تشخيصهن (أي بموت المخ) يستمر طبيعياً طوال فترة الغيبوبة، حتى تتم الولادة في موعدها الطبيعي، وهو ما تم تسجيله علمياً ونشر بالمجلات والصحف في عشرات المرات في السنوات الأخيرة، وإن هذه الدلائل كلها تقطع باستمرار الحياة في هذه الأجساد، ومن ثم فإن تدخل الطبيب بإنهاء حياة هؤلاء، إنما هو قتل لنفس حرم الله قتلها " ^(٢).

المناقشة: نوقش هذا الدليل بمناقشتين:

- (١) د. صفوت لطفي: تحديد المفهوم الحديث لموت الدماغ، منشور ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في الفترة من ٧ - ٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ١٩٢، ١٩٣، د. مصطفى الذهبي: نقل الأعضاء بين الطب والدين، ص ١٠٩ طبعة دار الحديث - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
- (٢) د. يحيى هاشم حسن: ملاحظات حول تعريف الموت ونقل الأعضاء، مؤتمر الطب والقانون، السابق، ٩٠/١، ٩١.

المناقشة الأولى: إن وجود هذه الانعكاسات لا يعني نفي موت الدماغ، وله شبيه في الطب كالميت الذي يتحرك بمجرد تعرض الجثة للصعق الكهربائي، حيث إن هذا الميت لا يمكن القول بأنه حي، بل كل ما في الأمر أن الصدمة الكهربائية أحدثت تنبيهاً للجهاز المركزي العصبي لدرجة أنه يتحرك، بل يجلس ويرجع إلى وضعه مرةً أخرى، فليس معنى أنه يحرك يديه أن نستبعد موت الدماغ^(١).

المناقشة الثانية: إن بقاء عضو من الأعضاء على قيد الحياة أو في حالة قابلية للحياة، لا يتعارض مع موت صاحبه؛ فالقلب العضوي يمكن أن يستمر في العمل خارج الجسد منفصلاً عن صاحبه لساعاتٍ عديدة، إذا ما تم توفير الغذاء والحرارة المناسبة له، وهو في هذه المرحلة يكون صاحبه قد مات ودفن، وكذلك كثير من أعضاء الجسد، ولذلك لا يمكن الاستدلال بحياة عضو من الأعضاء على حياة صاحب العضو أو موته^(٢).

الجواب: يجاب عما سبق بأن استمرار عمل الأجهزة المختلفة في الجسم، كالقلب، والكبد، والجهاز الهضمي، والكليتين، وإفراز الهرمونات، والاحتفاظ بدرجة الحرارة، كلها تعد أدلةً قاطعةً على الاستمرار في الحياة لهؤلاء المرضى، إذ لا يمكن أن يوصف المريض الذي تعمل فيه كل هذه الأجهزة بأنه ميت، وفرنسا التي تعتبر من أفضل الدول في هذا المجال، لم

(١) مناقشة الدكتور. خيرى باسمرة لبحث الدكتور. صفوت لطفي في ندوة التعريف الطبي

للموت، السابق، ص ٢٠٨.

(٢) د. أحمد القاضي: القلب وعلاقته بالحياة، بحث منشور ضمن بحوث ندوة الحياة

الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي، ضمن ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم

الطبية والتي عقدت في ٢٤ ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ الموافق ١٥ يناير ١٩٨٥، ص ٣٩٠.

تحكم على هذا الشخص بأنه ميت، بل إنهم أسموه بالميت الحي، وقالوا في تفسيرهم لهذا المصطلح: إنه حيٌّ لأن أعضائه حية، وأنه ميت حسب الوجهة القانونية، وفقاً للقانون الفرنسي، لأنه فقد الاتصال بالآخرين^(١).

سابعاً: إن المحكوم عليه بالموت بناءً على الاعتراف بموت الدماغ لا يزال قلبه ينبض، ودورته الدموية تعمل، وهذا أعظم دليل على استقرار الحياة في الجسد، إذ الإنسان لا يعتبر ميتاً بتوقف الحياة في بعض أجزائه؛ بل يعتبر ميتاً بالموت الكلي لجميع الأعضاء، فلا تبقى في الجسد حياة^(٢).

أضف إلى ذلك: أن هناك اتفاق بين علماء الشرع وعلماء الطب على طبيعة العلاقة بين الروح والجسد، وأن الروح متصلة بالجسد اتصالاً وثيقاً، وأن علامة صلاحية الدماغ هو مكان الإدراك وأن الروح تدرك المدركات باستعمال الدماغ، وأنها تتصرف بالأعضاء بواسطة الدماغ، وأن علامة مفارقة الروح للجسد هي موت الدماغ بصورة نهائية، وأن الحركة الاضطرابية لا تدل على حياة أو موت الإنسان، وأن حياة الخلايا الجسدية تميز حياة الروح، وإمكان اتصالهما وانفصالهما^(٣).

يقول الدكتور. توفيق الواعي: " إن تعطل الإنسان لا يدل على فقد الحياة، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز أو التشبيه، فلا يقول عاقل مثلاً أن النائم ميت، ولا يقول إن المجنون فاقد للحياة، كما لا يقال ذلك

(١) مناقشة د. صفوت لطفي في ندوة التعريف الطبي للموت، ص ٤٠٩.

(٢) بيان للناس من الأزهر الشريف، للشيخ. جاد الحق على جاد الحق، السابق، ٣١٧/٢.

(٣) د. فيصل عبد الرحيم: تعريف الموت، منشور ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت، الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في الفترة من ٧ -

٩ شعبان ١٤١٧ هـ الموافق ١٧ - ١٩ ديسمبر ١٩٩٦ م، ص ٣٠٢.

لناقص الأهلية كالصبي غير المميز، ولا يقال إن هؤلاء يعاملون معاملة الأموات، كما لا يقال إن المريض حين يكون في غيبوبة تحت أي ظرفٍ يعامل معاملة الأموات، إلا إذا كان الموت والحياة أصبحا بيد البشر، وحاشا لله أن يدعي أحد ذلك " (١).

ثامناً: إن الاعتماد على جهاز رسم المخ كليةً للوصول إلى اليقين والقطع أمرٌ غير مقبول؛ لأن الوقائع تكذب نتائج هذا الجهاز، ويدل على ذلك ما يلي:

أ - بعض المرضى الذين تعرضوا لاختبارات رسم المخ، وحُكِمَ عليهم بأنهم موتى لما أراد الأطباء نزع أعضائهم، ظهرت عليهم علامات الحياة الطبيعية، الأمر الذي جعلهم يوقفون هذا العمل، متجهين إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإفاقة.

ب - بعض المرضى الذين اعتبروا موتى بموجب نتائج هذا الجهاز، ظهرت عليهم علامات تؤكد أنهم على قيد الحياة، ومن هذه العلامات:

- الكحة، والاستعداد للقيء عند إدخال شيء في الفم.
- النشاط العضلي والعصبي وانقباضات العضلات، وتحرك الأطراف.
- ثني الذراعين، ومحاولة القيام من فوق منضدة العمليات وضم اليدين إلى الصدر.
- تغير النبض، وضغط الدم أثناء عملية نزع الأعضاء مثلما يحدث

(١) د. توفيق الواعي: حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية؛ مجلة مجمع الفقه

تماماً للشخص العادي^(١)

تاسعاً: إن القائلين بفكرة موت الدماغ بالرغم من اعترافهم أن المخ هو أهم أعضاء الجسم، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان موت المخ موتاً لسائر الجسم أم لا، فيقترح "جايلين" أن يطلق على الشخص الذي مات مخه اسم "الميت الجديد" ليميز بذلك الجسم الذي يتنفس صناعياً عن الجسم الميت موتاً حقيقياً، وجاء اقتراحه لهذا الاسم، لأنه أكثر قبولاً عند الناس من وجهة نظره، أضف إلى ذلك أن البلاد التي تم فيها قبول فكرة الموت الجديد، كان المرضى والأطباء فيها غير متأكدين من صلاحية استخدام معايير موت المخ لإعلان وفاة الشخص، وكأنهم قبلوا أن المخ قد مات، ومع ذلك ترددوا في مدى كفاية ذلك للقول بموت الإنسان، وفي مجال إجراء البحوث على مرضى موت الدماغ، اعترف الباحثون أن الميت الجديد يشبه الشخص الحي أكثر من شبهه بالشخص الميت، لدرجة أن هذا أثار التساؤل عما إذا كان الميت الجديد يعتبر ميتاً أم لا^(٢).

عاشراً: إن الأطباء يقررون أن وفاة الإنسان تتحقق بتوقف خلايا المخ عن أداء وظيفتها، إذ يستحيل بحسب الحالة الراهنة للعلم عودتها للحياة، إلا أن هذه القواعد التي ذكرها الأطباء قابلة للإثبات العكس، وذلك

(١) د. عبد الرحمن العدوي: نقل الأعضاء من الحي أو موتى المخ محرم شرعاً، بحث مقدم

إلى مؤتمر نقل وزرع الأعضاء الثالث عشر، المنعقد في مجمع البحوث الإسلامية-

القاهرة في ١٣ ربيع أول ١٤٣٠ هـ الموافق ١٠ مارس ٢٠٠٩ م، ص ١٧، ١٨.

(٢) د. رؤوف سلام: التعريف العلمي الطبي للموت، السابق، ص ٤٩٥.

بالكشف عن علاجاتٍ في المستقبل، والتطور العلمي أكبر شاهدٍ على ذلك، فهناك العديد من الأمراض مات بسببها الكثير من الناس، حيث لم تكن قد اكتشفت لها العلاجات، أما الآن فقد تم الكشف عن تلك العلاجات، وفي وقتٍ ليس بالبعيد اعتبر توقف القلب سبباً من أسباب الوفاة، إلى أن تم اكتشاف أساليب العلاج، عن طريق وسائل إنعاش القلب، أو غيرها، وبالتالي فالحكم بالموت بناءً على عدم وجود أدوية أو علاجاتٍ أمرٌ لا يمكن قبوله ^(١).

أضف إلى ذلك: أن الاختبارات التي يبنى عليها تشخيص موت المخ، كلها اختباراتٌ للكشف عن غياب أنشطة المخ، ولا تعتبر كاشفة عن موت المخ، إلا أن مفهوم موت المخ مبني أساساً على أن تغيراتٍ معينة حدثت بالمخ أدت إلى تورمه لزيادة كمية السائل المحتجز به، وأدى هذا التورم إلى زيادة الضغط داخل الصندوق العظمي للجمجمة إلى درجةٍ أوقفت الدورة الدموية للمخ، فأصبح المخ معطلاً وبلا دورةٍ دموية، أي ميتاً، وحدثت به التغيرات المتوقعة لانقطاع الدورة الدموية ^(٢).

حادي عشر: أقر الأطباء أن هناك فترةً لا تقل عن أربع دقائق بين توقف القلب والتنفس وبين تشخيص الموت الإكلينيكي، وخلال هذه الفترة تكون أغلب الأعضاء حية وقابلة للاستمرار في العمل، إذا ما تم إنعاشها بتوفير المحيط الملائم لها من تغذية وتصريفٍ للفضلات، وخلايا المخ في هذه

(١) د. علي محمد علي: معيار تحقق الوفاة وما يتعلق بها من قضايا معاصرة في الفقه الإسلامي "الموت الرحيم"، ص ١٣١، طبعة دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م.

(٢) د. رؤوف سلام: التعريف العلمي للموت، السابق، ص ٤٥٤.

الفترة تكون حية، ولو تم إسعاف هذا الشخص بتدليك قلبه، أو بإعطائه الصدمات الكهربائية مع التنفس الصناعي لرفع الأكسجين بالدم، وإعطاء المنشطات والمسعفات اللازمة، فمن الممكن أن يبدأ التنفس الذاتي في العمل، ويعود الإنسان إلى وعيه، هذا إذا كان سبب الوفاة الأصلي يسمح بذلك، وبهذه الطريقة يمكن إنقاذ حياة بعض المرضى في هذه الفترة الحرجة التي يعتبر الإنسان فيها ميتاً بكل المقاييس الإكلينيكية الطبية، ولكنه لا يكون بالفعل كذلك، لأن مخه ومعظم أعضاء الجسم لا زالت حية^(١).

وهذه الفترة تسمى فترة الاحتضار، وبالتالي فإن القيام بأي فعل يؤدي إلى تعجيل الموت سواء أكان فعلاً إيجابياً أم سلبياً يعتبر جريمة قتل، لأنه اعتداء على إنسان حي.

ومع التسليم بما توصل إليه العلم فإن الصواب ألا نحكم بالموت على هذا الشخص، فلا يعتبر ميتاً، وإنما هو في سبيله إلى الموت؛ لأنه في حالة احتضار، والمحتضر لا يوصف بأنه ميت^(٢).

ثاني عشر: إن الموت حقيقة وجودية خلقت ضد الحياة، والموت والحياة لا يجتمعان في بدن واحد في وقت واحد، فإن مرضي الغيبوبة الدماغية أو مرضى جذع المخ إما أن يوصفوا بالموت أو الحياة، ووصفهم أنهم أموات منقوض باستمرار مظاهر الحياة التي أكدها الأطباء في أبدانهم، ولا يجوز الحكم بموت إنسان وبدنه ما زالت فيه حياة، ولا يزال يقبل الدواء، وتظهر عليه آثار تقبله من نمو وغيره، والأعضاء البشرية لا تستجيب

(١) د. مختار المهدي: نهاية الحياة الإنسانية، مجلة مجمع الفقه، الدورة الثالثة، ص ١٦٥.

(٢) د. محمد رأفت عثمان: نقل وزرع الأعضاء، السابق، ص ١١.

لوسائل الحياة إلا إذا كانت حية، فالحياة البدنية هي المعتبرة وليست الحياة الإدراكية، لأنها مناط التكليف، ولكن انتهائها بالغيوبة لا يعنى موت صاحبها إن توافرت لديه مظاهر الحياة، ومن ثم فيتعين وصف هؤلاء المرضى بأنهم أحياء، لم تفارق أرواحهم أبدانهم لوجود دلائل بقائها فيها^(١).

ومما يؤكد هذا الأمر مفهوم الحياة عند الأطباء أنفسهم، حيث حددوا مفهومها بأنها: العمليات التي تقوم بها الكائنات الحية، والتي في مجملها تميزها عن النظم غير الحية، والأيض هو أكد علامات الحياة وضوحاً، وهو مجموع كل العمليات الكيميائية التي تتم في الكائن الحي، ويمثل كذلك مقدرة الكائن الحي على تحويل المواد الغذائية التي تصل إليه إلى وحدات كيميائية نباتية، ممكن أن يصنع منها مواد أخرى^(٢).

ثالث عشر: إنه لا زال من الأطباء - بل من الدول - من لا يعترف بأن الشخص الذي حدث له ما يسمى بموت الدماغ يعامل باعتباره ميتاً، فمع أن القوانين في معظم الدول في العالم تعتبر أن الشخص الذي مات جذع المخ عنده صار ميتاً، حتى لو كان قلبه لا زال ينبض، فإنه لا زالت الكثير من الدول لا تعتبره كذلك، وعلى هذا فإن معظم دول العالم الثالث ومنها بعض الدول الإسلامية، وكذلك الصين لا تعترف بأن الشخص قد مات الموت الحقيقي، فلا تعترف هذه الدول بالموت إلا إذا توقف القلب

(١) د. عبد الفتاح إدريس: موت الدماغ من منظور إسلامي، ص ٢٤، محاضرة ألقى بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر - القاهرة.

(٢) الحياة علم البيولوجيا، تأليف. وليام بروفيس، جوردون أوريانز، ص ٦، مشار إليه في

بحث د. رؤوف سلام، السابق، ص ٤٤١.

والنبض، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ومع أن معظم الولايات فيها تقول بموت الدماغ وتعترف به؛ إلا أن هناك بعض الولايات لا ترى ذلك، واليابان هي الأخرى لا تعترف بالموت، إلا إذا ماتت جميع أعضاء الإنسان، أي أن موت الدماغ ليس كافياً عندهم للحكم بالموت^(١).

رابع عشر: إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد مفارقةً تامة، بحيث لا يبقى أثر للارتباط بينهما، وهذا ما دلت عليه عبارات الفقهاء التي أكدت أن الموت هو مفارقة الروح للجسد^(٢) وبالثورة الهائلة في المجال الطبي، أكد الطب أنه من الممكن التأكد من موت الدماغ، وذلك بالعرض على جهاز رسم المخ، إلا أن هذا الأمر لم يصل بعد إلى مرتبة الحقيقة العلمية المستقرة، وبالتالي لا يجوز اعتماد هذه الظاهرة وحدها، وبناء الأحكام الشرعية عليها^(٣).

خامس عشر: أمر الإسلام بحفظ النفس، وفرض العقوبة على من يعتدي عليها، سواء كان هذا الاعتداء عمداً، أم كان بطريق الخطأ، وما شرع الإسلام تلك العقوبات إلا لأهمية النفس، وأن في الحفاظ عليها استمرار للحياة، ومن مقتضيات حفظ النفس الاحتياط والانتظار والتريث قبل الحكم على شخص ما بالموت، إذ لا ينبغي أن يتم الحكم إلا بتوافر الأدلة القاطعة التي لا تقبل العكس، طيبة كانت أو شرعية، وهو ما قرره الفقهاء، حيث قرروا أنه في حالة الشك في حصول الموت من عدمه، فإنه يجب الانتظار

(١) أ. ندى محمد نعيم الدقر: موت الدماغ بين الطب والإسلام، السابق، ص ٢٢٨، د.

محمد رأفت عثمان: نقل وزرع الأعضاء، السابق، ص ١٠.

(٢) حاشية البيجرمي، ٣٠٤/٤، نهاية المحتاج، ٤٣٣/٢.

(٣) ندى الدقر: موت الدماغ بين الطب والإسلام، السابق، ص ١٥٥.

والتريث لحين ظهور العلامات المؤكدة.

قال في المغني: "وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ، أُعْتَبِرَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ مِنْ اسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ، وَانْفِصَالِ كَفِّهِ، وَمِيلِ أَنْفِهِ، وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ وَجْهِهِ، وَانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فَجَاءَ كَالْمَضْعُوقِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ حَزْبٍ أَوْ سَبْعٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أُنْتَظَرُ بِهِ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ، حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، قَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَضْعُوقِ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا، قَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّهُ رَبَّمَا تَغَيَّرَ فِي الصَّيْفِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قِيلَ: فَكَيْفَ تَقُولُ؟ قَالَ: يُتْرَكُ بِقَدْرِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَيِّتٌ قِيلَ لَهُ: مِنْ غَدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ" ^(١).

وقال ابن تيمية: "قد استفاضت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأن الأرواح تقبض، وتنعم وتعذب، ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة" ^(٢).

وقد احتاط الفقهاء أشد الاحتياط عند حدوث الشك في الموت من عدمه، وأوجبوا التأكد بظهور العلامات، فقال النووي: "يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته، بأن يموت بعلّة، أو تظهر أمارات الموت فإن شك بالألا يكون به علة، واحتمل أن يكون به سكتة، أو ظهرت أمارات فرع أو غيره، أخر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو غيره" ^(٣).

وتحقق موت الدماغ بناءً على ما تم تقريره أمرٌ مشكوكٌ فيه، وبالتالي ووفقاً لما تقدم، فإنه يجب الانتظار لحين حصول اليقين.

المناقشة: نوقش الاستدلال السابق بأن العلامات التي ذكرها الفقهاء

(١) المغني، لابن قدامة، ٣٣/٢.

(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٢٢٣/٤.

(٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، ٩٨/٢.

سابقاً ليست قطعيةً، وليست بالضرورة دالةً على موت الإنسان، فالله عز وجل قادرٌ على أن يعيد الحياة للإنسان بعد ظهور تلك العلامات، وفي هذه الحالة لا يمكننا الحكم على أي شخصٍ بالموت، حتى يتن وتظهر رائحته، لذا كان الاعتماد على ما ذكره الأطباء في هذا المقام أولى.

الجواب: يجب عن ذلك بأن الله تبارك وتعالى أناط الحكم بموت الإنسان بالعلامات التي تدل عليه، مع الاحتياط في الحالات التي تكون استثنائية، كغرق، واحتراق، وانتشال من تحت أنقاض هدم، فالعهدة في الحكم بالموت بعد استكمال العلامات كلها مع الحيلة الزائدة في الحالات الاستثنائية، أما موت الدماغ وحده دون وجود سائر العلامات الأخرى، فالعهدة في الحكم فيها على الذين اجتهدوا وقاسوا، ولا شك أن هذا قياس مع الفارق^(١).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني، على قولهم باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً بالأدلة الآتية:

أولاً: استدلو بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر^(٢).

(١) د. محمد سعيد البوطي: بداية ونهاية الحياة من الناحية الشرعية والطبية والقانونية، السابق، ٦٦/١، ٦٧.

(٢) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء عليه إذا حضر، ٦٣٤/٢.

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، حيث أفاد أن الروح إذا فارقت البدن تبعها البصر، وبالتالي لا يبقى أي منعكس من منعكسات العين، وهذا هو حقيقة موت الدماغ

قال المناوي في فيض القدير: "قال القاضي: يحتمل أن الملك المتوفي للمحتضر يتمثل له، فينظر إليه نظر شزرا، ولا يرتد إليه طرفه حتى تفارقه الروح، وتضمحل بقايا القوى، ويبطل البصر على تلك الهيئة، فهو علة للشق، ويحتمل كونه للإغماض؛ لأن الروح إذا فارقت تتبعه الباصرة في الذهاب، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة" ^(١).

المناقشة: يناقش الاستدلال بهذا الحديث، بأنه استدلال أخرج الحديث عما يرمي إليه، حيث إن العلماء قرروا أنه يحتمل أمرين:

الأول: أن ذلك يكون بعد خروج الروح من أكثر البدن، وهي لا تزال باقية في الرأس والعين، فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم ينته كلها، نظر البعض إلى القدر الذي خرج، وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه، فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين، سَكَنَ النظر، وبالتالي يكون معنى قوله "إذا قبض" أي: إذا شرع في قبضه ولم ينته.

الثاني: أن يحمل ذلك على أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجةً، فيرى ويسمع ويرد السلام ^(٢) وبالتالي فالحديث خارج عن محل النزاع.

(١) فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي، ٣/٢٤٣، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،

١١٦٨/٣.

(٢) الدياج على صحيح مسلم بن الحجاج، ٣/١١.

ثانياً: إن العلماء - القدامى منهم والمحدثين - قرروا أن الإنسان روحٌ وجسد، وأن علامة الحياة هي ملازمة الروح للجسد حتى يقوم الجسد بخدمة الروح، وقرروا أيضاً أنه إذا أصبح الجسد عاجزاً عن خدمة الروح فإن ذلك يعد نهايةً لحياة ذلك الشخص، وموتى الدماغ تتحقق فيهم تلك الأوصاف، حيث لا يستطيع الجسد فعل أي شيء للروح، إذ صارت الأدوية غير مجدية في علاج مثل هذه الحالات.

يقول الإمام الغزالي: "معنى مفارقة الروح للجسد، انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها، فإن الأعضاء آلات الروح تستعملها، حتى أنها لتبطلش باليد، وتسمع بالأذن، وتبصر بالعين، وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب، وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفساد مزاج يقع فيه، وبشدة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها، فتكون الروح العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء، وقد استعصى عليها بعضها، والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها، وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها" (١).

ويقول ابن القيم: "الروح جسمٌ مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف، حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه

الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح" (١).

ويعقب الدكتور. محمد نعيم ياسين على هذه النقول، مدلاً على قوله باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً بقوله: "إن ملازمة الروح للجسد الإنساني مرهونةً بصلاحية هذا الجسد لخدمة هذه الروح وتنفيذ أوامرها، وقبول آثارها، وأن الله قد كتب عليها أن تفارق مسكنها المؤقت، وهو جسد الإنسان عندما يغدو عاجزاً عن القيام بتلك الوظائف" (٢).

المنافسة: يناقش هذا القول بأننا نسلم لكم أن الجسد خادم للروح، وسلمنا كذلك بأن الجسد إذا صار عاجزاً عن خدمة الروح، كان ذلك إيذاناً بنهاية الحياة، ولكن لا نسلم لكم اليقين بأنه في حالة موت الدماغ يتحقق عجز الجسد عن خدمة الروح، ثم إن المقصود بعجز الجسد الذي يحكم بناءً عليه بالمفارقة للحياة هو العجز الكلي، والمتمثل في عدم القدرة الحالية، وعدم إمكانية ذلك مستقبلاً، وهذا ما لا يمكن القطع به وفقاً للقواعد الطبية، بدليل خرق بعض الحالات لتلك القواعد، فالعجز المقصود هنا هو موت سائر أعضاء الجسد كلية، وهو غير متحقق في مسألتنا.

ثالثاً: استدلو بقولهم: إن من مات مخه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يعود للحياة، إذ من المبادئ الأساسية في علم الأمراض العصبية أن خلايا المخ لا يمكن أن تتجدد في حالة تلفها، وبالتالي فوجود أعضاء الجسم حيةً بعد موت المخ، لا يعني أنه بإمكانها أن تستمر كذلك طويلاً،

(١) الروح، لابن قيم الجوزية، ص ١٧٨.

(٢) د. محمد نعيم ياسين: نهاية الحياة الإنسانية، السابق، ص ٤٠٣.

لأن جميع أعضاء الجسم وخلاياه تعمل تحت سيطرة المخ وتستمد بقاءها منه، فهو القائد الذي يقودها، وبالتالي فبمجرد موت المخ تبدأ الأعضاء في التحلل التدريجي وفقاً لمدى اعتمادها على وظائف المخ في البقاء، وأسرعها في الزوال الوعي، ووظائف الحس، والحركة الإرادية، ثم باقي الأعضاء^(١)، أي أنه بذلك يفقد ما يميزه كإنسان، وهو كافٍ لإعلان الوفاة الحقيقية.

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بمناقشتين:

المناقشة الأولى: إن التسليم بذلك يعد أمراً في غاية الخطورة، بل قد لا يقبل عملاً ولا عقلاً، لأنه يفتح باباً واسعاً من الاعتداءات والانتهاكات لأجساد المرضى، إذ يترتب على التسليم بذلك أن المجنون يجوز التصرف في جسده، لفقدانه لتلك الخاصية، وهذا المفهوم لموت الدماغ يواجه معارضة كبيرة، إذ وفقاً له يجوز الحكم بالموت على كل مريض الغيوبة العميقة، وكذلك مصابوا الأمراض العقلية، وقد مال بعض الأطباء العرب إلى التأكيد على الأخذ بهذا الرأي، رغم المعارضة الشديدة والواسعة، وهو أمر تتفاقم خطورته، لأنه وفقاً لذلك سيكون المرضى النباتيون والمولودون بدون دماغ في عداد الأموات، بالرغم من حياة أبدانهم.

وقد قرر هذه الحقيقة المؤتمر الدولي لموت المخ الذي عقد في عام ١٩٩٢م إذ قرر أن موت المخ يكتنفه التخييط بين الأطباء حول حقيقة حالة المرضى الذين تم توقفت وظائف المخ لديهم، ولكن خلايا وأنسجة

(١) د. محمد مختار المهدي: مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم

الشرعي، السابق، ص ٢٦٧.

الأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة تستمر في الحياة^(١).

المناقشة الثانية: إن هذا الاستدلال منقوض بوجود حالات تم تشخيصها على أنها موت دماغ، ثم عادت إلى الحياة.

الجواب: يجاب عن المناقشة الثانية بأن الحالات التي تمت إفاقتها، وبالتالي عودتها إلى الحياة فوق ندرتها، لم يتم تشخيصها في البداية تشخيصاً صحيحاً، كما أن الخلط بين الغيبوبة الطويلة وموت الدماغ، هو خلط بين الحياة والموت، وأنه ليس من المقبول أن تكون تلك الحالات قد شخصت كحالات موت مخ حسب البروتوكولات والشروط الموضوعية، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها^(٢).

وابعداً: إن عبارات الفقهاء القدامى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الشخص لا يطلق عليه أنه ميت، إلا إذا انعدمت فيه كل مظاهر الحياة من تنفس، ونبض، وحركة، وما إلى ذلك، وقد تحدثوا عن هذه المسألة تفصيلاً في معرض حديثهم عن حكم الاشتراك في القتل:

فقال الزركشي في المنثور: "وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقَرَّةُ هِيَ أَنْ تَكُونَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ (وَمَعَهَا) الْحَرَكَةُ الْإِخْتِيَارِيَّةُ دُونَ (الْإِضْطِرَارِيَّةِ) كَالشَّاءِ، إِذَا أُخْرِجَ الذَّنْبُ حَشَوْتَهَا وَأَبَانَهَا (حَرَكَتَهَا) حَرَكَةً اضْطِرَارِيَّةً، فَلَا تَحُلُّ إِذَا ذُبِحَتْ، كَمَا لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ طُعِنَ إِنْسَانٌ وَقُطِعَ (بِمَوْتِهِ) بَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ يَوْمٍ، وَقَتْلُهُ إِنْسَانٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَجَبَ

(١) مناقشة الدكتور. صفوت لطفي، السابق، ص ٤٠٦.

(٢) د. عبد الهادي مصباح: قانون نقل الأعضاء ضرورة، بحث موجود على الإنترنت موقع

<http://abrakenheart.maktoobblog.com/p.post٢٥٨٠٧>

الْقِصَاصُ، لِأَنَّ حَيَاتَهُ مُسْتَقَرَّةً، وَحَرَكَتُهُ الْإِخْتِيَارِيَّةُ مُوجُودَةٌ، وَلِهَذَا أَمْضَوْا وَصِيَّةَ (أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ) عُمَرَ (بْنِ الْخَطَّابِ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِخِلَافِ مَا إِذَا أُبَيِّنَتْ الْحَشْوَةُ؛ لِأَنَّ مَجَارِيَ النَّفْسِ قَدْ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ الْحَرَكَةُ اضْطِرَارِيَّةً، وَقَدْ تَكُونُ الْحَوَاشِ سَلِيمَةً وَالْحَيَاةُ مُسْتَقَرَّةً وَالْحَرَكَةُ اخْتِيَارِيَّةً، وَيُعْطَى الْإِنْسَانُ فِيهَا حُكْمُ الْأَمْوَاتِ كَالْوَاقِعِ فِي بَحْرٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ (وَأَمَّا حَيَاةُ عَيْشِ الْمَذْبُوحِ وَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا) (إِنْصَارَ) وَلَا نُطْقٌ وَلَا حَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ" (١).

المنافسة: نقوش هذا الدليل بأن الفقهاء لم يحكموا بموت الشخص إذا كانت حياته غير مستقرة، وإنما لم يوجبوا القصاص على من طعن من أبينت حشوته، لأن فعله ليس هو المؤثر في موته، وإنما أثر في موته إبانة حشوته، إذ إن من أبينت حشوته لا يبقى معها حياة، لكنه لا يأخذ حكم الميت حتى يتيقن منه (٢).

ومما يؤكد ذلك، أن الفقهاء ذكروا أن المجني عليه إذا صار إلى مرحلة الحياة غير المستقرة بسبب مرضٍ لا بسبب جناية، أو فعل حيوان مفترس، كما لو صار إلى مرحلة النزع، فأجهز عليه مجرمٌ وهو في هذه الحالة فإن جمهور الفقهاء يذهبون إلى إيجاب القصاص على هذا الشخص (٣).

خامساً: أثبتت المصادر الطبية أن النسيج الشبكي هو المسئول عن وعي الإنسان، وإذا فقد الإنسان وعيه لأي سببٍ من الأسباب، فيكون هذا النسيج

(١) المنشور في القواعد الفقهية، للزركشي، ١٠٥/٢.

(٢) أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، السابق، ص ٣٢٩.

(٣) د. محمد نعيم ياسين: نهاية الحياة الإنسانية، السابق، ص ٤١٣.

قد تعرض لضرر، وليس هناك أمل لدى العلماء في إيجاد بديل للمخ في المستقبل يكون بديلاً للمخ التالف، نظراً للتعقيد الشديد في تركيب الدماغ ووظائفه.

وبالتالي فالمخ الحي لا يكون إلا في إنسان حي، ونقل المخ منه يعد بمثابة قتل محقق، وقد جاء في إعلان سيدني الصادر في عام ١٩٦٨ م: "إن الموت على مستوى الخلية أو مستوى الأنسجة عملية تدريجية، والأنسجة تختلف في تحملها، لحرمانها من الأوكسجين، وليس المهم تحديد موت الأعضاء المختلفة أو مجموعات الخلايا، وإنما المهم التأكد من أن عملية الموت قد وصلت إلى نقطة لا يمكن عندها وقفها مهما استعمل من وسائل العلاج والإنعاش، وإن وجد عضو، أو مجموعة من الخلايا حية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكائن ذاته حي" ^(١).

سادساً: إن مسألة تحديد نهاية الحياة من اختصاص الأطباء، فهم الذين يقفون على الشجرة الحرجة من هذه المسألة، فملازمة الروح للجسد الإنساني مرهونة بصلاحية هذا الجسد لخدمة هذه الروح، وتنفيذ أوامرها وقبول آثارها، وأن الله عز وجل قد كتب عليها أن تفارق مسكنها المؤقت، وهو جسد الإنسان عندما يغدو عاجزاً عن القيام بتلك الوظائف، والعلم هو الذي يستطيع أن يعرف تلك اللحظة التي يصبح فيها الجسد عاجزاً، ومما لا شك فيه أن معرفة التشريح النسيجي والفسيولوجي للدماغ وحالات مرضه،

(١) د. عصام الدين الشربيني: الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، ص ٥٧٩، د. أحمد جلال الجوهري: الإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانية، ص ١٢٩، بحث منشور بمجلة الحقوق والشرعية الصادرة عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الخامسة ١٩٨١ م.

ومن ثم موته، تعد من أمور الدنيا، فهي ليست أمراً دينياً^(١).

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأنه محل نظر؛ لأن الحكم على شخص بالموت أو بعدمه هي مسألة شرعية قبل كونها طبية، إذ يترتب عليها أحكام شرعية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلو سلمنا أن المسألة اختصاص أصيل للأطباء، فالأطباء أنفسهم مختلفون فيما بينهم، فمنهم من يعتبره موتاً حقيقياً، ومنهم من لا يعتبره كذلك، مضافاً إلى ذلك كله الأخطاء التي قد تحدث في التشخيص، والتي أقر الأطباء بوجودها، مع كل ذلك لا ينبغي الاعتماد على قول الأطباء وحدهم^(٢).

سابعاً: إن القول باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً يؤدي إلى جملة من الفوائد، منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي، ومن هذه الفوائد:

- اهتمام فريق نقل الأعضاء باستخدام الميت باعتباره متبرعاً.
- توفير التكاليف الباهظة للملاحظة في العناية المركزة.
- توفير سرير في وحدة العناية المركزة لحالة مريض آخر، قد تكون الآمال في إنقاذ حياته أكبر من المريض الميت دماغياً.
- التقليل من الفترة المحزنة للأقارب.
- منع الإساءة إلى المتوفي.
- رفع أجهزة الإنعاش عن المحكوم عليهم بالموت، وإسعاف من

(١) د. محمد نعيم ياسين: نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، ص ٦٤١.

(٢) د. محمد المختار المهدي: متى تنتهي الحياة، السابق، ص ٤٥٣، فقه النوازل، ل بكر أبو

مات قلبه دون دماغه.

- إزالة الإحباط الذي يصيب العاملين في وحدة العناية المركزة، حين يجبرون على تمريض جسم شخص ميت.
- البدء في ترتيب أوضاع المستحقين للإرث، واتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بأحكام الموتى^(١).

المناقشة: يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يلي:

- ١- إن الفوائد المادية التي من الممكن تحقيقها من الحكم بموت الدماغ، لا يمكن أن تكون بأي حالٍ من الأحوال من العوامل المؤثرة في تحديد الحكم الشرعي لهذه المسألة، ولو كان لها اعتبار لتغيرت الكثير من الأحكام، ولصار المجتمع مجتمعاً يقوم على المادة، دون أدنى اعتبارٍ للكرامة الإنسانية.
- ٢- القول بتقليل الفترة المحزنة للأقارب في حالة الحكم بالموت قولٌ غير مقبول؛ فإذا كان الأقارب يحزنون على بقاء مريضهم تحت أجهزة الإنعاش فترةً من الزمن، وكان هذا الحزن س ينتهي أو يقل لو تم إعلان موته، فإن الحزن سيزداد ويتعاضد في حالة علمهم أن ميتهم قد أخذت أعضاؤه لينتفع بها غيره، فكأننا بذلك جمعنا عليهم بلاءين، بلاء الموت، وبلاء هتك حرمة.
- ٣- الادعاء بأن العاملين في المستشفى القائمين على تمريضه يصابون

(١) د. سهيل الشمري: موت الدماغ المأزق والحل، السابق، ص ٣٨٥، د. عدنان خريط:

موت الدماغ التعريفات والمفاهيم، السابق، ص ٣٥٦، د. بكر أبو زيد: فقه النواز، ص

بإحباط أمر غير متصور؛ بل غير منطقي؛ لأن التسليم بذلك يعني أنه يجب إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه وفقاً للقواعد العلمية، كمرضى الإيدز، والسرطان، وغيرها من الأمراض التي لم يتوصل الطب لعلاج لها حتى الآن، وهو أمر لا يجوز شرعاً ولا عقلاً.

٤- إن هذا القول يتعارض مع الهدف من مهنة الطب والتمريض؛ فالطبيب يقوم بعلاج المريض مهما ساءت حالته، باذلاً أقصى ما في وسعه لإنقاذ حياة المريض، فإذا لم يتم الشفاء، فإن ذلك هو قدر الله خارج عن إرادته، أما إذا ترك المريض بدون علاج بدعوى عدم جدوى العلاج، فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها شرعاً وقانوناً.

ثامناً: إن تحديد الوفاة بموت الدماغ، واعتباره موتاً حقيقياً ساد العمل به في معظم البلدان المتقدمة خلال العقود السابقة، وحقيقة الموت واحدة للإنسان، ويجب ألا تختلف باختلاف البلدان، إذ إنه وضعت علامات واضحة للوفاة الدماغية، وأنها تعادل وفاة الجسد، وأن جميع من ماتوا لتوافر شروط التشخيص فيهم، لم يرجع أحد منهم للحياة مرة أخرى، ففي مراجع الطب الأدبي وجد "باليس كريستوفر" عدد ١٠٣٦ حالة موت دماغي، نشرت في ستة عشر تقريراً بين عامي ١٩٦٨ - ١٩٨٨ جميعها، توقفت قلوبهم، بالرغم من الاستمرار في علاجهم وإبقائهم على أجهزة الإنعاش^(١).

(١) د. محمد مختار المهدي: مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم

المنافسة: نوقش هذا الاستدلال بأن فيه نوع من التناقض؛ إذ إنه أفاد أن حقيقة الموت للإنسان واحدة، ويجب ألا تختلف باختلاف البلدان، وهذا كلام مقبول، ولكن الثابت الذي لا جدال فيه ولا مرأى، أن القواعد التي يتم بها التشخيص تختلف من بلدٍ لآخر، بل تختلف من ولايةٍ لأخرى في ذات البلد، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن القول بأن كل من تم تشخيصهم على أنهم موتى دماغ، لم يرجع منهم أحد للحياة مرةً أخرى مردود بأنه قد ثبت رجوع بعضهم للحياة بعد أن حكم عليهم بأنهم موتى دماغ وفقاً لقواعد التشخيص المعترف بها، فالدليل بناءً على ذلك لا ينهض حجة في الموضوع.

تاسعاً: إن موت القلب لا يعد موتاً نهائياً؛ وإنما الموت النهائي هو موت جذع الدماغ، والدليل على ذلك أن عملية زرع القلب بعد استئصال القلب الأصلي لا تعد موتاً، ولا أحد يعتبر المريض أنه قد مات مع أن قلبه الأصلي قد مات، وكذا من أخذ القلب منه، فإن قلبه لا يزال حياً مع أن صاحبه قد مات منذ زمن^(١)، حيث إن للموت علامات مبكرة وعلامات متأخرة، فالمبكرة تتمثل في فقدان الوعي والإحساس والحواس، وتوقف التنفس، وتوقف القلب عن النبض، والعلامات المتأخرة تتمثل في برودة الجثث، وتيبسها، وتغير لونها إلى اللون الأزرق، وتعفنها^(٢).

المنافسة: نوقش هذا الدليل بأنه خارج عن محل النزاع؛ فمحل النزاع

الشرعي، السابق، د. عدنان خريط: موت الدماغ التعريفات والمفاهيم، السابق، ص ٣٧٣.

(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٥/٢/٣.

(٢) د. فيصل عبد الرحيم شاهين: تعريف الموت، السابق، ص ٢٩٧.

موت الدماغ وليس موت القلب، والخلاف في وفاة الإنسان شرعاً بعد موت دماغه، وقبل توقف القلب والتنفس اللذان يعملان فيه بسبب الآلة، وبالتالي فلا يصلح هذا الدليل في مسألتنا.

عاشراً: استدلوا بقول اللخمي: "أُخْتِلِفَ فِي الْحَرَكَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْعُطَاسِ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْحَيَاةِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ أَقَامَ يَوْمًا يَتَنَفَّسُ وَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ وَيَتَحَرَّكُ حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ صَوْتُ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَحَرَكَتُهُ كَحَرَكَتِهِ فِي الْبَطْنِ لَا يُحْكَمُ لَهُ فِيهَا بِحَيَاةٍ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَقَدْ يَتَحَرَّكُ الْمَقْتُولُ (أَوْ عَطَسَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ (أَوْ بَالَ) ابْنُ عَرَفَةَ: بَوْلُهُ لَغَوٌ (أَوْ رَضَعَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَعَارَضَ هَذَا الْمَازِرِيُّ وَقَالَ: لَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ دَلَالَةِ الرَّضَاعِ عَلَى الْحَيَاةِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهُ مُحَالٌ بِالْعَادَةِ أَنْ يَرْضَعَ الْمَيِّتُ، وَلَيْسَ الرَّضَاعُ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَكُونُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الطَّبِيعَةِ وَالِاخْتِيَارِيَّةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنَّ الْعُطَاسَ يَكُونُ مِنَ الرِّيحِ وَالْبَوْلُ مِنَ اسْتِرْخَاءِ الْمَوَاسِكِ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ، وَالتَّشَكُّكُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْحَيَاةِ يُطْرُقُ إِلَى هَذِهِ قَوَاعِدَ ضَرُورِيَّةٍ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَالِاسْتِهْلَالِ بِالصُّرَاخِ"^(١).

وعقب المواق على ذلك بقوله: " فَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا طُعِنَ مَعْدُودًا فِي الْأَمْوَاتِ لَوْ مَاتَ لَهُ مَوْرُوثٌ لَمَّا وَرِثَهُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَئِذٍ لَمَّا قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ حِينَئِذٍ يَتَكَلَّمُ وَيَعْهَدُ، وَفَرَقَ بَيْنَ وَلَدِ الْبَقَرَةِ مَثَلًا تَزَلُّقُهُ وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ، وَبَيْنَ الْمَرِيضَةِ الَّتِي أَيْسَ مِنْ حَيَاتِهَا، هَذِهِ يُرَاعَى الْإِسْتِصْحَابُ فَتُحَسَّبُ حَيَّةً

(١) التاج والإكليل شرح مختصر خليل، للمواق، ٧١/٣.

وَتَعَلَّقَ بِهَا الزَّكَاءُ بِخِلَافِ الْمُزْلَقِ " (١).

فقد دلت النصوص السابقة، على أن الحياة لا تثبت إلا بالصوت، والصوت حركة مرتبطة بالدماغ، فإذا كان الدماغ هامداً لا يعطي أوامره، ولا يضبط الإرجاع عن المؤثرات فإنه لا حياة، ولذلك قدروا أن العطاس والبول والرضاع لا يعبر عن الحياة، وتنبه المازري إلى أن الرضاع حركة إرادية، يعني أن الدماغ هو الذي يتدخل ليرضع الإنسان، فالامتصاص ليس عملية طبيعية، وإنما هو عملية إرادية لا تكون إلا إذا كان الدماغ عاملاً (٢).

حادي عشر: من المتعارف عليه طبيًا، أن بعض أعضاء الجسد قد تبقى حيةً وتقوم بوظيفتها، على الرغم من موت صاحبها دماغياً، وإن استمر تنفسه بواسطة المنفسة، أو نبضه وتدفق دمه من الشرايين والأوردة ما عدا الدماغ، ومن أوضح الأمثلة على ذلك، ما يحدث للمحكوم عليهم بالإعدام شنقاً، فبمجرد الشنق تنقطع الدورة الدموية عن الدماغ، لأن جذع الدماغ يتمزق بعظمة ناتئة من الفقرة الثانية من العمود الفقري، تخترقه وتسبب توقف الدم عنه، بينما يستمر القلب في ضخ الدم لعدة دقائق قد تصل إلى ١٥ أو ٢٠ دقيقة، الأمر الذي يؤكد وجود فترة زمنية بين موت القلب وموت الإنسان، وهذه الفترة يمكن التحكم في إطالتها باستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي، التي تضمن استمرار القلب في النبض وضخ الدورة الدموية في الجسم، وتكون النتيجة أن تطول فترة حياة الأعضاء بعد وفاة صاحبها (٣).

(١) المرجع السابق، ٧١/٣.

(٢) د. محمد مختار المهدي: متى تنتهي الحياة الإنسانية، السابق، ص ٤٥٢.

(٣) د. عبد الرحمن السويد: الوفاة الدماغية وأمور الإنعاش التنفسي والقلبي، ص ٣، بحث

الرأي الراجح:

من خلال ما تقدم عرضه من آراء في هذه المسألة، وما اعتمد عليه كل رأي من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، يتضح لي أن هذه المسألة من المسائل الشائكة التي تنازع فيها الأطباء والفقهاء، ولكل منهم وجهة نظره التي يدافع عنها.

فالأطباء يرون في عجز الأعضاء عن خدمة الروح موتٌ محقق، ولا عبرة عندهم ببقاء بعض الأعضاء على قيد الحياة بعد موت الدماغ، اعتماداً منهم على أن الدماغ هو المحرك الرئيس لباقي الأعضاء، وأن بقاء الحياة في بعض الأعضاء بعد موت الدماغ لن يستمر طويلاً، فمصيرها إلى الزوال.

أما الفقهاء فإنهم يرون الجسد والروح شيئاً واحداً، وإن كان لكل منهما مهمته، ورؤية الفقهاء هذه تنبع من أن كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا يمكن أن يستغني أي منهما عن الآخر، ويعتبرون أن بقاء عضو من الأعضاء حياً، يعد مؤشراً واضحاً ودليلاً على حياة صاحبه.

لذا فإنني أرى أن الراجح في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، من القول بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، وذلك لما يلي:

أولاً: قوة الأدلة التي اعتمد عليها هذا القول، وضعف أدلة المخالف.

ثانياً: إن الأدلة التي اعتمد عليها الرأي المخالف تقوم على أساس قواعد علمية متعارف عليها في المجال الطبي، وهذه القواعد تم إثبات

عكسها في بعض الحالات، وهذه الحالات وإن كانت نادرة إلا أنها تضع علامة استفهام حول إمكانية الأخذ بها كقاعدة عامة، لأن الأمر يتعلق بالأرواح، وقد يترتب على ذلك الحكم على شخص حي بدخوله في عداد الأموات.

ثالثاً: إن القول باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً يخالف المنطق، ويتجافى مع ما يرمي إليه العقل، بل يؤدي إلى قتل الأبرياء، حيث إن الأطباء في الماضي كانوا يرون أن المعول عليه في الموت هو توقف القلب عن العمل، ثم بعد ذلك وجدت الأساليب التي يتم بها إنعاش القلب، مما أدى إلى التغاضي عن معيار توقف القلب، ثم نجدهم الآن يقررون أن موت الدماغ هو الفصل في تقرير إعلان الوفاة، وكل ذلك بناءً على ما لديهم من معلومات، وبالتالي فمن المنطقي جداً أن يتم استحداث منعشات للدماغ في المستقبل كما تم للقلب.

رابعاً: إن معنى الموت الذي يعلمه العامة قبل الخاصة عدم صلاحية الجسد لأن يحدث به أي مظهر من مظاهر الحياة، وهذا يختلف تماماً مع ما يسمى بموت الدماغ، حيث إن الأطباء أنفسهم القائلين بفكرة موت الدماغ قرروا أن الميت دماغياً تظل له بعض مظاهر الحياة، كنمو شعره وأظافره، والواقع أثبت ذلك أيضاً، فقد نقل أن امرأة من فينلندا دخلت في غيبوبة طويلة، وتم التقرير بموت دماغها، وكانت هذه المرأة حاملاً وولدت طفلها أثناء تلك الغيبوبة كامل النمو، ثم عادت المرأة للحياة بعد ذلك، ولو كان موت الدماغ كافياً في إنهاء الحياة لماتت تلك المرأة، ولما كانت صالحة لأن تقوم بما يقوم به الأحياء، وبالتالي فاجتماع النقيضين مستحيل.

خامساً: إن هناك تناقضاً واضحاً يدركه كل عاقل عند نظره لهذه المسألة، مفاده أن القائلين بموت الدماغ أطلقوا عليه اسم "الميت الحي"

واتفقوا على حياة بعض أعضائه وأجهزته الحيوية، فهل يجتمع الموت والحياة في جسد واحد؟ هذا أمر محال الحدوث، فعلماء اللغة يعرفون الموت والحياة بأن كلاً منهما نقيض الآخر.

سادساً: إن الأطباء عندما تكلموا عن موت الدماغ دائماً ما يرددون عبارة " توقفاً لا أمل في رجوعه " أي يقولون إنه ميؤوس من شفائه، وأنا أتساءل هل الميؤوس من شفائه، والشخص الذي لا أمل في رجوعه للحياة، هل هو شخص حي أم ميت؟ هو بالمنطق يعد حياً؛ لأنهم يطلقون عليه مريض، والمريض لا يمكن أن يكون ميتاً بأي حالٍ من الأحوال.

المبحث الثالث

حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ

تعد مسألة الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ من المسائل ذات الأثر الواضح في هذه القضية، إذ شاع لدى الكثيرين أن الهدف الرئيس من إقرار ما يسمى بموت الدماغ، هو إيجاد مبرر قانوني وشرعي للحصول على أعضاء هؤلاء الأشخاص في حالة جيدة، وهذه المسألة تركز على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الطبي، والمحور الشرعي والقانوني، والمحور الأخلاقي، وبين المحاور الثلاثة ارتباط لا يقبل التجزئة؛ لأن الأطباء المسلمون لن يقوموا بهذا العمل إلا إذا توفر لهم الغطاء الشرعي والقانوني الذي يجعلهم في مأمن من العقاب والمساءلة الدينية والقانونية، فهم مرتبطون بأخلاقيات المهنة الطبية.

لذا كانت مسألة الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ مثار خلاف بين الفقهاء، وهو ما أعرض له فيما يلي:

تحرير محل النزاع:

أولاً: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز نقل الأعضاء عموماً إذا ترتب على هذا النقل ضرر، سواء بالمنقول منه أم المنقول إليه، لنهي الشريعة الإسلامية عن إلحاق الإنسان الضرر بنفسه أو غيره.

ثانياً: لا خلاف بين الفقهاء على حرمة نقل الأعضاء إذا تم ذلك بمقابل، حتى لا يكون جسم الإنسان وأعضاؤه محلاً للتجارة، مما يفتح باب شر يصعب إغلاقه، وهو ما ورد صريحاً في نصوص الفقهاء، فقد قال ابن الهمام في شرح فتح القدير: "لا يجوز بيع أجزاء الإنسان، ولا الانتفاع

بها، لأن الأدمي مكرّم لا يبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً^(١).

ثالثاً: مع اتفاق الفقهاء على ما تقدم، إلا أنهم اختلفوا في الاستفادة بأعضاء موتى الدماغ عن طريق استئصالها وزرعها للغير، وانتهى هذا الخلاف إلى رأيين:

الرأي الأول: يرى عدم جواز استقطاع أعضاء موتى الدماغ وزرعها في أجساد الغير، وقد ذهب إلى هذا الرأي العلماء والأطباء القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، وذهب إليه كذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد رأفت عثمان وغيرهم، بناءً على أن الميت دماغياً يعتبر حياً، ونقل الأعضاء بين الأحياء لا يجوز^(٢).

الرأي الثاني: يرى جواز استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ، وهو ما ذهب إليه القائلون باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً^(٣)، وإلى هذا الرأي ذهبت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء في قرارها

(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام، ٤٣/٦.

(٢) شرح فتح القدير، ٤٣/٦، بدائع الصنائع، للكاساني، ٧٧/٧، بلغة السالك لأقرب المسالك، ٤٢٤/١، جواهر الإكليل، ١١٧/١، حاشية البيجرمي على الخطيب، ١٧٣/٤، المحلى، لابن حزم، ١٣٣/١، الشيخ محمد متولي الشعراوي: مقال بعنوان "الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه"، جريدة اللواء الإسلامي، العدد ٢٢٦، الصادر في ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٠٧هـ. د. عبد السلام السكري: نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، ص ١٣٣، ١١٨، طبعة دار المنار - القاهرة، ١٩٨٨م، د. محمد رأفت عثمان: نقل وزراعة الأعضاء، السابق، ص ١٠.

(٣) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، السابق، ص ١٤٩.

رقم ٩٩ الصادر في ١٤٠٢/١١/٦ هـ ما يلي: " قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسانٍ حيٍّ مسلم، أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعهِ، وغلب على الظن نجاح زرعهِ، كما قرر بالأكثرية ما يلي:

- جواز نقل عضو من إنسانٍ ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعهِ ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعهِ فيمن سيزرع فيه.
- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه، أو جزئه إلى مسلم مضطر لذلك "

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على قولهم بعدم جواز استقطاع أعضاء موتى الدماغ بالسنة، والقياس، والمعقول، ونصوص الفقهاء:

أولاً: استدلو من السنة بما روى عن جابر رضي الله عنه قال: ﴿لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَمَرَضَ فَجَزَعٌ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَرَأَاهُ مُعْطِيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهَجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُعْطِيًا يَدَيْكَ، فَقَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَضَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاعْفِرْ﴾^(١).

(١) الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، برقم

وجه الدلالة:

إن النبي ﷺ توعّد من أقدم على إهلاك نفسه؛ لأن الإنسان لا يملك أن يفسد من نفسه شيئاً، وفي نقل الأعضاء إفساد بالنفس؛ لأن صاحبها تصرف فيها على غير وجهها الشرعي، كما أن النبي ﷺ طلب المغفرة لمن يقوم بذلك، فكان هذا دليلاً على أنه ارتكب إثماً، حيث رتب النبي ﷺ العقاب على من أهلك نفسه بنفسه وهو مدرك يعقل ما يفعل، والميت دماغياً فاقد للقدرة على التعبير عن إرادته، ولا يملك قبولاً ولا رفضاً، ولم تصدر منه الموافقة - عند من قال بضرورة الموافقة - وبالتالي فالتصرف في أعضائه لا يجوز، ومن يقدم على فعل ذلك من الأطباء آثم يستوجب العقاب.

ثانياً: استدلو بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" ^(١).

وجه الدلالة:

أثبت الحديث معصومية الجسد، أي كانت الصفة القائمة به، أي سواءً أكان حياً أم ميتاً، وساوى بينهما في العقوبة المترتبة على الاعتداء على كل منهما، وما دام أن الإنسان الحي لا يجوز نقل أعضائه أو قطعها، لينتفع بها الغير، فكذلك الميت؛ لأن الاعتداء على الميت أشد وأخطر؛ لفقدانه وسائل الدفاع عن نفسه بخلاف الحي.

قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لهذا الحديث: "فيه دليلٌ على

﴿١١٦﴾ ١٠٨/١.

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتكبد ذلك المكان،

٢١٢/٣، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، ٥١٦/١.

وَجُوبِ الرَّفْقِ بِالْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَمْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَشْبِيهَ كَسْرِ عَظْمِهِ بِكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ إِنْ كَانَ فِي الْإِثْمِ، فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّائِبِ فَكَمَا يَحْرُمُ تَأْلِيمُ الْحَيِّ يَحْرُمُ تَأْلِيمُ الْمَيِّتِ، وَقَدْ زَادَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لَفْظَ " فِي الْإِثْمِ "، فَيَتَعَيَّنُ الْإِحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ^(١).

ثالثاً: استدلوها بجملة من النصوص التي وردت عن الفقهاء تدعم وجهة نظرهم، ومن هذه النصوص:

ما جاء في بلغة السالك: " فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عَظَامِهِ، فَالْحَرَمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ ظِفْرِ الْمَيِّتِ وَلَا جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا شَعْرَهُ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ مُحَرَّمَةٌ، وَفِي أَخْذِهَا انْتِهَآكٌ حَرَمَتِهَا " ^(٢).

قال ابن قدامة في المغني: " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَضْطَرُ شَيْئاً، لَمْ يَبِحْ لَهُ أَكْلُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا آدَمِيًّا مُحَقَّقُونَ الدَّمُ لَمْ يَبِحْ قَتْلَهُ إِجْمَاعاً، وَلَا إِتْلَافَ عَضْوٍ مِنْهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى نَفْسُهُ بِإِتْلَافِهِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا لَمْ يَبِحْ أَكْلَهُ " ^(٣).

وجه الدلالة:

دلت نصوص الفقهاء السابقة، على عدم جواز نقل الأعضاء، إذ إنها أفادت عدم جواز استخدام ظفر الميت ولا شعره، لأن في ذلك انتهاكاً لحرمته، ويقاس على ذلك سائر أعضاء الإنسان، كما أن الإنسان في حالة الاضطرار، لا يجوز له أن يأكل بعضه، لِيُخَيَّرَ بِهِ نَفْسُهُ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا

(١) نيل الأوطار، للشوكاني، ٣٤/٤.

(٢) بلغة السالك، ٤٢٤/١.

(٣) المغني، لابن قدامة، ١١/١٧٩.

يجوز له أن يُعطى عضوه، ليُخَيَّرَ غيره^(١).

والميت دماغياً ما زال على قيد الحياة، وفقاً لما رجحناه في المبحث السابق، وبالتالي ينطبق عليه الحكم، لذا كان استقطاع أعضائه والانتفاع بها أمراً محرماً شرعاً.

رابعاً: إن مسألة الحكم على الميت دماغياً فيها شيء من الشك والريبة، وما دام هناك احتمال ولو ضئيل في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة، فلا يجوز استقطاع أعضائه أو بعضها، إذ بهذا الفعل يصبح الموت مصيره المحتوم والمحقق، ومعلوم أن الضرر محرم شرعاً، وتؤكد المواثيق والأخلاقيات الطبية هذا المعنى، حيث منعت إجراء التجارب على الأشخاص الأحياء الذين يتوقع أن يصابوا بضرر^(٢).

خامساً: إن عملية نقل العضو من الميت دماغياً فيها نوعٌ من الإيلام والتعذيب، لا سيما وأنه قد تم التقرير بأن الميت دماغياً ما زالت فيه بعض مظاهر الحياة من حس وحركة ونبض وتنفس وما إلى ذلك.

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأمرين:

الأول: إن الدعوى بوجود الألم والتعذيب لا محل لها هنا؛ لأن تلك العمليات لا تتم إلا بعد تخديرٍ كامل للمريض، بحيث يفقد المريض الشعور والإحساس أثناء العملية، كما أن الألم الذي يحدث ألم محتمل، والحياة ملئية بالآلام، وهذا الألم في حالة التسليم بوجوده له أهداف إنسانية، وبالتالي فالغاية تبرر الوسيلة

(١) إراجع: مؤلفنا: الإيدز وآثاره الشرعية والقانونية، ص ٢٤٣.

(٢) د. محمد رأفت عثمان: نقل وزراعة الأعضاء، السابق، ص ١١.

الثاني: إن الإيلام والتعذيب المحرم الذي نهى عنه الشارع هو الإيلام المقصود لذاته، أما إذا كان الغرض مشروعاً مقصوداً به النفع، وصاحبه بعض الآلام فلا حرج في ذلك، وفي القديم كانت العمليات الجراحية والختان يتم إجراؤها بدون تخدير، وكان فيها ألم شديد، ومشقة بالغة، ومع ذلك أباحها الفقهاء لما فيها من منافع^(١).

الجواب: يجاب عن هذه المناقشة، بأن قولكم بعدم وجود الألم في إجراء تلك العمليات بعد تخدير المريض كلياً أمر محل نظر؛ لأن الميت دماغياً، والذي تقومون باستئصال أعضائه هو من وجهة نظركم ميت؛ فلماذا التخدير إذن؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد ذكرت المراجع الطبية ما مفاده أن مثل هذا النوع من عمليات استئصال أعضاء موتى الدماغ لا يتم فيه تخدير، حيث ذكرت أن بعض المرضى الذين حكم عليهم بالموت بناءً على تشخيص موت الدماغ، لما هم الأطباء بنزع الأعضاء شعر بالألم، وزادت حركته، فأوقف الأطباء عملهم، وهذا دليل على أن التخدير لا يتم في جميع الحالات.

سادساً: من المتعارف عليه في المجال الطبي أن نشاط أوعية القلب الدموية بالنسبة لمن يسمون بموتى الدماغ، ما زال يعمل ويدق بصورة طبيعية ومنتظمة، وبالتالي فإن نزع الأعضاء الحيوية منهم يتطلب تشريعاً، لاسيما وأن هناك مرسوم سمي بـ "مرسوم الحيوان" *animals act*، صدر في عام ١٩٦٨ م قرر أن الحيوان يعتبر حياً حتى يحدث توقف دائم

(١) د. محمد رشيد راغب قباني: نقل الأعضاء وزرعها، بحث منشور في مؤتمر نقل وزراعة الأعضاء، الذي عقد في رحاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، السابق، ص

لدورة الدم أو لتدمير دماغه.

يقول د. ديفيد ج. هيل أستاذ التخدير في جامعة كمبريدج، معلقاً على ذلك: " ألم يحن الوقت كي نمنح المرضى على الأقل الحماية ذاتها، التي نصر على منحها للحيوان، وأن نستخدم المعايير ذاتها القاضية بضرورة التوقف الدائم للدورة الدموية، أو تدمير الدماغ لكي نقرر أن الموت قد حدث فعلاً قبل أن نشرع في عملية إزالة الأعضاء الحيوية " (١).

ويقول الدكتور. صفوت لطفي: " إذا كان الله تعالى قد أمر بعدم قطع شيء من البهيمة قبل أن تموت تماماً وتبرد حركتها، ونهى الرسول ﷺ أن نتعجل بموتها فتسلخ، أو يقطع منها شيء قبل أن تهمد وتبرد، فأولى بذلك أن نتحرج من التصرف في الإنسان الذي كرمه الله حياً وميتاً، فنحن منهيون من باب أولى أن نتعجل موته ونبقر بطنه لناخذ كليته أو قلبه أو كبده قبل أن يموت ويبرد تماماً، وإذا مات وبرد، فإن أعضاءه لا تصلح، وبذلك يكون الله حماه من استخدام أعضائه " (٢).

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الشأن، أن السبب الرئيس والدافع المحرك لعملية تشخيص موت الدماغ، هو الحرص على جني الأعضاء الحيوية من مرضى الغيبوبة ومصابي الحوادث، وبهذا المنطق فإن التبرير يختلف في الحقيقة عما يقال من أن الغرض من تشخيص موت الدماغ، هو التعجيل بدفن الميت، أي إكرامه، بدلاً من تركه على أجهزة الإنعاش،

(١) د. صفوت حسن لطفي: السابق، ص ١٩٦.

(٢) د. صفوت لطفي: أسباب تحريم نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، جريدة الأخبار المصرية

الصادرة في ١٩٨٩/١/٢٤ م.

فالأمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً.

سابعاً: إن استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ يتعارض مع الرسالة السامية للأطباء؛ لأن الأخلاق الطبية والمهنية، توجب على الطبيب التحقق الذي يصل إلى مرتبة اليقين من موت الإنسان بجميع أعضائه، وليس الموت الجزئي لبعض الأعضاء دون البعض الآخر، لأن هذا الأمر أدى إلى ظهور مصطلح "موت الدماغ" أو "موت جذع المخ"، حيث جرت العادة على أن يطلق لفظ الفشل في مثل هذه الحالات، كالفشل الكلوي والكبدى، وحتى عندما يتوقف القلب يقال: توقف القلب، ولا يقال موت القلب، لذا فإن مصطلح موت الدماغ تم استحداثه في الأصل، لتحقيق غرض محدد، وهو الحصول على الأعضاء عن طريق الحكم بالموت على هؤلاء المرضى قبل أن يموتوا.

لذلك أفتى مجمع البحوث الإسلامية في مصر، بأن من يقوم بالانتزاع من جسد لم يزل قلبه نابضاً للحياة، ولم تزل فيه بقية من حياة، فهو قاتل نفساً حرم الله قتلها إلا بالحق، وتجب محاكمته جنائياً.

ثامناً: إن القول بجواز استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ، يقف عائقاً خطيراً أمام إيجاد علاج لبعض الأمراض المستعصية؛ حيث يعتمد الأطباء على أن الميت دماغياً ستم الاستفادة منه، من خلال جني أعضائه، وهو سبب من أسباب الفشل، فعلى الجميع أن يتكاتف للوصول إلى حلول، بدلاً من التكتاف لإيجاد مبررات، كذلك فإن الأخذ بأسباب العلم وتطوراتها، يطرح الكثير من البدائل الحالية والمستقبلية لهذه المشكلة، وقد ظهرت بعض دلائل النجاح في التجارب التي تجرى على الخلايا الجذعية، إضافةً إلى التجارب التي تجرى على محاليل يتم حقنها في جسد المتوفى فعلاً عند الوفاة مباشرة، وهذه المحاليل تعمل على أن تظل أعضاؤه في

حالة صالحة للنقل لفترات زمنية، يمكن خلالها إجراء هذه الجراحات^(١).

تاسعاً: استدلو من المعقول على عدم جواز ذلك، بوجهين:

الأول: إن حرمة المال أقل من حرمة النفس، وقد أمر النبي ﷺ بتوقي كرائم أموال الناس، فمن باب أولى أن تتقى أعضاؤهم.

الثاني: لا يجوز استقطاع الأعضاء الأدمية من موتى الدماغ؛ لأنهم أحياء، قياساً على عدم جواز استقطاع الأضباع، بجامع كون كل منهما من أعضاء الجسد^(٢).

أدلة الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بجواز استقطاع أعضاء الموتى دماغياً، بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: استدلو بعموم الأدلة التي تقضي بجواز نقل الأعضاء للتداوي، ومنها: قوله تعالى ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^(٣).

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن حالة الضرورة مستثناة من الحكم العام، وهو التحريم المنصوص عليه في الآية، والإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو يكون داخلاً في حكم المضطر؛ لأن حياته مهددة بالموت كما في حالة الفشل الكلوي وتلف القلب ونحوهما من الأعضاء المهمة في جسم

(١) جريدة الأهرام المصرية، الصادرة في ٢٠٠٩/٢/٥ م.

(٢) د. عبد السلام السكري: نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، السابق، ص ١١٧.

(٣) البقرة: ١٧٣.

الإنسان، وإذا كانت حالته حالة اضطرار، فإنه يدخل في عموم الاستثناء المذكور، وبالتالي يجوز له نقل العضو^(١)، لاسيما وأن المنقول منه - الميت دماغيا - يعد ميتاً وفقاً للمعايير الطبية، ولا أمل في عودته للحياة مرة أخرى.

المنافسة: الاستدلال على جواز استقطاع أعضاء موتى الدماغ بقاعدة الضرورة أمر محل نظر؛ لأنه لا علاقة للآية التي استدلتتم بها على نقل أعضاء الميت، بل إنها وردت في ما يحل وما يحرم من المأكل والمشرب، وإذا كان الله تعالى قد بين المحرمات على سبيل التفصيل، وأباح ما يجوز منها عند الضرورة، فيجب الاقتصار على ما ورد في ذلك^(٢)، وبما أن إباحة المحرم وردت على سبيل الاستثناء، فلا تجوز الزيادة عليه والتوسع فيه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره.

أضف إلى ذلك: أن نظرية الضرورة لا تقبل ولا يعمل بها في جرائم النفس؛ إذ لا يصلح أن ينقذ إنسان على حساب إنسان آخر، وهو أمر محل إجماع^(٣).

ثانياً: استدلو بما نقل عن الدكتور. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، حيث قال ما نصه: " وإن كان بعض العلماء يرى أن جسد الإنسان ملك لله، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه لا بالبيع أو التبرع، إلا

(١) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص ١٣٣.

(٢) د. عقيل بن أحمد العقيلي: حكم نقل الأعضاء، السابق، ص ٨١.

(٣) د. يوسف قاسم: نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والفقه الجنائي الوضعي،

ص ٢٨٦، طبعة مطبعة جامعة القاهرة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

أنني أخالفه الرأي في الجزء المتعلق بالتبرع، لأنه لا بأس به إذا رأى الأطباء أنه سيفيد المتبرع له أكثر من ضرره للمتبرع، والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء وليس جسم الإنسان فقط، إن بيع الإنسان لجزء من أجزائه جسده باطل ومحرم شرعاً، وإن التبرع جائز عند جمهور الفقهاء، ولا فرق بين تبرع الأقارب أو غيرهم، مادام يؤكد نفعه الأطباء الثقات، وأن المتبرع في هذه الحالة أجره عند الله، لأن تبرعه لون من ألوان الإيثار على النفس، بَشَّرَ الله تعالى أهله بالجنة" (١).

ثالثاً: إن بقاء الأعضاء الأدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها، يعتبر من قبيل الصدقة الجارية المأمور بها في حديث النبي ﷺ " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (٢).

وبهذا تكون هذه صدقة مندوب إليها، خاصة إذا أوصى صاحبها بذلك قبل الوفاة، محتسباً الأجر عند الله، فهو من باب الإيثار.

المناقشة:

نوقش الاستدلال بالدليلين السابقين بما يلي:

١- إن الصدقة الجارية لها حدودها المأذون فيها شرعاً، كالجهاد في سبيل الله تعالى، وبالتالي فالإيثار شرع في حدود قدرة الشخص، أي أن نطاق الإيثار ليس مطلقاً في كل شيء، بل هو في الحظوظ

(١) فتوى د. طنطاوي منشورة في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ١٣/٧/١٩٩١م.

(٢) الحديث صحيح: رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ١٢٥٥/٣.

الدينية، فأعضاء الجسم بناءً على ذلك ليست محلاً للإيثار^(١).
 ٢- إن قضية تبرع الإنسان بأعضائه ليست محل اعتبار هنا، لأن من أركان التبرع أن يكون الإنسان المتبرع مالكا للشيء الذي يتبرع به، أو موكلًا بذلك من مالكه، والمالك للجسد هو الله عز وجل ولا ولاية للإنسان عليه إلا في الحدود المرسومة من قبل الشرع^(٢)، فكان الدليل خارجاً عن محل النزاع.

رابعاً: إن في نقل الأعضاء تفريجاً للكربات، وتأكيذاً على مبدأ التراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع، والإحسان إلى المضطرين، قال تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(٣) وقال ﷺ: "من فرج عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة"^(٤)، وتفريج الكربات كما يكون بالمال يكون بغيره، فلم يقصر الإسلام المعروف على المال؛ بل المعروف عام يدخل فيه سائر أنواع البر، فدخل فيه التبرع ببعض البدن لمنفعة الغير، والبدن أفضل من المال^(٥).

خامساً: إن هناك من فقهاء المذهب الشافعي من أباح للمضطر أن يقطع

(١) د. حسن علي الشاذلي: حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، ص ١٤١، كتاب

الجمهورية - بدون تاريخ.

(٢) د. عبد السلام السكري: نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، السابق، ص ١٠٧.

(٣) الحشر: ٩.

(٤) الحديث أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ٨٦٢/٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ١٩٩٤/٤.

(٥) د. محمود محمد عوض سلامة: حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، ص ٨٥،

طبعة دار النهضة العربية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

جزءاً من جسده ليسد به رمقه، إذا خاف على نفسه الهلاك، فللمضطر أن يتلف الجزء لإبقاء الكل، لأن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأدنى، والضرر العام يدفع بالضرر الخاص، وهذه الإباحة هنا مقيدة بأن لا يجد المضطر ميتةً أو نحوها يسد بها رمقه، وأن يكون المراد حفظ نفس المضطر، لا حفظ نفس غيره، وأن يكون الخوف من القطع أقل من الخوف من عدم الأكل^(١)، والمريض هنا كالمضطر، فيجوز أن يتبرع شخص له بجزء من جسده، ما دام لا يلحق به الضرر، ولا يؤدي إلى عجزه أو تشويهه، وكان النقل مفيداً للمريض في غالب ظن الطبيب المسلم، شريطة أن يتم ذلك كله دون الحصول على أي مقابل مالي، لأن بيع الحر باطل شرعاً^(٢).

سادساً: استدلو على مذهبهم بالقياس من وجوه:

أولها: القياس على جواز نقل الأعضاء فيما بين الأحياء، فإذا جاز للإنسان التبرع بأعضائه حال الحياة؛ فلا مانع من أن يوصي بذلك بعد موته؛ لأن في ذلك منفعة خاصة للغير دون احتمال أي ضرر عليه، حيث إن هذه الأعضاء تتحلل بعد أيام.

الثاني: القياس على التشريع، فإذا كان التشريع أجاز الفقهاء لأغراض محددة، بما يشمل من استقطاع أجزاء من الجثة، فإن نقل بعض الأعضاء

(١) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، ١٦٠/٦.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، ص ١٩٨، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق - جامعة المنصورة، العدد رقم ١٨ ١٩٩٥ م.

للغير، لينتفع بها بعد موته هو الآخر يكون جائزاً^(١).

الثالث: يجوز التبرع بالأعضاء قياساً على التبرع بالدم، إذ الدم جزء من الجسم، ولا يحيا الجسم إلا بهذا الجزء، كذلك فإن المرأة يجوز لها أن تتبرع بلبنها، لترضع طفلاً لامرأة أخرى وهو جزء منها، فتبرع الإنسان بجزء من جسمه أمرٌ جائزٌ بشروط وضوابط، ما دام في ذلك منفعة للغير، وليس فيه مضرة للمتبرع.

الرأي الراجح:

من خلال ما تقدم عرضه من آراء الفقهاء، في حكم استقطاع أعضاء موتى الدماغ لزرعها في أجساد أناس آخرين، أرى أن الراجح في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، القاضي بحرمة استقطاع أعضاء موتى الدماغ، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: قوة الأدلة التي استند إليها أنصار هذا الرأي، وخلوها عن المعارض الذي يقدر في صحتها من الناحيتين الشرعية والطبية.

ثانياً: إن المجيزين لاستقطاع أعضاء موتى الدماغ، أسسوا رأيهم على اعتبار موتى الدماغ أموات بالمعنى الحقيقي لكلمة الموت، في حين أن الاتجاه القوي من الفقهاء والأطباء رفضوا هذا المفهوم، حيث يرون أنه لا يعد ميتاً، وفي تقديري أن لفظ الاستحالة في الطب، والجزم بعدم عودة مريض للحياة مرةً أخرى، أمر مستبعد تماماً ولا يمكن قبوله، حيث إن الله تعالى قادر على إنعاش المريض مرةً أخرى بعد فقدان الأمل من شفائه، والتاريخ الطبي بوقائعه الكثيرة أكبر شاهد على ذلك.

(١) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، السابق، ص ١٤٨.

ثالثاً: إن عمليات نقل الأعضاء لا تخلو من أضرارٍ تلحق بالمنتقل إليه، وتجعله عرضةً للإصابة بأمراضٍ خطيرة أكثر من غيره، منها:

الأورام السرطانية: حيث وجد أن نسبة الأورام السرطانية في المرضى الذين تم زراعة كلى لهم تزيد مائة مرة عن النسب المعتادة، وأهم هذه الأورام: سرطان الجلد، وسرطان العقد الليمفاوية، وورم كابوسي الذي يتميز بخطورته الشديدة، وسرعة انتشاره يظهر في مرضى الفشل الكلوي الذين أجريت لهم عمليات زرع الكلى نسبة تصل إلى (٢٠٠) مائتي ضعف النسبة المتوسطة المعتادة، وأنه يظهر في فترة مبكرة للغاية ^(١).

مضاعفات جراحة الأوعية الدموية في عمليتي انتزاع العضو أولاً، ثم زراعته في جسم المريض ثانياً، وتشمل هذه المضاعفات النزيف الدموي، والجلطات في الأوردة والشرابين، وكذلك ارتفاع ضغط الدم بعد عملية زرع الكلى، نتيجة ما يحدث من تأثيراتٍ على الأوعية الدموية ^(٢).

رابعاً: إن الهدف الرئيس من إثارة الأطباء لهذه المسألة، هو الحصول على الغطاء الشرعي الذي يسمح لهم بممارسة هذه الأعمال، والاعتداء على أجساد المرضى تحقيقاً لمطامع الشهرة والثراء.

خامساً: إن الأصل الذي جاءت به الشريعة هو المحافظة على النفوس، وليس القضاء عليها، لذا فإن الأطباء إنما يقدمون على هذا الفعل، لعلمهم أن أعضاء المريض في هذه المرحلة تكون صالحةً للاستعمال والزرع في

(١) د. محمود محمد عوض سلامة: حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، السابق، ص

(٢) د. صفوت لطفي: أسباب تحريم نقل وزراعة الأعضاء الأدمية، السابق، ص ٣٧.

أجسادٍ أخرى، أما بعد الموت الذي يعنى موت جميع الأعضاء، فتفقد تلك الأعضاء هذه الصلاحية، لذلك فإنهم يحرصون على جني الأعضاء في تلك الفترة، أي أنهم يتعجلون، والقاعدة أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، لذا تجرم هذه الأفعال، مضافاً إلى ذلك معاقبة الطبيب الذي يقدم على هذا الفعل.

تدريبات على الوحدة الثالثة

- ١- حدد المفهوم الشرعي للموت، مقارناً بينه وبين المفهوم العلمي.
- ٢- ما هو ضابط الموت الذي وضعه الفقهاء، وهل يتماشى مع ما ذهب إليه الأطباء.
- ٣- القول باعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً يترتب عليه مفسد كبيرة، اشرح هذه العبارة.
- ٤- هل يجوز نقل أعضاء موتى الدماغ؟ بين الآراء على سبيل الإجمال، مع ذكر الراجح.
- ٥- حدد المفهوم العلمي لموت الدماغ كما وضعه الأطباء، ثم بين مدى انطباقه على المفهوم الشرعي.

فهرس الموضوعات

المقدمة ١١

التجارب الطبية على الإنسان

المبحث الأول: مفهوم التجارب الطبية وأنواعها..... ١٥

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتجارب الطبية على الإنسان..... ٢٨

المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء..... ٣٣

المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأموات..... ٥٣

الحكم الشرعي لإجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى..... ٥٦

المطلب الثالث: حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة..... ٧٠

المبحث الثالث: القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر..... ٩٢

المطلب الأول: القيود الخاصة بالتجربة..... ٩٣

المطلب الثاني: القيود الخاصة بالأشخاص الخاضعين للتجارب..... ١٠٨

المطلب الثالث: القيود الخاصة بحماية المجتمع..... ١٢٤

المبحث الرابع: المسؤولية عن إجراء التجارب الطبية..... ١٢٩

المطلب الأول: المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية..... ١٢٩

الفرع الأول: المسؤولية العقدية عن إجراء التجارب الطبية..... ١٣١

الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية عن التجارب الطبية..... ١٣٤

تدريبات على الوحدة الأولى ١٤٧

حكم تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي

- المبحث الأول: التعريف بتأجير الأرحام ١٥٧
- المبحث الثاني: الحكم الشرعي لتأجير الأرحام ١٦٨
- المبحث الثالث: نسب طفل تأجير الأرحام ٢٠٣
- تدريبات على الوحدة الثانية ٢١٩

موت الدماغ وأثره في عمليات نقل الأعضاء

- المبحث الأول: مفهوم موت الدماغ ٢٢٦
- المبحث الثاني: التكيف الشرعي لموت الدماغ ٢٤٢
- المبحث الثالث: حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ ٢٨١
- تدريبات على الوحدة الثالثة ٢٩٨
- فهرس الموضوعات ٢٩٩